세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Acetphen premix inj	
성분/함량	Acetaminophen 1g/100ml/Bag	비마약성진통제
효능·효과	◆ 통증이나 고열로 인하여 신속하게 정맥 투여할 필요가 있거나 다른 경로로 투여할 수 없는 경우 ① 중등도의 통증(특히 수술 후)의 단기간 치료 ② 발열의 단기간 치료	
용법·용량	◆ 정맥으로 15분간 투여하며, 성인 및 체중 33kg(약 11세) 이상인 소아에 한함. ① 50kg이상인 성인: 1회 1g, 1일 4회, 투여간격은 최소 4시간 (1일 최대 4g) ② 33kg(약 11세) 이상 소아, 50kg 미만인 성인: 1회 약 15mg/kg(이 약 1.5ml/kg), 투여간격은 최소 4시간 (1일 최대 60mg/kg 또는 4g) ③ 중증 신장애 환자(Clcr ≤ 30ml/min): 투여간격 최소 6시간	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Prostaglandin의 합성을 저해하고 통증의 역치를 높여서 통증을 경감시키는 것으로 추정, CNS에서 Prostaglandin의 생성과 분비를 억제하고 시상하부의 thermoregulator에서의 endogenous pyrogen을 억제함으로써 해열 작용 나타냄. ◆ 부작용 : 권태감, 저혈압, 간 transaminase 농도 증가, 무과립구증, 호중구 감소증, 반점발진, 주사부위 반응(통증, 작열감), 구역, 구토, 두통, 과민반응 등 ◆ 금기 : 아세트아미노펜이나 프로파세타몰염산염 또는 이 약에 대해 과민증이 있는 환자, 소화성 궤양 환자, 중증의 혈액 이상/간장애/신장 장애/심장기능저하 환자, 아스피린 천식 또는 그 병력 환자(NSAIDs에 의한 천식발작 유발), 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 복용 환자, 알코올 복용 환자 ◆ 상호작용 : ①Isoniazid, Phenytoin: 간 독성 증가 ②Probenecid, Salicylamide: 이 약의 작용 증가 ③Carbamazepine, Phenobarbital, Primidone, Rifampicin, Phenytoin: 이 약의 작용 감소 ④경구 항응고제: INR 값 변화->병용투여기간 및 Acetaminophen 중단 후 1주 동안은 INR 값의 모니터링이 수행 ◆ 주의 ① mg과 ml의 혼동으로 인한 투약 오류 위험 주의 ②경구 투여 가능 시 바로 적절한 진통제 사용 ③과량 투여의 위험성을 피하기 위해, 기 투여한 다른 약에 Acetaminophen 함유 확인 ①간독성 주의: 권장용량 이상 용량은 매우 심각한 간 손상 수반 ⑤Acetaminophen 복용 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스 - 존슨증후군(SJS), 독성 표피 괴사용해(TEN)와 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 반응은 치명적일 수 있음. ⑥신중투여: 간장애 또는 그 병력이 있는 환자, 신장장애 또는 그 병력이 있는 환자, 소화성 궤양의 병력이 있는 환자, 혈액 이상 또는 그 병력이 있는 환자, 출혈경향이 있는 환자, 심장기능이상이 있는환자, 과민증의 병력이 있는 환자, 기관지 천식 환자, 고령자(노인), 소아, 임부 또는 수유부, 와파린 장기 복용 환자, 리튬/치아짓계 이뇨제 복용 환자, 만성 알코올중독 환자, 만성 영양실조(간글루타치온의 낮은 보유량) 환자, 탈수/저혈량증 환자	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Actilyse inj	
성분/함량	Alteplase(r-TPA) 20mg/V, 50mg/V	혈전용해제
효능·효과	◆ 급성심근경색증, 급성폐색전증, 급성허혈성뇌졸증 (증상 발현 후 4.5 시간 이내에 적절한 연상기법으로 두개내 출혈이 없음을 확인 후 투여)	
용법·용량	◆ 용해 및 희석 방법 ① WFI 를 넣어 1mg/ml 로 용해 후 정맥 내 투여 ② IV infusion: N/S 를 넣고 최고 1:5 의 비율(0.2mg/ml)로 희석 ◆ 급성 심근경색증: ① 증상발현 후 6 시간이내 치료를 시작하는 경우 (100mg 을 90 분 동안 정맥내 투여) : ▪ 15mg 을 IV bolus→ 50mg 을 30 분 동안 IV infusion→ 35mg 을 60 분 동안 IV infusion ▪ 체중 < 65kg 인 경우: 15mg 을 IV bolus→ 0.75mg/kg 을 30 분 동안 IV infusion(최대: 50mg)→ 0.5mg/kg 을 60 분 동안 IV infusion(최대: 30mg) ② 증상발현 후 6-12 시간이내 치료를 시작하는 경우 (100mg 을 3 시간동안 정맥내 투여) : ▪ 10mg 을 IV bolus→50mg 을 1 시간동안 IV infusion→ 20mg/hr 속도로 IV infusion(총 투여량:최대 100mg) ▪ 체중 < 65kg 인 경우 1.5mg/kg 를 초과하지 말 것 ◆ 급성 폐색전증(100mg 을 2 시간동안 정맥내 투여) ① 10mg 을 1-2 분에 걸쳐 IV bolus→ 90mg 을 2 시간 동안 IV infusion ② 체중 < 65kg 인 경우 1.5mg/kg 초과하지 말것 ◆ 급성 허혈성 뇌졸중(증상발현 후 4.5 시간 이내에 투여) : 0.9mg/kg 의 10% 용량을 1 분에 걸쳐 IV bolus(최대: 90mg) → 0.9mg/kg 의 90%용량을 60 분동안 IV infusion	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Recombinant human tissue type plasminogen activator(tPA)로서 Fibrin 과 결합된 plasminogen 에만 선택적으로 작용하여 plasmin 으로 활성화시켜 혈액 내 형성되어 있는 혈전만을 용해시킴 ◆ 부작용 : 심근경색치료 시 재관류에 의한 부정맥, 심부전, 재발성 국소빈혈, 협심증, 심인성쇽, 출혈, 과민반응으로 Anaphylaxis, 혈관부종, 발진, 열감, 기관지 경련, 두드러기, ALT□AST↑, 오심, 구토, 발한, 혈압저하, 출혈성 체질, 기존 또는 최근 중증 내출혈□뇌출혈, 최근 두달 이내의 뇌수술□척추수술, 최근 큰 외상이나 대수술, 조절이 불가능한 중증 고혈압, 세균성 심내막염, 급성췌장염 ◆ 상호작용 ① 항응고제(Heparin, Warfarin), 혈소판 응집억제제(Aspirin, Ticlopidine) : 이 약의 출혈 경향 증강 ② ACE 저해제 : Anaphylaxis 반응의 위험을 증가시킬 가능성 있음 ◆ 주 의 : ① IV 로만 사용 ② 희석 시 과도하게 흔들지 말 것 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비 고 : 용해액의 안정성: 8 시간(25℃이하 보관), 24 시간(2-8℃) ◆ 과량투여시의 처치 - 증상 : 피브리노겐 및 기타 혈액 응고성분이 현저히 감소할 수 있음 - 대부분의 경우 혈액응고인자들의 생리적 재생을 기다리는 것으로 충분 - 심각한 출혈이 초래된 경우 : 신선한 냉동 혈장이나 신선한 혈액을 수혈할 것이 권장, 필요하다면 합성 항섬유소용해제를 투여.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Adalat-oros tab	
성분/함량	Nifedipine 30mg/T	혈관확장제
효능·효과	◆ 관동맥심질환(만성안정형협심증) ◆ 고혈압	
용법·용량	◆ 1회 30-60mg씩 1회/일(최대: 120mg/일) ◆ 고혈압: 1회 20-30mg씩 1회/일로 치료 시작(최대: 120mg/일) ◆ 식사와 무관(삼투압 원리의 약물방출기전을 이용하는 약임)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 심근과 혈관근막의 Ca2+유입억제로 혈관 평활근 이완되어 혈압강하 Ca2+ channel blocker(catecholamine 분비시 Ca2+가 필요) ◆ 부작용 : 위장장애, 간기능이상, 두통, 현훈, 빈맥, 혈압강하, 하지부종, 사지저림, ALT·AST·ALP상승, BUN·SCr상승, 야뇨, 다뇨, 호흡곤란, 허혈성동통, 발적, 변비, 구역, 치육비후, 불면, 신경과민, 지각이상, 박리성피부염, 여성형유방, 어지러움 ◆ 금기 ① 임부, 수유부 ② 심인성 쇽 환자 ③ 불안정형 협심증 환자 ④ 저혈압(수축기압 90mmHg 미만) 환자 ⑤ 중증의 대동맥판협착증 환자 ⑥ 리팜피신을 투여받고 있는 환자 ⑦ 급성 심근경색(8일 이내) 환자 ⑧ 직장절제수술후 회장 조루술을 받은 Kock pouch환자다른 Bisphosphonate계 과민증 ◆ 상호작용 ① [병용금기] Rifampicin(보건복지부고시): 이 약 작용 감약 ② Reserpine, Methyldopa, Prazosin, β-blocker 등의 강압작용 증강 ③ DGX, Theophylline, Phenytoin의 혈중농도 상승 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : [임부금기] 2등급(보건복지부고시) ◆ 적용상의 주의 ① 고소작업·기계조작시 주의 ② 증량 30분 이내에 허혈성흉통이 나타나는 경우 투여중지 ③ 임부에 MgSO4 병용시 주의 ④ 분변에 정제 모양 그대로 배설될 가능성 있음 ⑤ 대동맥판·승모판 협착증, 폐고혈압, CHF, 노인, DM, 혈액투석시 신중투여	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	**Adacel prefilled syr**	
성분/함량	**Diphtheria toxoid ≥2IU,Tetanus toxoid ≥20IU,Pertussis toxoid 2.5㎍ 0.5ml/syr**	**Tdap**
효능·효과	디프테리아, 파상풍 및 백일해 예방	
용법·용량	- 1 회 투여용량은 0.5mL 로, 근육주사하며 혈관 내 직접 투여하지 않는다. - 영유아 시기에 소아용 DTP 기초접종을 일정대로 모두 마친 만 10~64 세의 청소년 및 성인을 대상으로 추가 접종하며 10 년 간격으로 재접종할 수 있다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 균이 생산한 독소(무독화시킬 성장물질)로 포르말린 처리에 의해 독성은 없고 항원성만 남아 활성 면역반응 ◆ 부작용 : 통증, 발적, 종창, 발열, 구토, 설사, 식욕저하, 졸음, 불면, 기침, 인후염, 상기도염, 기관지염, 중이염 ◆ 주의사항 : 냉동보관, 동결금지, IV 금지 ◆ 금기 1) 백신의 성분에 대하여 과민반응이 있거나 이 백신의 성분과 동일한 백신에 의해 과민반응 병력이 있는 자 2) 백일해항원을 포함한 백신 접종 후 7 일 이내에 다른 규명할 수 있는 원인에 기인하지 않은 뇌병증이 나타난 병력이 있는 환자 3) 진행성 신경계 질환, 조절 불가능한 간질 또는 진행성 뇌병증 환자 4) 발열성(40.5℃ 이상) 또는 급성 질환인 자 ◆ 상호작용 1) 본 백신은 불활화 인플루엔자백신 및 11 세 ~ 12 세에 B 형 간염백신 접종 시 다른 접종부위에 별도의 주사기로 동시투여 2) 정제 백일해를 포함한 백신제제는 다른 불활화 또는 생백신과 다른 접종부위에 동시접종이 가능하다. 이 경우 반드시 다른 주사기를 사용해 다른부위에 접종 3) 면역억제요법을 받고 있는 환자나 면역결핍환자에게는 적절한 면역반응이 나타나지 않을 수 있다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Adenocor inj	
성분/함량	Adenosine 6mg/2ml/V	부정맥용제
효능·효과	Wolff-Parkinson-White(WPW) 증후군을 포함한 발작성 상심실성 빈맥의 정상적인 동율동으로의 신속한 전환 심전도로 진단되지 않은 복합형 상심실성 빈맥의 진단 심근 신티그래피시, 운동이 불가능하거나 적절하지 않은 환자에게 관상동맥혈관이완을 목적으로 사용	
용법·용량	◆ WPW(Wolff-Parkinson-White) 증후군을 포함한 발작성 상심실성 빈맥의 정상적인 동율동으로 신속한 전환 ① 1 차용량 : 3mg 을 신속히 IV(2 초이상) ② 2 차용량 : 1 차용량으로 상심실성 빈맥이 1-2 분 이내에 소실되지 않으면 6mg 을 신속히 IV ③ 3 차용량 : 만약 2 차용량으로 동질환이 1-2 분 이내에 소실되지 않으면 12mg 을 신속히 IV ◆ 심전도로 진단되지 않는 복합형 상심실성 빈맥 진단시 : ①과 동일 ◆ 심근 신티그래피시, 운동이 불가능하거나 적절하지 않은 환자에게 관상동맥혈관이완을 목적 (bolus 금기) : infusion pump 를 통해 말초정맥내로 140mcg/kg/min 으로 6 분간 IV infusion (방사선약물은 이 약 투여 3 분 후 다른 부위에 투여)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 심장 방실 결절의 전도를 지연시키며 방실결절을 통한 혈액의 재유입 차단 ◆ 부작용 : 심차단, 부정맥, 중등도의 심실반응저하, 호흡부전, 안면홍조, 호흡곤란, 구역, 흉부압박감, 중증의 서맥, 두통, 두개압, 가벼운 상기, 무감각, 서혜부 압박 ◆ 금 기 ① 2-3 도의 방실 차단 환자, 동기능 부전환자(심박조율기 착용환자제외) ② (관상동맥 혈관이완 목적으로 사용시) 천식, QT 증후군, 중증의 저혈압환자, 약물로 안정되지 않는 불안정형 협심증, 보상작용이 상실된 심기능부전, 현저한 기관지경련을 동반한 COPD 폐질환 ◆ 주 의 ① 심방세동, 심방조동 환자 및 부전도로를 가진 환자 : 비정상적인 자극전도 증대 ② 발작 또는 그 발작의 병력이 있는 환자(발작을 유발시킬 수 있으므로 주의 깊게 모니터링) ③ 좌측주관상동맥협착증, 교정되지 않는 저혈량증, 협착성심판막질환, 좌우단락, 심막염 또는 심막삼출, 자율신경계 장애 또는 뇌혈관 장애가 있는 협착성 경동맥질환 환자(유의한 저혈압이 나타날 수 있음) ④ 심근 신티그래피시 관상동맥 혈관이완 목적으로 사용시 반드시 infusion pump 를 이용해 IV 내로 서서히 주입 ◆ 상호작용 ① Caffeine, Theophylline: 이 약 효과 억제됨 ② Dipyridamole: 이 약 작용상승 ③ Carbamazepine: 심차단 정도 증가 ◆ 비 고 ① 냉동보관 하지말 것(∵침전생성) ② 과량투여시는 $t_{1/2}$ < 10 초 이므로 부작용 금방 소실 ◆ 과량투여시의 처치 : 반감기가 매우 짧기(10 초 미만) 때문에 이상반응이 일반적으로 빠르게 소실 - 이상반응이 오래 지속되면 처치는 개인과 그 정도에 따라 직접적으로 실시한다. - 경쟁적 길항제: 카페인, 아미노필린, 테오필린과 같은 methylxanthine 류(투여가 필요한 경우 정맥주사)	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	AGRAstat inj	
성분/함량	Tirofiban HCl monohydrate 12.5mg/50ml/V	항혈소판제
효능·효과	◆ 다음 환자에서 헤파린과 병용투여 - 급성 관증후군 치료시 대상 환자 - 경피적관상동맥확장성형술(PTCA) 또는 죽상반절제술 시술 등의 환자 이 약은 사망, 심근경색의 발생, 또는 치료 불응성허혈/ 재심장시술의 통합결과변수(combined endpoint) 발생률을 감소시키는 것으로 나타났다	

용법·용량

◆ PCI 를 진행할 환자에서, 이 약을 시술 시작시점에서 Bolus 로 25mcg/kg 을 3 분간 투여
그 이후는 0.15mcg/kg/min 속도를 유지하며 12-24 시간 동안 IV Infusion

환자체중(kg)	대부분의 환자		중증의 신부전 환자(CrCL<30ml/min)	
	Bolus (ml/hr)	유지주입속도(ml/hr)	Bolus (ml/hr)	유지주입속도(ml/hr)
30-37	17	6	8	3
38-45	21	7	10	4
46-54	25	9	13	56
55-62	29	11	15	6
63-70	33	12	17	7
71-79	38	14	19	8
80-87	42	15	21	8
88-95	46	16	23	9
96-104	50	18	25	10

◆ 최초 30 분간 0.4mcg/kg/분의 속도로 이후에는 0.1mcg/kg/분 IV Infusion
(N/S, D5W 로 희석하여 50mcg/ml 의 농도로 조제 후 투여)

환자체중(kg)	대부분의 환자		중증의 신부전 환자(CrCL<30ml/min)	
	30 분간 초기주입속도(ml/hr)	유지주입속도(ml/hr)	30 분간 초기주입속도(ml/hr)	유지주입속도(ml/hr)
30-37	16	4	8	2
38-45	20	5	10	3
46-54	24	6	12	3
55-62	28	7	14	4
63-70	32	8	16	4
71-79	36	9	18	5
80-87	40	10	20	5
88-95	44	11	22	6
96-104	48	12	24	6

사용상의 주의사항

◆ 약리작용 : 혈소판 표면 수용체인 Glycopeptide Ⅱb/Ⅲa 에 결합하여 fibrinogen 의 가역적 antagonist 로 작용하여 혈소판 응집억제
◆ 부작용 : 부종/종창, 골반통, 서맥, 하지통, 어지러움, 발한, 출혈, 두통, 혈종, 구역
◆ 금기

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

	① 30 일내 활동성 소화기내 출혈 또는 출혈경향의 병력자 ② 두개내 출혈, 두개내 신생물, 동정맥기형 또는 동맥류의 병력자 ③ 최근 30 일내 뇌졸중의 병력이 있거나 출혈성 뇌졸중의 병력자 ④ 중증의 고혈압자, 간장애 ⑤ 급성 심막염환자 ⑥ 이 약을 투여하여 혈소판감소증 발생한 경우 ⑦ 1 개월 이내에 대수술이나 중증의 외상을 입은 환자 ⑧ 대동맥 해리의 병력 ◆ 배합금기 : Diazepam ◆ 상호작용 ① Levothyroxine, Omeprazole: 이 약의 배설 증가 ② Heparin, Dopamine, Lidocaine, KCl, Famotidine 은 배합 가능함 ◆ 주 의 : ① 투여전, 주입 후 6 시간이내 매일 1 회씩 CBC 측정함 ② Aspirin, Heparin 과 병용 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비 고 : 실온(15-30℃), 차광보관 ◆ 과량투여시의 처치 - 환자의 임상상태를 평가하여 약물의 투여를 중지하거나 주입용량을 적절히 조절 - 이 약은 혈액투석으로 제거될 수 있다.

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Afilivu inj	
성분/함량	Aflibercept 11.12mg/0.278ml/V	항혈관신생제
효능·효과	◆ 신생혈관성 (습성) 연령 관련 황반변성의 치료 ◆ 중심막막정맥폐쇄성 황반부종의 치료 ◆ 당뇨병성 황반부종, 망막병증의 치료 ◆ 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상의 치료	
용법·용량	◆ 유리체내 주사로 투여 ◆ 신생혈관성 (습성) 연령 관련 황반변성의 치료 ① 2mg (이 약 50 mcL 와 동일) 을 첫 3개월 동안 매월 1회 주사 -> 이후 2개월마다 1회 주사 ② 장기사용 (처음 12개월 사용 이후) 시, 계속해서 2개월마다 주사하는 것이 권장 ◆ 중심망막정맥폐쇄성 황반부족의 치료 ① 2mg (이 약 50 mcL 와 동일) 을 처음 주사 후 1달에 1회 주사 (주사 간격은 1개월 미만이 되어서는 안됨) ② 시력 및 해부학적 검사를 1개월 간격으로 3회 평가하여 안정될 때까지 주사 ◆ 당뇨병성 황반부종의 치료 ① 2mg (이 약 50 mcL 와 동일) 을 첫 5개월 동안 매월 1회 주사 -> 이후 2개월마다 1회 주사	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Angiogenic VEGF (Vascular endothelial growth factor)에 결합 -> 혈관신생 및 혈관투과성 저해 ◆ 부작용 : 결막 출혈, 눈 통증, 유리체 박리, 백내장, 유리체 부유물, 안압상승 등 ◆ 금기 : 안구 또는 안구 주변 감염환자, 활동성 중증의 안내 염증이 있는 환자, 이 약에 과민증 있는 환자 ◆ 주의 ① 이 약의 유리체내 주사 및 눈 검진 후 일시적 시력 장애가 나타날 수 있으므로, 시력이 충분히 회복될 때까지 운전이나 기계조작은 피하도록 해야 함 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 냉장(2~8℃)보관 (사용 전 미개봉된 이 약의 바이알은 24시간까지 실온(25℃)에서 보관 가능 ② 차광을 위해 바이알을 원래의 상자에 보관 ◆ 적용상의 주의 ① 다른 의약품과 혼합해서는 안됨 ② 1회 투여용으로만 사용	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Aloxi inj	Paloset PFS inj	
성분/함량	Palonosetron HCl 0.075mg/V, 0.25mg/V	Palonosetron HCl 0.25mg/5ml/syringe	항구토제
효능·효과	중등도와 심한 구토 유발성 항암 화학요법제의 초기 및 반복적인 치료에 의해 유발되는 급성 구역 및 구토의 예방 중등도의 구토 유발성 항암 화학요법제의 초기 및 반복적인 치료에 의해 유발되는 지연형 구역 및 구토의 예방 수술 후 24 시간까지의 구역 및 구토의 예방 수술 후 구역 및 구토의 치료		
용법·용량	◆ 성인 ① 항암 화학요법제에 의해 유발되는 구역 및 구토의 예방 : 화학요법 시작 30 분 전에 팔로노세트론 0.25 mg 을 1 회 30 초 이상에 걸쳐 정맥 주사한다. ② 수술 후 구역 및 구토의 예방 : 마취유도 직전 0.075 mg 을 1 회 10 초 이상에 걸쳐 정맥 주사한다. 다른 항구토제와 마찬가지로 수술 후 구역 및 구토가 유발될 가능성이 낮다고 예상되는 환자에게 관례적으로 투여하는 것은 권장되지 않는다. 수술 후 구역 및 구토를 피해야 하는 환자에게는, 수술 후 구역 및 구토가 발생할 확률이 낮더라도 이 약의 투여를 권장한다. ③ 수술 후 구역 및 구토의 치료: 구역 및 구토가 나타나는 즉시 0.075mg 을 1 회 10 초 이상에 걸쳐 정맥주사한다. ◆ 소아 ① 항암 화학요법제에 의해 유발되는 급성 구역 및 구토의 예방: 화학요법 시작 30 분 전에 0.02mg/kg(max 1.5mg)을 1 회 15 분 이상에 걸쳐 점적 정맥주사한다. 이 약은 다른 약물과 혼합해서는 안된다. 이 약의 투여 전후에 주입관에 생리식염수를 흘려준다.		
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Selective 5-HT_3 수용체 길항작용 ◆ 부작용 : 두통, 변비, 설사, 어지럼증, 피로감, 복부통증, 불면증, 비지속성 빈맥, 서맥, 저혈압, 고혈압, 심근경색, 주기외수축, 동성 빈맥, 동성 부정맥, 심실상성 주기외수축, 알러지성 피부염, 멀미, 이명, 눈의 작열감, 약시, 설사, 소화불량, 복통, 구강건조, 딸꾹질, 복부팽만감, 쇠약, 피로, 발열, 전신 열감, 유사 독감증후군, 고칼륨혈증, 전해질 변동, 고혈당, 대사성 산증, 당뇨, 식욕감소, 식욕부진, 관절통, 어지럼증, 졸림, 불면증, 과다수면, 지각이상 불안, 행복감 뇨정체, 정맥변색, ◆ 주의 ① 어지러움, 졸음 및 피로를 유발할 수 있으므로, 환자는 운전 및 기계 조작시 주의 ② QT 간격을 증가시킬 수 있는 약물과의 병용 시 주의하여야 하며, QT 간격이 연장되어 있거나 연장될 수 있는 가능성을 가진 환자에는 주의 ③ 다른 약물과 혼합금기, 투여 전후 주입관에 N/S 통과 ④ 동일계열약물(5- HT_3 수용체 길항제)과 다른 세로토닌성 약물의 병용투여에 따른 세로토닌 증후군 주의 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고: 차광, 실온보관 ◆ 과량투여시의 처치 - 이 약에 대해 알려진 해독제는 없으며, 과량투여는 보조적 치료와 함께 관리 - 주된 독성 증상 : 경련, 숨가쁨, 창백, 청색증 및 허탈 등이었다.		

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Alpit inj	
성분/함량	Cimetropium bromide 5mg/A	진경제
효능·효과	◆ 위장관계의 경련 및 기능적 운동장애 ◆ 소화관 내시경 검사 전 투약 : 십이지장의 무긴장증과 오디괄약근의 이완	
용법·용량	◆ ① 과민성 대장통증을 동반한 위장관경련 : 1회 5㎎을 IM, IV ② 검사시의 전투약: 1회 10㎎을 40분 이상에 걸쳐 IV	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Muscarine receptor blocker로서 위장관계, 담도계, 비뇨기계에 있는 평활근에 선택적으로 항근성 작용 ◆ 부작용 : 고용량 사용시 시조절장애, 빈맥을 동반한 심계항진, 감각장애, 배뇨곤란, 안내압증가, 두통, 어지러움, 다행증, 졸음, 무력, 변비, 구역, 알러지성 피부반응 ◆ 금기 : 전립샘 비대, 녹내장, 요저류, 유문협착, 마비성 장폐색, 궤양성 대장염, 거대 결장증, 역류성 식도염, 중증 근무력증 ◆ 일반적 주의 ① 약에 의해 졸음이 나타날 수 있으므로 이 약 투여 중 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다. ② 주사제는 용량당 1 mmol (23 mg) 이하의 나트륨을 함유하고 있다. ◆ 태아위험도 : 자료없음 ◆ 비고 : 실온(1-30℃), 밀봉용기 보관 ◆ 상호작용 ① 브로퓸과 항히스타민제, 페노치아진계 약물, 삼환계 항우울약 및 항콜린성 약물과 같은 약물과의 병용 투여는 브로퓸의 항콜린성 효과를 증가시킬수 있으므로 병용하지 않는다. ② 부교감신경효능제는 브롬화시메트로피움의 효과를 감소시키거나 무효화시킬 수 있다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	**Aminophylline inj**	
성분/함량	**Aminophylline 250mg/10ml/A**	**기관지 천식(COPD 포함) 치료제**
효능·효과	기관지천식, 천식성기관지염, 폐기종, 만성기관지염 등 기도폐쇄성장애에 의한 호흡곤란 등 여러 증상의 완화 울혈성심부전, 심장천식(발작예방), 관상혈관장애, 체인스톡스형호흡, 신성부종	
용법·용량	250mg 을 1-2 회/일 DW 나 N/S 에 희석 5-10 분간 IV, IV infusion, (최대 : 12mg/kg/일, 투여간격 8 시간 이상)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Phosphodiesterase 를 억제하여 cAMP 분해를 방지함으로써 기관지 확장 ◆ 부작용 : 구토, 식욕부진, 복통, 설사, 두통, 불면, 단백뇨, 중추신경계 흥분, 불안, 과량 투여시 경련·섬망·혼수, 어지러움, 심계항진, 피진, 가려움, 단백뇨, 부종, 혈청 uric acid↑, AST·ALT·ALP↑, 호흡율 증가 ◆ 금 기 : 위,십이지장 궤양, Xanthine 계 약물에 부작용 or 과민증 기왕력자, 포르피린증 환자, 카페인 또는 테오브로민에 과민반응 환자, 급성 빈맥성 부정맥 환자, 심근경색 환자 ◆ 배합금기 : Atracurium besylate, Bleomycin, Ciprofloxacin, Clindamycin, Dobutamine, Epinephrine, Hydroxyzine, Insulin, Isoproterenol, Vit. B complex with C ◆ 상호작용 ① 타 Xanthine 계 약물, 중추신경 흥분제: 과도한 중추신경 자극 작용 ② Phenytoin, Carbamazepine: 상호 혈중농도 저하 ③ Lithium 의 배설 증가 ④ Propranolol 의 효과 저해 ⑤ β_2효능약, Steroid 제제, 이뇨제, 저산소증: 혈중 K 저하 악화 ⑥ β-효능약, Glucagon, 타 Xanthine 계 약물: 이 약의 효과 증강 ◆ 주의 : 간질 환자, 갑상선 기능항진증, 급성 신염, 간장애, 소아, 노인, 고혈압 환자, 비후성 심근병증, 빈맥성 부정맥, 심근경색 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비 고 : 차광보관 ◆ 과량투여시의 처치 - 소화기증상(특히 구역, 구토, 복통), 정신신경증상(두통, 불면, 불안, 흥분, 경련 등), 순환기증상(동빈맥, 심실성부정맥), 근골격증상(횡문근융해증) 및 대사이상(산/염기 장애)이 나타나는 경우 위내 내용물을 비우고 심전도를 모니터하며 체액균형을 유지 - 활성탄의 경구투여는 혈중농도를 낮추고 심한 중독의 경우 활성탄-컬럼 혈액활류를 한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Amoburofen inj	
성분/함량	Ibuprofen(IVF) 400mg/Val	해열, 소염, 진통제
효능·효과	◆ 중등도 및 중증 통증 조절을 위한 마약성 진통제의 보조요법, 해열	
용법·용량	◆ 성인(17세 이상): 이 약은 환자의 치료 목표에 부합하는 최소 유효용량을 최단기간 투여, 1일 최대 3200mg까지 가능 ① 중등도 및 중증 통증 조절을 위한 마약성 진통제(모르핀)의 보조요법: 1회 400-800mg을 필요에 따라 6시간 간격으로 30분 이상 IVF ② 해열: 1회 400mg을 필요에 따라 4-6시간 간격으로 30분 이상 IVF (환자상태에 따라 초회 400mg 투여 이후 매 4시간 간격으로 100-200mg을 투여 가능) ③ 정맥 주입 전 최종 농도가 4mg/ml가 되도록 희석	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Ibuprofen은 anti-inflammatory, antipyretic, analgesic activity arachidonic acid pathway에서 prostaglandins을 형성을 촉매하는 cyclooxygenase(COX-1과 COX-2)를 억제하여 신체조직에서 prostaglandin 합성을 억제 ◆ 부작용 : 저혈소판증, 호중성백혈구감소증, 소화계통의 질환, 고나트륨혈증, 무기폐, 부신겉질부전/ 부신피질부전증, 부종,빈혈, 상기도감염, 세균성패혈증, 요로 감염, 저칼슘혈증, 출혈, 호흡기능부족, 저혈당 장애, 피부 자극, 괴사성 장결장염, 신장질환 등 ◆ 금기 : 위장관궤양, 위장관 출혈, 심각한 혈액이상, 심한 간장애, 심한 신장애, 심한 심장기능부전, 심한 고혈압, 이 약 성분에 과민증, 아스피린이나 다른 NSAIDs에 대해 천식, 두드러기, 알레르기 반응과 같은 과민반응, 관상동맥 우회로술 전후 통증발생환자, 임신 말기 3개월 기간에 해당하는 임부, 항암요법으로 고용량 메토트렉세이트를 투여중인 환자 ◆ 태아위험도: C ◆ 비고: 실온(1-30℃), 밀봉용기 보관 ◆ 적용상의 주의 정맥 주입 전에 최종 농도가 4mg/mL 이하가 되도록 정주용 수액(0.9% NS, 5% DW, 유당첨가 링겔액)으로 희석함. IV bolus 로 투여하지 않음. 희석된 정맥주입용액은 20-25℃, 실내조명조건에서 24 시간 동안 안정함.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Antithrombin III inj	
성분/함량	Antithrombin Ⅲ, human 500 IU/V	항응고제
효능·효과	◆ 선천성 항트롬빈 III 결핍에 기인하는 혈전색전합병증의 예방 및 치료 ◆ 후천성 항트롬빈 III 결핍의 예방 및 치료 - 중독, 간염, 대상부전 간경변증 등에 의한 급성 간부전증 - 집중치료 혈장 반출법 - 패혈증, 다발성외상, 양수색전증 등에 있어서의 소모성 응혈이상증 - 혈액투석	
용법·용량	◆ 용량 ① 치료 - 초기량 : 1,000-2,000 IU/일 - 유지량 : 2,000-3,000 IU/일, 4-6 시간 간격으로 1 회에 500IU 씩 분할투여 또는 IV infusion ② 투여기간 : AntithrombinⅢ 혈장수준이 정상화되고 제반 증상이 소실될 때까지 ③ 예방 : 1,000-1,500IU/일 ◆ 소아용량(신생아) : 8 시간마다 250 IU 씩 continuous IV infusion 2-4 일간 1 일 3 회	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 항응고작용을 하는 혈장단백질로, 혈액응고계에 관여하는 serine protease 의 inhibitor, 혈액응고 인자(Thrombin, Ⅸa, Ⅺa, Ⅻa, Kallikrein)의 활성을 저해 ◆ 부작용 : 쇽, 발진, 담마진, AST ALT 상승, 구토, 오한, 발열, 두통, 흉부불쾌감, 호산구증다증 ◆ 주의 : 용혈성 실혈성 빈혈환자, 면역 부전환자, 면역억제상태 환자에 신중투여 ◆ 상호작용 : 고용량 Heparin: 출혈유발(Heparin 투여량<500 IU/hr) ◆ 금기 : 이 약의 성분에 대해 Anaphylaxis 성 쇽의 병력이 있거나 과민증의 기왕력자 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비 고 ① 2-8℃ 냉장 보관, 조제된 용액의 안정성: 48 시간(실온) ② 희석용매: 5% albumin, N/S, D5W, Lactated Ringer`s soln ③ 희석 비율(1:10) ④ 1 IU/kg 투여 시 이 약의 활성이 통상 정상치의 1% 이상 증가	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Atropine inj	
성분/함량	Atropine sulfate 0.5mg/1ml/A	진경제
효능·효과	위장관의 경련성 동통, 담관·요관의 산통, 경련성 변비, 위·십이지장궤양에서의 분비 및 운동 항진, 방실전도장애, 미주신경성 서맥, 마취전투약, 유기인 살충제·부교감신경흥분제 중독	
용법·용량	○ 성인 ◆ 황산아트로핀으로서 1 회 0.5mg 을 피하 또는 근육주사한다. 경우에 따라 정맥주사할 수 있다. ◆ 유기인 살충제 중독 ① 경증 : 황산아트로핀으로서 0.5-1mg 을 피하주사 ② 중등증 : 이 약으로서 1-2mg 을 피하 또는 근육주사하고 필요시 20-30 분 간격으로 반복주사 ③ 중증 : 이 약으로서 2-4mg 을 정맥주사하고 증상에 따라 아트로핀의 포화 징후가 나타날 때까지 반복주사 ◆ 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 평활근, 심근(미주신경) 및 각종 선세포에 있는 수용체에서 acetylcholine 과 상경적으로 작용 (Muscarine 길항효과) ◆ 부작용 : 산동, 구갈, 오심, 구토, 배뇨장애, 호흡장애, 심계항진, 두통, 습진성피부염, 어지러움, 안검결막염, 속발성녹내장, 안압상승, 발진, 혈관울혈, 부종, 삼출, 광과민, 변비 ◆ 금기 : 녹내장, 전립선비대로 인한 배뇨장애, 마비성 장폐쇄, 천식 ◆ 상호작용 ① Amantadine, Quinidine, TCA, 사환계 항우울약, 신경이완약, MAOI, Phenothiazine 계 약물, INAH 와 병용시 이 약의 항 choline 작용증강 ② 항히스타민약, 항파킨슨 약품: 이 약의 약효증강 ③ Digoxin 의 독성 증가 ④ Dopamine 길항약: 위장관 운동능 감소 ⑤ Pilocarpine, Physostigmine 등 항 cholinesterase: 이 약의 약효감소 ⑥ 시조절장애, 동공확대 등이 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계 조작을 하지 않도록 주의한다. ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 차광보관 ◆ 적용상의 주의 : 피하·근육주사시 동물실험(토끼)에서 충혈, 출혈, 변성 등의 국소장애가 나타났으므로 피하 또는 근육주사시 조직·신경 등에 영향을 주지 않도록 주의한다	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Atrovent UDV	
성분/함량	Ipratropium bromide 500mcg/2ml/EA	기관지 확장제
효능·효과	다음 질환의 기도폐쇄 장애에 의한 호흡곤란 등 여러 증상의 완화 : 기관지천식, 만성 기관지염, 폐기종	
용법·용량	◆ 간헐적 양압환기 요법기기 또는 적당한 네뷸라이저를 이용하여 투여한다. - 성인 : 이프라트로퓸브롬화물수화물로서 100~500 μg 을 1 일 4 회 흡입투여한다. - 어린이(3~14 세) : 이 약으로서 100~500 μg 을 1 일 3 회 흡입투여한다. ◆ 네뷸라이저 액은 적절한 최종 용량을 취할 수 있도록 생리식염 주사액을 이용하여 희석할 수 있다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 제 4 급 ammonium anticholinergic bronchodilator 로 기도 내경을 조절하는 미주신경 반사를 억제 FEV_1 을 증가시킴, 흡입 3-5 분후 작용이 나타나며 4-6 시간의 지속효과를 가짐 ◆ 부작용 : 구갈, 안구조절장애, 두통, 진전, 두중감, 현훈, 구역, 변비, 고미, 심계항진, 피부발진, 구내염, 위장운동장애, 과민반응, 심와부통, 가래, 요저류, 빈맥 , 과민반응(대두 등 식품 과민증 기왕력자 주의) ◆ 금기 : Atropine 과민증, 폐쇄각 녹내장, 전립선 비대증 ◆ 상호작용 ① 교감신경효능제 및 Xanthine 계 약물 : 기관지확장효과를 증가시킬 수 있음 ② 녹내장의 병력을 가지고 있는 환자에게 이 약과 β2-효능제를 동시에 투여할 경우 급성 녹내장 발병 위험을 증가시킬 수 있다 ③ 이 약과 방부제로 벤잘코늄염화물을 사용하는 크로모글리크산디나트륨을 같은 네뷸라이저에 넣어 동시에 투여할 경우 침전물이 생길 수 있으므로 병용투여하지 않는다. ④ 아트로핀 물질 (삼환계 항우울제, 아트로핀성 항히스타민제 H1, 항콜린성 항파킨슨제, 아트로핀성 진경제, 디소피라미드, 페노티아진성 신경이완제, 클로자핀): 소변축적, 녹내장의 급성 안압상승, 변비, 구강건조 등을 더 쉽게 야기하고 이상반응을 더할 수 있음 ◆ 주의 ① 안구에 분사할 때 안구합병증(산동증, 안내압증가, 폐쇄각형 녹내장, 안구통증)을 유발가능 ② 방광경 폐색 소인, 낭성섬유증 환자는 신중투여 ③ Nebulizer sol 은 Cromolycate 2Na 와 Nebulizer 에 동시 투여시 침전 가능(∵benzalkonium HCl) ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 : 흡입 5-10 분후 작용이 나타남 .	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Avaxim inj 160U	
성분/함량	Purified inactivated Hepatitis A antigen 0.5ml/Syringe	A형 간염 백신
효능·효과	◆ 만 16 세 이상 성인에서의 A 형 간염의 예방	
용법·용량	◆ 기본 면역 : 1회 0.5ml 을 삼각근(둔부 제외)에 근육주사 ◆ 추가 면역 : 기본 면역일로부터 6~12개월 후에 기본 면역과 동일한 방법으로 추가 접종	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 불활성화 바이러스 백신(inactivated virus vaccine)으로, A형 간염 바이러스 감염에 대한 면역을 유도 ◆ 부작용 : 주사부위의 홍반을 동반한 통증, 결정, 경미한 고열, 무력증, 두통, 근육통, 관절통, 위장장애 등 ◆ 금기 : 발열 및 급·만성 질환자(백신 접종 연기할 것), 본 백신의 성분, Neomycin 또는 Polysorbate 80에 과민한 환자, 본 백신에 의한 과민증의 기왕력이 있는 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 냉장(2~8℃) 및 차광 보관 ◆ 적용상의 주의 ① 이 약은 현탁액이므로 투여 전 잘 흔들어 균질한 상태로 만든 후 사용할 것	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	BCG vaccine for Percutaneous inj	
성분/함량	BCG vaccine 12mg/A (냉장)	결핵 예방 백신
효능·효과	◆ 결핵의 예방	
용법·용량	◆ 통산 용제를 가한 것을 상박외축의 중앙부에 떨어뜨려 바르고 경피접종 침을 사용하여 접종	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : BCG 생백신은 결핵균에 대해 세포 매개 면역(cell-mediated immunity)을 유도 ◆ 부작용 : 발적, 종창, 가피형성, 농포, 피부궤양, 액와 임파절 ◆ 금기 : 현저한 영양장애자, 중증 열병, 만연성 피부병 환자, 급성 및 중증의 심혈관계·신·간질환, 외상 등으로 켈로이드가 인정된자, 과거 면역부전, 임부, 다른 생백신 접종 후 4주가 경과되지 않은 자, 면역기능 이상자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 10℃ 이하 보관 ◆ 적용상의 주의 ① 현탁한 백신은 2시간 내에 사용해야 함 ② 첫 백신 접종은 6세 이전에 실시	

약품명	Beovu PFS inj	
성분/함량	Brolucizumab 19.8mg/0.165ml/Syringe	안과용제
효능·효과	신생혈관성 (습성) 연령관련 황반변성의 치료	
용법·용량	6mg(0.05ml)을 4주마다, 3회 → 이후 12주마다, 유리체내 주사로 투여	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : VEGF inhibitor: 내피세포증식, 혈관신생 및 혈관투과성 억제 ◆ 부작용 : 시력감소, 망막출혈, 포도막염, 홍채염, 유리체 박리, 망막열공, 백내장, 결막출혈, 유리체 부유물, 안구 통증, 안압증가, 결막염, 망막 색소 상피 열공, 시야흐림, 각막 찰과상, 점상 각막염 ◆ 금기 : 안구 또는 안구 주변의 감염이 있거나 감염이 의심되는 환자, 안구 내 염증이 있는 환자 ◆ 비고 ① 냉장보관(2~8℃), 직사광선을 피하고 얼리지 말 것 ② 이 약의 유리체내 주사를 위해 30 G x ½" 무균 주사바늘을 사용해야 한다. ③ 운전, 기계조작시 주의: 일시적인 시력 장애 발생	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	BetaLOC	
성분/함량	Metoprolol tartrate 100mg/T	ß-blocker
함량/단위	100mg/T	
효능·효과	고혈압, 협심증, 빈맥성부정맥(특히 상실성부정빈맥)	
용법·용량	◆ 고혈압 1) 초기량 : 100mg/일 1-2 회 분복(1 회시 아침복용) 2) 유지량 : 100-200mg/일 1-2 회 분복(최대용량: 400mg/일) ◆ 협심증 : 1 회 50-100mg 씩 2-3 회/일 ◆ 빈맥성부정맥 : 1 회 50mg 을 2 회/일 (필요시 300mg 까지 증량하고 2-3 회 분복) ◆ 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.	
사용상의 주의사항	◆ 소아용량 : 1-5mg/kg/일을 2 회 분복 ◆ 약리작용 : β_1-adrenergic bloker 로 심박출량, 심박동율, 혈압저하시킴 체위성저혈압이나 전해질의 불균형이 나타나지 않음 ◆ 임상응용 : 고혈압, 협심증, 빈맥성 부정맥(특히 상실성 부정맥) ◆ 부작용 : 발진, 소양증, CHF, 서맥, 말초순환장애, 천식(+) 발작, 두통, 불면, 졸음, 위장장애, 부종, 건선, 탈모, 발한, 이명, TG CPK 상승, 체중증가, AST ALT 상승 ◆ 금기 : 당뇨병성 ketoacidosis, 대사성 acidosis, 고도의 서맥, 방실(2°, 3°) 및 동방블록, 심인성 쇽, 울혈성 심부전, 임부, 중증의 저혈압, 동기능 부전증후군환자, 폐고혈압에 의한 우심부전 환자, 중증의 말초순환장애 환자 ◆ 상호작용 ① Lidocaine 의 혈중농도 상승 ② Cimetidine, Hydralazine, Alcohol: 이 약의 혈중농도 상승 ③ 혈당강하제의 작용 증강 ④ 맥각알칼로이드: 말초순환장애 ⑤ Indomethacin: 혈압강하작용 감소 ⑥ Rifampicin: 이 약의 혈중농도 감소 ◆ 주의 ① 기관지 천식, 특발성 저혈당, 심한 간 신장애, 말초순환장애, 크롬친화세포종(α-blocker 를 병용), CHF 가 일어날 수 있는 환자는 신중투여 ② 기계조작 ③ 수술전 48 시간에 투여중지 ④ 갑상선 기능항진증의 증상 masking 가능 ◆ 태아위험도 : C(Manufacturer), D(2nd, 3rd trimester-expert analysis) ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 과량투여시 증상은 보통 20 분~2 시간 이내에 나타난다. 주로 심혈관계 장애(저혈압, 동서맥, 방실블록, 심부전, 심인성 쇽, 심정지), 기관지경련, 의식장애, 구역, 구토, 청색증, 저혈당증, 저칼륨혈증이다. ② 처치 : 생체지수를 모니터링할 수 있도록 입원시키는 것이 바람직하다. 보통 다음의 처치를 한다. - 최토, 위세척 - 현저한 저혈압, 서맥, 심부전에는 β-효능약(염산이소프로테레놀)으로 효과가 보일때까지 2~5 분 간격으로 정맥주사하고, 효과가 없을 경우에는 황산아트로핀 0.5~2mg 을 정맥주사한다. 특히 필요에 따라 염산도파민, 염산도부타민, 노르에피네프린을 투여한다. 글루카곤 1~5mg(또는 10mg) 정맥주사가 유효한 경우도 있다. ③ 기관지경련에는 β-효능약(황산살부타몰 등) 또는 아미노필린을 정맥주사한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Betamethasone inj	
성분/함량	Betamethasone sodium phosphate 4mg/1ml/A	부신호르몬제
효능·효과	부신호르몬제로서 내분비 장애, 류마티스성 장애, 교원성 질환, 피부 질환, 알레르기성 질환, 안과 질환, 위장관 질환, 혈액 질환, 종양성 질환, 부종성 질환, 신경계 질환 등에 사용	
용법·용량	① IV, IM: 2-8mg/회, 3-6hr 마다 주사 ② IVF: 2-10mg/회, 1-2 회/일, N/S 또는 DW 에 희석하여 주사 ③ 관절강내: 0.1-4mg 을 관절의 대소에 따라 조절 ④ 연조직내: 0.4-5mg ⑤ 구결막하, 구후: 0.4-2mg ⑥ 척수강내, 흉강내 주입: 1-4mg 을 주 1-3 회 ⑦ 난관내 주입 : 0.4-1mg	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 단백질 합성 속도 조절, polymorphonuclear leukocytes 와 fibroblasts 의 유주 억제, 모세관 투과성 감소, 염증반응 억제 ◆ 부작용 : 감염증, 속발성 부신부전, 당뇨병, 월경이상, 성장억제, 부신피질자극, 호르몬 분비억제, Cushing's syndrome, 소화성궤양, 췌장염, 설사, 구역 구토, 식욕항진, 식욕부진, 정신장애, 불면, 경련, 골다공증, 근육통, 관절통, 부종, 혈압상승, 알칼리혈증, 안압항진, 백혈구 증가, 혈전증, 여드름, 다모, 탈모, 과민증, 발열, 피로감 ◆ 금기 : 유효한 항균제가 없는 감염증, 전신 진균 감염증 환자, 관절강내, 점액낭내, 건조내 또는 건주위에 감염증, 관절강내가 불안정한 환자, 단순포진, 대상포진, 수두 환자, 생백신 투여환자 ◆ 상호작용 ① Barbiturate, Phenytoin, RFP, Carbamazepine, Primidone, Aminoglutethimide, Rifabutin: 이 약의 작용 감소 ② NSAIDs: 위장관 궤양의 위험 증가 ③ 항응고제, 경구혈당강하제의 작용 감소 ④ 이뇨제, Amphotericin B: 저 K 혈증 ⑤ CsA 혈중농도 상승 ⑥ Anticholinergic agent 병용시 안구내압 상승 ⑦ Aspirin 의 신청소율 증가 ◆ 주의 : 결핵성 질환, 단순포진성 각막염 환자, 후낭하 백내장 환자, 전해질이상, 고혈압 환자, 혈전증 환자, 최근 장문합술을 받은 환자, 신부전, 울혈성 심부전 환자, 갑상선기능저하증 환자, 간경변 환자, 급성 심근경색을 일으킨 적이 있는 환자, 소화성 궤양 환자, 정신병 환자, 중증 골다공증 환자, 녹내장 환자, 감염증 환자, 골다공증 환자, 지방색전증 환자, 중증 근무력증 환자, 바이러스성 결막, 각막질환, 결핵성안질환, 진균성안질환 및 급성화농성 안질환 환자, 당뇨병 환자, 간질환자, 골다공증, 고혈압, 울혈성심부전, 심각한 감정이상, 당뇨병, 결핵, 녹내장, 간장애, 심부전, 간질, 소화성 궤양의 병력 ※ 첨가제로 아황산수소나트륨 함유(천식유발) ◆ 태아위험도 : C ◆ 적용상의 주의사항 : 정맥내 투여에 의해 혈관통, 혈전 또는 정맥염을 일으킬수 있으므로 이것을 예방하기 위해 주사부위, 주사방법 등을 충분히 고려하여 주사속도는 매우 서서히 주입한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Betasin inj	
성분/함량	Labetalol HCl 100mg/20ml/A	고혈압치료제
효능·효과	임신성고혈압을 포함한 응급성고혈압, 급성심근경색에 의한 고혈압, 마취시 혈압강하	
용법·용량	◆ 성인 이 약은 입원환자의 정맥주사용으로 사용하며, 이때 환자를 배위 또는 좌측위 상태로 눕혀서 정맥주사한다. 이 약 정맥주사 후 3 시간 이내에 일어서면, 심한 기립성 저혈압이 나타날 수 있으므로 주의한다. ① 고혈압 - IV bolus: 신속 혈압강하시 50mg 을 최소 1 분에 IV (필요시 5 분마다 반복투여, 최대 200mg 까지 투여가능) (on set 은 투여 후 5 분이내, 작용지속시간은 6-18 시간) - IV infusion:1mg/ml 의 농도가 되도록 주사액과 혼합사용 (N/S, D5W) ② 임신성 고혈압: 초기량은 20mg/hr 로 IV infusion : 160mg/hr 도달할 때까지 30 분마다 용량을 2 배씩 증가시킴 ③ 급성 심근경색증에 의한 고혈압 : 초기량 15mg/hr 로 IV infusion → 120mg/hr 까지 점차적 증량 ④ 기타 원인에 의한 고혈압: 2mg/min 속도로 주입후 투여중지(상용량: 50-200mg) →혈압조절시 100mg 을 2 회/일로 경구전환 ⑤ 마취시 혈압강하 - 10-20mg 을 IV(Thiopental, Halothane 병용시) - 25-30mg 사용, 5 분후 5-10mg 씩 증량가능(Halothane 병용 불가능시)	
사용상의 주의사항	◆ 부작용 ① 이 약 투여시 3 시간 이내에 일어서면 현저한 체위성 저혈압이 나타남 ② 현기증, 두피이상감, 두통, 불면, 우울, 졸음, 마비, 진전, 발진, 가려움, 호흡곤란, 오심, 기립성 저혈압, 어지러움, 비충혈, 급성요폐, 배뇨장애, 건선, 시각장애, 간기능 수치상승, 발한, 오한 ◆ 금기 ① 제 2, 3 도의 심차단, 심인성 쇽, 장기중증의 저혈압 또는 서맥, 폐고혈압에 의한 우심부전환자, 심부전환자, 동방차단환자 ② 급성 심근경색에 의한 고혈압환자 중 말초혈관 수축으로 심박출량이 감소된 환자 ③ 당뇨병성 케톤산증, 대사성 산증 ④ 기관지 천식 또는 폐쇄성 기도질환 ◆ 상호작용 ① 교감신경억제제(Reserpine 등) 병용시 작용증강 ② 혈당강하제의 작용증강 ③ 마취제에 의한 이 약의 작용증가 ④ Disopyramide, Procainamide, Propafenone, Amiodarone 과도한 심기능 억제 ⑤ NSAIDs :혈압강하 효과 감소 ⑥ Digoxin 의 효과 증강 ⑦ 중탄산나트륨 주사액 4.2%(w/v) 배합 금기 ◆ 주의 ①저용량에서 시작하고, 심기능검사를 정기적으로 할 것 ②투여중지시 서서히 감량(∵협심증의 악화 및 심근경색) ③크롬친화세포종 이외의 외과 수술 24 시간 전 투여하지 말 것 ④기계조작 주의 ⑤기관지경련 시 β_2 agonist(Salbutamol 고용량) 흡입, 필요시 Atropine 1mg IV ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 차광보관 ◆ 과량투여시의 처치 ① 과량투여시 환자의 하체를 높게 하여 눕히며, 복용 후 2-3 시간 이내에는 위세척이나 최토를 시행 ② 심부전에는 강심배당체와 이뇨제를, 기관지연축에는 β_2효능성 흡입제를 투여 ③ 서맥 완화를 위해서는 아트로핀 0.25-3mg 을 정맥 투여 ④ 혈액순환 개선을 위해서는 최초에 노르아드레날린 5-10mcg 을 정맥투여하고 반응에 따라 반복투여 ⑤ 상당히 과량을 투여한 경우에는 글루카곤을 정맥투여하는 것이 바람직 초회에 글루카곤 5-10mg 을 포도당이나 생리식염주사액에 녹여 정맥 주사한 후 5mg/시간 속도로 정맥내 주입하거나 또는 심박출량 유지에 충분한 양을 투여한다. 정맥통과조율(transvenous pacing)이 요구될 수 있다.	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Binicapin inj	
성분/함량	Nicardipine HCl 5mg/5ml/A, 10mg/10ml/A	고혈압치료제
효능·효과	수술시 이상고혈압의 구급처치, 응급성 고혈압증	
용법·용량	◆ 수술시 이상고혈압의 구급처치 ① IV infusion: D5W, N/S 에 0.1-0.2mg/ml 로 희석 (속도: 2-10 μg/kg/분) ② IV: 10-30 μg/kg(급속히 혈압을 내릴 경우) ◆ 응급성 고혈압증 : IV infusion: N/S, D5W 에 희석하여 0.1-0.2mg/ml (속도: 0.5-6 μg/kg/분)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : CCB 로서 혈관 평활근 세포 속으로의 Ca^{2+} 유입을 억제하여 혈관 확장작용, c-AMP, Phosphodiesterase 의 억제작용 ◆ 부작용 : 마비성 장폐색증, 저산소혈증, 폐수종, 호흡곤란, 협심증, 빈맥, 동계, 안면홍조, 전신권태감, 심전도변화, 간기능장애, BUN, SCr 상승, 구역, 구토, 두통, 체온상승, 혈청 K^{+}상승 등 ◆ 금기 ① 두개내 출혈로 지혈되지 않은 자 ② 뇌졸증 급성기로 두개내압이 항진된 자 ③ 급성신부전, 급성 중증심근경색, 대동맥판 협착증환자 ④ 이완기 혈압강하가 심근 산소공급 증가보다 안 좋은 환자 ◆ 상호작용 ① 혈압 강하제 효과 증상 ② Cimetidine: 이 약 혈중농도 상승 ③ Digoxin 의 혈중농도 상승 ④ Fentanyl: β-blocker 와 병용시 저혈압 ⑤ CSA, Tacrolimus 의 혈중농도 상승 ⑥ Phenytoin 의 혈중농도 상승 ⑦ Dantrolene: 심실세동 가능성 있음 ⑧ NTG: 방실블럭 유발 높음 ⑨ Rifampicin: 이 약의 혈중농도 감약 ⑩ α-1 차단제(tamsulosin 등), Baclofen: 혈압강하 효과증대 ◆ 태아위험도 : C ◆ 주의 : 간장애(∵ 간에서 대사), 신장애(∵ 급격한 강압으로 인한 신기능 저하유발) ◆ 비고 : 차광 ◆ 적용상의 주의 ① 점적정주할 때 배합하는 수액에 따라서는 pH 가 높다거나 하는 원인으로 이 약이 석출될 수 있으므로 주의 ② 배합 가능 수액 : 생리식염주사액, 5% 포도당주사액, 10% EL-3 호, 5% 과당주사액, KN 보액 1A, KN 보액 4A, 솔리타(Solita)-T1 호, 솔리타-T3 호, 피지오졸(Physiosol)·3 호, 피지오졸·4 호, 포타콜(Potacol)R, 15% 만니트(Mannit)주사액 TM, 만닐 F-2 호, 락텍(Lactec)D 주, 링겔액, 링겔당주사액, 10w/v%레오마크로덱스(Rheomacrodex) ③ 배합변화를 일으키는 약물 : Furosemide, potassium canrenoate, aminophylline, bucladesine sodium, amrinone, lidocaine, iohexol, iopamidol, tranexamic acid, carbazochrome sodium sulfonate, heparin sodium, urokinase, tisokinase, alteplase, fosfomycin, cefotiam hydrochloride, cefzonam sodium, imipenem, flomoxef sodium, sodium bicarbonate ④ 염류 용액에서는 니카르디핀이 관류장치의 소성재로 흡수될 위험이 있음.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Bosmin sol	
성분/함량	Epinephrine 100mg/100ml/Btl	혈관수축제
효능·효과	◆ 기관지 천식 발작의 완화, 국소 부위의 출혈 (외상, 코, 입, 인후두 점막의 출혈)	
용법·용량	◆ 기관지천식 : 0.1% 용액을 5-10배로 희석해서 흡입한다(1회 투여량은 0.3mg 이내). 2-15분이 지나도 효과가 불충분할 경우에는 한번 더 반복한다. 단, 연속 사용이 꼭 필요한 경우에는 4-6시간의 간격을 두어 사용한다. ◆ 국소 출혈 : 0.1% 용액을 5-10배로 희석해서 직접 도포하거나 분무한다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용: α와 β adrenergic receptor에 모두 작용하는 sympathomimetic catecholamine · α adrenergic- 혈관 수축을 유발하여 anaphylactic reactions 동안 혈관확장 및 혈관 투과율 증가에 따른 저혈압과 세포내액 부피의 소실에 효과적으로 대응 · β adrenergic- 기관지평활근의 이완을 일으켜 천명과 호흡곤란 완화 ◆ 부작용 1) 정신신경계 : 때때로 두통, 수지진전, 졸음이 나타나며, 또한 드물게 어지러움, 신경과민, 불면증, 발한 등 2) 감각기계 : 매우 드물게 인두염, 비충혈 3) 소화기계 : 때때로 식욕부진, 소화불량, 구역, 구토 등 4) 순환기계 : 때때로 심계항진, 맥박증가, 혈압변동이 나타나며, 드물게 부정맥, 고혈압 등 5) 호흡기계 : 드물게 기관지 경련, 기침, 기관지염, 천명, 흡입시 기도자극증상 등 6) 과민반응 : 매우 드물게 피부 발진, 혈관 부종, 두드러기, 구강인두 부종, 저혈압, 허탈 등 7) 눈 : 때때로 결막, 안검, 눈 주위 등의 과민증상, 결막충혈, 안통 등 8) 전신증상 : 폐부종 등 전신성 증상이 발현될 수 있으며, 이러한 경우에는 투여를 중지 ◆ 금기: 폐쇄각 또는 전방이 얇아서 안압 상승의 요인이 있는 환자(안주위부 등에 사용시 폐쇄각 녹내장 환자의 발병을 촉진할 수 있다) ◆ 상호작용 1) 할로탄 등의 할로겐 함유 흡입마취제- 빈맥, 심실세동, 급성 폐부종 발현 위험성 증가 2) 항정신병약(리스페리돈, 페노치아짓계 약물, 뷰틸로페논계 약물 등), 알파 차단제- 혈압상승작용 반전(저혈압) 3) 이소프레날린 등의 카테콜아민계 약물, 프로테레놀 등의 에피네프린 효능약- 심부정맥, 심정지 가능 (소생 등의 위급 상황 이외의 경우에는 병용투여하지 않음) 4) 프로프라놀롤 등의 비선택성 베타차단제- 혈압상승, 서맥 발생 가능 5) 인슐린등의 혈당강하제- 혈당강하제의 작용 감소 6) MAO 저해제, 삼환계 항우울약- 이 약의 혈관계에 대한 작용이 증강 ◆ 태아위험도 (Category C) : 태아의 산소결핍을 초래할 수 있으므로 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다. ◆ 비고 : 차광 보관 ◆ 적용상의 주의 1) 주사하지 않는다. 2) 눈에는 사용하지 않는다. 3) 흡입이외의 방법으로 사용시 의사 및 약사의 지시에 따라 사용하도록 한다. 4) 변색에 의한 효력 감퇴는 없지만, 혼탁해진 경우에는 사용하지 않는다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Botox inj	
성분/함량	Clostridium botulinum A Toxin 50unit/V	Toxin 류
효능·효과	◆ 12 세 이상 성인에 있어서 양성 본태성 눈꺼풀경련이나 제 7 신경 장애를 포함한 근긴장 이상과 관련된 사시 및 눈꺼풀경련의 치료 ◆ 2 살 이상의 소아뇌성마비 환자에 있어서 경직에 의한 첨족 기형(dynamic equinus foot deformity)의 치료 ◆ 경부근긴장이상(cervical dystonia)의 징후와 증상의 치료 ◆ 18 세 이상 성인에 있어서, 국소치료에 저항성을 보이고 일상생활의 활동을 방해하는, 지속적인 중증도 원발성 겨드랑이 다한증의 치료 ◆ 근육경직 : 18 세 이상 성인의 뇌졸중과 관련된 상지 경직 ◆ 18 세 이상 65 세 이하의 성인에 있어서 눈썹주름근(corrugator muscle) 그리고/또는 눈살근(procerus muscle) 활동과 관련된 중등도 내지 중증의 심한 미간 주름의 일시적 개선 ◆ 성인 만성 편두통환자에서의 두통 완화(하루에 4 시간 이상 지속되는 두통이 한달에 15 일 이상 지속되는 경우) ◆ 방광기능장애 - 18 세 이상 성인에서 항콜린제 치료가 어렵거나 적절히 조절되지 않는, 신경인성 배뇨근 과활동성(예. 척수 손상, 다발성 경화증)으로 인한 요실금의 치료 - 18 세 이상 성인에서 항콜린제 치료가 어렵거나 적절히 조절되지 않는, 절박성 요실금, 절박뇨, 빈뇨의 증상이 있는 과민성 방광의 치료	
용법·용량	◆ 각 적응증에 따라 용량 다양 (의사의 지시에 따름)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Cholinergic nerve 말단에 존재하는 high-affinity recognition sites 에 presynaptically 결합하여 acetylcholine 의 방출을 감소시킴으로써 neuromuscular blocking effect 를 나타냄 ◆ 부작용 : 삼킴곤란, 폐렴 그리고/또는 심각한 무기력, 피부발진, 가려움증, 알러지 반응, 주사부위 통증/당김/종창/열감 등 ◆ 금기 : 이 약에 과민증, 전신성 신경근접합부 장애 환자, 경부근긴장이상에 사용시 중증의 호흡기능장애 환자, 임신 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 주사예정부위 감염이 있는 환자 ◆ 상호작용 ① Aminoglycoside 계 항생제 또는 근육, 신경전달을 방해하는 약물(투보쿠라린계 근이완제)와 병용시 Botox 약효 증가함. ② Aminoglycoside 계 항생제 또는 spectinomycin 과의 계속적인 병용은 금기임 ③ Botox 투여 환자에 polymyxin, tetracycline, lincomycin 사용은 신중할 것 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 냉장(2~8℃) 보관 ② 용해 시킨 경우 24 시간 동안 냉장(2~8℃) 보관 가능	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

<table>
<tr><td>약품명</td><td colspan="2">Brevibloc inj</td></tr>
<tr><td>성분/함량</td><td>Esmolol HCl 100mg/10ml/V</td><td>부정맥 치료제</td></tr>
<tr><td>효능·효과</td><td colspan="2">다음 경우의 상실성빈맥의 치료
- 수술전·후 또는 기타 긴급상황에서 심방세동 및 심방조동 환자에 대한 심실율의 신속한 조절
- 비대상성동빈맥에서 빠른 심박수의 조절</td></tr>
<tr><td>용법·용량</td><td colspan="2">◆ 초기량은 500mcg/kg 으로 1 분간 IV 후 유지량은 50mcg/kg/분을 4 분간 IV →적절한 효과가 5 분이내 나타나지 않으면 1 분간 부하용량 반복투여 후 4 분간 유지량 100mcg/kg/분을 투여, 유지량 50-200mcg/kg/분까지 투여
◆ 적절한 심박수와 safety end-point 에 도달하면 유지량을 5mcg/kg/분 또는 이하로 투여
<table>
<tr><td>대체약물</td><td>용 량</td></tr>
<tr><td>염산프로프라놀롤</td><td>1 회 10-20mg 4-6 시간마다 경구투여</td></tr>
<tr><td>디곡신</td><td>1 회 0.125-0.5mg 6 시간마다 경구투여또는 정맥주사</td></tr>
<tr><td>베라파밀</td><td>1 회 80mg 6 시간마다 경구투여</td></tr>
<tr><td>퀴니딘</td><td>1 회 200mg 2 시간마다 경구투여</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>사용상의
주의사항</td><td colspan="2">◆ 약리작용 : β_1-selective adrenergic blocker(Ultra-short acting)
◆ 임상응용 : Supraventricular tachycardia(aterial fibrillation/flutter, 비대상성 동빈맥에서 빠른 심박수조절)
◆ 부작용 : 저혈압, 발한, 현기증, 졸음, 피로, 오심, 구토, 요저류, 창백, 홍조, 서맥, 착란, 기관지경련
◆ 금기 : 동서맥, 1 도 이상의 심블록, 심인성 쇽, 명백한 심부전환자
◆ 배합금기 : Sodium bicarbonate
◆ 상호작용
① Digoxin: 혈중농도 10-20%증가 ② Morphine: 이 약의 혈중농도 상승(46%)
③ Verapamil: 48 시간이내 병용금지 ④ succinylcholine: 신경근차단시간 증가(5 분->8 분)
◆ 주의: 저혈압, 심부전, 기관지천식, 당뇨, 저혈당 환자, 수액제에 희석한 후 다른 약물과 혼합
◆ 태아위험도 : C
◆ 비고
① 심혈관계 질환을 가진 환자의 비심장수술시에는 bolus dose 와 유지량 인정
② 일반환자의 마취 및 수술중 빈맥
③ 동결이 제품에 나쁜 영향을 주지 않으나 상승된 온도에 노출은 피하는 것이 바람직
◆ 과량투여시의 처치
: 과량투여시 심장마비, 서맥, 저혈압, 전기-기계적 분리, 의식상실을 야기시킬 수 있음
① 서맥 : 아트로핀 또는 기타 항콜린약물을 투여한다.
② 기관지경련 : β_2효능약 또는 테오필린 유도체를 정맥투여한다.
③ 심부전 : 이뇨제 또는 디기탈리스제제를 정맥투여하며 부적절한 심장 수축으로 인한 쇽의 경우에는 도파민, 도부타민, 이소프로테레놀 또는 암리논을 정맥투여한다.
④ 증후성 저혈압 : 수액류 또는 혈압상승제를 정맥투여한다.</td></tr>
</table>

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Bridion inj	
성분/함량	Sugammadex Na 200mg/V	자율신경제
효능·효과	◆ Rocuronium 또는 Vecuronium 에 의해 유도된 신경근 차단의 역전	
용법·용량	◆ 이 약은 정맥주사(Bolus)로 단회 투여 ◆ 성인 1) 일반적인 역전 - 신경근 차단 상태로부터 강직 후 연축반응수가 1~2회 나타날 때 : 1회 4mg/kg IV - 자발적 회복에 접어들었을 때 : 1회 2mg/kg IV 2) Rocuronium 투여 후 신속한 역전 : Rocuronium 투여 3분 후 이 약 16mg/kg 1회 IV 3) 이 약 투여 후 Rocuronium 또는 Vecuronium 재투여 : 이 약(최고 4mg/kg) 투여 후 재투여 대기 시간은 다음과 같음	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Rocuronium, Vecuronium 과 복합체를 형성하여 neuromuscular junction에 있는 nicotinic receptor에 결합할 수 있는 neuromuscular-blocking agent의 양을 감소시켜 rocuronium, vecuronium에 의해 유도된 neuromuscular blockade 역전 시킴 ◆ 부작용 : 과민반응(아나필락시스, 홍조, 두드러기, 홍반성 발진, 중증의 저혈압, 빈맥, 혀부종, 인두부종 등), 마취 합병증(마취처치 또는 수술 중 사지 또는 몸의 움직임, 기침, 찡그림 등), 마취 동안 원하지 않는 각성상태 등 ◆ 금기 : 이 성분에 과민증이 있는 환자 ◆ 상호작용 ① Toremifen : 신경근 차단 상태에서 회복의 지연 또는 신경근 차단의 재발 나타날 수 있음 ② 경구용 호르몬성 피임제 : 피임제의 유효성이 감소할 수 있음 ③ Fusidic acid: 수술 전 정맥 투여 시 신경근차단 회복되는 시간이 지연될 수 있다. ◆ 비고 ① 차광 보관 ② 2~30℃ 보관 ③ 희석 후 2~25℃ 안정성은 48시간동안 유지 ◆ 과량투여시의 처치 : 고유량(high-flux) 혈액 투석법으로 제거 가능 ◆ 적용상의 주의 ① 0.9% 염화나트륨용액, 5% 포도당용액, 0.45% 염화나트륨용액 및 2.5% 포도당용액, 유산화링거액 (Ringer's lactate solution), 링거액, 5% 포도당과 0.9% 염화나트륨 혼합 용액 이 주입되고 있는 라인을 통해 이 약을 투여할 수 있음 ② ① 의 약을 제외한 다른 약과 혼합되어서는 안됨 ③ Verapamil, Ondansetron, Ranitidine 과의 물리적 배합금기 보고됨	

대기시간	투여 용량
5 분	Rocuronium 1.2 mg/kg
4 시간	Rocuronium 0.6 mg/kg 또는 Vecuronium 0.1 mg/kg

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	$CaCl_2$ inj 3%	
성분/함량	Calcium chloride 600mg/20ml/A	무기질제제(칼슘)
효능·효과	저 칼슘혈증에 의한 테타니 또는 그 관련 증상, 마그네슘중독	
용법·용량	◆ 0.4-1g 을 1 회/일, 매우 천천히 IVF(Ca^{2+}: 0.68-1.36mEq/min) ① Hyper-K, Hypo-Ca, Mg toxicity, Ca-antagonist toxicity : 2-4mg/kg, 필요시 매 10 분마다 반복가능 ② Hypo-Ca tetany : 1g 을 10-30 분이상 투여, 6 시간후 반복가능 ③ Hypo-Ca : 500mg-1g(7-14mEq)/dose, 필요시 4-6 시간마다 반복가능 ④ Citrated blood transfusion 으로 인한 Hypo-Ca : Citrated blood 500ml 당 200-500mg ◆ 소아용량 ① Hyper-K, Hypo-Ca, Mg toxicity, Ca-antagonist toxicity : 20mg/kg, 필요시 10 분내 반복가능 ② Hypo-Ca tetany : 10mg/kg(0.5-0.7mEq/kg)를 5-10 분이상 투여하고 6-8 시간 후 반복가능(최대: 200mg/kg/일) ③ Hypo-C a: 10-20mg/kg/dose (infant <1mEq, children 1-7mEq), 필요시 4-6 시간마다 반복가능 ④ Citrated blood transfusion 으로 인한 Hypo-Ca : 수혈된 혈액 100ml 당 0.45mEq 의 Ca 투여	
사용상의 주의사항	◆ 임상응용 : Ca 보급제(저 Ca 혈증성 tetany, Mg 중독) ◆ 부작용 : 근육통, 관절통, 골격근이완, 식욕부진, 체중감소, 변비, 결석, 구토, 구역, 위통, 말초혈관이완, 혈압강하, 심박동불규칙, 산증, 고 Na 혈증, CHF, 부종, 권태, 홍조, 졸음, 심계항진, 발한, 피부발진 ◆ 금기 : 심부전증, 강심배당체 투여중인 환자, 고 Ca 혈증□신결석증의 병력이 있는 고 Ca 뇨증 환자, 유육종증, 신질환, 신결석, 중증의 신부전, 저단백혈증 환자 ◆ 상호작용 ① Digoxin 의 작용증강→ 병용금기 ② 비탈분극성 근이완제(Pancuronium, Vecuronium)의 근이완작용 감소 ③ 자궁수축제의 작용증강→ 병용금기 ④ 항 Aldosterone 제, Triamterene: 고 Ca 혈증 유발 ⑤ Tetracycline 의 효과 반감→ 병용금기 ◆ 주의 ① 갑상선기능 항진증 환자, 활성형 Vit.D 제제 복용중인 환자에 신중투여 ② SC 및 IM 금지 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 탄산, 구연산, 수산, 인산, 주석산염, 은염, 납염, Ceftriaxone 과 혼합시 침전 생성 ◆ 적용상의 주의 ① 정맥주사에만 사용하며 주사시 혈관밖으로 주사액이 누출되지 않도록 주의한다(특히 신생아 또는 영·유아). ② 급속히 정맥주사하는 경우 심장성 실신 의 증상이 나타날 수 있으므로 천천히 주사한다. ③ 정맥내 주사에 의해서 심계항진, 서맥, 혈압변동, 열감, 홍조, 발한 등이 나타날 수 있다. ④ 탄산, 구연산, 수산, 인산, 황산, 주석산의 염류, 은염, 연(鉛)염, 세프트리악손등 여러 가지 성분과 혼합할 경우 침전이 생기므로 혼합하지 않는다. ⑤ 에탄올에 의해서 침전이 생기므로, 에탄올로 소독한 주사기는 사용하지 않는다. ⑥ 투여 전 : 한냉기에는 체온정도로 따뜻하게 하여 사용한다. 개봉직후 바로 사용하고, 잔액은 사용하지 않는다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Calcium gluconate inj 10%	
성분/함량	Calcium gluconate 2g/20ml/A	무기질제제(칼슘)
효능·효과	저칼슘혈증에 의한 테타니 또는 그 관련 증상, 두드러기, 고칼륨혈증, 마그네슘 중독	
용법·용량	0.4~2g 을 분당 0.68~1.36mEq 의 속도로 정맥주사, 연령 및 증상에 따라 적절히 증감	
사용상의 주의사항	◆ 임상응용 : 저 Ca 혈증에 의한 Tetany, 두드러기, 고 K 혈증, Mg 중독 ◆ 부작용 : 식욕부진, 오심, 구역, 권태, 변비, 위통, 홍조, 발한, 말초혈관이완, 부종,심박동불규칙, 산증, 골격근이완, 식욕부진, 체중감소, 근육통, 피부발진, 결석, 고 Na□Ca 혈증, 신결석, 구토, 졸음, 저혈압, 관절통, CHF, 혈압강하 ◆ 금기 : 강심배당체 투여중인 환자, 고 Ca 혈증, 신결석증의 병력이 있는 고 Ca 뇨증, 유육종증, 신질환, 신결석, 저단백혈증, 중증의 신부전 ◆ 상호작용 ① Digoxin 의 작용증강→ 병용금기 ② 비탈분극성 근이완제(Pancuronium, Vecuronium)의 근이완작용 감소 ③ 자궁수축제의 작용증강→ 병용금기 ④ 항 Aldosterone 제, Triamterene: 고 Ca 혈증 유발 ⑤ Tetracycline 의 효과 반감→ 병용금기 ◆ 주의 : 활성형 Vit.D 제제 복용환자, 고 Ca 혈증이 나타나기 쉬운 환자, 갑상선 기능항진증, 심장□순환기능 장애 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① Ethanol 에 의해 침전 생성 ② Citrate, Carbonate, Phosphate, Sulfate, Tartrate 에 의해서 침전유발 ③ 급속히 IV 하는 경우 심계항진, 서맥, 혈압변동, 열감, 홍조, 발한, 부정맥,실신,심박동정지등의 증상이 나타날수있으므로 천천히 주사 ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 고칼슘혈증, 식욕부진, 구역, 구토, 변비, 근력저하, 다음, 다뇨, 전신증상 등이 나타나고, 심한 중독이 되면 부정맥, 의식장애가 나타날 수 있다. ② 처치 : 이 약과 비타민 D 제제의 투여를 중지하고, 생리식염주사액 등의 보액, 푸로세미드, 엘카토닌, 또는 칼시토닌 등을 투여한다. ◆ 적용상의 주의사항 ① 정맥주사에만 사용하며 주사시 혈관밖으로 주사액이 누출되지 않도록 주의한다.(특히 신생아 또는 영,유아) ② 정맥내 주사에 의해서 심계항진, 서맥, 혈압변동, 열감, 홍조, 발한 등이 나타날 수 있다. ③ 소아에 투여할 경우 두피정맥(Scalp vein)으로 투여하지 않는다. ④ 결정이 석출된 제품은 사용하지 않는다. ⑤ 에탄올에 의하여 침전을 생성하므로 에탄올로 소독된 주사기는 사용하지 않는다. ⑥ 근육주사는 통증, 종양, 농 등을 형성할 수 있으므로 근육주사하지 않는다. ⑦ 구연산, 탄산, 인산, 황산, 주석산염 등 여러 가지 성분이 혼합되어있는 약과 섞어서 주사하지 않는다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Carmine inj	
성분/함량	Indigocarmine 40mg/5ml/A	검사용 시약
효능·효과	신기능검사	
용법·용량	◆ 20-40 밀리그람을 정맥주사 후 방광경으로 처음 배설기간을 측정한다. ※ 정산인의 처음 배설기간은 3-5 분이고 늦어도 10 분이내면 기능이상은 아니다. ◆ 신장애가 있는 경우에는 처음 배설기간이 지연된다. ◆ 이밖에 색소가 뇨증 배설 최고농도에 도달하는 시간 (정상 5-7 분), 배설지속기간(정상 90 분)을 측정하는 경우도 있다.	
사용상의 주의사항	◆ 다음 환자에는 투여하지 말 것 : 본제에 대해서 과민증의 기왕력이 있는 환자 ◆ 다음 경우에는 신중히 투여할 것. ① 알레르기 증상이 있는 환자 ② 고령자 ⑤ 고혈압의 환자 ◆ 일반적 주의 : 주입에서 검사 종료까지 환자를 옆으로 눕히거나 않히는 등 안정하게 관찰을 충분히 한다. ◆ 부작용 ① 쇽: 드물게 쇽이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 한다. 이와 같은 증상이 나타났을 경우에는 중지하고 적절한 조치를 취한다. ② 과민증 : 발진 등의 과민증상이 나타날 수 있다. ③ 순환기 : 혈압 상승, 서맥등의 증상이 나타날 수 있다. ④ 소화기 : 오심, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다. ◆ 임신부, 수유부에의 투여 - 임신 중이거나 수유중의 투여에 있어서는 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임산부 또는임신 가능성이 있는 부인이나 수유 중의 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단될 경우에만 투여한다. - 앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입시 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히, 어린이, 노약자 사용사에는 각별히 주의 할 것. ◆ 비고 차광밀봉용기, 실온(1~30℃) 보관	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	CD.Jevax inj	
성분/함량	Japanese encephalitis vaccine live attenuated 0.5ml/V	일본뇌염 백신 (생백신)
효능·효과	◆ 일본뇌염의 예방	
용법·용량	◆ 멸균주사용수로 용해하여 0.5ml 를 피하주사 ◆ 접종일정 - 1차 : 접종개시일 - 2차 : 1차 접종일로부터 1년 후 - 3차 : 2차 접종일로부터 4년 후 (통상 만 1년 이상의 건강한 아동을 대상으로 1세, 2세, 6세에 접종)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 이 백신은 항-일본 뇌염 바이러스 중화 항체를 측정 가능하게 증가시킴으로써 바이러스에 대한 활발한 면역 반응을 유발 ◆ 부작용 : 발열, 발진, 현기증, 오심 등 ◆ 금기 : 발열이 있는 자 또는 영양장애자, 급성전염병, 중이염, 활동성 결핵에 걸린 자, 심장질환, 신장질환 또는 간장질환에 걸린 자로 해당질환이 급성기 또는 증악기 및 활동기에 있는 자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 자, 알레르기 혹은 경련을 일으킨 적이 있는 자, 최근 면역억제 치료를 받았거나 현재 면역억제 치료를 받고 있는 자로 면역기능에 이상을 가져올 우려가 있는 자, 이 약의 주성분 및 기타성분에 과민반응을 나타내는 자, 다른 생백신의 접종을 받은 후 1개월을 경과하지 않은 자 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 : 냉장(2~8℃) 및 차광 보관 ◆ 적용상의 주의 ① 첨부된 용제를 용해한 후 침전 및 이물혼입, 변색 등을 확인하고 접종할 것 ② 본제의 용해는 접종 직전에 실시하고 용해 후 즉시 사용할 것	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Cefazolin inj	
성분/함량	Cefazolin sodium 1g/V	1세대 Cephalosporin계 항균제
효능·효과	◆ 유효균종 : 폐렴연쇄구균, 클레브시엘라, 인플루엔자균, 포도구균, 대장균, 프로테우스 미라빌리스, 엔테로박터, 연쇄구균, 장내구균 ◆ 적응증 : 기관지염, 폐렴, 인후두염 등 호흡기 감염증, 요로감염증, 피부 및 연조직감염증, 담관염, 담낭염, 골 및 관절감염증, 전립선염, 부고환염 등 생식기감염증, 패혈증, 심내막염	
용법·용량	◆ 성인 ① 1g/일을 2 회 분할 IM, IV(최대: 5g/일) ② 효과 불충분한 경우: 1.5-3g/일을 3 회 분할 ◆ 소아 ① 20-40mg/kg/일을 2 회 분할 IM, IV(최대: 100mg/kg/일) ② 효과 불충분한 경우: 50mg/kg/일 3 회 분할 ◆ 주사액의 조제 - 정맥주사 시는 주사용수, 생리식염주사액 또는 5% 포도당 주사액에 녹여 주사한다. - 점적 정맥주사 시 녹일 때 주사용수는 사용하지 않는다(등장액이 아님.). - 근육주사 시 0.5% 리도카인주사액 2~3mL 에 녹여 주사한다. - 온도에 의한 용해도 차에 의하여 가끔 백탁하는 경우가 있으며, 이 경우 온탕으로 따뜻하게 하여 투명한 용액으로 만든 후 사용한다. - 용해 후 신속히 사용하고 보존할 필요가 있는 경우에는 차광하여 실온에서 48 시간이내에 사용한다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 제 1 세대 Cephalosporin 계 항균제로 세균의 세포벽 합성 차단 ◆ 부작용 : 발열, 외음부 소양증, 호산구 증다증, 호중구 백혈구 감소증, 천명, 두통, AST·ALT·ALP 상승, 설사, 아구창, Coombs'test 양성반응, 어지러움, 신부전 환자에 과량 복용시 경련 등 신경독성, 구내이상감, 두드러기, anaphylactoid 증상, 발진, 홍반, 가려움, 과립구감소, BUN 상승, 외음부질칸디다증, 구강칸디다증, 혈관부종, 약물열, 용혈성빈혈, 스티븐스-존슨증후군, 간염 ◆ 금기 : Penicillin, Cephalosporin 계 약물에 과민증, Lidocaine 등의 국소마취제에 과민반응 병력자(IM 에 한함), ◆ 상호작용 ① Probenecid 와 병용투여시 배설 지연 ②항응고제의 활성증가 ③ 신독성약물과 병용투여시 신독성 증가 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 ① 희석 후 안정성: 48 시간(차광실온) ② Skin test ◆ 적용상의 주의 ① 정맥내 대량투여에 의해 드물게 혈관통, 혈전성 정맥염을 일으킬 수 있으므로 주사액의 조제, 주사부위, 주사방법 등에 대하여 충분히 주의하고 주사속도는 가능한 천천히 한다. ② 근육주사는 정맥주사가 곤란한 경우에만 사용한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

<table>
<tr><td>약품명</td><td colspan="2">Ceftazidime inj</td></tr>
<tr><td>성분/함량</td><td>Ceftazidime 1g/V</td><td>제 3세대 Cephalosporin계 항균제</td></tr>
<tr><td>효능·효과</td><td colspan="2">◆ 유효균종 : 세프타지딤에 감수성인 황색포도구균(메티실린감수성), 메티실린감수성 표피포도구균, 소구균, 스트렙토콕쿠스 피오게네스(그룹 A-베타 용혈성), 스트렙토콕쿠스 아갈락티에(그룹 B), 스트렙토콕쿠스 비리단스, 연쇄구균(장내구균 제외), 폐렴연쇄구균, 슈도모나스(녹농균 등), 클레브시엘라(폐렴간균 등), 프로테우스 미라빌리스, 프로테우스 불가리스, 모르가넬라 모르가니, 프로테우스 프로비덴시아 레트게리, 프로비덴시아, 대장균, 엔테로박터, 시트로박터, 세라티아, 살모넬라, 시겔라, 예르시니아 엔테로콜리티카, 동물파스퇴렐라증 병원균, 아시네토박터, 임균, 수막염균, 인플루엔자균(암피실린내성균 포함), 파라인플루엔자균(암피실린내성균 포함), 펩토구균, 펩토연쇄구균, 프로피오니박테륨, 클로스트리듐 퍼프린젠스, 푸소박테륨, 박테로이드(박테로이즈 프라질리스 제외)
◆ 적응증 : 패혈증, 수막염, 폐렴, 흉막염, 농흉, 폐농양, 기관지확장증(감염 시), 기관지염, 낭포성 섬유증 환자의 폐감염, 중이염, 악성외이도염, 유양돌기염, 부비동염, 기타 중증의 귀와 목 부위 감염증, 신우신염, 전립선염, 방광염, 요도염, 단독, 농양, 화상 및 외상 후 2 차 감염, 유선염, 피부궤양, 담관염, 담낭염, 담낭축농, 복강내농양, 복막염, 게실염, 소장결장염, 골반감염증, 골수염, 골염, 패혈성관절염, 감염성 점액낭염, 면역기능저하 환자의 중증감염증, 화상감염 등의 중증감염증, 혈액 및 복막투석으로 인한 감염증, 지속성 외래복막투석(CAPD) 환자와 관련된 감염증</td></tr>
<tr><td>용법·용량</td><td colspan="2">◆ 성인 ① 0.5-2g을 2-3회/일 IV, IM
② 낭포성 섬유종: 100-150mg/kg/일 3회 분할투여(최대: 9g/일)
③ 요로감염증, 중증도감염증: 1회 0.5-1g을 12시간마다 IV, IM
④ 중증감염증, 호중구감소 등의 면역기능 저하: 1회 2g을 8-12시간마다 IV, IM
⑤ 노인(>80세): 최대 3g/일
⑥ 신장애: 초기량 1g, 유지량 <표> 참조
<table>
<tr><td>CrCL(ml/min)</td><td>유지량(g)</td><td>투여간격(hr)</td></tr>
<tr><td>50-31</td><td>1</td><td>12</td></tr>
<tr><td>30-16</td><td>1</td><td>24</td></tr>
<tr><td>15-6</td><td>0.5</td><td>24</td></tr>
<tr><td><5</td><td>0.5</td><td>48</td></tr>
</table>
◆ 소아 ① ≥2개월:
ㄱ. 30-100mg/kg/일 2-3회 분할투여 IV, IM (최대용량: 6g/일)
ㄴ. 감염으로 인한 면역기능 저하, 낭포성 섬유증, 수막염 소아: 150mg/kg/일 3회 분할투여
② 신생아 및 2개월 미만 유아
ㄱ. 25-60mg/kg/일을 2회 분할투여 IV, IM
ㄴ. 신생아의 경우 세프타지딤의 혈청반감기는 성인의 3~4배 길어질 수 있음</td></tr>
<tr><td>사용상의
주의사항</td><td colspan="2">◆ 약리작용 : 제3세대 반합성 Cephalosporin계 항균제(Pseudomonas에 감수성)
◆ 부작용 : 쇽, 과민반응(발진, 두드러기, 홍반, 가려움), 구역, 구토, 식욕부진, 불쾌한 미각, 간질성폐렴, 호산구성 폐침윤, 과립구감소, 백혈구감소, 적혈구감소, 호산구증가, 호중구감소, 혈소판감소, 빈혈, 신기능장애, 두통, 열감, AST·ALT·ALP·LDH↑, 황달, 급성신부전, BUN·SCr↑, 단백뇨, 균교대증(구내염, 칸디다증), 위막성대장염(혈변, 복통, 빈번한 설사), Vit.K 결핍증, 전신권태감
◆ 금기 : Cephalosporin계약물에과민반응 환자 또는 이 약 성분에 쇼크를 포함한 과민반응 환자
◆ 상호작용
① 이뇨제(Furosemide 등), AG계 항생제: 신장애 증가
② Chloramphenicol: 길항작용 고려
③ 장내균총 영향을 주어 Estrogen의 재흡수율 낮춰 경구용 피임제 효과 감소
④ 임상검사치에의 영향
ㄱ. 구리 환원시험법(베니딕트, 펠링, 클리니테스트)에 약간 영향, 거짓양성 나타날 수 있음
ㄴ. 직접 쿰스시험 양성 나타날 수 있음
◆ 태아위험도 : B
◆ 비고
① 차광보관
② 용해 후 안정성: 6시간(실온), 3일(냉장)
③ 부주의로 동맥 내 투여 시 말단 괴사 유발</td></tr>
</table>

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Cerebyx inj 150, 750	
성분/함량	Fosphenytoin Na 150mg/2ml/A, 750mg/10ml/A	항전간제
효능·효과	1. 강직간대발작(대발작)성 간질중첩증 조절 2. 신경외과 수술 중 발생하는 발작의 치료와 예방 3. 경구투여가 가능하지 않거나 또는 금기시될 때의 경구용 페니토인의 대체	
용법·용량	◆ 페니토인 당량(PE): 1.5mg 포스페니토인 = 1mg PE 1) 간질중첩상태 (IV) - 초회용량: 100-150mg PE/min으로 15mg PE/kg - 유지용량: 50~100mg PE/min으로 4~5mg PE/kg/day 2) 발작의 예방 또는 치료 (IV or IM) - 초회용량: 10~15mg PE/kg (IV 투여 시: 최고 150mg PE/min) - 유지용량: 4~5mg PE/kg/day (IV 투여 시: 50~100mg PE/min) 3) 경구용 페니토인 대체 (IV or IM) - 경구용페니토인과 동일용량 및 빈도로 투여	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 3-hydroxymethyl-5,5-diphenylhydantoin의 disodium phosphate ester로서 phenytoin의 수용성 prodrug임. 비경구적 투여시 혈액 및 조직속의 phosphatases에 의해 빠르게 phenytoin으로 분해 ◆ 부작용 : 과민성, 과민성 약물반응, 눈떨림, 안진, 안구진탕, 독성표피괴사용해, 림프절병증, 말더듬, 불명료 언어, 스티븐스-존슨증후군, 신경과민, 약물 열, 운동이상증, 인지 손상, 잇몸증식증, 전신홍반루푸스 중추신경계 독성, 진전, 떨림 피부 발진, 흥분, 변비, 어지러움, 어지럼(증), 오심, 메스꺼움, 구역 및 구토, 졸림, 졸음 등 ◆ 금기 1) 이 약, 이 약의 구성성분, 페니토인 또는 다른 히단토인계 화합물에 과민반응이 있는 환자 2) 동서맥, 동방블록, 2·3도 방실 블록, 애덤스-스톡스 증후군(Adams- Stokes syndrome) 환자(비경구 페니토인은 심실의 자동성에 영향을 끼침.) 3) 심근경색(3개월 이내) 환자 4) 중증의 혈액 및 골수장애 환자 5) 급성 간헐성 포르피린증 환자 ◆ 태아위험도: D ◆ 비고: 기밀용기, 냉장보관(2~8℃) ◆ 적용상의 주의: 1.5 ~ 25 mg PE/mL 농도로 5 % 포도당 주사액 또는 생리식염 주사액에 희석하여 사용	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	**Clotinab inj**	
성분/함량	**Abciximab 10mg/5ml/V**	**항응고제**
효능·효과	PTCA 시술중에 고위험 환자군의 허혈성 심장 합병증 예방을 위해서 Heparin 과 Aspirin 투여에 보조적 사용	
용법·용량	◆ 성인 PTCA 시술 시작 10 분 전에 0.25 mg/kg 용량의 일시 IV bolus 후에 12 시간동안 0.125 μg/kg/min (최대 10 μg/min) 용량의 IV infusion	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Monoclonal antibody 로서 혈소판의 당단백 수용체 GPⅡb/Ⅲa 와 결합하는 Platelet Aggregation Inhibitor ◆ 부작용 : 출혈, 혈소판 감소증, human antichimeric antibody development, 저혈압, 폐렴, 서맥, 빈혈, 백혈구증다증, 구역, 구토, 지각감퇴, 착란, 흉막삼출액, 동통, 흉막염, 말초부종, 시각이상, 감각저하 ◆ 금기 ① 양성 내부 출혈 ② 최근 (6 주 이내), 임상적으로 위험한 위장관 또는 비뇨생식기 출혈 ③ 2 년 이내에 뇌혈관 발작의 병력이 있거나, 심각한 신경학적 결함의 후유증이 있는 뇌혈관 발작 ④ 출혈소질 ⑤ 프로트롬빈 time 이 1.2 시간 이하로 제어되는 경우를 제외한 7 일 이내에 경구 항응고제의 투여 ⑥ 혈소판 감소증(<100,000Cells/μℓ) ⑦ 최근 (6 주 이내) 대수술 또는 외상 ⑧ 두개내의 신생물, 동정맥 기형, 동맥류 ⑨ 중증 무조절성 고혈압 ⑩ 맥관염으로 추정되거나 맥관염의 병력이 있는 경우 ⑪ PTCA 전에 정맥투여 덱스트란의 사용 또는 PTCA 중에 덱스트란을 사용하려고 하는 경우 ⑫ 고혈압성 당뇨병 환자 ⑬ 중증의 간신장애 ⑭ 이 약 또는 뮤린 단백질에 과민증을 나타낸 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고: 밀봉용기, 냉장보관(2~8℃)	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Cordarone inj	
성분/함량	Amiodarone HCl 150mg/3ml/A	부정맥 치료제
효능·효과	심방성부정맥, 심실성부정맥, 기타 다른 부정맥용제로 치료되지 않는 재발성중증부정맥 신속한 반응이 요구되거나 경구투여가 불가능한 경우에 투여한다	
용법·용량	◆ 성인 ① 포화요법 : 5mg/kg 을 DW 250ml 에 희석하여 20 분-2 시간동안 IV infusion (24 시간동안 2-3 회 반복가능) ② 유지요법 : 10-20mg/kg 을 DW 250ml 에 희석하여 2-3 일에 걸쳐 투여 (평균 투여량 : 600-800mg/일, 최대: 1,200mg/일) ③ 정맥주사 개시 1 일째 경구요법 : 600mg/일로 치환시키며 800-1,000mg/일까지 증량 가능 ◆ 소아 ① 부하용량 : 5mg/kg 을 30 분에 걸쳐 투여 (반응 없을 경우 3 회까지 반복투여 가능) ② 유지량 : 2-20mg/kg/일(5-15mcg/kg)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Antiarrhythmic agent(class III) ① 심장의 산소소비량 감소(총 심박출량 조절효과, 말초저항의 감소효과) ② 심혈관 확장, 심근혈류 증가(ST-segment 저하 막음) ③ 심근 섬유질의 활동 잠재력 연장 시킴 ◆ 부작용 : 흐린시력, 광과민반응, 갑상선기능저하증 항진증, 추체외로진전, 구토, 색소침착, 악몽, 수면장애, 서맥, 식욕부진, 저혈압, Hgb Hct↓, 현기, 두통, 불면, 간기능 이상, pulmonary fibrosis, 간질성 폐렴, 폐포염, 폐섬유증,흉막염, 간효소↑, QT 간격 연장 ◆ 금기 : 심실성 서맥, 동서맥, 동방블록, 심이성 심폐색, 임부, 수유부, 신생아, 중증의 동기능 부전증후군, 2 도 이상 방실전도장애, 갑상선기능장애, 미숙아, 요오드 과민증 ◆ 상호작용 ① β-blocker, CCB, Digitalis: 자동능 저해(현저한 서맥), 전도장애 유발 ② 자극성 완하제: 저 K^+유발 ③ 저 K^+유발약품(이뇨제, 전신성 부신피질 호르몬제, Amphotericin-B) ④ 경구용 항응고제, Phenytoin 의 혈중농도 상승 ⑤ CYP 3A4 의 저해제 및 이 효소에 의해 대사되는 약물(CSA, Fentanyl)의 혈중농도 상승→ 독성 증가 ⑥ Theophylline 의 혈중농도 상승 ⑦ Fluoroquinolone: QTc 연장 가능 ◆ 병용금기 : Torsades de pointes 유발약물(부정맥치료제, 신경이완제, Cisapride, EM, 비경구형 Pentamidine) ◆ 주의 : 복용 중 햇빛에 장시간 노출시 일시적인 피부색소 침착유발 가능성있음 ◆ 태아위험도 : D ◆ 비고 ① 희석농도(300mg/500ml 이하), 희석수액(DW 만) ② IV bolus 금기 ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 동서맥 현상, 심장블록, 심실성 빈맥, 토르사드 데 포인트, 순환성 쇽, 간 손상 ② 치료 : 증상에 따라 일반적인 대증요법을 실시, 투석으로 제거되지 않는다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Covid-19 vaccine (Comirnaty JN.1)	
성분/함량	Covid-19 vaccine (0.48ml/V)	예방 백신
효능·효과	12 세 이상에서 SARS-CoV-2 바이러스에 의한 코로나 19 의 예방	
용법·용량	◆ 투여일정 및 용량 이 약은 12 세 이상에서 이전 COVID-19 백신접종과 상관없이 근육주사로 0.3 mL 을 1 회 투여한다. 이전에 COVID-19 백신을 접종 받은 경우, 가장 최근 COVID-19 백신 접종 후 최소 3 개월 이후에 이 약을 투여해야 한다. ◆ 투여방법 이 약은 근육주사로 투여한다. 사용 전에 희석해서는 안 된다. 가급적 위팔 삼각근에 투여한다. 이 약에는 0.3 mL 씩 6 회 용량이 들어있다. 1 개의 바이알에서 6 회 용량을 취하기 위해서는 최소잔여형 주사기 및 주사바늘을 사용해야 한다. 최소잔여형 주사기와 주사바늘 조합제품의 잔류량은 35 마이크로리터 이하여야 한다. 표준 주사기와 주사바늘을 사용하는 경우 1 개의 바이알에서 6 회째 용량을 취하지 못할 수 있다. 주사기 및 주사바늘의 종류와 관계없이, - 각 1 회 용량에는 이 약 0.3 mL 가 포함되어야 한다. - 바이알에 남아있는 백신의 양이 0.3 mL 가 안 되는 경우에는 바이알과 내용물을 폐기해야 한다. - 여러 바이알에 남아있는 백신을 모아서 사용해서는 안 된다. 이 약은 혈관내, 피하 또는 피내 주사해서는 안 된다. 동일한 주사기로 다른 백신 또는 약물과 혼합해서 사용해서는 안 된다.	
사용상의 주의사항	◆ 부작용 : 두통, 설사, 관절통, 근육통, 주사부위 통증, 피로, 오한, 발열, 주사부위 종창 ◆ 신중투여: 1) 급성 중증 열성 질환이 있는 자(급성 중증 열성질환 또는 급성감염이 있는 경우, 백신접종을 연기해야 한다. 경미한 감염 또는 미열로 접종을 연기할 필요는 없다) 2) 항응고제를 투여중이거나, 혈소판감소증 또는 기타 혈액응고장애(예, 혈우병)가 있는 환자 (근육주사 시 출혈 또는 멍이 있을 수 있으므로 주의하여 투여하여야 한다) ◆ 금기 : 이 약의 주성분 또는 구성성분에 과민증이 있는 자 ◆ 상호작용 다른 주사용 백신은 각각 다른 주사부위(다른 팔)에 투여되어야 한다. ◆ 주의 : - 괴민증 및 아낙필락시스 - 심근염 및 심장막염 - 불안관련 반응 - 면역기능 저하자: 유효성이 낮을 수 있음 ◆ 적용상의 주의 : 이 약은 **단회투여용(single-dose vial)** 바이알이다. 희석하지 않고 사용하는 제품으로 1 개의 단회투여용 바이알에는 1 회 용량(0.3 mL)이 들어있다. ◆ 보관 및 취급상의 주의 - 냉동된 바이알: -90°C ~ -60°C 에서 18 개월 동안 보관 - 해동된 바이알: 2°C ~ 8°C 에서 10 주 동안 보관 및 운반 - 개봉된 바이알: 2°C ~ 30°C 에서 물리 화학적으로 12 시간 동안 안정하나, 미생물학적 관점에서, 미생물 오염을 고려하여, 즉시 사용 - 차광	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Cortisolu inj	
성분/함량	Hydrocortisone sodium succinate 100mg/V	부신호르몬제
효능·효과	◆ 부신피질 호르몬 제제 내분비 장애, 류마티스성 장애, 교원성 질환, 피부 질환, 알레르기성 질환, 안과 질환, 위장관 질환, 호흡기계질환, 혈액 질환, 종양성 질환, 부종성 질환, 신경계 질환, 결핵성 수막염(지주막하의 차단상태 또는 차단이 우려되는 경우로서, 적절한 항결핵 화학요법제와 병용투여), 선모충증(신경성 또는 심근성 합병증이 수반된 경우)	
용법·용량	◆IV, IVF, IM 가능. 응급시 IV 바람직 -> 위기 넘기면 주사 또는 경구요법(∵지속적효과) ◆중증의 쇽 치료시: 다량투여(약리학적 용량)를 권장 ◆ cute adrenal insufficiency: IM, IV ① 성인 : 100mg IV bolus 후 300mg/일을 8 시간마다 분할투여 또는 48 시간마다 IVF(경구전환 시 50mg 을 8 시간마다 6 회 투여한 후 30-50mg/일을 분할투여하며 tapering) ② 영아·유소아 : 1-2mg/kg/dose bolus 후 25-150mg/일을 6-8 시간마다 분할투여 ③ 소아 : 1-2mg/kg/dose bolus 후 150-250mg/일을 6-8 시간마다 분할투여 ◆ Anti-inflammatory/immunosuppressive: IM, IV ① 성인 : 15-240mg 을 매 12 시간마다 ② 유·소아 : 1-5mg/kg/일 또는 30-150mg/㎡/일을 12-24 시간마다 분할투여 ◆ Physiologic replacement: IM ① 소아: 0.25-0.35mg/kg/일 또는 12-15mg/㎡/일을 하루 한번 ◆ Shock: IM, IV ① 성인 : 500mg-2g 을 매 2-6 시간마다 ② 소아 : 50mg/kg, 투여 후 4 시간마다 반복, 24 시간 마다 반복가능 ◆ Status asthmaticus: IV(성인/소아) : 1-2mg/kg/용량을 6 시간마다 24 시간 투여 후 유지량은 0.5-1mg/kg 를 매 6 시간마다	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Glucocorticoid 류 Polymorphonuclear leukocyte 의 이동을 억제하고 증가된 Capillary permeability 를 역전시킴으로써 염증반응억제 ◆ 부작용 : Hydrocortisone Jenapharm 참조 ◆ 금기 : 전신 진균감염, 단순포진, 대상포진, 수두환자, 관절강내 또는 건주위에 감염증이 있는 환자, 관절강내가 불안정한 환자, 생백신투여환자, Hydrocortisone Jenapharm 참조 ◆ 상호작용 ①Astemizole, EM, Pentamidine: 다형성 심실빈맥 ②Amiodarone, Disopyramide, Sotalol, Quinidine: 부정맥 ◆ 주의 : 소화성 궤양 환자, 정신병 환자, 중증 골다공증 환자, 녹내장 환자, 게실염, 결핵성 질환 환자, 후낭하 백내장 , 고혈압 환자, 전해질 이상 환자, 혈전증 환자, 최근 장문합술을 받은 환자, 급성 심근경색의 병력이 있는 환자, 안과 투여시 바이러스성 결막·각막 질환, 결핵성·진균성·급성 화농성 안질환 환자, 감염증 환자, 당뇨병 환자, 골다공증 환자, 신부전, 울혈성 심부전 환자, 갑상선기능저하증, 경변증 환자, 지방간, 지방색전증 환자, 중증 근무력증 환자, 비특이성 궤양성 대장염 환자, 혈전성 정맥염 소인이 있는 환자, 골다공증, 고혈압, 울혈성 심부전, 심각한 감정이상, 당뇨병, 결핵, 녹내장, 간장애, 간질, 소화성 궤양, 코르티코이드로 인한 근병증의 병력이 있는 환자, 소아 및 고령자 ◆ 태아위험도 : C	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Curosurf	
성분/함량	Lung surfactant (Poractant alfa)	폐포 표면 활성물질
효능·효과	신생아 호흡곤란 증후군의 치료 및 예방	
용법·용량	◆ 치료목적 ① 1 회 100-200mg/kg(1.25-2.5ml/kg)을 기관지나 기관내로 투여 ② 인공호흡기를 부착한 신생아 및 산소보충을 요하는 신생아에게는 약 12 시간 간격으로 1 회 100mg/kg 씩을 추가 투여할 수 있음 ③ 최대 총 투여용량 : 300-400mg/kg ◆ 예방목적 ① 1 회 100-200mg/kg(1.25-2.5ml/kg)을 가능한 빨리(출생 후 15 분 이내) 투여 ② 100mg/kg 의 추가용량은 처음 투여 후 6-12 시간에 투여 ③ 기계적 환기가 필요한 호흡곤란증후군 발생 시 12 시간 간격으로 추가투여 할 수 있음 ◆ 투여방법 ① 사용 전에 37℃로 가온 한 후, 상·하로 천천히 흔들어 균일한 현탁액이 되도록 함 ② 무균 바늘과 주사기로 취한 1 회 용량의 현탁액을 인공호흡기를 순간적으로 제거한 환자의 하기도에 직접 주입하거나, 또는 반씩 분할하여 기관내 삽입관을 통해 각각 좌·우 기관지 튜브로 직접 주입 ③ 균일한 분포를 위해, 주입 후 인공호흡시와 동일한 산소농도에서 1 분간 hand-bagging 을 실시하고 인공호흡기를 투여전과 같이 환자에게 연결시킴 ④ 투여 후 산소의 급작스런 증가나 산소포화가 일어날 수 있으므로 동맥혈의 가스 농도, 경피성의 산소분압, 산소포화도의 모니터링이 필요함	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 부족한 내인성 폐포표면활성제를 보충하여 공기와 폐포 표면적 사이의 표면장력을 낮추고 호기시 폐포의 허탈을 막아줌 ◆ 부작용 : 폐출혈, 서맥, 저혈압 등 ◆ 주의 ① 호흡곤란증후군이 있는 미숙아의 모니터링과 인공호흡에 대한 시설을 갖춘 병원에서 미숙아 치료 및 소생술의 경험이 있는 의사의 지시하에서만 사용해야 함 ② 이 약은 인공호흡 장치를 사용하여 폐에 골고루 분포되도록 하며 약물이 최적으로 작용하기 위해서는 산증, 저혈압, 빈혈, 저혈당증, 저온증에 대한 조절이 필요함 ◆ 기타 ① 3 주 이상의 장기적인 막파수 발생 후 태어난 미숙아에게는 외인성 계면활성제가 최적효과를 나타내지 않을 수 있음 ② 예방목적으로 사용 시, 일반적 예방투여는 28 주 이하의 재태기간을 가진 신생아에게 투여함 ③ 계면활성제 투여는 조산아의 호흡곤란증후군 발생빈도와 증세를 크게 감소시키나, 조산아 본래의 미성숙에 기인하는 기타 합병증에 의하여 나타나는 조산아 사망률 및 질병률을 완전히 감소시키지 못함 ◆ 비고 밀봉용기, 5±3℃ 냉암소 보관	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Decapeptyl inj	
성분/함량	Triptorelin acetate 0.1mg/1ml/Syringe	항악성 종양제
효능·효과	◆ 혈청 중 성스테로이드치 저하를 필요로 하는 호르몬의존성 전립선암 ◆ 불임여성에서 체외수정시술 및 수정란 이식에서 성선호르몬 (사람폐경 생식샘자극호르몬(hMG), 난포자극호르몬(FSH), 사람융모성 생식샘자극호르몬(hCG))과 병행하여 배란을 유도하기 위한 보조적 치료	
용법·용량	◆ 전립선암 : 트립토렐린아세트산염으로서 1일 1회 0.1mg을 매일 피하주사한다. ◆ 불임치료: 황체기 중반 (생리주기 21~23일 또는 다음 생리주기 시작 5~7일 전)부터 배란이 유도되기 전까지 트립토렐린아세트산염으로서 1일 1회 0.1 mg을 매일 피하주사한다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : triptorelin은 황체 형성 호르몬 방출 호르몬(LHRH or GnRH)의 강력한 유사체로 처방된 용량에서 지속적으로 적용하였을 때 gonadotropin의 분비를 가역적으로 억제함 ◆ 부작용 ① 호르몬 생성억제에 따른 약리학적 부작용 ㄱ. 남성: 홍조, 발기부전, 성욕감퇴, 여성화유방 및 고환위축 ㄴ. 여성: 홍조, 출혈, 질건조, 이상성감증, Estrogen 농도 저하로 약간의 소주골량의 감소 ◆ 금기 : LHRH 유사약물 과민반응 있는 환자, 원인불명의 질출혈, 양쪽 고환 절제술, 호르몬 비의존성 전립선암, 진단된 뇌하수체 샘종, 임부, 수유부 ◆ 상호작용: 이 약 치료동안 에스트로겐을 함유하는 약물은 사용하지 않아야 함. ◆ 태아위험도 : X ◆ 비고 : 냉장(2~8℃) 보관	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Diphereline PR inj	
성분/함량	Triptorelin acetate 3.75mg/V	항악성 종양제
효능·효과	◆ 혈청 중 성스테로이드치 저하를 필요로 하는 호르몬의존성 전립선암 ◆ 불임여성에서 체외수정시술 및 수정란 이식에서 성선호르몬 (사람폐경 생식샘자극호르몬(hMG), 난포자극호르몬(FSH), 사람융모성 생식샘자극호르몬(hCG))과 병행하여 배란을 유도하기 위한 보조생식술 ◆ 자궁내막증 ◆ 자궁근종 등 ◆ 소아: 9 세 이하 여아 및 10 세 이하 남아의 중추성 사춘기조발증	
용법·용량	◆ 전립선암 : 28~30일마다 트립토렐린으로서 3.75 mg을 근육주사 ◆ 자궁내막증, 자궁근종 : 생리주기 5일 이내에 트립토렐린으로서 3.75 mg을 4주마다 근육 또는 피하주사 ◆ 체외수정 시술 시 보조생식술 : 생리주기 3일 무렵에 트립토렐린으로서 3.75 mg을 4주마다 근육 또는 피하주사 ◆ 중추성 사춘기조발증 : 치료개시일 14, 28일째에 3.75mg → 그 후 4주마다 근육 또는 피하주사 ▪ <20kg: 1.875mg ▪ 20-30kg: 2.5mg ▪ >30kg: 3.75mg * 골격 연령이 여아 12세, 남아 13세 이상이면 중지	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : triptorelin은 황체 형성 호르몬 방출 호르몬(LHRH or GnRH)의 강력한 유사체로 처방된 용량에서 지속적으로 적용하였을 때 gonadotropin의 분비를 가역적으로 억제함 ◆ 부작용 ① 호르몬 생성억제에 따른 약리학적 부작용 ㄱ. 남성: 홍조, 발기부전, 성욕감퇴, 여성화유방 및 고환위축 ㄴ. 여성: 홍조, 출혈, 질건조, 이상성감증, Estrogen 농도 저하로 약간의 소주골량의 감소 ㄷ. 소아: 출혈, 질분비물 분비 ◆ 금기 : LHRH 유사약물 과민반응 있는 환자, 원인불명의 질출혈, 양쪽 고환 절제술, 호르몬 비의존성 전립선암, 진단된 뇌하수체 샘종, 임부, 수유부, 골다공증 또는 골밀도저하와 같은 골다공증 위험이 있는 환자, 진행성 뇌종양 소아환자 ◆ 상호작용: 이 약 치료동안 에스트로겐을 함유하는 약물은 사용하지 않아야 함. ◆ 태아위험도 : X ◆ 비고 : 냉장(2~8℃) 보관	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Denogan inj	
성분/함량	Propacetamol HCl 1g/V	중추성 진통제
효능·효과	통증이나 고열로 인하여 신속하게 투여할 필요가 있거나 다른 경로로 투여할 수 없는 경우 ① 외과 수술 후 통증 ② 발열의 단기간 치료	
용법·용량	◆ 성인 : 1 회 1~2 g 을 4 시간 간격으로 2~4 회 투여 (최대: 1 일 8 g) - 사용 직전 용해액으로 용해시킨후 1~2 분내 근육주사, 정맥주사하거나 정맥 내 점적주입한다. - 정맥내 주입의 경우 5% 포도당 주사액 또는 생리식염 주사액 125 mL 를 이용하여 15 분내에 점적주입한다. - 일단 재구성한 제품은 2 시간 이내에 사용해야 한다. - 정맥내 주입시 불용의 파라세타몰로 가수분해될 수 있으므로 점적주입병의 생성물은 투여하지 말아야 한다. ◆ 중증 신장애 환자의 경우(크레아티닌청소율이 분당 10 mL 이하), 투여간격을 적어도 8 시간 이상으로 한다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : NSAIDs 로 Paracetamol 로 가수분해되어 해열, 진통 효과 나타냄 ◆ 부작용 : 홍반, 담마진, 구토, 혈소판 감소증 ◆ 금기 : 간부전 환자, 중증 용혈성 빈혈환자, 접촉피부염 있는 환자, 소아, 임신 초기의 임부 ◆ 상호작용 1) 간효소 유도약물(바르비탈계, 카르바마제핀, 히단토인계, 리팜핀, 설핀피라존 등) : 과량을 장기간 병용시에 간독성을 유발할 수 있으므로 주의해야 한다. 2) 지도부딘 : 비스테로이드성 소염진통제와 병용 투여 시 혈액학적 독성이 증가할 수 있다. 3) 알코올 : 만성적으로 과량 섭취하는 사람에게 이 약의 치료용량을 늘리거나 과량 투여했을 때 독성이 증가할 수 있다. ◆ 주의 ① ClCr <10ml/min 인 경우 투여간격 8 시간 이상 ② 가수분해되어 불용성의 Paracetamol 이 생성 가능하므로 병 사용금지 : bag 수액 사용 ③ 만성 알코올 중독 환자 ④ 만성 영양실조(간 글루타티온의 낮은 보유량) 환자 ⑤ 탈수 환자 ⑥ 임신 중기, 말기의 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 ⑦ 항전간제를 복용중인 환자 ◆ 과량투여 시의 처치 ① 증상 : 급성중독의 증세로 구역, 구토, 식욕부진, 창백, 복부통증이 24 시간이내에 나타나며 과량 (파라세타몰로서 10 g 이상) 투여 시는 간부전, 대사성산증, 혼수상태 또는 사망에 이르는 뇌질환 등이 나타나고 특히 간의 트랜스아미나제, 락토스데히드로게나제, 빌리루빈을 활성화시켜 간괴사가 일어난다. ② 처치 : N-아세틸시스테인을 해독제로 정맥주사하거나 경구투여로 가능한한 10 시간 내에 빨리 투여해야 한다. ◆ 적용상의 주의 ① 프로파세타몰의 가수분해로 불용성의 파라세타몰이 생성될 위험이 있으므로 infusion 병을 사용하지 말 것. ② Incompatibility 위험이 일어날 수 있으므로 같은 주사기내에서 다른 약물과 혼합하지 말 것. ◆ 비고 : 차광보관	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Denosin inj	
성분/함량	Adenosine 90mg/30ml/V	순환계용약
효능·효과	심근 신티그래피시 운동이 불가능하거나 적절하지 않은 환자에게 관상동맥 혈관이완을 목적으로 사용	
용법·용량	희석하지 않고 주입펌프를 이용해 말초정맥내로 아데노신으로서 140 μg/kg/min 의 용량으로 6 분간 지속적으로 정맥내 주입하는데, 아데노신 투여 3 분후에 방사성 약물은 아데노신 투여부위와 다른 곳을 통해(아데노신의 bolus 효과 예방을 위해) 투여	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 심장 방실 결절의 전도를 지연시키며 방실결절을 통한 혈액의 재유입 차단(Adenosine receptor A1 및 A2 와의 상호작용에 의함) ◆ 부작용 : 심차단, 부정맥, 중등도의 심실반응저하, 호흡부전, 안면홍조, 호흡곤란, 구역, 흉부압박감, 중증의 서맥, 두통, 두개압, 가벼운 상기, 무감각, 서혜부 압박 ◆ 금기 ① 2-3 도의 방실 차단 환자, 동기능부전 증후군 환자(심박조율기착용환자제외) ② 만성폐쇄성폐질환 환자(천식) ③ QT 간격연장증후군 환자 ④ 중증의 저혈압 환자 ⑤ 미보상 상태의 심부전 환자 ⑥ 약물치료로 안정되지 않은 불안정형 협심증 환자 ⑦ 디피리다몰 투여중인 환자 ◆ 상호작용 ① Caffeine, Theophylline: 이 약 효과 억제됨 ② Dipyridamole: 이 약 작용상승 ③ Carbamazepine: 심차단 정도 증가 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 냉동보관 하지말 것(∵침전생성)	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Dexamethasone inj	
성분/함량	Dexamethasone sodium phosphate 5mg/1ml/A	부신호르몬제
효능·효과	부신호르몬제로서 내분비 장애, 류마티스성 장애, 교원성 질환, 피부 질환, 알레르기성 질환, 안과 질환, 위장관 질환, 혈액 질환, 종양성 질환, 부종성 질환, 신경계 질환 등에 사용	
용법·용량	① 정맥 또는 근육주사 : 1 회 2-8mg 을 3-6 시간마다 ② 점적 주사 : 1 회 2-10mg 을 1 일 1-2 회 ③ 관절내 주사, 점액낭내 주입 : 1 회 0.8-5mg, 원칙적으로 투여간격 2 주 이상 ④ 연조직내 주사 : 1 회 2-6mg, 원칙적으로 투여간격 2 주 이상 ⑤ 건초내 주사 : 1 회 0.8-2.5mg, 원칙적으로 투여간격 2 주 이상 ⑥ 국소피내 주사 : 1 회 0.05-0.1mg 씩 1mg 까지 주 1 회 ⑦ 결막하 주사 : 1 회 0.4-2.5mg ⑧ 구후 주사 : 1 회 1-5mg	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Glucocorticoids (장시간 지속형) ◆ 금기 관절강내, 점액낭내, 건초내 또는 건주위에 감염증이 있는 호나자, 관절이 불안정한 환자, 생백신 투여환자, 단순포진, 대상포진, 수두 환자, 유효한 항균제가 없는 감염증, 전신 진균 감염증 환자 ◆ 부작용 ① 국소조직의 함몰, 혈관통, 혈전성 정맥염, 만월형 얼굴, 부종, 다모, 자반, 소양감, 오심, 구토, 불면, 다행증, 근육통, 월경이상, 발열, 당뇨, 소화성궤양, 만성췌장염, 혈압상승, 녹내장, 진전 ② 시신경 손상이 수반되는 녹내장, 시력 저하, 백내장, 숙주 반응억제에 의한 이차감염, 안구천공 ◆ 배합금기 : Daunorubicin, Doxorubicin, Vancomycin, Doxapram, Glycopyrrolate ◆ 상호작용 ① Barbiturate, Phenytoin, RFP: 이 약의 작용 감소 ② NSAIDs: 위장관 궤양의 위험 증가 ③ 항응고제, 경구혈당강하제의 작용 감소 ④ 이뇨제와 병용시 저 K 혈증 ⑤ CSA 혈중농도 상승 ◆ 주의 : 투여 중 생백신 투여하지 말 것 ◆ 태아위험도 : C ◆ 적용상의 주의 : 정맥내 투여에 의해 혈관통, 정맥염을 일으킬 수 있으므로 주사 부위, 주사 방법 등에 충분히 주의하고 되도록 천천히 주사한다.	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Dextomin premix inj	
성분/함량	Dexmedetomidine HCl 200mcg/50ml/V	최면진정제
효능·효과	◆ 집중치료 관리하의 진정 : 집중치료 관리 하에 초기 삽관되어 인공호흡을 실시하는 환자의 진정 ◆ 수술 및 시술 시 비삽관 환자의 의식하 진정 1) 감시 하 마취 관리(Monitored Anesthesia Care, MAC) 2) 의식 하 광섬유 삽관(Awake Fiberoptic Intubation, AFI)	
용법·용량		

적응증	용법.용량
집중치료 관리하의 진정 개시	- 성인: 10~20 분간 1mcg/kg 의 부하용량으로 주입
집중치료 관리하의 진정 유지	- 성인: 유지용량으로 0.2-0.7mcg/kg/시간으로 주입 유지용량의 정맥주입 속도는 원하는 진정 수준을 달성하기 위하여 조절
의식 하 진정 개시	- 성인: 10 분간 1mcg/kg 의 부하용량으로 주입 안과수술과 같은 침습성이 적은 수술에서는 10 분 동안 0.5mcg/kg 의 부하용량 주입 - 의식 하 광섬유 삽관 환자 : 10 분간 1mcg/kg 의 부하용량 주입
의식 하 진정 유지	- 성인: 유지용량으로 0.6mcg/kg/시간으로 개시하고 원하는 임상 효과를 얻기 위해 0.2~1mcg/kg/시간으로 적정 유지용량 정맥주입의 속도는 목표한 진정 수준을 달성하기 위하여 조정 - 의식하 광섬유 삽관 환자 : 기관내 튜브가 안전하게 될 때까지 0.7mcg/kg/시간의 유지용량 주입

사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 상대적으로 선택적인 alpha-2 adrenergic agonist로 진정작용을 가짐. 마취 효과의 정확한 기전은 알려져 있지 않으나 아마 central postsynaptic alpha-2 수용체의 자극과 관련 있는 것으로 추정 ◆ 부작용 : 서맥, 심방세동, 저산소증, 저혈압, 구역 등 ◆ 금기 : 이 성분에 과민증이 있는 환자 ◆ 상호작용 ① 마취제, 진정제, 수면제, 마약류 : 이 약과 병용 시 효과 증강 ◆ 태아위험도 : C ◆ 적용상의 주의 ① 이 약은 항상 엄격한 무균상태에서 취급한다. ② 이 약은 정맥으로만 투여한다. ③ 이 약의 지속 투여시 투여속도의 조절 가능한 주입기구(시린지펌프 등)를 사용한다.

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Diclon inj	
성분/함량	Diclofenac beta dimethyl aminoethanol 90mg/2ml/A	NSAIDs
효능·효과	류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 강직성 척추염, 외상후·수술후 염증 및 동통, 급성통풍, 신 및 간산통	
용법·용량	◆ 성인 : 90mg 을 1 일 1 회(둔부의 상부) IM (중증: 90mg 을 1 일 2 회 양쪽둔부에 주사) ◆ 연령, 질환, 증상에 따라 적절히 증감한다. 심혈관계 이상반응을 최소화하기위해 최단기간동안 최소유효용량을 사용하여야 한다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : NSAIDs ◆ 부작용 : : 쇽증상(가슴동통, 냉한, 호흡곤란, 사지마비감, 혈압강하, 부종, 발진, 가려움증 등), 소화성 궤양, 위장출혈, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 설사 드물게 구내염, 구갈, 변비, 과립구감소, 혈소판감소, 빈혈, 재생불량성 빈혈, 용혈성 빈혈, 출혈경향, 스티븐스-존슨증후군(피부점막안증후군), 리엘증후군(중독성 표피괴사증), 광과민증, 황달, 간장애, GOT&GPT 상승, 급성신부전, 핍뇨, 혈뇨 등의 증상 및 요단백, BUN, 혈중 크레아티닌 상승, 고칼륨혈증, 천식발작, 발진, 두드러기, 두통, 졸음, 현기, 불면, 신경과민, 저림, 착란, 환각, 경련, 시야몽롱, 이명, 혈압상승, 혈압저하, 심계항진, 빈맥, 부종, 전신권태, 발한, 탈모 ◆ 금기 : 소화성 궤양환자, 심한 혈액이상 환자, 심한 간장애 환자, 심한 신장애 환자, 심한 고혈압 환자, 심한 심기능부전 환자, 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자, 관상동맥 우회로술 전후에 발생하는 통증의 치료, 울혈성 심부전환자(NYHA 2-4), 허혈성 심장 질환자, 말초동맥 질환자 및/또는 뇌혈관 질환자 - 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제(COX-2 저해제 포함)에 대하여 천식, 두드러기, 알레르기 반응 또는 그 병력이 있는 환자(이러한 환자에서 비스테로이드성 소염진통제 투여후 치명적인 중증의 아나필락시양 반응이 드물게 보고되었다.) ◆ 주의 : 소화성궤양의 병력이 있는 환자, 혈액이상 또는 그 병력이 있는 환자, 간장애 또는 그 병력이 있는 환자, 신장애 또는 그 병력이 있는 환자, 고혈압 환자, 심기능부전 환자, 과민증의 병력이 있는 환자, 기관지 천식 환자, 궤양성 대장염 환자, 크론병 환자, 식도통과장애 환자, 고령자 및 어린이 ◆ 태아위험도 : 임신 제 1-2 기 C, 제 3 기 D ◆ 상호작용 ① Lithium, Digoxin, MTX 의 작용 증가 ② ACE 저해제, Furosemide 및 Thiazide 계 이뇨제의 작용감소 ③ Steroid: 신장애 등 이상반응 증강 ④ Warfarin : 병용시 상승작용 ① 다른 NSAIDs : 이상반응 위험 증가	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Digoxin inj	
성분/함량	Digoxin 0.25mg/1ml/A	강심제
함량/단위	0.25mg/1ml/A	
효능·효과	◆ 울혈성심부전(폐부종, 심장천식 등 포함) : 판막질환, 고혈압, 허혈성심질환(심근경색, 협심증 등), 선천성심질환, 폐성심(폐혈전, 색전증, 폐기종, 폐섬유증)에 의한 것. ◆ 심방세동·조동에 의한 빈맥, 발작성심방성빈맥 ◆ 심부전 또는 각종 빈맥의 예방 및 치료 ◆ 기타 심질환(심막염, 심근질환 등), 갑상선기능항진증 및 저하증	
용법·용량	◆ 성인 1) 급속 포화요법(포화량 : 1.0-2.0mg) : 디곡신으로서 1 회 0.25-0.5mg 을 2-4 시간마다 정맥주사하고 충분한 효과가 나타날 때까지 계속한다. 2) 완서 포화요법을 사용할 수도 있다. 3) 유지요법 : 1 일 0.25mg 을 정맥주사한다. ◆ 소아 1) 급속 포화요법 ① 신생아, 미숙아 : 1 일 체중 kg당 0.03-0.05mg 을 3-4 회 분할 정맥 또는 근육주사한다. ② 2 세 미만 : 1 일 체중 kg당 0.04-0.06mg 을 3-4 회 분할 정맥 또는 근육주사한다. ③ 2 세 이상 : 1 일 체중 kg당 0.02-0.04mg 을 3-4 회 분할 정맥 또는 근육주사한다. 2) 유지요법 : 포화량의 1/15-1/10 을 정맥 또는 근육주사한다	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Positive inotropic action, negative chronotropic action, AV node 를 통한 전도속도를 감소시킴 ◆ 부작용 : 부정맥, 서맥, 식욕부진, 구역, 구토, 현기, 시각이상 ◆ 금기 : 방실블록(특히 애덤스-스토크스증후군), 동방블록, 경동맥동증후군 환자, 디기탈리스 중독, 폐쇄성 심근병증(특발성 비대성 대동맥판하협착증 등) 환자, 심실빈맥 환자, WPW 증후군 환자 ◆ 상호작용 : Thiazide 계 이뇨제 병용시 hypokalemia 에 의해 심장독성 초래 ◆ 주의 ① 급성 심근경색, 심실성 기외수축, 심내막염, 폐성심, 갑상선기능항진 또는 저하증, 신장애 환자(저용량에서도 중독을 일으키기 쉽고 효과의 발현이 현저하지 않으므로 과량 투여로 중독을 일으킬 위험이 있음.) ② 혈액투석을 받고 있는 환자 ③ 전해질평형실조(저칼륨혈증, 고칼륨혈증, 고칼슘혈증, 저마그네슘혈증) 환자 ④ 동기능부전증후군 환자(동서맥을 유발 또는 악화시키거나 동방블록을 일으킬 수 있다.) ⑤ 중증의 호흡기질환 환자(디기탈리스제제에 대한 심근의 감수성을 증가시킬 수 있다.) ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 차광보관, 축적효과가 큼 ◆ 적용상의 주의 : 빠른 정맥주사는 혈관수축으로 고혈압을 일으키거나 관상혈류가 감소될 수 있다. 그러므로 고혈압성 심부전 및 급성 심근경색시 주사속도를 천천히 하는 것이 중요하다	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Diphereline PR inj	
성분/함량	Triptorelin pamoate 11.25mg/V	항악성종양제
효능·효과	◆ 호르몬의존성 국소진행성 또는 전이성 전립선암 ◆ 생식기 및 외부 생식기의 자궁내막증(1~4 단계) ◆ 중추성 성 조숙증	
용법·용량	◆ 3개월마다 1회 IM ① 자궁내막증: 생리주기 5일째 시작, 치료기간: 최소 3개월~최대 6개월 ② 중추성 성 조숙증의 경우 체중 20kg초과한 소아에 적용	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : triptorelin은 황체 형성 호르몬 방출 호르몬(LHRH or GnRH)의 강력한 유사체로 처방된 용량에서 지속적으로 적용하였을 때 gonadotropin의 분비를 가역적으로 억제함. ◆ 부작용 ① 남성 ㄱ. 치료초기: 비뇨기계 증상, 전이로 인한 골격통증 및 척추전이에 기인한 척수압박 관련 증상 악화 ㄴ. 치료기간 중: 홍조, 성욕감퇴 및 발기부전 ② 여성 ㄱ. 자궁내막증의 증세 악화, 자궁의 부정출혈 ㄴ. 홍조, 질건조, 성욕감퇴 및 이상성감증, 두통, 관절통, 근육통 ◆ 금기 : GnRH 유사약물 과민반응 있는 환자, 임부, 수유부, 호르몬 비의존성 전립선암, 양쪽 고환 절제술을 받은 후, 이 약에 의해 더 이상 testosterone의 감소를 기대할 수 없는 환자, 골다공증 위험 환자, 뇌하수체 샘종 환자 ◆ 주의 신중투여: 고혈압 환자 ◆ 상호작용 프로락틴 수치를 증가시키는 약물: GnRH 수용체의 수치 감소 ◆ 태아위험도 : X ◆ 적용상의 주의 ① 25℃를 초과하여 보관하지 않는다	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Dopamine inj	
성분/함량	Dopamine HCl 200mg/5ml/A	순환기계용제
효능·효과	심근경색, 외상, 내독성패혈증, 수술 후 신장애 만성심대상부전증 (울혈성심부전)으로 인한 쇽, 핍뇨, 무뇨증, 심박출량 감소로 인한 저혈압	
용법·용량	◆ 용량 : 성인 : D5W, N/S 에 0.4mg/ml 이 되게 희석하여 2-5mcg/kg/분으로 IV infusion. (중증시 5-10mcg/kg/분에서 20-50mcg/kg/분까지 증량). ◆ 소아용량 - 신생아 : 1-20mcg/kg/분 - 소아 : 1-20mcg/kg/분(최대용량: 50mcg/kg/분) ◆ 이 약을 투여하기 전에 혈액이나 혈장을 투여하여 정맥압이 10-15 ㎝ H2O, 폐쐐기압이 14-18mmHg 가 되도록 한다. ◆ 체중 kg당 50mcg/분 이상 투여할 경우에는 요량 검사를 자주 한다. ◆ 희석용액 : 정맥주사시 250ml 또는 500ml 의 다음 용액에 희석하여 사용한다. 생리식염주사액, 5% 포도당주사액, 5% 포도당가 0.9% 생리식염주사액, 0.45% 생리식염주사액에 용해시킨 5% 포도당, 젖산함유 링겔액에 용해시킨 5% 포도당, 젖산나트륨주사액, 젖산함유 링겔액 등	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 ① 소량 시 : dopamine 수용체에 직접 작용하여 혈관이완 1-5mcg/kg/분 : renal blood flow□urine output 증가 ② 중간용량 : 5-15mcg/kg/분 renal blood flow, HR, CO, cardiac contractility 증가 ③ 다량 시 : norepinephrine 의 전구물질로 작용하여 심장을 촉진하고 혈관을 수축시킴 >15mcg/kg/분 : α-adrenergic, BP 상승 ◆ 부작용 : 전위성심박, 빈맥, 협심증, 동계, 혈관수축, 저혈압, 호흡곤란, 불안, 오심, 구토, 고질소혈증 ◆ 금기 : 크롬친화세포종, 빈맥성 부정맥환자, 심실세동, 갑상선 중독증, 폐쇄우각형 녹내장환자 ◆ 상호작용 ① MAO inhibitor 와 병용시 초기량을 상용량의 1/10 로 감량 ② Phenothiazine, Butyrophenone : 신동맥혈류 증가 등 이 약 반응 감소 ◆ 주의 : 빈맥성 부정맥, Na 염 함유 주사약과의 혼합, alkali 용액에 희석 (pH 8 이상) 금지 ◆ 배합금기 : Sodium bicarbonate, Acyclovir sodium, Amphotericin B, Ampicillin sodium, Penicillin G potassium ◆ 태아위험도 : C ◆ 비 고 : 차광, 희석 후 24 시간내 사용 ◆ 적용상의 주의 ① 주사부위 조직이 침윤되면 괴사를 일으킬 위험이 있으므로 대정맥에 투여한다. 특히 손등 정맥보다도 팔꿈치 앞의 대정맥에 투여하는 것이 바람직하다. 조직이 침윤되면 교감신경차단제 5-10mg 을 포함한 10-15ml 생리식염주사액을 투여한다. ② 희석하여 사용시 제조후 24 시간 동안 안전하나 사용시 제조하여 사용한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Dopamix inj	
성분/함량	Dopamine HCl 400mg, Dextrose 10g/200ml/Bag	순환기계용제
효능·효과	심근경색, 외상, 내독성패혈증, 수술 후 신장애 만성심대상부전증 (울혈성심부전)으로 인한 쇽, 핍뇨, 무뇨증, 심박출량 감소로 인한 저혈압	
용법·용량	◆ 용량 : 2.5mcg/kg/분으로 정맥주사 (중증시 5-10mcg/kg/분에서 20-50mcg/kg/분까지 증량) ◆ 소아용량 - 신생아: 1-20mcg/kg/분 - 소아: 1-20mcg/kg/분(최대용량: 50mcg/kg/분) ◆ 이 약을 투여하기 전에 혈액이나 혈장을 투여하여 정맥압이 10-15 ㎝ H2O, 폐쐐기압이 14-18mmHg 가 되도록 한다. ◆ 체중 kg당 50mcg/분 이상 투여할 경우에는 요량 검사를 자주 한다. ◆ 환자 치료시 혈량, 심내막 수축의 증대 및 말초혈관 관류의 분배에 대한 치료방법을 지속적으로 평가한다. 도파민의 용량을 감소하고 있거나 일시적으로 유지되고 있는 용량에 대한 지표인 소변유속의 감소, 빈맥증가 또는 새로운 율동부정으로 발전에 특별히 주의하면서 환자의 반응에 따라 조정한다. 모든 강력한 정맥 투여약물은 주입속도를 조절하는 것을 주의하여 부주의한 일시투여를 피한다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 ① 소량 시 : dopamine 수용체에 직접 작용하여 혈관이완 1-5mcg/kg/분: renal blood flow□urine output 증가 ② 중간용량 : 5-15mcg/kg/분 renal blood flow, HR, CO, cardiac contractility 증가 ③ 다량 시 : norepinephrine 의 전구물질로 작용하여 심장을 촉진하고 혈관을 수축시킴 >15mcg/kg/분: α-adrenergic, BP 상승 ◆ 부작용 : 전위성심박, 빈맥, 협심증, 동계, 혈관수축, 저혈압, 호흡곤란, 불안, 오심, 구토, 고질소혈증 ◆ 금기 : 크롬친화세포종, 빈맥성 부정맥환자, 심실세동, 갑상선 중독증, 폐쇄우각형 녹내장환자 ◆ 상호작용 ① MAO inhibitor 와 병용시 초기량을 상용량의 1/10 로 감량 ② Phenothiazine, Butyrophenone : 신동맥혈류 증가 등 이 약 반응 감소 ◆ 주의 : 빈맥성 부정맥, Na 염 함유 주사약과의 혼합, alkali 용액에 희석 (pH 8 이상) 금지 ◆ 배합금기 : Sodium bicarbonate, Acyclovir sodium, Amphotericin B, Ampicillin sodium, Penicillin G potassium ◆ 태아위험도 : C ◆ 과량투여시의 처치 - 우발적인 과량투여시에 심한 혈압 상승이 나타나면 환자의 상태가 안정될 때까지 투여 속도를 감소시키거나 염산 도파민을 일시적으로 중단 - 염산 도파민의 작용 지속 시간은 매우 짧기 때문에 보통 추가적인 치료 조치는 불필요 - 처치 후에도 환자의 상태를 안정화시키지 못하는 경우 단시간 작용하는 알파-아드레날린 차단제인 펜톨아민을 사용하는 것을 고려해야 한다. ◆ 적용상의 주의 : 주사부위 조직이 침윤되면 괴사를 일으킬 위험이 있으므로 대정맥에 투여한다. 특히 손등 정맥보다도 팔꿈치앞의 대정맥에 투여하는 것이 바람직하다. 조직이 침윤되면 교감신경차단제 5-10mg을 포함한 10-15ml 생리식염주사액을 투여한다.	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	DTAP vaccine inj	
성분/함량	Diphtheria toxoid 16.7Lf,Tetanus toxoid 26.7mcg,Pertussis toxoid 4IU 0.5ml/Syringe	백일해, 디프테리아, 파상풍 백신
효능·효과	백일해, 디프테리아, 파상풍의 예방	
용법·용량	IM 또는 SC ① 기본접종 : 1 회 용량 0.5ml 씩 생후 2, 4, 6 개월에 3 회 접종 ② 추가접종 : 18 개월과 4-6 세에 접종	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 항독소 (antitoxin)는 독소와 결합하여 이를 중화시키는 항체를 의미하며 수동면역제로 이용 ◆ 부작용 : 통증, 발적, 종창, 발열, 구토, 설사, 식욕저하, 졸음, 불면, 기침, 인후염, 상기도염, 기관지염, 중이염, 치메로살(유기수은제제)을 함유하고 있어 과민반응이 일어날 수 있음 ◆ 금기 ① 발열이 있는 자 또는 현저한 영양장애자 ② 심혈관계, 신질환 또는 간질환 혈액질환 및 발육장해 등의 기초질환 환자로서 해당질환이 급성기, 중악기 또는 활동기에 있는 자 ③ 이 약 접종에 의해 이상한 부작용을 나타낸 일이 있는 자 ④ 이전의 접종에서 2 일 이내에 발열을 나타냈던 일이 있는 자 또는 전신성 발진 등의 알레르기가 의심되는 증상을 나타냈던 일이 있는 자 ⑤ 접종 전 1 년 이내에 경련증상을 나타낸 일이 있는 자 및 간질과 같은 신경장애 가능성이 있는 환자 ⑥ 진행성 퇴행신경성 질환 환자 ⑦ 간질 또는 중추신경계의 유전적 질환의 가족력이 있는 자 ⑧ 최초 투여시 중추신경계 부작용이 우려되었던 환자 ⑨ 과거에 면역부전의 진단을 받은적이 있는 자 ⑩ 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 ⑪ 신생아 ⑫ 가사(질식) 또는 저혈당증의 병력이 있는 소아 ⑬ 기타 예방접종 실시가 부적당한 상태에 있는 자 ◆ 상호작용 이 백신과 B 형 간염이나 헤모필루스 인플루엔자비형(Hib) 백신을 혼합 접종하지 않음(혼합제품 제외) ; 혼합 시 각 백신의 안전성 및 유효성에 부정적인 영향을 주어 백신 접종 효과가 약화 또는 무효화되기도 한다. 또한 외국에서 두백신을 혼합접종하여 헤모필루스성 수막염이 발생하였다는 보고가 있다. ◆ 주의 : 빈맥성 부정맥, Na 염 함유 주사약과의 혼합, alkali 용액에 희석 (pH 8 이상) 금지 ◆ 배합금기 : Sodium bicarbonate, Acyclovir sodium, Amphotericin B, Ampicillin sodium, Penicillin G potassium ◆ 태아위험도 : C ◆ 비 고 : 냉장보관, 동결 금지, IV 금지 ◆ 적용상의 주의 ① 냉장고에서 꺼내 실온으로 한 다음 잘 흔들어 균등하게 사용한다. 특히 이 약은 침강되기 쉬우므로 사용할 때마다 흔들어 사용한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Duratocin RTS inj	
성분/함량	Carbetocin 100mcg/1ml/A	자궁수축제
효능·효과	경막외 또는 마취하에 실시하는 선택적 제왕절개술에 따르는 자궁 무력증 및 출산후 출혈의 방지	
용법·용량	제왕절개술로 태아 만출 후, 카르베토신으로서 100 마이크로그램(1mL)을 1 분에 걸쳐 1 회 정맥주사한다	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Oxytocin 의 합성유도체로서 자궁평활근 상에 존재하는 oxytocin 수용체에 결합하여 수축빈도를 증가시키고 수축강도를 증가시킴으로써 자궁을 수축시킴 ◆ 부작용 : 복통, 두통, 배부통, 요통, 구역, 구토, 저혈압, 열감, 홍조, 심계항진, 빈혈, 호흡곤란, 진전, 불안, 현기증, 오한, 분만후 출혈, 금속성 미각 ◆ 금기 : 분만 전 투여 금기(분만 유도 포함), Oxytocin 또는 이 약의 과민증 기왕력자, 관상동맥 질환자, 간·신질환, 소아, 전자간증 및 자간증 환자 ◆ 상호작용 : 구조적으로 Oxytocin 과 매우 비슷하기 때문에 Oxytocin 에서 발생한 약물상호작용 중 일부가 일어날 가능성이 있음 ① 미추마취와 함께 혈관수축제를 예방적으로 투여하고 3-4 시간 후에 Oxytocin 투여시 심각한 고혈압이 보고됨 ② Cyclopropane 마취는 Oxytocin 의 심혈관 효과를 변화시켜, 저혈압과 모체의 비정상적인 방실리듬을 수반한 동성 서맥이 보고됨 ◆ 주의 : 환자에 따라 이 약 1 회 투여로 적절한 자궁수축을 나타내지 않는 경우 이 약의 반복 투여 금기 (Ergometrine 또는 고용량 Oxytocin 등의 더 적극적인 처치를 해야 함) ◆ 비고 ① 출산 후 7-14 주에 이 약 70mcg 을 IM 투여한 수유부에서 소량이 혈장에서 유즙으로 이행한 것이 보고됨 ② 차광, 실온(1~30℃)보관 ◆ 과량투여시의 처치 - 카르베토신은 구조적으로 옥시토신과 매우 유사하므로, 이 약을 출산 후에 과량투여할 경우 옥시토신 과량투여와 유사하게 자궁의 과잉반응으로 인한 자궁 파열, 분만 후 출혈 및 통증을 유발할 수 있으며, 특히 동시에 많은 양의 액제를 투여받은 환자에서는 저나트륨혈증 및 중독증상이 나타날 수 있다 - 과량투여시에는 대증요법 및 보조 요법으로 처치한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Emend inj	
성분/함량	Fosaprepitant dimeglumine 150mg/V	최토제, 진토제
효능·효과	1. 항암 화학요법에 의한 구역과 구토(CINV)의 예방 다른 항구토제와 병용하여 다음과 같은 경우에 투여한다. -심한 구토유발성 항암화학요법(HEC, Highly Emetogenic Chemotherapy) (예, 고용량의 시스플라틴)의 초기 및 반복치료에 의한 급성 및 지연형 구역 및 구토의 예방 -중등도 구토유발성 항암화학요법(MEC, Moderately Emetogenic Chemotherapy)의 초기 및 반복치료에 의한 지연형 구역 및 구토의 예방 2. 사용 한계 이 약은 이미 발생한 구역과 구토의 치료에 대하여 연구된 바 없다.	
용법·용량	◆ 화학요법 치료 첫째날에만 화학요법제가 투여되기 30분전에 20~30분에 걸쳐 정맥주입. 코르티코스테로이드 및 5-HT3 길항제 병용 - 고령자, 중증의 신장애 환자, 혈액투석을 받는 말기의 신장 질환자, 경증 내지 중등도의 간장애 환자 용량 조절 불필요	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : fosaprepitant는 aprepitant의 prodrug으로 human substance P/neurokinin 1(NK-1) receptors에 대해 선택적이고 매우 높은 친화력을 지니는 길항제이다. aprepitant는 serotonin(5-HT3), dopamine, corticosteroid receptors에 친화력이 미미하거나 없으며 화학요법 유도성 메스꺼움 및 구토(CINV)를 치료하는데 쓰임. ◆ 부작용 : 중증 변비, 탈수, 설사 또는 묽은 변, 경련을 동반한 복부통증(복통), 공복감을 느끼지 못함, 딸꾹질, 주사부위 염증, 피로감, 무력감, ALT상승, 어지러움, 두통, 식욕부진 ◆ 금기 1) 이 약, 아프레피탄트, 폴리소르베이트80 및 기타 이 약 성분에 과민한 자 2) 아프레피탄트는 CYP3A4의 중등도의 저해제이다. 이 약은 빠르게 아프레피탄트로 전환되므로 pimozide, terfenadine, astemizole 등과 동시에 투여해서는 안됨. 아프레피탄트가 CYP3A4를 저해함으로써 이들 약물의 혈중 농도가 상승할 수 있으며 이에 따라 중증 또는 생명을 위협하는 결과를 초래할 수 있음. 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됨. ◆ 태아위험도: B ◆ 비고: 밀봉용기, 냉장보관(2~8℃) ◆ 적용상의 주의: ① 생리식염수 5ml 바이알벽을 따라 흐르도록 주입, 가볍게 흔듦. (거품방지) ② 145ml의 생리식염수가 든 주입백에 전량 옮김. (최종 농도 1mg/ml) 가볍게 2~3회 흔듦 ③ 재현탁된 최종 약물 용액 실온(25℃ 이하)에서 24시간동안 안정

약품명	**EpheDRINE inj**	
성분/함량	**Ephedrine HCl 40mg/1ml/A**	**기관지 확장제, 비충혈제거제**
효능·효과	기관지천식, 감기, 급·만성기관지염, 상기도염에서의 기침, 비점막의 충혈·종창, 척추마취시 혈압강하, 급성 저혈압	
용법·용량	◆ 성인 : 1 회 25-40mg 을 1-2 회/일 SC	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : α, β 수용체 효능약으로 기관지확장, 비점막혈관수축, CO BP↑, 뇨저류 ◆ 임상응용 : 기관지 천식, 비점막 충혈, 종창, 감기, 급 만성기관지염, 척추마취시 혈압강하 ◆ 부작용 : 혈압상승, 심계항진, 부정맥, 어지러움, 두통 ◆ 금기 : 고혈압, 녹내장, 갑상선 기능 항진증, 당뇨병, 전립선비대, 크롬친화세포종, MAOI 투여중인 자(2 주 이내 중지한 자 포함), 허혈심장병 ◆ 상호작용 ① 갑상선제제: 이 약 작용 증가 ② Halothane 등: 심실성 부정맥 ③ Epinephrine, Isoproterenol: 부정맥, 심정지	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

	◆ 주의 : 용법·용량에 맞게 투여하여도 효과가 나타나지 않는 경우 투여 중지 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 차광 ◆ 적용상의 주의 : 특수한 경우를 제외하고는 정맥주사 및 유제로 사용하지 않는다.

약품명	**Epinephrine inj**	
성분/함량	**Epinephrine HCl 1mg/1ml/A**	**혈관수축제, 천식치료제**
효능·효과	기관지 천식 발작의 완화, 혈청병·두드러기·맥관신경성 부종의 증상 완화, 약물에 의한 쇽·심정지의 보조치료, 국소마취제 효력의 지속	
용법·용량	0.1% 주사액으로서 1 회에 다음의 양을 사용한다. ◆ SC, IM : 1 회 0.2-1.0mL 투여한다. ◆ IV : 심정지 등 긴급시에는 0.25mL 를 넘지 않는 범위 내에서 NS 등에 희석하여 천천히 주사 ◆ 국소마취제와 병용시 : 국소마취제 10mL 에 이 약 1-2 방울의 비율로 첨가하여 사용한다.	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : α, β adrenaline 성 수용체에 직접 결합하여 교감신경흥분작용 나타냄 (α_1, α_2, β_1, β_2 adrenergic receptor stimulant) ◆ 부작용 : 심계항진, 두통, 어지러움, 불안, 진전, 구역, 구토, 호흡곤란, 주사부위괴사, 안검, 결막의 색소침착, 혈관경련(점안, 결막하 주사시) ◆ 금기 : 동맥경화증, 기질성심장질환, 심확장, 만성 cocaine 중독, 객혈, 분만도중, 녹내장, 고혈압, 전립선 선종, 기질성뇌손상, 정신신경증, 갑상선기능항진, 당뇨병, 심인성·외상성·출혈성 쇽, 크롬친화세포종, 중증 신기능 장애, 폐성심, 손가락, 발가락, 코, 음경부위 마취 환자 ◆ 상호작용 ① Catecholamine 류: 부정맥, 심정지 유발 ② Halogen 함유 흡입마취제: 빈맥, 심실세동, 급성폐부종 ③ 항정신병약(Risperidone, Phenothiazine, Butyrophenone): 저혈압 ④ MAOI, TCAs, 분만촉진제: 혈압이상 상승 ⑤ Digitalis: 이소성 부정맥 ◆ 태아위험도 : C ◆ 과량투여시의 처치 - 증상 : 중증 고혈압, 심부정맥, 폐부종, 뇌출혈, 심실세동, 신혈관 이상수축에 의해 신기능 정지, 심지어 사망까지도 초래할 수 있음 - 처치 : 라베테롤과 같은 알파, 베타 교감신경차단제를 병용투여한다. 또는 속효성 혈관확장제(질산염, 니트로프루시드나트륨)를 투여 ◆ 적용상의 주의 ① 정맥주사시 혈압이상상승이 초래되지 않도록 신중하게 주사 ② 피하주사시 많은 양을 한번에 투여하는 것보다 소량씩 시간을 두고 주사하는 것이 바람직 ③ 알칼리제, 산화제, 중조, 질산은, 바르비탈계 약물, 포르말린, 요오드틴크 등과는 혼합해서 사용하지 않는다. ④ 점적정맥주사시 대량의 주사액이 혈관 밖으로 유출되었을 경우 국소 허혈성 괴사가 나타날 수 있으므로 주사부위를 자주 체크한다. 만약 주사액이 혈관 밖으로 유출되었을 경우 즉시 펜톨아민을 투여한다. ◆ 저장상의 주의사항 ① 산화되기 쉽고 산화에 의해 갈색 또는 담황색으로 변하기 쉬움 (특히 공기, 빛, 열, 알칼리에 의하여 촉진) ② 차광하여 냉소 보관

약품명	**Eruvin inj**	
성분/함량	**Methylergonovine maleate 200mcg/1ml/A**	**자궁수축제**
효능·효과	다음의 경우 출혈의 방지 및 치료: 태반만출 후, 분만 후, 제왕절개술 후, 유산 후 출혈, 자궁퇴축부전	
용법·용량	1 회 0.1-0.2mg 을 IV 또는 1 회 0.2mg 을 SC, IM 한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 자궁 평활근에 직접 선택적으로 작용하여 수축시켜 분만 후의 출혈량 감소시킴 ◆ 부작용 : 위장 장애, 혈압 상승, 빈맥, 두통, 졸음, 현기증, 이명, 흉부압박감, 피부발진, 구역, 구토, 복통, 설사, 말초혈관경련, 발한, 쇽, 자궁수축에 의한 복통 ◆ 금기 : 임부, 분만중인 여성, 자간환자, 분만유도, 아두만출전, 고혈압, 임신중독증, 중증 허혈성 심질환, 폐색성 혈관질환, 중증 전염상태, 패혈증환자 ◆ 상호작용 ① Bromocriptine, 교감신경효능약, Macrolide 계, TC 계는 혈관수축작용이 증가 ② Oxytocin, PG: 고혈압 ③ β-blocker: 말초혈액 공급장애의 위험성 증가 ◆ 주의 ① 심·간·신질환 ② 주사시 60 초 이상 혈압을 관찰함 ③ IA 주사 금지 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 차광보관, 냉장(2-8℃) 보관 ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 구역, 구토, 불안감을 동반하는 급성 위염, 오한, 창백, 어지러움, 고혈압 또는 저혈압, 말초혈관수축, 사지의 마비, 자통, 통증, 호흡기능저하, 경련, 혼수 ② 처치 : 경구투여한 경우에는 위세척에 의해 약물을 제거한 후 활성탄을 투여한다. 증상의 치료는 심혈관 및 호흡기능을 엄격히 감독하면서 실시하며 안정이 필요하다면 벤조디아제핀을 사용할 수 있다. 중증의 동맥경련이 나타나면 니트로프루시드나트륨, 펜톨아민, 디히드랄라진 등 혈관확장제를 투여한다. 관상동맥 수축시 즉시 질산염류 등의 협심증치료제를 투여한다. ◆ 적용상의 주의 ① 60 초 이상 혈압을 주의깊게 관찰하면서 정맥주사시 천천히 주사한다. ② 근육주사시 조직, 신경에 대한 영향을 피하면서 다음 사항에 주의한다. - 신경 주행부위를 피하고, 주사침을 삽입할 때 신경을 건드리는 듯한 통증을 호소할 경우에는 즉시 부위를 바꾸어 주사한다. - 반복 주사할 경우에는 좌·우로 바꾸어서 주사하거나, 주사부위를 변경하면서 주사한다. ③ 동맥내 주사나 동맥주위 주사는 피한다.

약품명	**Etomidate lipuro inj**	
성분/함량	**Etomidate 2mg/mL/A**	**정맥마취제**
효능·효과	◆ 전신마취 유도제	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

용법·용량	◆ 성인 : 에토미데이트로서 1 회 체중 kg 당 0.15~0.3 mg 을 정맥투여 한다. ◆ 2 세 이상 어린이부터 15 세 이하의 청소년 및 고령자 : 에토미데이트로서 1 회 체중 kg 당 0.15~0.2 mg 을 정맥투여 한다. ◆ 반드시 정맥투여하고 일반적으로 서서히(1 회 투여시간 30 초)투여하고 필요에 따라 분할 투여한다.
약리작용	마취 유도를 위한 초단시간 작용하는 non-barbiturate hypnotic, 화학적으로는 carboxylated imidazole 이며 최소한의 심혈관 및 호흡기계의 작용으로 빠르게 마취를 유도함. 빠르게 분포, 대사되고 배설됨. 다른 단시간 작용 유도 마취제, 특히 barbiturate 류와는 다르게 히스타민을 방출하지 않음
사용상의 주의사항	◆ 부작용 ① 주사부위의 통증, 메스꺼움, 구토, 딸국질, 오한 등이 나타날 수 있음 ② 간대성 근경련, 후두경련, 기관지 경련, 떨림, 심부정맥, 일시적인 혈압강하와 같은 드물지만 심각한 부작용이 나타나면 의사에게 즉시 알림 ③ 드물기는 하지만 심각한 알레르기 반응의 증상에는 발진, 가려움/부종(특히 얼굴/혀/목구멍), 심한 어지러움, 호흡곤란 나타날수 있음 ◆ 금기 ① 신생아와 2 세 미만의 영유아 ② Heme 생합성에 장애가 있는 환자 ③ 임부 사용 금기 (Category: C) ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 차광하여 25℃ 이하 실온보관 ◆ 적용상의 주의 ① 투여 전 이 약이나 지질유제에 알레르기가 있거나 그 밖에 다른 알레르기가 있을 경우, 대두유, 콩 또는 땅콩에 알레르기가 있을 경우 사용 주의 ② 동맥 내 투여 시 괴사 초래 될 수 있으므로 동맥 내 주사는 반드시 피하며 천천히 주입한다. ③ 이 약 투여 후 24 시간 동안 이 약으로 인해 어지럽거나 졸릴 수 있으므로 운전이나 기계조작과 같이 집중력을 요하는 활동을 피하고 알코올성 음료의 섭취를 제한. ④ 이 약은 모유로 분비됩니다. 수유기간 동안 이 약을 사용해야 하는 경우는 수유를 중지하고 이 약 투여 후 24 시간 안에는 수유하지 마십시오. 이 기간 중의 모유는 짜서 버리십시오. 경우) 등에는 신중히 투여할 것

약품명	**Euhib inj**	
성분/함량	**Haemophilus influenza type B polysaccharide conjugated with tetanus toxoid 30~50mcg 0.5ml/V**	**헤모필루스인플루엔자 B형 백신**

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

효능·효과	◆ 2 개월 이상의 영아에서 헤모필루스 인플루엔자 비형(Haemophilus influenza type B)에 의한 침습성 감염증의 예방
용법·용량	◆ 대퇴부 전외측에 근육주사 ◆ 기초접종 : 1회 0.5ml 씩 생후 2, 4, 6개월에 3회 접종 ◆ 추가접종 : 생후 12~15개월에 1회 0.5ml를 접종
사용상의 주의사항	◆ 부작용 : 주사부위의 경미한 발적, 통증 및 부종, 발열, 과민흥분/불안, 지속적인 울음, 식욕부진, 구토, 설사, 졸림 등 ◆ 금기 : 급성 열성 질환자, 급성 감염이 있는 환자, 이 백신이나 파상풍 톡소이드를 포함하는 백신 또는 이 백신 제제 중 어떠한 성분에 대해서라도 과민반응 증상이 나타났던 자, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자(유당함유) ◆ 상호작용 : 본 제제는 디프테리아, 파상풍 톡소이드 및 정제 백일해 백신과 동시에 또는 1~2주의 간격을 두고 접종할 수 있으며, 투여 부위는 다르게 해야 함. ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 냉장(2~8℃) 보관 ◆ 적용상의 주의 ① 첨부용제로 동결건조 약물을 용해한 후 충분하게 흔들어 균질하게 혼합하고, 용해 후 즉시 접종할 것 ② 정맥 투여하여서는 안되며 둔부에 주사하지 않는다.

약품명	**Euvax B PFS inj, Euvax B inj (소아용)**	
성분/함량	**Hepatitis B type surface antigen 20mcg/1ml/Syringe** **Hepatitis B type surface antigen 10mcg/0.5ml/V (소아용)**	**B형 간염 백신**

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

효능·효과	◆ B 형 간염의 예방
용법·용량	◆ 성인 1회 1ml (20mcg), 신생아 및 유·소아 1회 0.5ml (10mcg)을 근육주사 ◆ 기본 면역 ① 1차 접종 : 접종 개시일 ② 2차 접종 : 1차 접종 1개월 후 ③ 3차 접종 : 1차 접종 6개월 후 (단, 감염 노출의 위험이 높은 경우나 기본 면역 일정에 맞출 수 없는 부득이한 경우 등 조속한 면역 획득이 필요한 경우에는 1개월 간격으로 3회 근육주사 가능)
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 본 백신은 Hepatitis B virus의 purified surface Ag을 함유한 비감염성 DNA 재조합 Hepatitis B vaccine 임. ◆ 부작용 ① 국소반응(홍반, 통증, 종창 등), 발열, 권태감, 피로감, 두통, 구역, 구토, 어지러움, 근육통, 관절통 등 ② 본제는 치메로살을 함유하고 있어 이에 의한 과민반응이 나타날 수 있음 ◆ 금기 : 이 약의 조성에 과민성인 사람, 치메로살에 과민증인 사람, 급성 중증 질환자, 급성 열성 감염증 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 냉장 보관 (2~8℃) ◆ 적용상의 주의 ① 이 약은 현탁액이므로 투여 전 잘 흔들어 균질한 상태로 만든 후 사용할 것 ② 잠복기 및 진행성인 B형 간염 환자에게는 면역효과를 기대할 수 없으므로 충분히 고려할 것 ③ 혈액투석환자나 면역기능이 손상된 환자는 일차적인 접종(3회) 후에도 적절한 항체농도를 얻을 수 없으므로 추가 접종 필요할 수 있음 ④ 항체가 10mIU/mL 이하일 경우 추가접종 고려

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	**Euvichol plus**	
성분/함량	**Inactivated cholera vaccine**	**콜레라 백신**
효능·효과	◆ 1 세 이상의 소아, 청소년 및 성인에서 Vibrio cholerae 에 의해 발병되는 콜레라의 예방	
용법·용량	-투여방법 : 1세 이상의 소아, 청소년 및 성인에게 한 튜브(1.5mL) 전량을 경구 투여 필요시 물 한 모금 정도 섭취 가능 -투여일정 : 2주 간격으로 2회 경구로 투여	
사용상의 주의사항	◆ 부작용 : 복통,치통,설사,발열,비인두염,두통,기침,가려움증 ◆ 주의사항 1) 이 백신은 비경구적으로 투여해서는 안 된다. 반드시 경구투여 해야 한다. 2) 이 백신은 현탁액(부유액)으로 존재한다. 튜브를 격렬히 흔든 후 1.5mL를 피접종자의 구강으로 투여하고 필요 시 물을 마신다. 5) 이 백신은 미량의 포름알데히드가 포함 되어 있기 때문에 과민성을 가진 대상자에게 투여 시 주의가 요구된다. 6) HIV/에이즈 감염 환자 : HIV/에이즈 환자를 대상으로 한 안전성과 면역반응은 임상적으로 평가되지 않았다. ◆ 금기 1) 백신 성분에 대하여 과민반응이 있거나, 이전 접종 시 과민성 징후를 보인 경우 투여해서는 안 된다. 2) 급성 위장관 질환이나 급성 열성 질환이 있으면 투여를 연기해야 한다. ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 냉장 보관 (2~8℃), 동결금지	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Eylea PFS inj	
성분/함량	Aflibercept 7.08mg/0.177ml/syr	항혈관신생제
효능·효과	◆ 신생혈관성 (습성) 연령 관련 황반변성의 치료 ◆ 중심막막정맥폐쇄성 황반부종의 치료 ◆ 당뇨병성 황반부종, 망막병증의 치료 ◆ 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상의 치료	
용법·용량	◆ 유리체내 주사로 투여 ◆ 신생혈관성 (습성) 연령 관련 황반변성의 치료 ① 2mg (이 약 50 mcL 와 동일) 을 첫 3개월 동안 매월 1회 주사 -> 이후 2개월마다 1회 주사 ② 장기사용 (처음 12개월 사용 이후) 시, 계속해서 2개월마다 주사하는 것이 권장 ◆ 중심망막정맥폐쇄성 황반부족의 치료 ① 2mg (이 약 50 mcL 와 동일) 을 처음 주사 후 1달에 1회 주사 (주사 간격은 1개월 미만이 되어서는 안됨) ② 시력 및 해부학적 검사를 1개월 간격으로 3회 평가하여 안정될 때까지 주사 ◆ 당뇨병성 황반부종의 치료 ① 2mg (이 약 50 mcL 와 동일) 을 첫 5개월 동안 매월 1회 주사 -> 이후 2개월마다 1회 주사	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Angiogenic VEGF (Vascular endothelial growth factor)에 결합 -> 혈관신생 및 혈관투과성 저해 ◆ 부작용 : 결막 출혈, 눈 통증, 유리체 박리, 백내장, 유리체 부유물, 안압상승 등 ◆ 금기 : 안구 또는 안구 주변 감염환자, 활동성 중증의 안내 염증이 있는 환자, 이 약에 과민증 있는 환자 ◆ 주의 ① 이 약의 유리체내 주사 및 눈 검진 후 일시적 시력 장애가 나타날 수 있으므로, 시력이 충분히 회복될 때까지 운전이나 기계조작은 피하도록 해야 함 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 냉장(2~8℃)보관 (사용 전 미개봉된 이 약의 바이알은 24시간까지 실온(25℃)에서 보관 가능 ② 차광을 위해 프리필드시린지를 원래의 상자에 보관 ◆ 적용상의 주의 ① 다른 의약품과 혼합해서는 안됨 ② 1회 투여용으로만 사용	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

<table>
<tr><td>약품명</td><td colspan="2">Ferinject inj</td></tr>
<tr><td>성분/함량</td><td>Ferric hydroxide carboxymaltose complex 500mg/10ml/V</td><td>빈혈치료제</td></tr>
<tr><td>효능·효과</td><td colspan="2">◆ 경구용 철분제제의 효과가 불충분하거나 복용이 불가능한 철 결핍환자</td></tr>
<tr><td>용법·용량</td><td colspan="2">① 이 약의 총 투여량은 헤모글로빈 수치 및 체중에 따라 개인별로 결정
<table>
<tr><td>Hb (g/dL)</td><td>체중 35kg 이상 70kg 미만</td><td>체중 70kg 이상</td></tr>
<tr><td><10</td><td>1,500mg</td><td>2,000mg</td></tr>
<tr><td>≥10</td><td>1,000mg</td><td>1,500mg</td></tr>
</table>
② IV(정맥직접주사)
ㄱ. Fe로서1,000mg까지 희석하지 않은 용액으로 IV 가능
ㄴ. 투여속도: 200-500mg: 100mg/min 이하, 500-1,000mg: 15분 이상
③ IV infusion(정맥점적주사)
ㄱ. 1회 Fe로서 1,000mg까지 IVF 가능
ㄴ. 0.9% N/S로 희석, 2mg/ml보다 낮은 농도로 희석해서는 안됨
④ 주의:
ㄱ. 체중 35kg 미만: 총 철 투여량이 500mg을 초과해서는 안됨
ㄴ. 과체중: 철 필요량을 결정할 때 정상 체중/혈액량의 관계 추정해야함
ㄷ. Hb 14 g/dL 이상인 환자: 초회 용량으로 500mg의 철을 투여하고, 반복 투여 전에 철분 관련 지표를 확인함
⑤ 최대 1회 투여량
ㄱ. 1회 1일 Fe로서 1,000 mg(20 mL) 또는 Fe로서 20 mg/kg(0.4mL/kg): Fe로서 1,000 mg(20 mL)의 투여는 1주 1회를 초과하여서는 안됨
ㄴ. 혈액투석-의존성 만성 신장질환 환자에의 투여: 1일 1회 Fe로서 200mg(4mL)</td></tr>
<tr><td>사용상의 주의사항</td><td colspan="2">◆ 부작용 : 두통, 어지러움, 고혈압, 오심, 주사부위 반응, ALT 증가, 저인산혈증, 과민반응, 감각 또는 미각이상, 심계항진, 저혈압, 홍조, 호흡곤란, 구토, 소화불량, 복통, 변비, 설사, 가려움증, 두드러기, 홍반, 발진, 근육통, 요통, 관절통, 근육경련, 발열, 피로, 흉통, 말초성 부종, 통증, 오한
◆ 금기
① 다른 비경구 철 제제에 대한 중대한 과민반응이 알려진 환자
② 철 결핍증 이외의 빈혈환자
③ 철분 과다 또는 철 이용 장애 환자
④ 진행형 세균혈증 환자
◆ 상호작용
경구용 철분제제: 경구용 철분제제의 흡수가 저해되므로 이 약 마지막 투여 후 최소 5일 후 경구용 철분제제 복용
◆ 태아위험도 : C
◆ 비고
① 기밀용기, 실온(1-30℃) 보관. 냉장보관하거나 얼리지 말 것
② 약액 누출시 이 약의 투여 즉시 중단
③ 개봉 또는 희석 후 즉시 사용
④ 희석액: N/S만 가능
⑤ 용기: 폴리에틸렌 및 유리 용기
⑥ 나트륨 조절 식이 환자 주의(이 약 1 mL에는 5.5 mg (0.24 mmol) 까지의 Na 함유)
⑦ 임신초기 3개월에 나타나는 철분 부족의 경우 대부분 경구철분제제의 투여로 치료 가능, 이 약의 치료는 모체와 태아 모두에게 유익성이 잠재적 위해성을 상회한다고 판단되는 경우에 임신 2기 및 3기로 제한되어야 함</td></tr>
</table>

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Fibrinogen	
성분/함량	human fibrinogen 1g/V	지혈제(Fibrinogen)
효능·효과	선천성 저·무 피브리노겐혈증, 후천성 저피브노겐혈증	
용법·용량	◆ 1회 3 g을 주사용수로 용해하여 정맥주사 한다. 증상에 따라 혈장 피브리노겐 양이 될 때까지 반복한다. 체중, 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.	
사용상의 주의사항	◆ 금기: 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자 ◆ 신중투여: 1) 용혈성, 실혈성 빈혈 환자(사람 파르보바이러스 B19의 감염을 일으킬 가능성을 부정할 수 없다. 감염된 경우 발열, 급격하고 심한 빈혈을 수반한 위급한 전신 증상을 일으킬 수 있다) 2) 면역부전 환자, 면역결핍 환자(사람 파르보바이러스 B19의 감염을 일으킬 가능성을 부정할 수 없다. 감염된 경우 지속성 빈혈이 나타날 수 있다) ◆ 부작용 1) 과민반응 : 오한, 발열 등의 증상이 나타날 수 있다. 2) 아나필락시스 : 투여에 의해 아나필락시스 쇼크를 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 호흡곤란, 쌕쌕거림, 흉부불쾌감, 혈압저하, 맥박미약, 청색증 등이 보이는 경우에는 중지하고 적절한 처치를 한다. 3) 혈전색전증 : 혈전색전증(심부정맥혈전증, 장간막혈전증, 폐색전증 등)이 나타날 수 있으므로 혈중 피브리노겐 농도, 혈소판수, 혈액응고능력(프로트롬빈 시간 등) 등의 혈액검사를 하는 등 관찰을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 적절한 처치를 한다. ◆ 일반적 주의 1) 이 약의 투여에 의해 비A형, 비B형 간염 등의 바이러스 감염증이 보고되어 있으므로 관찰을 충분히 하고 간장애가 나타나는 경우에는 적절한 처치를 한다. 이 약은 가열처리를 실시하지 않은 점에 유의하여 사용 시에는 환자의 위험성과 투여에 의한 치료상의 유익성을 고려한다. 2) 혈장분획제제의 현재의 제조공정에서는 사람 파르보바이러스 B19 등의 바이러스완전하게 불활성화, 제거하는 것이 곤란하여 이 약의 투여에 있어서는 그 감염가능성을 부정할 수 없으므로 투여 후의 경과를 충분히 관찰한다. 3) 사용 시에는 질병의 치료에서 이 약의 필요성과 더불어 제조 시 감염증의 전파를 방지하기 위한 안전대책이 취해져 있으나 사람의 혈액을 원재료로 하고 있는 것에 유래하는 감염증 전파의 위험을 완전히 배제할 수 없음을 환자에게 설명하고 그 이해를 얻도록 노력한다. 4) 이 약은 선천성 피브리노겐 혈증에 피브리노겐 수치가 현저하게 저하되고 있는 환자에 대하여 사용하는 것임에 유의하여 투여한다. ◆ 적용상의 주의 1) 미세 여과망 수혈 세트를 사용하여 투여한다. 2) 주사속도가 빠르면 청색증, 두근거림 또는 혈관 내 응고에 의한 혈전을 일으킬 수 있으므로 가능한 천천히 주입한다. 3) 용해 시에 침전이 확인되면 사용하지 않는다. 4) 다른 약들과 혼합주사하지 않는다. 덱스트란 제제와 혼합하면 복합물 침전을 만들므로 각종 덱스트란제제의 주사에 사용하는 수액세트와 공동으로 사용하지 않도록 한다. 5) 전해질 보액의 주사 등에 의한 탈수 등의 체액이상을 개선한 후에 점적 정맥주사 하는 것이 바람직하다. 6) 용해 후 1시간 이내에 사용하며 사용 후의 잔액은 세균오염의 우려가 있으므로 사용하지 않는다(세균 증식에 좋은 단백이고 티메로살, 기타 방부제를 함유하지 않기 때문이다).	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Flumarin inj	
성분/함량	flomoxef sodium 0.5g/V	기타 베타-락탐 항생제
효능·효과	◆ 패혈증, 감염성 심내막염 ◆ 외상 및 수술창 등의 표재성 2 차감염 ◆ 인후두염, 편도염, 기관지염, 기관지확장증의 감염 시, 만성 호흡기 질환의 2 차감염 ◆ 신우신염, 방광염, 전립선염, 임균성 요도염 ◆ 담낭염, 담관염 ◆ 복막염, 골반복막염, 다글라스와농양 ◆ 자궁부속기염, 자궁내감염, 골반사강염, 자궁방결합직염, 바토린선염 ◆ 중이염, 부비동염	
용법·용량	◆ 성인 : 플로목세프로서 1~2g(역가)를 2회로 분할하여 정맥 또는 점적 정맥주사한다 ◆ 소아 : 1일 체중 Kg당 60~80mg(역가)을 3~4회로 분할하여 정맥 또는 점적 정맥주사한다. ◆ 미숙아, 신생아 : 1회 체중 Kg당 20mg(역가)을 생후 3일까지는 1일 2~3회, 4일 이후는 1일 3~4회 정맥내 주사 또는 점적 정맥주사한다. ◆ 난치성 또는 중증감염증 : 성인 1일 4g(역가)까지 증량하여 3~4회로 분할 투여하며, 미숙아, 신생아, 소아에서는 1일 체중 Kg당 150mg(역가)까지 증량하여 3~4회로 분할 투여한다. 연령 및 증상에 따라 적절히 증감한다.	
사용상의 주의사항	◆ 부작용 : 쇽, 스티븐스-존슨 증후군, 독성표피괴사용해, 발진, 두드러기, 급성 신부전, 적혈구 감소, 과립구 감소, AST, ALT 상승 등 ◆ 금기 : 이 약 성분에 의한 쇽의 병력이 있는 환자 ◆ 태아위험도 : ◆ 비고 : 실온보관, 밀봉용기 ◆ 적용상의 주의 : 정맥 내 대량투여에 의해 혈관통, 정맥염, 작열감을 일으키는 일이 있으므로 이것을 예방하기 위해 주사액의 조제, 주사부위, 주사방법 등에 있어서 충분히 주의하고 그 주사속도는 가능한 천천히 한다. ◆ 주사액의 조제법 : 정주용 0.5g 및 1g(역가)의 10mL 용량 바이알 : 4mL 이상의 주사용 증류수, 5% 포도당 주사액 또는 생리식염액을 가하여 잘 흔들어서 용해시킨다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Freepan inj	
성분/함량	Scopolamine butylbromide 20mg/1ml/A	진경제
효능·효과	◆ 다음 질환에 있어서의 경련 및 운동기능 항진 : 위·십이지장궤양, 식도경련, 유문연축, 위염, 장염, 장산통, 경련성 변비, 기능성 설사, 담낭염, 담관염, 담석증, 담도이상운동증, 위·담낭절제후의 후유증, 요로결석, 방광염, 기능성설사, 기구삽입에 의한 요도·방광 경련, 월경곤란, 분만시 자궁하부경련 ◆ 소화관의 엑스선 및 내시경 검사의 전처치	
용법·용량	1 회 10-20mg 을 피하, 근육 또는 정맥주사한다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 항콜린성 벨라돈나 알칼로이드(Scopolamine) ◆ 부작용 : 보고된 이상반응들 중 많은 것들이 이 약의 항콜린성 특성에 기인한 것으로 일반적으로 경미하고 제한적 아나필락시스 쇽, 구갈, 구토, 변비, 산동, 배뇨장애, 두통, 두중, 졸음, 심계항진, 빈맥, 호흡곤란, 안면홍조, 이상고열 등. ◆ 금기 : 협우각녹내장, 전립선비대에 의한 배뇨장애, 유문협착 등 위장관의 기능적 협착, 마비성 장폐색, 중증 근무력증, 거대결장 환자, 빈맥, 중증의 심질환, 출혈성 대장염 환자, 이 약 혹은 이 약의 첨가제에 과민한 환자, 근육내 혈종이 나타날 수 있으므로 항응고제로 치료 받고 있는 환자는 이 약을 근육주사로 투여해서는 안된다. 이러한 환자는 피하주사 또는 정맥주사로 이 약을 투여해야 한다. ◆ 상호작용 ① Phenothiazine, TCA, MAOI, Quinidine, Amantadine, Disopyramide, 항히스타민제 : 항콜린작용 증강 ② Dopamine antagonist(Metoclopramide): 두 약의 효과 모두 감약 ③ β-agonist: 심박 증가작용 증강 ◆ 주의 ①자동차 운전 등 기계조작 금지(시조절장애, 졸음, 어지러움등이 나타날 수 있음) ②치료되지 않은 협우각형 녹내장 환자에게 안내압 상승 가능하므로 주사후 눈에 통증이 느껴지고 충혈되며 시력을 잃는 증상이 나타나면 즉시 안과의사에게 상담 ③세균성설사, 전립선 비대, 울혈성 심부전, 부정맥, 궤양성 대장염, 갑상선 기능 항진증, 고온 환경에 있는 환자는 신중투여 ◆ 비고 : 실온, 차광보관 ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 과량투여 시에는 항콜린성 증후가 관찰될 수 있다. ② 처치 : 필요한 경우, 부교감신경 효능약을 투여해야 한다. 녹내장의 경우에는 즉시 안과의사와 상의한다. 심혈관계 합병증은 일반적인 처치법에 따라 처치한다. 호흡마비에는 삽관법, 인공호흡을 하며 배뇨장애에는 카테터를 삽입한다. 또, 필요에 따라 적절한 보조요법을 실시한다. ◆ 적용상의 주의 ① 정맥투여시 환자의 상태를 관찰하면서 천천히 주사한다. ② 동물실험에서 충혈, 출혈, 변성등의 국소장애가 관찰되었으므로 피하 또는 근육주사시 조직, 신경등에 영향을 주지 않도록 주의한다.	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Futhan inj	
성분/함량	Nafamostat mesylate 10mg/V, 50mg/V	혈전치료제, 소염진통제
효능·효과	◆ 췌염의 급성증상(급성췌염, 만성췌염의 급성 악화기, 수술후의 급성췌염, 췌관조영술 후의 급성췌염, 외상성 췌염)의 개선 ◆ 파종혈관내응고증(DIC) ◆ 출혈성 병변 또는 출혈경향을 갖는 환자의 혈액체외순환시 관류혈액 응고방지(혈액투석 및 혈장분리반출술)	
용법·용량	◆ 췌염의 급성증상 개선: 10mgdmf 5%DW 500ml 에 용해하고 약 2 시간에 걸쳐 1 일 1~2 회 IVF ◆ 파종혈관내으고증(DIC) : 1 일량을 5%DW 1000ml 에 용해하여 0.06~0.20mg/kg/hr 로 24 시간에 걸쳐 IVF ◆ 출혈성 병변 또는 출혈경향을 갖는 환자의 혈액체외순환시 관류혈액 응고방지 : 20mg 을 소량의 5%DW 나 WFI 에 용해 후 NS 500ml 에 용해한 액으로 혈액회로내를 세정, 충진하고, 체외순환개시 후에는 20~50mg/hr 를 5%DW 에 용해하여 항응고제 주입라인에 지속주입	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 항혈전제(Nafamostat) ◆ 부작용 : 간기능 이상, 발진, 소양감 등의 과민증상, 고칼륨혈증 등의 전해질이상, 쇼크, 아나필락시스양 증상, 고칼륨혈증, 저나트륨혈증, 근육통, 관절통, 식욕부진, 설자, 구역, 구토 등 ◆ 금기 : 이 약에 대하여 과민증의 병력이 있는 환자 ◆ 주의 ① 신장으로부터 칼륨 배설억제, 나트륨 배설촉진 등으로 인하여 고칼륨혈증 및 저나트륨혈증이 발생할 수 있으므로 정기적으로 혈청 칼륨치 및 혈청 나트륨치를 측정하고 이상이 확인된 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 해야 한다. ② 칼륨함유제제, 칼륨보존성이뇨제 등을 병용할 경우에는 고칼륨혈증의 발현에 주의해야 한다. 또한, 혈청 칼륨치 이상이 인정된 경우에는 심전도소견 등의 확인을 충분히 하고 부정맥 유발에 주의해야 한다. ③ 출혈을 악화시킬 수 있으므로 본제의 혈액체외순환시 사용에 있어서는 충분히 관찰하고 출혈이 심해질 경우에는 감량 또는 투여를 중지해야 한다. ◆ 비고 : 차광, 밀봉용기, 실온(1-30℃) 보관 ◆ 적용상의 주의 1) 조제시의 주의 (1) 반드시 5% 포도당주사액 및 주사용수를 바이알에 가하여, 완전히 용해시킨 후에 사용해야 한다. (2) 용해시에는 바이알의 고무 중심에 주사침을 꽂아야 한다. 또한 18 게이지 이상의 큰 주사침 및 양두침을 사용하는 경우에는 고무 및 그 일부가 바이알 내로 탈락하는 경우가 있기 때문에 특히 주의해야 한다. (3) 백탁 또는 결정이 석출될 수 있으므로 생리식염액 및 무기염류를 함유한 용액을 바이알에 직접 가해서는 안된다. 2) 조제후의 주의 용해 후에는 빨리 사용해야 한다. 3) 투여시의 주의 (1) 투여량: 이 약을 혈액체외순환시에 투여할 경우에는 출혈상황, 체외순환로 내의 잔혈, 응혈 및 전혈 응고시간 등을 고려하여 적절용량을 조절해야 한다. (2) 투여속도: 이 약을 정맥내 및 체외순환회로 내로 급속하게 주입해서는 안된다. (3) 투석기: 이 약은 AN69(폴리아크릴로니트릴)막에 대한 흡착성이 높기 때문에 이 약을 사용해서는 안된다. (4) 투여시: 정맥내 투여에 있어서 약액이 혈관 외로 유출되고 주사부위에 염증 및 궤사를 일으키는 일이 있으므로 약액이 혈관 외로 유출되지 않도록 주의해야 한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Gardasil prefilled inj	
성분/함량	Papillomavirus human types 6,11,16,18 0.5ml/Syringe	인유두종바이러스 백신
효능·효과	◆ 여성 : 9~26 세 에서 인유두종바이러스(Human Papillomavirus)에 의한 다음 질병의 예방 - 인유두종바이러스 16, 18 형에 의한 자궁경부암, 외음부암, 질암, 항문암 - 인유두종바이러스 6, 11 형에 의한 생식기 사마귀(첨형콘딜로마) 및 인유두종바이러스(HPV) 6, 11, 16, 18 형에 의한 다음의 전암성 또는 이형성 병변의 예방: - 자궁경부 상피내 선암(Adenocarcinoma in situ, AIS) - 자궁경부 상피내 종양(Cervical intraepithelial neoplasia, CIN) 1 기, 2 기 및 3 기 - 외음부 상피내 종양(Vulvar intraepithelial neoplasia, VIN) 2 기 및 3 기 - 질 상피내 종양(Vaginal intraepithelial neoplasia, VaIN) 2 기 및 3 기 - 항문 상피내 종양(Anal intraepithelial neoplasia, AIN) 1 기, 2 기 및 3 기 ◆ 남성 : 9~26 세 에서 인유두종바이러스(Human Papillomavirus)에 의한 다음 질병의 예방 - 인유두종바이러스 16, 18 형에 의한 항문암 - 인유두종바이러스 6, 11 형에 의한 생식기 사마귀(첨형콘딜로마) 및 인유두종바이러스(HPV) 6, 11, 16, 18 형에 의한 다음의 전암성 또는 이형성 병변의 예방: - 항문 상피내 종양(Anal intraepithelial neoplasia, AIN) 1 기, 2 기 및 3 기	
용법·용량	◆ 접종일정 : 1회 0.5ml 씩 3회 근육주사 (0개월(최초 접종일), 2개월, 6개월에 접종) ◆ 접종방법 : 상완의 삼각극 또는 대퇴부 전외측 상부에 근육주사	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Inactive human papillomavirus (HPV) proteins HPV 6 L1, HPV 11 L1, HPV 16 L1, HPV 18 L1를 함유하며, neutralizing antibodies 를 생산하여 HPV에 의해 야기되는 cervical cancer, cervical adenocarcinoma, cervical/vaginal/vulvar neoplasia, genital warts를 예방 ◆ 부작용 : 주사부위 반응(통증, 종창, 홍반 등), 두통, 발열, 구역, 어지러움 등 ◆ 금기 : 이 백신 또는 이 백신의 성분에 과민한 사람 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 : 냉장(2~8℃) 및 차광 보관	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Gardasil 9 PFS inj	
성분/함량	Papillomavirus human type 6,11,16,18,31,33,45,52,58 0.5ml/Syr	인유두종 바이러스에 의한 질병 예방
효능·효과	◆ 1. 여아 및 여성: 9~26 세 여성에서 인유두종바이러스(Human Papillomavirus)에 의한 질병의 예방 2. 남아: 9~15 세 남성에서 인유두종바이러스에 의한 질병의 예방	
용법·용량	◆ 1회 0.5 mL씩 3회 IM - 1차 접종: 방문일 - 2차 접종: 1차 접종으로부터 2개월 후 - 3차 접종: 1차 접종으로부터 6개월 후	
사용상의 주의사항	◆ 다음 환자에는 투여하지 말 것. 이 백신이나 가다실 또는 각 백신의 성분에 과민한 사람 (이 백신이나 가다실 접종 후 과민증상이 나타나는 경우 추가 접종하지 않는다) ◆ 주의사항 1) 다른 백신과 마찬가지로 이 백신을 접종받은 모든 피접종자가 면역예방 효과를 나타내는 것은 아니다. 2) 이 백신은 진행 중인 외부 생식기 병변, 자궁경부암, 외음부암, 질암, 항문암, 자궁경부 상피내 종양(CIN), 외음부 상피내 종양(VIN), 질 상피내 종양(VaIN), 항문 상피내 종양(AIN)의 치료를 대상으로 하지 않는다. 3) 이 백신은 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV)에 의한 것이 아닌 질병은 예방하지 않으며, 백신에 포함되지 않은 HPV 유형에 의한 질병에 대해서도 예방하지 않는다. 4) 다른 주사용 백신과 마찬가지로 백신 투여 후 드물게 아나필락시스 반응이 나타나는 경우 적절한 치료가 즉시 이루어져야 한다. 5) 면역억제제의 사용, 유전적 결함, 사람 면역결핍바이러스(HIV) 감염 또는 기타의 원인에 의해 면역 반응이 저해되어 있는 경우 백신접종에 의한 항체 반응이 감소될 수 있다. ◆ 상호작용 1) 다른 백신과의 병용투여 임상시험 결과, 이 백신은 메낙트라주[수막구균 A, C, W135, Y) - DT 단백접합백신(Meningococcal(Groups A, C, Y and W-135) Polysaccharide Diphtheria Toxoid Conjugate Vaccine, MCV4)], 아다셀주[성인용 흡착 디프테리아, 파상풍톡소이드 및 정제 백일해 혼합백신(Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid and Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed, Tdap)], Repevax[흡착 디프테리아, 파상풍톡소이드, 정제 백일해 및 불활화 소아마비 혼합백신(Diphtheria, Tetanus, Pertussis (acellular, component) and Poliomyelitis (inactivated) Vaccine, (adsorbed, reduced antigen(s) content), dTap-IPV)]과 동시에 접종할 수 있다(단, 각각 다른 부위에 주사할 것). 2) 호르몬성 피임제 임상시험에서 이 백신을 접종받은 16 ~ 26세의 여성 7,269명중 60.2%가 백신접종 기간 동안 호르몬성 피임제를 복용하였다. 호르몬성 피임제는 이 백신의 면역 반응에 영향을 주지 않았다. 3) 스테로이드제 방사선 치료, 항대사제, 알킬화제, 세포독성제 및 생리학적 투여량 이상의 코르티코스테로이드의 투여를 포함하는 면역 억제 요법을 받고 있는 경우, 백신접종에 대한 면역 반응이 감소할 수 있다 ◆ 보관 및 취급상의 주의사항 1) 이 백신은 냉장상태에서 꺼낸 후 가능한 빨리 투여한다. 냉장고에서 꺼낸 후(8℃ ~ 25℃의 온도) 72시간(여러 번 꺼냈을 경우 냉장고에서 꺼낸 총 누적 시간)이 지나기 전에 이 백신을 투여한다. 0℃ ~ 2℃에 노출되는 경우, 노출된 총 누적시간이 72 시간까지는 허용될 수 있으나, 이 보관 조건은 권장되지 않는다. 2) 만약 얼어있거나, 이물이 있는 경우 또는 변색이 관찰된 경우에는 폐기한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Gaster inj sol	
성분/함량	Famotidine 20mg/10ml/V	소화성궤양 및 위식도역류질환치료제
효능·효과	상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성위염에 의한), 졸링거-엘리슨증후군, 신체적스트레스(대수술 후, 중증의 뇌혈관장해・두부외상・다장기부전・중증의 화상)에 의한 상부소화관출혈의 억제, 마취전 투약	
용법·용량	ㄱ. 상부 소화관 출혈, Zollinger-Ellison syndrome: 1 회 20mg, 2 회/일 1 주간 IV, IVF, IM ㄴ. 신체적 stress 에 의한 상부소화관 출혈 억제 : 1 회 20mg, 2 회/일, 3 일(수술후 stress)-7 일간(기타 신체적 stress) 투여 ㄷ. 마취전 투약: 마취 도입 1 시간 전에 1 회 20mg IM, IV	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : H2 수용체에 길항함으로써 지속적인 위산분비 억제작용 ◆ 부작용 : 발진, 두드러기, 식욕부진, 변비, 설사, 구갈, 구역, 맥박수 증가, 이명, 두통, 권태감, 월경불순, 백혈구감소, AST·ALT·ALP↑, 혈소판 감소, 호산구 증가, 구토, 혈압상승, 기관지경련, 관절통 ◆ 금기 : 임부, 가임부, 수유부 ◆ 상호작용 : Azole 계 항진균약(Itraconazole)의 혈중농도 저하 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 ① 용해액 : N/S, DW, WFI ② 용해 후 안정성 : 48 시간(실온, 냉장보관) ③ 이 약 투여로 위암에 의한 증상 은폐 우려	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Gentamicin sulfate inj	
성분/함량	Gentamicin sulfate 80mg/2ml/A	Aminoglycoside계 항균제
효능·효과	◆ 유효균종 : 녹농균, 대장균, 프로테우스, 포도구균(페니실린 및 메치실린 내성균포함), 클레브시엘라, 엔테로박터, 세라티아, 시트로박터, 살모넬라, 시겔라 ◆ 적응증 : 패혈증(신생아 패혈증 포함), 중추신경계 감염증(수막염 포함), 요로감염증, 호흡기감염증, 위장관감염증(복막염 포함), 피부, 골 및 연조직감염증(화상 및 창상 포함), 그람음성균 감염증의 초기치료, 원인균 미상시 초기치료 (페니실린계 또는 세팔로스포린계 약물과 병용), 녹농균에 의한 치명적 감염증(카르베니실린과 병용), - 심내막염 (페니실린계 약물과 병용)	
용법·용량	◆ 성인 ① 신기능정상: 3mg/kg/일을 3 회 분할하여 IM, IV ② 중증: 5mg/kg/일을 3-4 회 분할하여 IM, IV ③ 신기능 부전 환자: 신기능 부전 정도에 따라 용량조절 ④ 혈액투석중인 환자 : 매 투석말기에 성인(1-1.7mg/kg), 소아(2mg/kg)투여 ◆ 소아용량 ① 어린이: 6-7.5mg/kg/일을 3 회 분할 IM, IV ② 유아: 7.5mg/kg/일을 3 회 분할 IM, IV ③ 미숙아 및 신생아(1 주미만): 5mg/kg/일을 2 회 분할 IV ◆ 요로감염증 : 정상적인 신기능 환자의 요로감염증에는 1 일 1 회 160mg(역가)을 투여할 수 있다.	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 감수성균의 단백 합성을 억제 → 살균작용 ◆ 부작용 : 쇽, 과민반응, 8 뇌신경장애(청력상실, 운동실조, 어지러움, 이명, 난청), 구토, 식욕부진, 호흡곤란, 후두부종, 폐섬유종, 호산구 증가, 간장애, 급성 신부전, 비타민 K 결핍증상, IM 시 주사부위의 동통 경렬, 비감수성균의 과도성장, 고혈압 저혈압, 원형탈모증, 체중감소 ◆ 금기 :다른 aminoglycoside 계 항생물질 및 bacitracin 에 과민증 병력자, 임부, 수유부 ◆ 배합금기 : Fat emulsion, Amphotericin B, Ampicillin, Heparin, Ticarcillin, Idarubicin, Furosemide, Hetastarch, Carbenicillin, Cefoperazone, Cefotetan, Ceftazidime, Phenytoin, Piperacillin ◆ 상호작용 ① Dextran, Arginate Na 의 신독성 증강 ② Heparin, β-lactam 계 항균제와 혼합주사 : 이 약의 활성저하 → 병용 시 다른 경로로 투여 ③ Loop diuretics(Furosemide, Torasemide)의 신 이독성 증가시키므로 병용금기 ④ 다른 Aminoglycoside 계, Cisplatin, Polymyxin B, Vancomycin, 신장애 제 8 뇌신경장애 유발약품과 병용금기 ⑤ 마취제, 근이완제 : Curare 유사 작용에 의한 호흡억제 ⑥ Cephalosporin 계 항균제 : 신독성 증가 ◆ 주의 : 내성균 발현 방지를 위해 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소 기간만 투여 ◆ 태아위험도 : D ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 신장애, 청각장애, 전정장애, 신경근 차단증상, 호흡마비가 나타날 수 있다. ② 처치 : 혈액투석, 복막투석에 의해 약물을 제거한다. 신경근 차단증상, 호흡마비에 대해서는 콜린에스테라제 저해제, 칼슘제제의 투여 또는 기계적 호흡보조기계를 사용한다. ◆ 적용상의 주의 ① 근육주사의 경우 경결을 초래할 수 있으므로 주사직후 국소를 충분히 문질러 준다. ② 베타락탐계 항생물질(카르베니실린, 슬베니실린, 페니실린 및 세팔로스포린 등), 헤파린나트륨과의 혼합주사는 이 약의 활성을 저하시킬 수 있으므로 병용투여 시 각각 다른 경로로 투여한다. ◆ 기타 ① 구연산 항응고처리 혈액(Citrate-anticoagulated blood)을 대량수혈 받은 환자에게 아미노글리코사이드계 항생물질을 투여하면, 투여경로에 관계없이 신경근 차단증상, 호흡마비가 나타날 수 있다. ② 희석용액: N/S, D5W

약품명	**Glycopyrrolate inj**	
성분/함량	**Glycopyrrolate 200mcg/1ml/A**	**자율신경제**
효능·효과	◆ 마취시 ① 수술전 타액분비, 기관기관지액 분비, 인두분비, 위액의 유리산 분비 감소 ② 마취시나 마취유도시 심장미주신경 억제반사의 방지 ③ 비탈분극성 근이완제에 의한 신경근 차단을 역전하기 위해 네오스티그민이나 피리도스티그민 등의 콜린성 약물 사용시 나타나는 말초 무스카린 효과(서맥 및 과다분비) 등 방지 ◆ 소화성 궤양의 보조 : 급속한 항콜린작용 필요시 또는 경구투여에 내약성이 없는 경우	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

용법·용량	근육 또는 정맥주사로 투여하며 희석하지 않고 투여할 수 있다. ◆ 성인 ① 마취시 수술전 - 마취유도기 30-60 분전이나 마취전에 0.02ml/kg, IM - 수술중 (약물유발 또는 부정맥에 수반된 미주신경로 반사방지 목적) : 0.5ml 를 1 회 또는 반복해서 2-3 분 간격으로 IV - 근신경차단역전시: Neostigmine 1mg 또는 Pyridostigmine 5mg 에 대하여 1ml 를 IV ② 소화성 궤양의 보조 : 1 회 0.5ml 를 4 시간 간격으로 3-4 회/일, SC, IM, IV (보다 강한 효과가 요구될 경우 1ml 투여) ◆ 소아용량 ① 마취시 - 수술전: 마취유도기 30-60 분전이나 마취전에 ▪ 생후 1 개월-12 세 : 0.02ml/kg, IM ▪ 1 개월-2 세: 0.04ml/kg, IM - 수술 중: 0.02ml/kg 을 1 회 IV, 반복시에는 2-3 분 간격 투여 (최대: 0.5ml/회) - 근신경차단 역전시: 성인과 동일		
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 ① 평활근에서의 acetylcholine 수용체 차단 작용 ② 수술전 타액분비, 기관 및 기관지액의 분비, 인두 분비를 감소시키고, 위액의 유리산 분비를 감소시키는 작용 ③ 마취시나 마취유도 시 심장 미주신경 억제 반사를 방지하는 작용 ④ 비탈분극성 근이완제에 의한 신경근 차단을 역전하기 위해 Neostigmine, Pyridostigmine 등의 choline 성 약물 사용시 나타나는 말초 muscarine 효과 등 방지 ◆ 부작용 : 구갈, 배뇨장애, 요저류, 시야혼탁, 안압증가, 빈맥, 심계항진, 발한감소, 두통, 오심, 불면, 유액분비억제, 변비, 담마진 ◆ 금기 소화성궤양 보조시 : 녹내장, 폐쇄성 위장관 뇨질환, 마비성 장폐색증, 노인 쇠약자의 장 atony 증, 근무력증, 급성출혈로 인한 불안전한 심혈관상태, 중증의 궤양성대장염, 거대결장, 12 세이하 ◆ 배합금기 : Sodium bicarbonate, Pentobarbital sodium, Dimenhydrinate, Dexamethasone, Methylprednisolone acetate succinate, Chlorampheniol, Diazepam, Thiopental, Lactated Ringer's inj ◆ 주의 : 임부, 수유부, 관동맥질환, CHF, 부정맥, 고혈압, 갑상선기능항진증, 천식, 녹내장, 운전 기계조작 시 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 : 희석수액: N/S, DW ◆ 과량투여시의 처치 - 말초성 항콜린효과 억제 : 황산메칠네오스티그민 제제(뇌-혈관관문을 통과하지 못한다.)와 같은 4 급 암모늄 항콜린에스테라제를 성인의 경우 정맥주사로 0.25mg 씩 증가시키면서 투여. 지나친 항콜린효과가 반전되거나 최대용량인 2.5mg 에 이를 때까지 매 5-10 분 간격으로 이 용량을 반복투여한다 - 흥분, 불안, 경련, 정신이상적 행위 등 중추신경증상 : 피소스티그민을 사용한다. 이 때는 0.5-2mg 을 천천히 정맥주사하고, 필요하면 성인의 경우 5mg 까지 반복 투여		
약품명	**Grasin prefilled inj**	**Leucostim PFS inj**	
성분/함량	**Filgrastim 150mcg/Syr, 300mcg/Syr**	**Filgrastim 150mcg/Syr, 300mcg/Syr**	**G-CSF(Granulocyte Colony-stimulating factor)**

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

효능·효과	◆ 고형암 및 혈액종양에 대해 항암화학요법을 받고 있는 환자의 호중구 감소증 ◆ 골수이형성증후군에 따른 호중구감소증 ◆ 재생불량성빈혈에 따른 호중구감소증 ◆ 선천성 · 특발성 호중구감소증 ◆ 사람면역결핍바이러스(HIV) 감염증 치료에 지장을 초래하는 호중구감소증 ◆ 조혈모세포의 말초혈중으로의 동원 - 동종 및 자가 말초조혈모세포 채취시의 Filgrastim 의 단독투여에 의한 동원 - 자가 말초조혈모세포 채취시의 항암화학요법제 투여 종료 후 Filgrastim 투여에 의한 동원 ◆ 조혈모세포이식시의 호중구수 증가 촉진
용법·용량	◆ 각 적응증 별, 호중구수치에 따라 투여량을 결정 ◆ 각 적응증 별로 피하, 정맥, 점적정맥주사 중 선택하여 투여
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 특정한 세포 표면 수용체에 결합하고 neutrophil 생성, progenitor 증식, 분화를 조절함으로써 Hematopoietic cells 에 작용하는 Human granulocyte colony-stimulating factor(G-CSF) 이며, 식세포능, 세포 대사 및 항체 의존적 killing 를 포함하는 몇몇 end-cell 기능적 활성화에도 영향을 미침 ◆ 부작용 : 요통, 두통, 관절통, 발열, 구역, 구토, 구내염, 복통, 간질선폐렴 발현 증가 및 악화, 혈소판감소 비장비대, 백혈구감소, 호중구감소 등 ◆ 금기 ① 이 약 또는 다른 G-CSF 제제에 과민반응 환자 ② 골수중의 아구가 충분히 감소하지 않은 골수성백혈병 환자 및 말초혈액중에 골수아구가 보이는 골수성백혈병 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 냉장(10℃ 이하)보관, 동결은 피할 것 ◆ 적용상의 주의 : 점적 정맥주사시 N/S, 5% DW 에 혼합하고, 다른 약물과는 혼합하지 말 것

약품명	**Heparin inj**

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

성분/함량	Heparin Na 20,000unit/V	항응고제
효능·효과	① 혈전증의 예방, 수술후 혈전증 및 폐색전증의 예방 및 치료 ② 전색성 심방세동의 예방 및 치료 ③ 급성 및 만성 응고이상증의 진단 및 치료, 혈관 및 심장수술시 응고예방 ④ 뇌혈전증 예방	
용법·용량	Heparin 감수성 시험을 실시하여 혈액응고시간이 15-20 분 또는 그 이상이 되도록 유지 ① 체외순환시(혈액투석 인공심폐) ㄱ. 혈액투석 ▪ 전신 헤파린화법: 투석전에 1,000-5,000 IU 를 투여, 그 후 500-1,500 IU/hr 을 지속적 또는 1 시간마다 간헐적으로 투여 ▪국소 헤파린화법: 1,500-2,500 IU/hr 을 지속투입 ㄴ. 인공심폐에 의한 혈액관류시: 150-300 IU/kg ② IVF: 10,000-30,000 IU 를 N/S, D5W, Ringer soln 1L 에 희석하여 30 적/분으로 주입 ③ IV: 1 회 5,000-10,000 IU 를 4-8 시간마다 IV ④ SC: 10,000-20,000 IU 를 투여후 8,000-10,000 IU 를 8 시간마다또는 15,000-20,000 IU 를 12 시간마다 투여 ⑤ 수혈시: 혈액 100ml 에 대해 400-500 IU 를 사용 ⑥ 혈액검사시: 혈액 20-30ml 에 대해서 100 IU 사용	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 ① Factor X inhibitor 를 활성화시킴으로써 활성화된 factor X 중화 ② FactorIX(Christmas) 활성화억제 ③ Thrombin 을 직접적으로 억제하여 fibrinogen 이 fibrin 으로 전환 되는 것을 억제 ◆ 부작용: 알러지반응, 혈소판감소, 비출혈, 백반, 원형탈모증, 출혈성 괴사, 골다공증, 신장애, ALT,AST 상승, 기관지 천식, 유루, 최루 ◆ 금기: 출혈환자, 소화성궤양, 혈액응고 검사결과 응고간격이 적당하지 않은 환자, 신생아, 미숙아 ◆ 상호작용 ① 항응고제, Salicylate, 소염효소제, Dipyridamole: 이 약 효능 증가 ② 항히스타민제, Ascorbic acid, 강심배당체, TC, Phenothiazine 계 : 이 약 효능 감소 ◆ 주의: 임신말기 3 개월의 임부는 신중 투여 ◆ 태아위험도: C ◆ 비고: 해독제: Protamine sulfate 10-15mg 은 Heparin 1,000 IU 해독	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Herben inj	
성분/함량	Diltiazem HCl 50mg/V	심혈관계용제
효능·효과	빈맥성부정맥(상실성), 불안정 협심증, 수술시 이상 고혈압의 구급처치, 응급성고혈압(고혈압성발증)	
용법·용량	이 약은 5ml 이상의 생리식염주사액 또는 포도당주사액에 용해하여 다음과 같이 투여한다. ◆ 빈맥성 부정맥(상실성): 1 회 10mg 을 3 분간 IV ◆ 수술시 이상 고혈압의 구급처치 ① bolus IV : 1 회 10mg 1 분간 IV ② IV infusion : 5-15mcg/kg 1 분간 IV infusion ◆ 응급성 고혈압(고혈압성 발증) : 5-15mcg/kg 을 1 분간 IV infusion ◆ 불안정 협심증 : 1-5mcg/kg 을 1 분간 IV infusion (최대 용량: 5mcg/kg/분)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Ca Channel blocking agent ◆ 부작용 : 현훈, 조홍, 서맥, 방실블록, 동계, 두통, 두중감, 탈력감, 권태감, 황달, 간종대, 발진, 다형성 홍반상 피진, 식욕부진, 변비, 복통, 구기, 설사, 구갈, 치은비후 ◆ 금기 : 중증의 저혈압 또는 심인성 쇽 환자, 동기능부전증후군, 동방블록, 방실블록(2, 3 도)환자, 중증의 울혈성 심부전 환자, 중증의 심근병증 환자, 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 심실성 빈맥 환자, 심방세동 또는 심방조동 환자, β-차단제(정맥주사) 투여중인 환자 ◆ 상호작용 ① Dantrolene(주사), Terfenadine Astemizole 과 병용금기 ② 혈압강하제, 질산염제제 : 작용증강 ③ β-blocker, 부정맥용제(아미오다론) : 서맥유발 ④ Digitalis, CSA, Midazolam, Phenytoin 의 혈중농도 상승 ⑤ Cimetidine : 이 약 혈중농도 상승 ⑥ Theophylline 의 대사지연 ⑦ 마취제 : 심자극생성 억제, 심전도 억제 작용 증강 ⑧ Carbamazepine, Triazolam, Tacrolimus 의 혈중농도 상승 ◆ 주의 : 저혈압 환자, 서맥, 방실블록(1 도) 환자, 울혈성 심부전 환자, 심근병증 환자, 급성 심근경색이 있는 환자, 중증의 간·신부전 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 5ml 이상의 N/S 또는 D/W 액에 용해하여 사용 ② 타제제와 배합하여 pH 8 을 넘을 경우 diltiazem 석출 ③ 캅셀: 개봉하거나 씹지 않도록 함. ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 서맥, 완전방실블록, 심부전, 저혈압 등이 나타날 수 있다 ② 처치 - 서맥, 완전 방실블록 : 황산아트로핀, 이소프로테레놀 등의 투여와 심장 박동(pacing)을 사용 - 심부전, 저혈압 : 강심제, 혈압강하제, 수액 등의 투여와 보조순환을 적용	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Hirax inj	
성분/함량	Hyaluronidase 1500unit/1ml/V	효소제제
효능·효과	빈맥성부정맥(상실성), 불안정 협심증, 수술시 이상 고혈압의 구급처치, 응급성고혈압(고혈압성발증)	
용법·용량	◆ 피하주입 시 : 1,500IU를 WFI 또는 N/S 1ml 녹인 후 해당 부위에 주사 (IV line을 잡을 수 없는 환자에게 수액 투여시 수액 500-1,000ml에 해당하는 용량임) ◆ SC, IM: 1,500 IU를 주사액에 녹여 사용 ◆ 국소마취제: 국소마취제에 녹여 사용(안과 : 15 IU/ml) ◆ 혈관외 유출, 혈종: 1,500 IU를 WFI 또는 N/S 1ml 녹여 해당 부위에 침윤	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : ① Hyaluronidase 는 Hyaluronic acid 를 가수분해함으로써 결합조직의 투과성을 조절하는 확산물질 ② 결합조직과 피부의 주요한 Viscous polysaccharides의 하나인 Hyaluronic acid는 gel 상태로 액체가 조직을 통하여 확산하는 것을 방지 ◆ 부작용 : 국소자극감, 발적, 동통, 감염확산, 출혈, 멍, 부종, 발열, 치아동요, 월경과다 ◆ 금기 : 각막, 관절강내 주사, IV 금지, Bovine protein 과민자, 물리거나 쏘여서 된 부종, 감염증이나 암 부위의 주변, 원인불명 조기 분만시 마취, 선천성 심장 결손 환자, 정맥울혈 환자, 혈청단백 수치가 5.5g%이하인 환자 ◆ 상호작용 ① 중금속염 ② Salicylate류: 이 약의 흡수 감약 ③ 알콜의 작용증강 ◆ 주의 : 각막, 관절강내 주사, IV 금지, Bovine protein 과민자, 물리거나 쏘여서 된 부종, 감염증이나 암 부위의 주변, 원인불명 조기 분만시 마취, 선천성 심장 결손 환자, 정맥울혈 환자, 혈청단백 수치가 5.5g%이하인 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고: Thimerosal 1mg 함유 ◆ 배합금기: Heparin, Epinephrine, Furosemide, Benzodiazepine 계, Phenytoin, Chondroitin sulfate, Bile acid 염	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	H-lase inj	
성분/함량	Hyaluronidase 1,500 IU/A	효소제제
효능·효과	피하주사·근육주사·국소마취제·피하주입 시 침투력 증가, 조직 내 과다하게 존재하는 체액 및 혈액의 재흡수 촉진	
용법·용량	◆ 피하이완 : 1,500IU 를 WFI 또는 N/S 1ml 녹인 후 해당 부위에 주사 (IV line 을 잡을 수 없는 환자에게 수액 투여시 수액 500-1,000ml 에 해당하는 용량임) ◆ SC, IM: 1,500 IU 를 주사액에 녹여 사용 ◆ 국소마취제: 국소마취제에 녹여 사용(안과 : 15 IU/ml) ◆ 혈관외 유출, 혈종: 1,500 IU 를 WFI 또는 N/S 1ml 녹여 해당 부위에 침윤	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 ① Hyaluronidase 는 Hyaluronic acid 를 가수분해함으로써 결합조직의 투과성을 조절하는 확산물질 ② 결합조직과 피부의 주요한 Viscous polysaccharides 의 하나인 Hyaluronic acid 는 gel 상태로 액체가 조직을 통하여 확산하는 것을 방지 ③ SC 투여시 함께 투약되는 약이 더 빨리 확산하도록 도움 ◆ 부작용 : 국소자극감, 발적, 동통, 감염확산, 출혈, 멍, 부종, 발열, 치아동요, 월경과다 ◆ 금기 : Bovine protein 과민자, 물리거나 쏘여서 된 부종, 감염증이나 암 부위의 주변, 원인불명 조기 분만시 마취, 선천성 심장 결손 환자, 정맥울혈 환자, 혈청단백 수치 5.5g%이하 환자, 수유부 ◆ 배합금기 : Heparin, Epinephrine, Furosemide, Benzodiazepine 계, Phenytoin, Chondroitin sulfate, Bile acid 염 ◆ 상호작용 ① 중금속염 ② Salicylate 류: 이 약의 흡수 감약 ③ 알콜의 작용증강 ◆ 주의 : Skin test 할 것 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : Thimerosal 1mg 함유 ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 구역, 홍조, 두드러기, 빠른맥(빈맥), 호흡곤란, 쇽, 호흡정지 등이 나타날 수 있다. ② 처치 : 이 약의 투여를 중지하고 홍조, 두드러기 등의 피부 증상이 나타나면 항히스타민제를 투여하고 빠른맥(빈맥)이 나타날 경우 코르티코이드를 정맥주사할 수 있다. 쇽이 나타날 경우에는 에피네프린, 산소 공급, 코르티코이드 정맥 투여 및 기도 유지 등의 처치를 하고 호흡정지가 나타날 경우 심폐소생술을 실시한다. ◆ 적용상의 주의 ① 용액으로 조제한 즉시 사용한다. ② 부종을 일으킬 수 있으므로 각막 또는 관절 내에 직접 투여하지 않는다. ③ 정맥주사하지 않는다. ④ 이 약은 헤파린 및 에피네프린과의 배합이 물리적으로 부적절하나(혼탁해짐), 임상에서는 매우 낮은 농도의 에피네프린과 혼합해서 문제없이 사용할 수 있다. 이 약은 푸로세미드, 벤조디아제핀계 약물, 페니토인, 술폰산염 계면활성제가 함유된 황산콘드로이틴 B, 담즙산염과는 배합하지 않는다. ⑤ 알파차단제, 도판민 약물의 확산이나 흡수의 촉진을 우해 사용하지 않는다.	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Instillagel gel	
성분/함량	Lidocaine HCl 230mg, Chlorhexidine digluconate 28.6mg	국소마취제
효능·효과	◆ 카테터 삽입, 부지법, 요도(남성 · 여성)내 수술, 각종 내시경 검사, 삽관, 시술로 인한 직장과 결장에서의 손상 예방 및 시술시 표면마취, 소독, 윤활작용	
용법·용량	◆ 카테터삽입 : 이 약 6 ml 또는 11 ml를 주입한다. 귀두와 요도를 깨끗이 한 후 요도에 서서히 주입하고 국소마취와 소독효과가 나타낼 때까지 귀두를 압박한다. ◆ 방광경검사 : 이 약 11 ml를 사용하며, 필요시 6 ml 또는 11 ml를 추가로 주입한다. 외부조임근을 포함하여 전체요도에 도포한다. ◆ 요도협착 (요도구절개술, 부지법) : 이 약 11 ml를 사용하며, 필요시 6 ml 또는 11 ml를 추가로 주입하고 클램프로 집어준다. 요도 마취효과는 5-10분 후 나타난다. ◆ 소독 : 이 약 6 ml 또는 11 ml 를 점막에 골고루 바르거나 주입한다. ◆ 기타 : 적용부위에 6 ml 또는 11 ml를 천천히 주입하며, 삽입될 카테타나 시술도구에 골고루 도포한다. 국소마취 및 소독효과는 5-10분 후에 나타난다.	
사용상의 주의사항	◆ 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 아미드계 마취제, 클로르헥시딘제제 또는 알킬파라옥시안식향산 등 이 약의 성분에 대하여 과민증이 있는 환자 2) 손상된 피부, 눈 및 눈주위 3) 뇌, 척수, 귀(내이, 중이, 외이)(청각신경 또는 중추신경에 직접 사용할 경우 난청, 신경장애를 일으킬 수 있다) 4) 포르피린증 5) 조절되지 않는 간질 6) 중증의 심장전도 이상 7) 2세 미만의 소아 ◆ 이상반응 1) 쇽 : 쇽이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 혈압저하, 안면창백, 맥박의 이상, 호흡억제, 구역, 불쾌감, 식은땀, 어지러움, 답답함, 발적 등이 나타나는 경우에는 즉시 사용을 중지하고 적절한 처치를 한다. 2) 신경계 ① 진전, 경련 등의 중증의 심각한 증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여중지하고 디아제팜 또는 초단시간형 바르비탈산 제제(치오펜탈나트륨) 투여 등 적절한 처치를 한다. ② 졸음, 불안, 흥분, 무시, 어지러움, 구역·구토, 신경과민, 의식소실, 불쾌감, 식은땀, 답답함, 피로, 방향감각상실, 안장애, 언어장애, 귀울림, 경련, 감각이상(자주 투여시), 다행감, 환각, 우울, 혼수, 일반경련, 호흡저하(드물게, 특히 과량투여시), 초조, 하품, 떨림, 걱정, 눈떨림, 병적다변증, 두통, 귀울림, 반응느림, 흥분 등이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하여 쇽 또는 중증의 심각한 증상으로 이행하는 것에 주의하고 필요에 따라 적절한 처치를 한다. 3) 심혈관계 저혈압, 심근억제, 서맥, 심정지, 부정맥, 방실블록, 심실세동(경우에 따라), 빈맥, 고혈압, 기능저하지속 등이 나타날 수 있다. 4) 호흡기계 빠른호흡 및 호흡곤란 5) 위장관계 구역·구토와 같은 위장관 불쾌감(자주투여시) 6) 과민증 : 때때로 발적, 발진, 두드러기 등의 피부증상 및 부종이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 즉시 사용을 중지한다. 7) 과량투여시 요도손상이 나타날 수 있다. 8) 드물게 클로르헥시딘에 의한 접촉부위의 알레르기 습진이 나타날 수 있다. 9) 광감작이 나타날 수 있다. ◆ 과량투여시의 처치 1) 리도카인으로 인한 신경학적 독성증상이 나타난 경우 초단시간형 바르비탈산 제제 또는 벤조디아제핀을 투여하고	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

	산소를 공급하여 호흡을 보조하는 등 적절한 처치를 한다. 2) 과량을 경구복용한 경우 계면활성제를 사용하여 위세척을 통해 배출시킨다. ◆ 상호작용 1) 이 약과 부정맥용제(토카이니드 등)를 병용투여하는 경우, 부작용이 증강될 수 있으므로 주의한다. 2) 동물실험결과 이 약과 페치딘을 병용투여시 리도카인의 독성이 증가될 수 있으므로 주의한다. 3) 클로르헥시딘은 양이온성 살균제이므로 음이온성 물질(비누)과 함께 사용하지 않는다. ◆ 임부에 대한 투여 1) 임부에 대한 투여 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다. 2) 수유부에 대한 투여 이 약은 모유중으로 이행되는 것으로 알려져 있으므로, 투여 후 약 12시간 내에는 수유를 하지 않도록 한다. ◆ 적용상의 주의 1) 눈에 접촉시 각막손상을 일으킬 수 있으므로 눈에 들어가지 않도록 주의하고 만약 들어갔을 경우에는 즉시 깨끗한 물로 잘 씻어낸다. ◆ 25℃ 이하에서 습기를 피하여 보관할 것

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Isoptin inj	
성분/함량	Verapamil HCl 5mg/2ml/A	심혈관계용제
효능·효과	협심증, 부정맥	
용법·용량	◆ 성인 : 1 회 5-10mg 을 IV(2 분이상), 반복투여 가능 ◆ 소아용량 (미확립) : Supraventricular tachyarrhythmia ① 1 세이하 : 0.1-0.2mg/kg IV(2 분이상) , 필요시 30 분 간격으로 반복 ② 1-15 세 : 초회 0.1-0.3mg/kg(최대용량 : 1 회 5mg) 2 분이상 IV 효과가 만족스럽지 않을 때 15 분내에 반복투여 (2 회 최대용량: 10mg)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 ① SA node 및 AV node 에 작용하고 전도를 느리게 함 ② Calcium channel blocker 로서 심근, 혈관 평활근의 세포막에 작용하여 Ca^{2+}유입 차단하므로 심근의 산소요구량 감소, 관상동맥 및 말초혈관 확장 ◆ 부작용 : 서맥, 방실블록, 저혈압, 부종, CHF, 폐부종, 방실전도시간의 연장, 두통, 어지러움, 발진, 변비, 구역, 구토, 치은비후, AST·ALT 상승, Prolactin 상승, LH 와 Testosteron 저하(남성), 피로, 호흡곤란, 홍조, 비뇨증가 ◆ 금기 : 중증 CHF, 동기능부전증후군, 방실블록(2°, 3°), 동방블록, 저혈압(수축기압<90), 심인성 쇽, 부전도로를 수반하는 심방조동, 심방세동, 급성심근경색, 임부, 가임부 ◆ 상호작용 ① Pb, DPH, Rifampin 과 병용시 이 약 효과 감소 ② Quinidine, Amiodarone, Aspirin, β-blocker 의 독성 증가 ③ CSA, Doxorubicin, Digoxin, Vecuronium 의 농도 증가 (Carbamazepine, Midazolam, Theophylline, Simvastatin, Lovastatin) ④ 신경근 차단제의 작용상승 ⑤ Disopyramide: 이 약 투여전 48 시간이나 투여후 24 시간이내 투여금지 ◆ 주의 ① 서맥(50 회/분 미만), 1°의 방실블록, CHF, 저혈압□간□신장애□신경근 전달이 저하된 환자는 신중투여 ② 심전도, 혈압측정을 자주함 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 차광보관 ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 저혈압, 고차의 방실블록 및 동정지에 이르는 서맥, 고혈당증, 혼미, 대사성 산증, 심부전 악화, 심장무수축 ② 처치 : 과량투여시의 처치는 개인의 특성을 고려하여야 행한다. β-교감신경 항진제 및/또는 칼슘 주사의 정맥투여는 경구로 투약된 이 약의 과량투여를 치료하는데 사용된다. 이 약은 혈액투석에 의해 제거될 수 없다. 임상적으로 유의한 저혈압 반응 또는 고도의 방실블록은 혈관수축제 또는 심장박동조율에 의해 치료한다. 무수축은 이소프렌 및 기타 혈관수축제 또는 심폐소생술과 같은 조치로 치료한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	**Japanese Encephalitis C.C Vac inj**	
성분/함량	**Inactivated cell-culture japanese encephalitis virus 0.4ml/V** **(3세 미만 소아용)**	**일본뇌염백신 (사백신)**
효능·효과	◆ 일본뇌염의 예방	
용법·용량	◆ 기초접종 : 0.5ml 씩 1~4 주 간격으로 2 회 -> 1 년 후 1 회 0.5ml 피하주사 (단, 3 세 미만인 경우, 0.25ml 씩 같은 방법으로 주사) ◆ 추가접종 : 기초접종 후 만 6 세, 만 12 세에 1 회 0.5ml 를 피하주사	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 항-일본 뇌염 바이러스 중화 항체를 측정 가능하게 증가시킴으로써 바이러스에 대한 활발한 면역 반응을 유발하는 불활성화 바이러스 제제 ◆ 부작용 : 울음이상, 발열, 주사부위 통증, 홍반, 부기, 과민성, 졸림, 식욕감소, 설사, 구토, 상기도 감염, 비인두염, 두드러기, 발진 ◆ 금기 ① 발열이 있는자 ② 심각한 급성 질환이 있는 자 ③ 이 백신의 성분에 아나필락시스를 일으킨 적이 있는 자 ④ 기타 예방접종 실시가 부적당한 상태에 있는 자 ◆ 주의 ① 심혈관, 신장, 간, 혈액질환, 발육장애 등의 기저질환이 있는 자 ② 백신접종 후 48 시간 이내에 발열이 있었던 자 또는 전신성 발진 등의 알레르기가 의심되는 증상이 있었던 자 ③ 과거에 경련의 병력이 있는 자 ④ 과거에 면역부전의 진단을 받았거나 가족력이 있는 자 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 : 차광, 냉장보관 (2~8℃) ◆ 적용상의 주의 ① 용해한 후에는 가능한 즉시, 늦어도 24 시간 이내에 사용하여야 함 ② 보존제를 함유하고 있지 않으므로 잔량을 재사용하지 않음	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Keppra inj	
성분/함량	Levetiracetam 500mg/5ml/V	항전간제
효능·효과	◆ 레비티라세탐 주사제는 경구투여가 일시적으로 불가능한 환자에 투여한다. 1. 단독요법: 처음 간질로 진단된 2 차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작의 치료(16 세 이상) 2.부가요법 - 기존 1 차 간질치료제 투여로 적절하게 조절이 되지 않는 2 차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작의 치료(16 세 이상) - 소아 간대성 근경련 간질(Juvenile Myoclonic Epilepsy)환자의 근간대성 발작의 치료(16 세 이상) - 특발성 전신성 간질(Idiopathic Generalized Epilepsy) 환자의 1 차성 전신 강직-간대 발작의 치료(16 세 이상)	
용법·용량	◆ 용법: 정맥으로만 투여하며 반드시 투여 전에 희석 (투여용량을 100mL의 배합가능한 희석제로 희석하고, 15분간 정맥주입) ◆ 용량 1.단독요법(성인 및 16세 이상의 청소년) 초회량은 1일 2회, 1회 250mg으로 시작, 2주 후 1일 2회, 1회 500mg으로 증량 투여. 임상적 반응에 따라, 2주마다 1일 500mg[1회 250mg, 1일 2회] 씩 증량할 수 있으며, 최대투여량은 1일 3000mg[1일 2회, 1회 1500mg] 2.부가요법 1)부분발작: 성인(18세 이상) 및 청소년(16세 이상) 1일 2회, 1회 500mg으로 투여를 시작. 임상적 반응과 내성에 따라, 2주 내지 4주마다 1일 1000mg	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 정확한 기전은 잘 알려져 있지 않으나 1) 전압의존적 N-형 칼슘채널 저해 2) 음성조정의 전이를 통해GABA억제 전달물질 방해 3) 지연된 칼륨의 흐름 감소 4)신경전달물질의 분비를 조절하는 시냅스 단백질로의 결합 ◆ 부작용 : 졸음, 우발적 상해, 적개심, 신경과민, 무력증, 복통, 우발적 상해, 약시, 관절통, 등통, 기관지염, 흉통, 착란, 변비, 경련, 설사, 약물농도의 증가, 소화불량, 반상출혈, 열, 유행성 감기증상, 진균성 감염, 위장염, 치은염, 대발작 경련, 불면증, 구역, 중이염, 발진, 비정상적 사고, 떨림, 요로 감염, 구토, 체중증가 ◆ 금기 본제 주성분이나 다른 피롤리돈 유도체 또는 다른 구성성분에 과민 반응이 있는 환자 ◆ 신중 투여 1) 레비티라세탐을 투여받은 환자에서 자살, 자살 시도 및 자살 상상이 보고되었다. 우울 및/또는 자살 상상의 증상이 있는 경우 처방의에게 즉시 보고하도록 환자에게 권고 2) 주사제는 바이알 당 0.313mmol(7.196mg)의 나트륨을 함유하므로 저염식이요법 중인 환자는 고려 3) 신장애 환자에 이 약을 투여하는 경우 용량 조정이 필요 ◆ 일반적 주의 1) 환자 및 보호자에게 항간질약이 우울증의 징후 및 증상의 발현 또는 악화, 비정상적 기분과 행동의 변화, 자살충동 및 자살행동 또는 자해충동의 위험을 증가시킬 수 있음을 알려 환자에게 이러한 증상 또는 행동이 발현될 경우 즉시 의료전문가에게 보고될 수 있도록 한다. 2) 현재까지 나와 있는 임상자료에 의하면, 소아에 대해 성장 및 사춘기에 대한 영향은 없었다. 그러나, 장기 투여 시, 학습능력, 지능, 성장, 내분비기능, 사춘기, 가임 능력에 대한 영향은 알려지지 않았다. ◆ 임신 Category: C ◆ 비고 : 밀봉용기. 실온(1~30℃) 보관 ◆ 과량투여 시의 처치 :구토나 위세척을 통해 흡수되지 않은 약물을 제거. 특별한 해독제는 없으며 대증적이고 혈액투석을 포함하는 것이 좋다. ◆ 적용상의 주의 케프라 주사액은 다음의 희석제와 항간질약과 물리적으로 배합 가능하고 배합시 상온에서 PVC bag에 보관할 때 최소 24시간	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

	동안 안정하다. : 희석제 -> 염화나트륨(0.9%) 주사액, 락트산 링거주사액, 덱스트로스 5% 주사액 항간질약 -> Lorazepam, Diazepam, Valproate

약품명	Keromin inj	
성분/함량	Ketorolac tromethamine 30mg/1ml/A	NSAIDs
효능·효과	◆ 중등도 및 중증의 급성통증(수술후 통증 포함)에 대한 단기요법 ◆ 2세 이상의 소아 : 마약성 진통제가 금기인 중증의 수술후 통증	
용법·용량	◆ 성인 : 초기량 10mg 투여, 유지량 10-30mg 을 4-6 시간마다 IM, IV 투여기간 : 최대 2 일 최대용량 : 90mg/일(60mg/일: 노인, 신장애, 체중<50kg) ◆ 2 세 이상 소아 : 수술후 1 회 IV(필요시 수회 반복가능) 0.5-1mg/kg 투여후 필요시 6 시간마다 0.5mg/kg(최대 2 일)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Acetic acid 계 NSAIDs 로 말초성 prostaglandin 합성억제하여 진통, 소염, 해열작용 ◆ 부작용 : 위장관계 부작용, 졸음, 현기증, 두통, 발한, 우울증, 구갈, 불면증, 흥분, 혈관확장, 호흡곤란, 천식, 소양증, 담마진, 빈뇨, 핍뇨, 무력감, 혈소판 응집저하, 부종, 기관지경련 ◆ 금기 ① 소화성궤양 ② 위장관, 뇌혈관계, 기타출혈 ③ 기관지천식, 기관지경련 ④ 중증도 또는 심한 신부전(SCr>160μmol/L) ⑤ 혈액량감소, 탈수증 ⑥ 항응혈제, Pentoxifylline, Probenecid, Lithium, 타 NSAIDs 병용 ⑦ 16 세 미만(경구), 2 세미만(주사) ⑧ 산과영역 진통제: 자궁수축과 태아순환에 영향 미침 ⑨임부, 수유부 ⑩염증성 장질환 환자 ⑪ 중증 심부전, 간장애 환자 ⑫ 관상동맥 우회로술 전후에 발생하는 통증 치료 ◆ 상호작용 ① Warfarin 의 혈장단백 결합률 감소로 출혈경향증가 ② Probenecid: 이 약의 clearance 감소 ③ Furosemide 의 이뇨작용 20% 감소 ④ Lithium 의 혈장농도 증가 ⑤ MTX 의 clearance 감소로 MTX 독성증가 ⑥ 비탈분극성 근육이완제의 효과 증강 ⑦ ACEI 와 병용으로 신장 손상 증가 ◆ 주의 ① 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 ②신장애 또는 그 병력이 있는 환자 ③ 고령자 ④ 고혈압 환자 ⑤ 체액저류 또는 심부전 환자 ⑥ 기관지 천식 환자, 혈액량 감소 환자 ⑦ 탈수환자 ⑧ 이뇨제 또는 ACE 억제제를 투여 중인 환자 ⑨ 위장관 질환의 병력이 있는 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 차광보관 ◆ 과량투여 시의 처치 - 투석으로 케토롤락이 제거되지 않는다. - 일반적인 비스테로이드성 소염진통제 과량투여 시의 대증치료 및 보조요법에 따라 환자를 치료한다. ◆ 적용상의 주의 ① 주사를 모르핀황산염, 에페리딘염산염, 프로메타진염산염 또는 염산하이드로리진 등과 작은 용기(주사기 등)내에서 혼합할 경우에는 침전을 일으킬 수 있으므로 이와 같이 혼합해서는 안된다. ② 이 약은 알코올을 함유하고 있으므로 중추신경계통(epidural 또는 intrathecal)으로 투여하여서는 안된다..	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Kytril inj	
성분/함량	Granisetron hydrochloride 1mg/1ml/A	항구토제
효능·효과	◆ 성인 - 화학요법, 방사선요법으로 인한 구역 및 구토 - 수술 후 구역 및 구토 ◆ 2세 이상의 소아 : 화학요법으로 인한 구역 및 구토	
용법·용량	◆ 성인 ① 화학요법, 방사선 요법에 의한 구역, 구토 : 40 μg/kg(보통 3 mg)을 20 ~ 50 mL 의 주입용액에 희석하여 5 분이상 IVF. 추가로 24 시간 이내에 3mg 씩 2 회까지 최소 10 분 간격으로 투여가능(최대 9mg/일(3mg 씩 3 회)) ② 수술 후의 구역 및 구토 : 1 회 1mg 을 0.9% N/S 로 5ml 가 되도록 희석하여 서서히 (30 초이상) IV.(최대 2mg/일) ◆ 2 세 이상 소아 : 화학요법, 방사선 요법에 의한 구역, 구토 : 40 μg/kg(최대 3 mg)을 10 ~ 30 mL 의 주입용액에 희석하여 5 분이상 IVF. 추가로 24 시간 내에 40mcg/kg(최대 3mg) 1 회 투여가능(단, 처음주입 후 최소한 10 분 이상 경과 후 추가투여)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 세로토닌(5-HT3)길항제로 항구토작용 ◆ 부작용 : 경련을 동반한 복부통증, 두통, 변비, 설사, 전신 쇠약, 피로 ◆ 금기 이 약 또는 이 약의 다른 성분에 과민반응을 나타내는 환자 ◆ 상호작용 ① [병용금기] Domperidone (보건복지부고시) : QTc 연장 효과 증가로 심각한 위험 가능성 ② Apomorphine : 심한 저혈압이나 의식 소실 ③ Hydroxyzine, Vandetanib 등 QTc 간격 연장 약물과 병용 시 QTc 연장 효과 증가 ◆ 주의 ① 아급성의 장폐색의 징후가 있는 환자 ② 심장관련 동반질환 ② 심장독성 화학요법 및/또는 전해질 이상을 수반하는 환자 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 : 차광 ◆ 과량투여 시의 처치 - 이 약에 대한 특별한 해독제는 없다. 과량투여의 경우에는 대증요법을 실시해야 한다. ◆ 적용상의 주의 ① 이 약은 용액상태에서 다른 약물과 혼합해서는 안된다. ② 미생물학적 관점에서 희석된 용액은 즉시 사용해야 한다. 그렇지 않을 경우, 보통 2-8℃에서 24 시간 이하로 보관해야 한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Lanobin inj	
성분/함량	Hydroxocobalamin 5mg/2ml/A	해열·진통·소염제
효능·효과	◆ 비타민 B12 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈과 관련된 다발성신경염의 치료	
용법·용량	◆ 1 회 5,000 μg을 IM, IV	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Vitamin B12 의 synthetic form 으로 vitamin B12 는 nucleoprotein 과 myelin 합성, cell reproduction, normal growth, maintenance of normal erythropoiesis 에 필요함 ◆ 부작용 : 설사, 피부 가려움 등 ◆ 금기: B12 에 과민증, 악성종양 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 차광한 밀봉용기, 실온보존	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Lasix inj	
성분/함량	Furosemide 20mg/2ml/A	이뇨제
효능·효과	고혈압(본태성, 신성 등), 심성부종(울혈성심부전), 신성부종, 간성부종(복수), 급성폐부종	
용법·용량	◆ 성인 : 20-40mg 을 1 일 1 회 IM, IV, 필요시 2 시간마다 20mg 씩 증량하여 1-2 회/일 ◆ 소아 : 1mg/kg/용량, 필요시 2 시간마다 1mg/kg/회씩 증량	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Henle's loop 상행각(수질, 피질 모두)의 Na+의 능동적 수송을 억제 ◆ 부작용 : 무과립구증, 혈소판 백혈구 감소증, 저 Na·K·Ca·Cl 혈증, 발진, 알칼리증, 빈혈, 식욕부진, 구토, 설사, 두통, 현기증, 청각장애, 혈압저하, 가려움, BUN SCr↑, 두드러기, 무력감 ◆ 금기 : 무뇨증, 간 신독성 물질 중독에 의한 신부전, 중증의 간장애, 중증의 저 Na 저 K 혈증, 혈액량이 현저히 감소하여 협압이 저하된 환자, 탈수증, Terfenadin Astemizole 투여환자, Sulfonamide 계 약물에 과민증, 임부, 수유부 ◆ 배합금기 : Chlorpromazine, Diazepam, Dobutamine, Metoclopramide, Ondansetron, Quinidine, Norepinephrine, Doxapram, Doxorubicin, Vincristine, Vinblastine, Esmolol, Filgrastim, GM, Droperidol, Morphine, Hydralazine, Netilmicin, Ascorbic acid, Bleomycin, Ciprofloxacin, Dopamine, Epinephrine, Labetalol, Fluconazole, Hyaluronidase, Idarubicin ◆ 상호작용 ① Curare 등 유사작용 물질의 마비작용 증가 ② SM, KM, AMK 의 청각장애 증가 ③ Cepha 계, AG 계와 병용시 신독성 증가 ④ 혈당강하제 작용 감소 ⑤ Lithium 의 배설감소 ⑥ 통풍치료제의 요산배설 억제 ⑦ Phenytoin : 이 약의 작용 50% 감소 ⑧ Salicylic acid 의 독성 증가 ⑨ 이뇨제 투여중인 환자가 ACEI, ARB 병용시 신기능 악화 우려 ⑩ Theophylline 의 작용 증가 ⑪ Digitalis 의 심장에 대한 작용 증가 ⑫ Cisplatin : 청각장애 등 내이독성 증가 ⑬ Probenecid, MTX : 이 약의 효과 감소 ⑭ CSA : 신독성 증가 ⑮ 전해질 평형실조(저 K 혈증, 저 Mg 혈증) : 이 약의 독성 증가 ⑯ 당질부신호르몬, 부신피질자극호르몬, Amphotericin B, 많은 양의 감초, 장기간 하제 : 저 K 혈증 유발 ⑰ 제산제($AlPO_4$): 이뇨제 흡수 감소 ⑱ Sucralfate : 이 약의 작용 약화 → 2 시간의 투여 간격 필요 ◆ 주의 : 전해질 평형 실조 및 탈수현상에 주의 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 주사: 차광 ② IV 투여시 속도: 4mg/분 이하(대량을 급속주사 시 난청 유발 가능) ③ pH 7 이하에서는 주성분이 침전됨 ④ 희석수액 : N/S ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 급성 또는 만성 과량투여시의 임상적 징후로는 일차적으로 전해질과 체액손실 정도에 따라서 혈액량 감소, 탈수, 혈액농축, 부정맥(방실 차단 및 심실 세동 포함) 등이 나타난다. 또한 이러한 장애의 증상으로는 쇼크로 진행될 수 있는 심각한 저혈압, 급성신부전, 혈전증, 섬망증, 이완마비, 무감동 및 혼돈 등이 있다. ② 처치 : 특별한 해독제는 알려져 있지 않다. 즉시 위 세척을 하거나 활성탄 등을 이용하여 흡수를 감소시키는 등의 조치를 통하여 이 약의 주성분이 더 이상 전신으로 흡수되는 것을 막는다	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Lavopa inj	
성분/함량	Ritodrine HCl 50mg/5ml/A	자궁수축 억제제
효능·효과	단순 조숙산통에 대한 단기관 관리 : 자궁수축억제제치료에 대한 의학적 또는 산과적 금기에 해당되지 않는 임신기간 22 주에서 37 주 사이의 임부 분만억제.	
용법·용량	◆ IV Infusion: ① 초기량 : 0.05mg/분에서 매 10 분마다 0.05mg/분씩 증량 ② 적정량 : 0.15-0.3mg/분 ◆ IM ① 10mg 을 IM 으로 1 시간내에 다시 10mg 을 주사 가능 ② 3-8 시간마다 10-20mg 씩 12-48 시간동안 계속 투여	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : β_2 수용체 흥분약으로 직접적 자궁평활근 이완, 이상수축 방지 (adenylcyclase 를 활성화시켜 증가된 c-AMP 가 Actin-Myosin 작용억제) ◆ 부작용 : 심계항진, 빈맥, 안면홍조, 발열, 발한, 진전, 오심, 구토, 빈맥, 일과성 혈당상승, K^+저하, 모체폐부종, 무과립구증, AST·ALT 상승, 근육통, 무력감, 어지러움, 발한, 모체의 장폐쇄 ◆ 금기 ① 자궁출혈 및 분만전 출혈, 자간 및 전자간증, 전기파수예 중 자궁내 감염을 합병하는 증례, 상위태반 조기박리, 자궁내 태아사망, 임신의 계속이 위험하다고 판단되는 환자 ② 중증의 갑상선 기능항진 고혈압 심질환 당뇨병 폐고혈압 환자 ③ 임신나이 22 주 미만의 임부, 65 세 이상 고령자 및 12 세 미만 소아 ④ 임신 1 기 및 2 기 동안 절박유산이 있는 환자 ◆ 배합금기 : Furosemide, Cefotiam ◆ 상호작용 ① β-blocker: 이 약의 효과 감소 ② 부신피질 Hr: 폐부종, 고혈당증 ③ 전신마취제: 이 약의 저혈압 효과증강 ④ $MgSO_4$: CPK 상승 ⑤ Atropine: 모체의 빈맥과 체성 고혈압 ◆ 주의 ① 당뇨병, 갑상선기능 항진증, 고혈압증, 심질환, 폐성 고혈압증 환자는 신중투여 ② 임신 35 주 이하 또는 추정 태아체중 2.5kg 미만의 절박조산에 유효 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 ① 차광보관, D5W 나 10% maltose 주사액으로 희석 ② 아황산수소나트륨으로 인한 천식 발작 ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 구역, 구토, 동공산대, 발한, 조홍, 빈맥, 두근거림, 근육의 진전, 경련, 고혈당증, 저칼륨혈증 등 ② 처치 : 흡수가 매우 빠르므로 경구 과량투여 후에는 활성탄(석탄, 흡착제 등)과 아황산나트륨염(하제)을 즉시 투여하거나 양이 너무 많을 때는 최종적으로 위세척이 필요 심각한 과량투여시 중환자실로 옮겨야하며 해독제로는 비선택적 β-차단제를 투여할 수 있다. ◆ 적용상의 주의 : 정맥내 주입시는 15 분 간격으로 혈압, 맥박, 태아의 심박수를 측정하고 저혈압을 방지하기 위해 환자를 반쯤 옆으로 누인 상태 또는 옆으로 누인 상태에서 주사한다.	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Ferbon inj	
성분/함량	Leucovorin Ca 50mg, 100mg, 300mg/V	해독제
효능·효과	◆ 엽사대사길항제의 독성 경감 ◆ 진행성대장암에서의 5-Fluorouracil(5-FU)과의 병용투여	
용법·용량	◆ 메토트렉세이트 통상요법 : 폴리네이트로서 1회 6~12mg을 6시간마다 1일 4회 근육주사, 또 메토트렉세이트를 과량투여한 경우에는 투여한 메토트렉세이트와 동량을 투여 ◆ 메토트렉세이트/폴리네이트 구원요법 : 메토트렉세이트 투여 종료 후 3시간 후부터 폴리네이트로서 1회 15mg 3시간마다 9회 정맥주사 -> 이후 6시간마다 8회 정맥 또는 근육주사 ◆ 진행성 대장암에서의 5-FU와의 병용투여 : 항암 Regimen에 따라 다양(예) 200mg/m_2 등)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 ① Purine, Pyrimidine 합성에 필요한 tetrahydrofolate로 전환하는 dihydrofolate reductase(MTX와 같은 folate antagonist에 의해 저해되는 효소)를 이용하지 못하게 하여 folic acid antagonist의 치료 효과 및 독성을 중화 ② 5-FU의 전환된 형태(fluorodeoxyuridylic acid)가 DNA 복구 및 복제에 중요한 thymidylate synthase에 결합하는 것을 안정화하여 5-FU 의 효과를 강화 ◆ 부작용 ① 아나필락시스, 두드러기 등의 과민증 ② 투여부위의 혈관통(IV시), 일과성 동통(IM) ③ 발열, 중추신경계장애(마비성장애, 흥분, 우울) ④ 5-FU와 병용시 복용배합에 따라 설사, 피부반응, 피부건조, 구내염, 결막염, 점막염, 약한혈액독성, 백혈구 감소증 등 나타날 수 있음 ◆ 금기 : 임부 및 수유부(5-FU와의 병용투여에 한함) ◆ 주의 ① 엽산길항제(예)MTX)의 과량투여 치료에서는 가능한 이 약을 즉시 투여할 것 ② 이 약의 치료기간과 최적용량을 결정하기 위해 혈청 MTX 농도를 측정 ◆ 태아위험도 : C ◆ 상호작용 ① Phenobarbital, phenytoin, primidone 의 혈장농도를 감소시켜 발작 빈도를 증가시킬 수 있음 ② 5-FU 의 효력과 이상반응 증가시킴 ③ 엽산저해 항암제(예)MTX)와 동시에 투여시 항암 효과가 감소되거나 중화 ◆ 비고 ① 냉장(2~8℃) 및 차광 보관 ◆ 적용상의 주의 ① 이 약은 Calcium을 포함하고 있으므로 정맥주사하는 경우 분당 160mg을 초과하지 않도록 주의할 것 ② 경막내(intrathecal) 투여하지 말 것	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Leuplin inj, Luphere depot inj	
성분/함량	Leuprorelin acetate 3.75mg/V	항악성종양제
효능·효과	◆ 자궁내막증 ◆ 과다월경, 하복통, 요통 및 빈혈 등을 수반한 자궁근종에서 근종핵의 축소 및 증상의 개선 ◆ 전립선암 ◆ 폐경전 유방암 ◆ 중추성 사춘기조발증	
용법·용량	◆ 자궁내막증: 3.75mg(50 kg 미만 환자는 1.88 mg)을 SC로 4주마다 1회 투여 (초회투여는 월경주기 1-5일째 행함) ◆ 자궁근종: 1.88mg을 4주마다 1회 SC (과체중, 자궁종대가 고도인자: 3.75mg, 초회는 월경주기 1-5일째 행함) ◆ 전립선암, 폐경전 유방암: 3.75mg을 SC로 4주마다 1회 투여 ◆ 중추성 사춘기 조발증: 30mcg/kg을 4주마다 1회 SC(max 90mcg/kg)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : GnRH 또는 LHRH의 합성유사체로 생체내 Hr보다 강력한 효력을 나타내며 feedback inhibition에 의해 성선자극Hr 분비가 억제되고 난소와 고환의 steroid 생성억제 ◆ 부작용 : 무월경, 자궁출혈, 말초부종, 심계항진, 심장전도이상, 여성다모증, 혈관부종, 협심증, 구토, 기분변화, 두통장애, 메스꺼움, 발기기능장애, 부종, 불면, 성욕변화, 식욕부진, 어지러움, 여성형유방증, 유방통증, 전신 쇠약, 주사부위 후유증, 질염, 체중증가, 흐린시력 등 ◆ 금기 ① 이 약의 성분, GnRH 유사약물에 대해 과민반응의 병력이 있는 환자 ② 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 ③ 자궁내막증, 자궁근종, 중추성사춘기조발증 : 원인불명의 질출혈이 있는 환자(악성질환의 가능성이 있다.) ④ 호르몬 비의존성 전립선암 환자 ⑤ 양쪽 고환 절제술을 받은 후, 이 약에 의해 더 이상 테스토스테론의 감소를 기대할 수 없는 환자 ⑥ 진행성 뇌종양 소아 환자 ⑦ 진단된 뇌하수체 샘종 환자 ◆ 상호작용 성호르몬제 (에스트라디올 유도체, 에스트리올 유도체, 결합형 에스트로겐제제, 난포호르몬과 황체호르몬의 복합제, 양성혼합호르몬제 등): 자궁내막증, 자궁근종의 경우에 이 약의 효과 감소 ◆ 태아위험도 : X ◆ 비고 ① 실온(1~30℃)보관 ② [임부금기] 1등급, 2등급(보건복지부 고시) - 자궁내막증, 자궁내막축소증환자 : 1등급 - 폐경전 유방암환자 : 2등급	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Leuplin DPS inj	
성분/함량	Leuprorelin acetate 11.25mg/syr	항악성종양제
효능·효과	◆ 자궁내막증 ◆ 과다월경, 하복통, 요통 및 빈혈 등을 수반한 자궁근종에서 근종핵의 축소 및 증상의 개선 (체중이 무거운 환자, 자궁종대가 고도인 환자에 한함) ◆ 전립선암 ◆ 폐경전 유방암 ◆ 중추성 사춘기조발증 (만9세 미만의 여아 및 만10세 미만의 남아에 한함)	
용법·용량	◆ 자궁내막증, 자궁근종: 11.25mg을 12주마다 SC(초회 투여는 월경주기 1-5일째) ◆ 진행성 전립선암, 폐경전 유방암: 11.25mg을 12주마다 SC ◆ 중추성 사춘기 조발증 -체중 20kg 이상: 11.25mg(1ml 현탁액)을 12주마다 SC -체중 20kg 미만: 5.625mg(0.5ml 현탁액)을 12주마다 SC, 남은 현탁액은 폐기	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : GnRH 또는 LHRH의 합성유사체로 생체내 Hr보다 강력한 효력을 나타내며 feedback inhibition에 의해 성선자극Hr 분비가 억제되고 난소와 고환의 steroid 생성억제 ◆ 부작용 : 무월경, 자궁출혈, 말초부종, 심계항진, 심장전도이상, 여성다모증, 혈관부종, 협심증, 구토, 기분변화, 두통장애, 메스꺼움, 발기기능장애, 부종, 불면, 성욕변화, 식욕부진, 어지러움, 여성형유방증, 유방통증, 전신 쇠약, 주사부위 후유증, 질염, 체중증가, 흐린시력 등 ◆ 금기 ① 이 약의 성분, GnRH 유사약물에 대해 과민반응의 병력이 있는 환자 ② 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 ③ 자궁내막증, 자궁근종, 중추성사춘기조발증 : 원인불명의 질출혈이 있는 환자(악성질환의 가능성이 있다.) ④ 호르몬 비의존성 전립선암 환자 ⑤ 양쪽 고환 절제술을 받은 후, 이 약에 의해 더 이상 테스토스테론의 감소를 기대할 수 없는 환자 ⑥ 진행성 뇌종양 소아 환자 ⑦ 진단된 뇌하수체 샘종 환자 ◆ 상호작용 성호르몬제 (에스트라디올 유도체, 에스트리올 유도체, 결합형 에스트로겐제제, 난포호르몬과 황체호르몬의 복합제, 양성혼합호르몬제 등): 자궁내막증, 자궁근종의 경우에 이 약의 효과 감소 ◆ 태아위험도 : X ◆ 비고 ① 실온(1~30℃)보관 ② [임부금기] 1등급, 2등급(보건복지부 고시) - 자궁내막증, 자궁내막축소증환자 : 1등급 - 폐경전 유방암환자 : 2등급	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Lidocaine inj 1%	Lidocaine inj 2%
성분/함량	Lidocaine HCl	국소마취제
함량/단위	200mg/20ml/V	100mg/5ml/V, 400mg/20ml/V
효능·효과	[마취] 경막외마취, 전달마취, 침윤마취, 표면마취 [내과적 사용] 심실성 부정맥	
용법·용량	◆ 마취 ① 경막외 마취 : 100-200mg (최대: 200mg) ② 전달마취 : 30-200mg (최대: 200mg) - 지지신경차단: 30-100mg - 근간신경차단: 50mg ③ 침윤마취: 20-200mg(최대: 200mg) ④ 표면마취: 적당량 도포 및 분무 ◆ 부정맥 ① IV 1 회 투여법: 1 회 50-100mg(1-2mg/kg)을 1-2 분간 서서히 IV , 효과가 없다면 5 분 후 동량추가, 효과지속을 기대할 때 10-20 분간격으로 동량 추가 가능 (최대: 300mg/hr) ② IV infusion: EKG monitoring 하 1-2mg/분으로 투여(4mg/분)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 지각 신경세포내 voltage dependent Na^+유입을 차단하여 탈분극 억제하므로 신경전도 차단 ◆ 상호작용 ① Cimetidine: 이 약의 혈중농도 상승 ② Metoprolol, Propranolol: 이 약의 대사지연 ③ 부정맥용제, Terfenadine: QT 연장, 심실성 부정맥 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 : 암소보관 [마취] ◆ 금기 ① 중독한 출혈 또는 쇽 상태의 환자 ② 주사부위 또는 그 주위에 염증 환자 ③ 패혈증 환자 ◆ 주의 ① 중추신경계 질환(수막염, 회백척수염 등) 환자 ② 임산부 ③ 고령자 ④ 중증의 고혈압 환자 ⑤ 척추에 현저한 변형 환자 ◆ 부작용 : 쇽(혈압저하, 안면창백, 맥박 이상, 호흡억제 등), 악성고열, 진전, 경련, 졸음, 불안, 흥분, 무시, 어지러움, 구역·구토, 두드러기, 부종 ◆ 적용상의 주의 : (표면마취) 안과용으로 사용하지 않는다. [내과적 사용] ◆ 금기 : 중독한 자극전도장애(완전방실블록 등) 환자 ◆ 주의 ① 경증의 자극전도장애 환자 ② 현저한 동성서맥 환자 ③ 중증의 간기능장애 환자 ④ 중증의 신기능장애 환자 ⑤ 순환혈액량 감소 환자, 쇽 상태의 환자 ⑥ 고령자 ◆ 부작용 : PQ 간격의 연장 또는 QRS 폭의 증대, 혈압저하, 쇽, 서맥, 심정지, 악성고열, 진전, 경련, 헛소리, 어지러움, 졸음, 불안, 다행감, 구토, 마비감	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	**Lipothasone inj**	
성분/함량	Dexamethasone palmitate 4mg/T	Glucocorticoids
효능·효과	류마티스관절염	
용법·용량	① 관절내주사: 대관절(슬관절 등) 7.5mg, 중관절(주관절 등) 2.5-5mg, 소관절(지관절 등) 1.25mg ② 정맥주사: 2.5mg 2 주에 1 회	
사용상의 주의사항	◆ 부작용 : 감염, 과다분비상태, 불면증, 신경과민, 증가된 식욕 등 ◆ 금기 : 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자, 수유부, 대두가유, 콩, 땅콩에 과민증이 있는 환자 ◆ 상호작용 ① Asunaprevir, Live vaccines, Aldeseukin, Dasatinib, Lapatinib, Sunitinib, Selected anticholinesterase 의 효과 감소 우려 ② Natalizumab: 두 약물의 부작용 유발 ③ Amphotericin B, Mifepristone 의 부작용 유발 ◆ 신중투여 : 유효한 항균제가 없는 감염증, 전신성 진균증, 소화성궤양, 정신병, 결핵성질환, 단순포진성각막염, 후낭백내장, 녹내장, 고혈압, 전해질 이상, 혈전증, 최근에 시행한 내장의 수술상처가 있는 급성심근경색을 일으킨 적이 있는, 조절되지 않는 당뇨병 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : ① [임부금기] 2 등급(보건복지부고시) ② 밀봉용기, 차광 실온보관	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Lucenbs PFS inj	
성분/함량	Ranibizumab 1.65mg/0.165ml/Syringe	안과용제
효능·효과	신생혈관성 (습성) 연령관련 황반변성의 치료, 당뇨병성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료, 망막정맥폐쇄성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료, 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상의 치료, 병적근시 또는 신생혈관성 연령관련 황반변성 이외의 원인으로 인한 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상의 치료	
용법·용량	·1 회 0.5mg(0.05ml) 투여 ·1 개 바이알은 반드시 1 회 유리체내 투여에만 사용, 분할투여 않음 ·1 개월 이상의 투여간격을 둠 ·시력이 안정되어 치료를 중단한 후에도 매달 시력검사 권장 ① 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성의 치료 -첫 3 개월(loading phase) 동안 월 1 회 투여한 후 유지기를 가지며, 유지기 동안 환자들은 매달 시력을 모니터링함 -재투여: 만약 환자가 5 시표 이상의 시력 저하가 있을 경우(ETDRS 또는 Snellen line 평가), 이 약을 재투여 ② 당뇨병성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료 -월 1 회, 매달 시력 측정 시 3 회 연속으로 시력 안정될 때까지 투여 -중단: 3 회 연속 투여해도 개선 없으면 더 이상 치료 권고되지 않음 -재투여: 당뇨병성 황반부종에 의해 시력 손상 재발 시 ③ 망막중심정맥폐쇄성(Central Retinal Vein Occlusion) 및 망막분지정맥폐쇄성(Branch Retinal Vein Occlusion) 황반부종에 의한 시력 손상의 치료 -월 1 회, 매달 시력 측정 시 3 회 연속으로 시력 안정될 때까지 투여 -중단: 망막중심정맥폐쇄성(CRVO) 황반부종에 의한 시력 손상의 경우 3 회 연속 투여해도 개선 없으면 더 이상의 치료는 권고되지 않음. -재투여: 망막정맥폐쇄성 황반부종에 의해 시력 손상 재발 시 ④ 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상의 치료 -1 회 투여 -재투여: 질병활성(시력 저하 및/또는 병변활성의 징후)이 있는 경우 (투여 첫 1 년 동안 대개 1 회 또는 2 회 투여) -모니터링: 투여 첫 1 년 중 첫 2 개월 동안은 매달 모니터링, 이후에는 최소 3 달에 한번 (첫 1-2 개월에서 질병활성을 보인 환자의 경우 더 자주 모니터링)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 혈관신생과 안구 혈관형성에서 누출물의 원인이 되고 연령관련 황반 변성(AMD)의 혈관 신생 진행에 주된 역할을 한다고 알려져 있는 VEGF-A 의 수용체 VEGF110 의 결합 자리에 결합 → 내피세포의 표면에서 VEGF-A 와 그 수용체 (VEGFR1 과 VEGFR2)간의 상호작용을 저해하고, 내피세포의 증식, 혈관누출, 새로운 혈관 생성을 감소시킴 ◆ 부작용 : 심방세동, 두통, 결막출혈, 안구동통, 유리체부유물, 망막출혈, 안압증가, 유리체박리, 안구염증, 안구자극, 백내장, 이물감, 시야장애, 눈꺼풀염, 망막하 섬유증, 안구충혈, 시력감소/시력흐림, 안구건조, 유리체염, 안구불쾌감, 결막충혈, 후낭혼탁, 망막 삼출물, 주사부위 반응, 눈물분비 증가, 안구소양증, 결막염, 망막상피세포 분리, 황반변증, 오심, 관절통, 요통, 기관지염, 빈혈, 고혈압 ◆ 금기 : 환자안구 또는 안구 주변의 감염이 있거나 감염이 의심되는 환자, 중증의 안내 염증이 있는 환자 ◆ 상호작용 : ① Ca channel blocker, 면역억제제, Sildenafil, Irinotecan 의 병용 : 치료효과 부작용 모두 증가 ② Rifampin, 제산제, 완충약제, H2blocker,PPI,St.John'swort (Hypericum perforatum): 이 약의 혈중농도 감소 ③ Atenolol, Diltiazem : PR 간격을 연장시킴 ④ HMG-CoA reductase 저해제 : 횡문근 융해증 등 근육질환의 중증 반응 유발 가능성 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : ① 환자는 유리체내 주사 3 일 전후로 하루에 4 번씩 항균 점안액을 스스로 투여하도록 지시되어야 함 ② 냉장(2~8℃) 및 차광 보관	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Lucentis inj	
성분/함량	Ranibizumab 2.3mg/0.23ml/V	안과용제
효능·효과	신생혈관성 (습성) 연령관련 황반변성의 치료, 당뇨병성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료, 망막정맥폐쇄성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료, 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상의 치료, 병적근시 또는 신생혈관성 연령관련 황반변성 이외의 원인으로 인한 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상의 치료	
용법·용량	·1 회 0.5mg(0.05ml) 투여 ·1 개 바이알은 반드시 1 회 유리체내 투여에만 사용, 분할투여 않음 ·1 개월 이상의 투여간격을 둠 ·시력이 안정되어 치료를 중단한 후에도 매달 시력검사 권장 ① 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성의 치료 -첫 3 개월(loading phase) 동안 월 1 회 투여한 후 유지기를 가지며, 유지기 동안 환자들은 매달 시력을 모니터링함 -재투여: 만약 환자가 5 시표 이상의 시력 저하가 있을 경우(ETDRS 또는 Snellen line 평가), 이 약을 재투여 ② 당뇨병성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료 -월 1 회, 매달 시력 측정 시 3 회 연속으로 시력 안정될 때까지 투여 -중단: 3 회 연속 투여해도 개선 없으면 더 이상 치료 권고되지 않음 -재투여: 당뇨병성 황반부종에 의해 시력 손상 재발 시 ③ 망막중심정맥폐쇄성(Central Retinal Vein Occlusion) 및 망막분지정맥폐쇄성(Branch Retinal Vein Occlusion) 황반부종에 의한 시력 손상의 치료 -월 1 회, 매달 시력 측정 시 3 회 연속으로 시력 안정될 때까지 투여 -중단: 망막중심정맥폐쇄성(CRVO) 황반부종에 의한 시력 손상의 경우 3 회 연속 투여해도 개선 없으면 더 이상의 치료는 권고되지 않음. -재투여: 망막정맥폐쇄성 황반부종에 의해 시력 손상 재발 시 ④ 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상의 치료 -1 회 투여 -재투여: 질병활성(시력 저하 및/또는 병변활성의 징후)이 있는 경우 (투여 첫 1 년 동안 대개 1 회 또는 2 회 투여) -모니터링: 투여 첫 1 년 중 첫 2 개월 동안은 매달 모니터링, 이후에는 최소 3 달에 한번 (첫 1-2 개월에서 질병활성을 보인 환자의 경우 더 자주 모니터링)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 혈관신생과 안구 혈관형성에서 누출물의 원인이 되고 연령관련 황반 변성(AMD)의 혈관 신생 진행에 주된 역할을 한다고 알려져 있는 VEGF-A 의 수용체 VEGF110 의 결합 자리에 결합 → 내피세포의 표면에서 VEGF-A 와 그 수용체 (VEGFR1 과 VEGFR2)간의 상호작용을 저해하고, 내피세포의 증식, 혈관누출, 새로운 혈관 생성을 감소시킴 ◆ 부작용 : 심방세동, 두통, 결막출혈, 안구동통, 유리체부유물, 망막출혈, 안압증가, 유리체박리, 안구염증, 안구자극, 백내장, 이물감, 시야장애, 눈꺼풀염, 망막하 섬유증, 안구충혈, 시력감소/시력흐림, 안구건조, 유리체염, 안구불쾌감, 결막충혈, 후낭혼탁, 망막 삼출물, 주사부위 반응, 눈물분비 증가, 안구소양증, 결막염, 망막상피세포 분리, 황반변증, 오심, 관절통, 요통, 기관지염, 빈혈, 고혈압 ◆ 금기 : 환자안구 또는 안구 주변의 감염이 있거나 감염이 의심되는 환자, 중증의 안내 염증이 있는 환자 ◆ 상호작용 : ① Ca channel blocker, 면역억제제, Sildenafil, Irinotecan 의 병용 : 치료효과 부작용 모두 증가 ② Rifampin, 제산제, 완충약제, H2blocker,PPI,St.John'swort (Hypericum perforatum): 이 약의 혈중농도 감소 ③ Atenolol, Diltiazem : PR 간격을 연장시킴 ④ HMG-CoA reductase 저해제 : 횡문근 융해증 등 근육질환의 중증 반응 유발 가능성 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : ① 환자는 유리체내 주사 3 일 전후로 하루에 4 번씩 항균 점안액을 스스로 투여하도록 지시되어야 함 ② 냉장(2~8℃) 및 차광 보관	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Lumasate inj	
성분/함량	Flumazenil 0.5mg/5ml/A, 0.2mg/2ml/A	해독제
효능·효과	벤조디아제핀계 약물의 중추진정작용 역전(reversal) ◆ 마취시 - 입원환자에서 벤조디아제핀계 약물로 유도 또는 유지되는 전신마취의 종료 - 입원 및 외래환자의 단시간 진단 및 치료시의 벤조디아제핀계 약물에 의한 진정작용의 역전 ◆ 중환자 치료시 - 벤조디아제핀계 약물중독의 확진 및 해독 - 원인불명으로 의식불명시 벤조디아제핀계 약물, 다른 약물 또는 뇌손상에 의한 것인지의 감별을 위한 진단수단 - 약물과량 투여시 벤조디아제핀계 약물의 중추작용에 대한 특정 역전(삽관법이 불필요하게 하거나 발관법을 실시할 수 있도록 하기 위하여 자발 호흡 및 의식을 회복시킴.)	
용법·용량	◆ 이 약은 마취과 전문의 또는 경험이 많은 의사가 정맥주사한다. 이 약은 5%포도당주사액, 유당첨가링겔액 또는 생리식염주사액에 희석하여 점적정맥주입할 수 있으며 다른 인공소생처치와 동시에 사용될 수도 있다. ◆ 마취 역전시 : 초회 0.2mg을 15초이내 IV, 60초내 의식 회복되지 않으면 2회째 용량 0.1mg IV, 필요시 60초마다 0.1mg씩 반복 IV [상용량: 0.3-0.6mg IV(최대:1mg)] ◆ 중환자 치료시 서서히주사 : 초기 0.3mg IV, 60초 이내 의식이 회복되지 않으면 각성될 때까지 총투여량 2mg까지 투여가능, 혼미상태가 재발될 경우 0.1-0.4mg/hr로 IV infusion	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Imidazobenzodiazepine계 화합물로 benzodiazepine 수용체에 작용하는 약물의 중추작용을 상경적 저해 ◆ 부작용 : 경련, 두통, 흥분, 혈압상승, 어지러움, AST ALP↑, 주사부위 통증 ◆ 금기 ① 삼(사)환계 항우울제의 중증 중독에 의한 자율신경성(항콜린 작용성), 운동이상 또는심혈관계 증상(부정맥, 심혈관폐쇄 등), 저체온증, 허탈감이 나타나는 경우 ② 생명에 지장이 있을 수 있는 상황(예: 머리손상 후 두개내압 이상 또는 간질 지속상태)에서 benzodiazepine 을 투여받고 있는 환자 ③ 수술 후 아편의 지속적인 호흡억제 효과가 있는 경우, 이미 의식이 명료한 환자 ④ Benzodiazepine 제제에 과민증 ◆ 상호작용 ① Zopiclone 의 중추작용 차단 ② 자살기도 등 고의로 과량의 Benzodiazepine 계 약물과 동시에 삼(사)환계 향우울약 복용 시 이 약 투여로 Benzodiazepine 작용 저하에 따라 향우울약의 중독작용 증강 우려 ◆ 주의 ① Benzodiazepine 계 약물을 장기간 투여중인 간질 환자, 수술전 진정되기 전의 불안정도가 높은 환자(특히 관동맥질환자), ICU 에서 고혈압 환자, Benzodiazepine 계 제제가 투여된 중증두부외상 불안정한 두개내압환자, 노인, 간기능장애, 심근경색, 부정맥, 근신경차단제와 병용시(근신경차단제 효과소실 후 이약 투여) ② 이 약 투여 첫 24 시간 동안 운전 기계조작 금지 ◆ 태아위험도 : C ◆ 과량투여시의 처치 : 구체적인 해독제는 없으며, 이 약을 과량 투여한 경우, vital sign 을 모니터하고 환자의 임상상태를 관찰하는 등 일반적인 보조요법이 고려되어야 한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Macperan inj	
성분/함량	Metoclopramide HCl 10mg/A	진토제, 소화관 운동 조절
효능·효과	◆ 성인 : 수술 후, 방사선요법 유발 구역,구토 예방. 구역, 구토의 증상 치료. ◆ 1~18 세 소아 : 2 차 치료로써 항암화학요법 후 지연된 구역,구토 예방. 수술 후 구역, 구토 치료	
용법·용량	◆ IV, IM 가능하며 IV 시 적어도 3 분 이상 천천히 주입해야 한다. 일일최대권장용량은 30mg 또는 0.5/kg, 투여간격은 6 시간 이상 권장. ◆ 성인 : 10mg 단회투여가 권장되며 일일 3 회까지 반복하여 투여 ◆ 1~18 세 소아 : 권장용량은 0.1~0.15mg/kg, 일일 3 회까지 반복하여 투여. 24 시간 내 최대용량은 0.5mg/kg	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 ① Dopamine antagonist, CTZ 에서 Serotonin receptor 저해함 ② Upper GI 에서 Acetylcholine 의 반응을 증감시켜 위장관운동촉진 ③ Esophageal sphincter tone 증가시킴 ◆ 부작용 : 권태감, 두통, 불안, 졸음, 위장장애, 유즙분비, 여성형 유방(과량투여), 수전증, 근육강직, 안부경련, 심부정맥, NMS(악성 신경마비 증후군), 추제외로 증상, 복통, 설사, 변비, 내분비기능조절이상, 권태감, 발진, 부종, Methemoglobinemia ◆ 금기 : 크롬친화세포종환자, 위장관 운동자극이 위험한 환자(위장관 출혈, 기계적 장폐색, 천공), 간질환자 및 추체외로 증상을 야기하는 약물을 투여 받는 환자, 파킨슨병 환자, 1세 미만 소아 ◆ 상호작용 ① Benzamide 계, Phenothiazine 계, Butyrophenone 계, Reserpine : 추체외로 증상, 내분비기능 조절이상 ② Digitalis 의 포화 지표인 구역, 구토가 은폐 ③ Carbamazepine 의 혈중농도를 급속히 상승 ④ 위장관에 대한 작용이 항 choline 제, 마약성 진통제에 의해 길항 ◆ 배합금기 : Alkali 주사액: 혼합시 혼탁을 일으킴 ◆ 주의 ① 기계조작 주의 ② 지발성운동장애, 자살경향증가, AV node block 현상주의 ◆ 태아위험도 : C B ◆ 비고 : 차광보관 ◆ 과량투여시의 처치 : 이 약의 대량투여로 메트헤모글로빈혈증이 나타났다는 보고가 있다. 과량 투여시 급성 근긴장 증상이 나타날 수 있으며 매우 드물게 AV block이 나타날 수 있다. ◆ 적용상의 주의 : 근주부위에 동통, 경결이 나타날 수 있다.	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Magnesium sulfate 10% inj	
성분/함량	Magnesium sulfate 2g/20ml/A	무기질제제(마그네슘)
효능·효과	경련, 자간, 전해질보급(저마그네슘혈증), 자궁경직(분만촉진)	
용법·용량	◆ 저마그네슘혈증에 의한 경련 : 1~2g 을 IV ◆ 자간증의 발작 : 4~5g 을 10 분간 IV ◆ 자궁경직 방지 : 4g 을 IV. 이후 1g 을 투여 할 수 있다. ◆ 전해질보급(저마그네슘혈증) : 1g 을 6 시간마다 4 회 IM. 또는 5g 을 5%포도당주사액이나 0.9%생리식염 주사액에 첨가하여 3 시간동안 IV.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 ① motor nerve terminal 에서 acetylcholine 을 감소시키고 심근의 SA node 에서 전도 형성을 늦추고 속도를 연장 ② 평활근 이완작용 ◆ 부작용 : 대량투여시 중독(열감, 갈증, 혈압강하, 중추신경억제, 심박동수억제, 호흡억제 등: 해독제 Ca IV 제제), 전도장애, 서맥, 말초혈관 확장 ◆ 금기 : 신기능장애, 혼수환자, 고 Mg 혈증 환자, 방실차단, 근무력증 환자 ◆ 상호작용 ① Barbiturate, 마약, 최면약(전신마취제): 중추신경 억제효과 증강 ② INAH, Chlorpromazine, Digoxin 의 흡수 변화 ③ Fe, TC, NaF 의 약물흡수 감소(∵ 염 또는 복합체 형성) ◆ 배합금기 : Sulfa 제, 알칼리탄산염, 탄산수소, 주석산염, 가용성 인산염, 브롬화칼륨, 브롬화암모늄과는 침전형성 ◆ 주의 ① 신생아에서 고 Mg^{2+}혈증 유발 ② 정맥주사 단독투여 시 10% 이하의 농도로 주사 ③ 장내 기생충 질환의 소아 ◆ 태아위험도 : D ◆ 적용상의 주의사항 ① 정맥주사 단독투여시에는 10% 이하의 농도로 천천히 주사한다. ② 이 약의 수용액과 설파제, 알칼리탄산염, 탄산수소염, 주석산염, 가용성 인산염, 브롬화칼륨, 브롬화암모늄 등을 함유하는 제제와 혼합시 침전이 형성될 수 있으므로 혼합을 피한다. ③ 전해질 보정용으로 사용할 경우에는 반드시 희석하여 사용하고 인산염을 함유하는 제제와 배합시 침전을 형성할 수 있으므로 주의한다. 또한 감염을 고려하여 환자의 피부 및 기구를 소독하고 개봉후 즉시 사용하며 남은 액은 재사용하지 않는다.	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Menactra inj	
성분/함량	**meningococcal A polysaccharide conjugated to C.diphtheriae vaccine 4mcg** **meningococcal C polysaccharide conjugated to C.diphtheriae vaccine 4mcg** **meningococcal Y polysaccharide conjugated to C.diphtheriae vaccine 4mcg** **meningococcal W-135 polysaccharide conjugated to C.diphtheriae vaccine 4mcg** **0.5ml/Vial**	**수막구균 백신**
효능·효과	9 개월 ~ 만 55 세의 유·소아 및 성인에서 Neisseria meningitidis A, C, W135 및 Y 군에 의한 침습성 수막구균 질환의 예방	
용법·용량	◆ 접종부위 : 근육주사. 절대로 정맥 주사 혹은 피하주사 안됨 ◆ 용량 : 접종연령 및 횟수 - 9~23개월 : 1회 용량 0.5mL씩 3개월 간격으로 2회 접종 - 24개월~만55세 : 1회 0.5mL을 접종 - 추가 접종에 대해서는 아직 결정되지 않음.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 수막구균 백신(Meningococcal vaccine conjugated to diphtheria CRM197) Neisseria meningitides : G(-) 쌍구균, 수막염/패혈증과 같은 침습성 질환을 야기함. 5개 seogroup(A, B, C, Y, W-135)이 침습성 수막구균 감염의 대부분을 일으킴. 혈청 내 살균성 항체들의 존재는 침습성 수막구균 질환을 예방. serogroups A, C, Y, W-135의 capsular polysaccharides에 대항하는 살균성 항체를 생산하도록 함. ◆ 부작용 관절통, 권태, 두통 장애, 설사, 식욕부진, 열, 오한, 주사 부위 후유증, 피로, 구토, 피부발진, 갈랑-바레증후군, ◆ 금기 이전에 수막구균 다당류 백신, 디프테리아 톡소이드, CRM197 포함 백신의 접종 시, 또는 본 백신의 구성성분에 대해 아나필락시스와 같은 심각한 과민성 반응을 보인 자 ◆ 일반적 주의 1) 갈랑-바레증후군 신중투여 2) 접종 전에 발생할 수 있는 백신 과민반응 및 이전에 백신-관련된 유해반응에 대한 병력을 검토하여 유익성 및 위험성을 평가해야 함. 급성 아나필락시스 반응이 발생하였을 때를 대비하여, 에피네프린 및 즉각적인 알러지 반응의 조절에 사용되는 다른 적절한 약물이 즉시 투여될 수 있어야 함. 3) 면역력이 약화된 사람(면역억제 치료 환자 포함)에서는 백신에 대한 면역반응이 떨어질 수 있음. ◆ 적용상의 주의 1) 정맥주사, 피하주사, 혹은 피내주사로 접종 안됨. 2) 접종 전, 백신을 육안으로 확인하여 어떠한 이물질이나 물리적 성상에 변화가 있는지 검사하고, 이상이 있는 경우에는 사용하지 않음. 3) 접종 부위는 보통 상완외측, 에탄올 또는 요오드틴크로 소독. ◆ 임신 Category: C ◆ 비고 : 동결을 피하여 2~8℃ 보관 (동결 되었던 제품은 사용하지 않음)	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Menveo inj	
성분/함량	**Meningococcal Oligosaccharide (A:10mcg/C:5mcg/W135:5mcg/Y:5mcg) conjugated to Diphtheria CRM197 Vaccine 0.5ml/V**	**수막구균 백신**
효능·효과	◆ 2 개월~55 세의 영·유아, 소아, 청소년 및 성인에서 Neisseria meningitidis A, C, W135 및 Y 군에 의한 침습성 수막구균 질환의 예방 (단, 2 개월~23 개월의 영·유아에서 Neisseria meningitidis A 군의 효능효과는 입증되지 않음)	
용법·용량	◆ 근육주사 (주사 부위 - 영아 : 대퇴부 전외측, 어린이와 청소년, 성인 : 상완부 삼각근) ◆ 2개월~23개월의 소아 ① 접종을 시작하는 2개월부터 6개월까지 소아의 경우 처음 3회 접종을 각각 0.5ml 씩 최소 2개월 간격을 두고 접종, 4차 접종은 적어도 6개월 간격을 두고 그 다음 연령에 실시 ② 본제 접종 경험이 없는 7개월~23개월의 소아의 경우 0.5ml씩 총 2회 접종, 두 번째 접종은 첫 번째 접종 후 최소 3개월의 간격을 두고 그 다음 연령에 실시 ◆ 만 2세~55세의 어린이, 청소년 및 성인 : 1회 0.5ml, 1회 접종	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Neisseria meningitidis는 G(-) 쌍구균으로 수막염과 패혈증과 같은 생명을 위협하는 침습성 질환을 야기하며 세계적으로 이 균의 5개 seogroup(A, B, C, Y, W-135)은 침습성 수막구균 감염의 거의 대부분을 일으킴. 본제의 접종은 serogroups A, C, Y, W-135의 capsular polysaccharides에 대항하는 살균성 항체를 생산하도록 함. ◆ 부작용 : 주사부위의 통증, 과민반응, 졸음, 식이 장애, 설사, 구토, 지속적 울음, 발진 등 ◆ 금기 : 활성 성분 및 디프테리아 톡소이드(CRM197)를 포함한 다른 성분에 과민성이 있거나 과거에 비슷한 성분을 함유한 백신을 투여한 후 생명을 위협하는 반응이 있었던 경우 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 냉장 보관(2~8℃) ◆ 적용상의 주의 ① 두 가지 용기에 들어 있는 두 가지 내용물(분말, 주사액)을 투여 직전에 혼합하여 1회 투여분 0.5ml 로 만듬	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Merit-C inj	
성분/함량	ascorbic acid 10g	비타민 C, 단일제(Ascorbic acid)
효능·효과	◆ 비타민 C 를 공급하여 다양한 결핍증상과 대사장애를 개선하는 비타민제	
용법·용량	◆ 아스코르빈산으로서 1일 50~1,000mg을 1일 1회~수회 분할하여 피하, 근육 또는 정맥주사 한다.	
사용상의 주의사항	◆ 금기 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자 2) 고수산뇨증(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태), 지중해빈혈증 환자 3) 통풍환자 및 시스틴뇨증 환자 4) Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) 결핍환자 : 고용량을 투여할 경우 용혈을 초래할 수 있다. 5) 신장의 수산결석 환자 : 1일 1 g 이상 투여할 경우 ◆ 부작용 1) 구역, 구토, 설사, 속쓰림, 복부경련, 피로, 홍조, 두통, 불면 2) 1일 1 g 이상 투여 시, 요의 산성화로 설사 및 신결석의 위험이 증가 3) 1일 600 mg 이상의 용량 투여 시, 이뇨작용 4) G6PD 결핍환자에서 용혈 발생가능 ◆ 일반적인 주의 1) 과량의 아스코르빈산 투여는 고수산뇨증, 또는 요산염, 시스틴, 수산염 또는 기타약물을 요로에 침전시킬 수 있다. 2) 이 약은 통상적으로 경구투여하며 주사투여는 급성 또는 경구투여가 어려운 경우, 즉, 소장의 흡수불량에 의한 비타민 C 결핍증 및 인공정맥영양투여에 한하여 실시한다. 또한, 경구투여가 가능하고 효과가 충분하다고 판단될 경우에는 곧 경구투여로 전환한다. ◆ 상호작용 1) 살리실산염은 비타민 C의 백혈구와 혈소판으로의 흡수를 저해 2) 아스피린, 흡연을 통한 니코틴, 알코올, 일부 식욕저해제, 철분제, 페니토인 및 일부 항전간제, 에스트로겐이 포함된 경구용 피임약, 테트라싸이클린계 항생제와의 병용은 이 약의 조직 탈포화작용(tissue desaturation)을 유도할 수 있으므로 병용 회피 3) 이 약의 고용량 투여 시, 경구용 항응고제(쿠마린계 약물)의 반응을 감소 가능 4) 이 약과 플루페나진과의 병용 시, 플루페나진의 혈장농도가 저하 5) 바르비탈산 유도체는 이 약의 신장 배설을 촉진 6) 코르티코스테로이드제는 이 약의 산화를 증가 ◆ 임부 및 수유부에 대한 투여 1) 고용량 투여에 대한 태아의 영향이 밝혀지지 않았으므로 임신 중 이 약을 1 g 이상 복용하지 않음 2) 임신 중, 고용량을 투여할 경우, 신생아에게 괴혈병을 초래가능 ◆ 적용상의 주의 1) 이 약은 피하 또는 근육주사할 때, 주사부위에 일시적인 경미한 통증을 유발가능 2) 피하, 근육주사는 부득이한 경우 필요 최소용량을 투여하되 신경주행부위를 피하고 동일 부위에 반복 주사 하지 않도록 하며 특히, 신생아, 미숙아, 유·소아에의 투여 시 주의 3) 주사침을 삽입할 때 격통을 호소하거나 혈액의 역류를 발견할 경우에는 바로 침을 뽑아야함 4) 정맥투여 시, 주사 속도가 빠를 경우에는 일시적인 기절, 어지러움을 초래할 수 있으며 혈관통이 나타날 수 있으므로 가능한 한 천천히 주사	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Midron tab	
성분/함량	Midodrine hydrochloride 2.5mg	α1-agonist
효능·효과	◆ 저혈압(기립성, 본태성, 증후성)	
용법·용량	◆성인 : 염산미도드린으로서 1회 2.5㎎ 1일 2-3회 장기 치료하는 경우에는 최소 유효량을 투여한다. 누운 자세 고혈압 위험을 줄이기 위해 늦어도 취침 4시간 전에 복용	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 아드레날린효능제 및 도파민제 ◆ 부작용 : 발진·두드러기, 가려움, 발적, 입모감, 구역·구토, 복통, 복부팽만감, 구내염, 변비, 간기능장애(AST, ALT, ALP 상승), 심실성 기외수축, 심계항진, 심실성 부정맥, 두통, 드물게 졸음, 초조감, 어지러움, 빈뇨, 전립선 환자에서는 배뇨곤란 등 ◆ 금기 : 고혈압, 심한 심질환, 급성 신장염, 갑상선기능항진증, 크롬친화세포종, 폐쇄우각형 녹내장, 혈관경련, 혈관폐색, 배뇨장애(특히 전립선종환자), 빈맥성 부정맥 환자 ◆ 상호작용 : ① 구아네티딘, MAO저해제 : 교감신경흥분작용 증강 ② 디기탈리스제제 : 반사성 서맥이 나타날 수 있으므로 신중 투여 ◆ 주의 ① 심한 신장애 환자, 부정맥 환자에는 신중히 투여 ② 당뇨병 환자는 혈당치를 조절한 후 투여 ③ 장기치료시에는 신기능에 유의하여 투여 ◆ 과량투여시의 처치 과량투여에 의해 입모감, 냉감, 요의 급박, 고혈압, 서맥 등이 나타날 수 있다. 감량에 의해 증상이 소실되나 필요한 경우 위세척을 하고 진정제, 신경안정제 등을 투여하며 중증인 경우 α,β-차단제를 투여한다. 서맥이 나타나는 경우 아트로핀을 투여하면 빠르게 개선된다. ◆기타 개인의 감수성과 자율신경계 반응성의 차이로 이 약의 효과는 개인차가 크다. 따라서 치료초기에는 용법·용량에 명시한 양을 투여하다가 환자의 내성에 따라 양을 조절해야 한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Minirin inj	
성분/함량	Desmopressin acetate 4mcg/1ml/A	바소프레신 및 그 유사체
효능·효과	◆ 중추성 요붕증, 뇌손상 및 뇌하수체 수술로 인한 일시적인 다뇨, 번갈 다음, A 형 혈우병 환자의 수술 전 출혈 예방제, 폰 빌레브란드 병(Type 1) 환자의 수술 전 출혈 예방제, 신장 농축 능력의 측정	
용법·용량	1) 중추성 요붕증, 뇌손상 및 뇌하수체 수술로 인한 일시적인 다뇨, 번갈 다음 - 성인 및 12세 이상의 소아 : 1일 2.0μg(0.5mL)-4.0μg(1mL) #2 IV - 아침 및 저녁의 용량은 수분전환의 주간리듬에 맞추어 각각 조절 - 이 약 성분의 비강투여 환자가 비강흡수가 불량하거나 수술이 필요하여 주사제로 투여할 경우 동일한 항이뇨 작용을 위한 주사액의 용량은 비강투여량의 약 1/10 사용 2) A형 혈우병 및 폰 빌레브란드 병 (Type I) : - 체중 kg당 0.3-0.4μg을 NS 희석(10kg 이상의 성인 및 소아 : 50mL, 10kg이하의 소아 : 10mL로 희석) 15-30분간 천천히 IVF 3) 신장 농축 능력의 측정 : 성인 4μg(1mL), 1세 이상의 유・소아 1-2μg(0.25-0.5mL), 1세 미만의 영아 0.4μg(0.1mL)를 SC, IM	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 바소프레신 및 그 유사체(Desmopressin acetate) ◆ 부작용 : 물중독, 수분중독, 저나트륨혈증, 경련을 동반한 복부통증, 두통장애, 오심, 구토, 메스꺼움 등 ◆ 금기 : 1) 이 약 및 이 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자 2) 제 8인자 응고활성도가 5% 이하인 A형 혈우병 환자 3) B형 혈우병 환자 4) 제 8인자 항체를 가진 혈우병 환자 5) 제 8인자 응고활성도, 제 8 폰 빌레브란드인자 항원치가 1% 미만인 중증의 동형 접합성 폰 빌레브란드 병 환자 및 제 8인자 항원이 비정상적인 폰 빌레브란드병 환자 (Type Ⅱ B)(혈소판응집 또는 혈소판감소를 유발할 수 있다) 6) 습관성 및 심리적 번갈 다음 환자 7) 대상기능장애성 심부전 환자 8) 불안정한 협심증 환자 9) 신성 요붕증 환자 10) 항이뇨호르몬분비이상증후군 (SIADH) 환자 ◆ 상호작용 : 1) 삼환계 항우울약, 염산이미프라민과 병용에 의해 저나트륨혈증성 경련발작 2) 수분 및/또는 나트륨 항상성에 영향을 미치는 다른 약물 (예를 들어 아편유사제, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제 (SSRI), 비스테로이드성 항염증제 (NSAID), 클로르프로마진, 카바마제핀 및 설포닐우레아 계열의 일부 항당뇨병제)과 병용투여 시, 체액저류/저나트륨혈증의 위험 증가 3) 전신 및 흡입 제제의 코르티코스테로이드(히드로코르티손, 메틸프레드니솔론, 프레드니솔론, 덱사메타손)와 병용 투여시 저나트륨혈증의 위험 증가 4) 글리벤크라미드와 병용투여시 항이뇨 작용 감소 5) 혈압상승제와 병용투여시 혈압이 과도하게 상승 ◆ 과량투여시의 처치 1) 증상 : 수분저류 및 저나트륨혈증의 위험성이 증가되어 두통, 냉감, 구기, 경련, 의식상실 등 2) 처치 : 증상에 따라 투여횟수 또는 용량을 줄이고 수분을 제한한다. 이 약에 대해 특별한 해독제는 없으나 중증의 수분저류시 등장 또는 고장 식염수 주입 및 푸로세미드와 같은 이뇨제를 투여	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	MMR II inj	
성분/함량	**Attenuated live Measles virus 1000TCID50이상** **Attenuated live Mumps virus 5000TCID50이상** **Attenuated live Rubella virus 1000TCID50이상 0.5ml/V**	**MMR 백신**
효능·효과	◆ 홍역, 유행성 이하선염 및 풍진의 예방	
용법·용량	◆ 첨부된 용해액으로 용해 후 전량을 상완외측에 1회 피하주사 ◆ 생후 12개월 이후 1차 접종, 1차 접종의 효과가 없는 경우, 항체 양전 유도를 위해 초등학교 입학 전에 재접종 실시 ◆ 권장 접종 시기 : 1차 - 생후 12~15개월, 2차 - 4~6세 ◆ 생후 12개월 미만(6~12개월)의 영아 : 홍역이 유행하고 있을 때에는 투여할 수도 있으나, 이 시기의 접종은 홍역항원에 반응을 나타내지 않을 수 있고, 유행성 이하선염 및 풍진 백신의 안전성, 유효성은 확립되어 있지 않음. 또한 접종 나이가 어릴수록 항체 양전율이 낮으므로 생후 12~15개월과 초등학교 입학 전에 재접종 실시 ◆ 가임기 여성 : 풍진 바이러스 감염 예방을 위해 접종 후 3개월간 피임 필요	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Measles, Mumps, Rubella 를 동시에 예방하는 생백신 ◆ 부작용 : 발열, 주사 부위 국소반응, 피부발진 등 ◆ 금기 : 임부, 선천적 또는 유전적인 면역 결핍의 가족력이 있는 환자, 면역억제 치료를 받고 있는 환자, 젤라틴을 포함하여 이 백신의 성분에 대해 과민한 자, Neomycin에 대해 아나필락시스 또는 아나필락시스양 반응을 보이는 자, 열성 호흡기 질환 또는 다른 열성 감염증 환자, 백혈병, 림프종 및 골수와 림프계에 영향을 미치는 다른 악성 종양 등 혈액 질환 환자, AIDS 또는 HIV 감염의 다른 임상 증상과 관련하여 면역이 억제된 환자를 포함한 일차적·후천적 면역 결핍상태 등 ◆ 태아위험도 ① 임부에 투여 시 태아에 손상을 유발하는지 또는 생식 능력에 영향을 미치는지의 여부는 알려져 있지 않으므로 임부에 투여하지 말 것 ② 가임 여성은 접종 후 3개월간 피임할 것 ◆ 비고 ① 냉장(2~8℃) 보관 ② 차광 보관 (∵ 빛에 노출되면 바이러스가 불활화 될 수 있음) ◆ 적용상의 주의 ① 반드시 첨부된 용해액만을 사용하여 용해할 것 ② 접종 전 육안으로 이물 및 변색 유무 확인할 것 (용해 시 이 백신은 투명한 황색임)	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Muteran inj	
성분/함량	Acetylcysteine 300mg/3ml/A	진해거담제
효능·효과	◆ 진하고 점도높은 가래를 수반하는 다음의 기관지 질환에서의 객담배출곤란 증상: ① 성인: 급·만성 기관지염, 기관지확장증, 천식양기관기지염, 기관지천식, 인·후두염, 부비강염, 낭성섬유증, 수술후 폐합병증 ② 소아 : 급·만성 기관지염, 낭성섬유증 ◆ 파라세타몰(아세트아미노펜) 중독의 해독	
용법·용량	◆ 성인 ① IV - 점액의 용해 1 회 600-900mg 을 2-3 회/일 (N/S, D5W 로 희석) - Acetaminophen 중독의 해독 (총주입량 300mg/kg, 투여시간 20 시간 15 분) : 처음 15 분간 150mg/kg 를 D5W 200ml 에 희석하여 IV infusion → 50mg/kg 를 D5W 500ml 에 희석하여 4 시간 IV infusion → 100mg/kg 를 D5W 1000ml 희석하여 16 시간 IV infusion ② IM : 1 회 300mg 을 1-2 회/일 ◆ 소아용량 ① IV : (점액의 용해) 1 회 300-450mg 을 2-3 회/일 ② IM : 1 회 150mg 을 1-2 회/일	
사용상의 주의사항	◆ 금기 : 이 약에 과민증이 있는 환자 ◆ 주의 ① 기관지 천식, 호흡기능부전을 수반한 환자(기관지 경련을 일으킬 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 기관지 확장제 투여등의 적절한 처치를 한다.) ② 신생아(중증 질환이 아닌 경우 신생아에 투여하지 않는다.) ◆ 부작용 : 구역, 구토, 식욕부진, 설사, 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련, 빈맥, 고혈압 ◆ 일반적 주의 ① 액화된 기관지 분비물이 증량되는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고, 자연적인 객출이 곤란한 경우에는 기계적 흡인 또는 체위변환 등 적절한 처치를 한다. ② 근육주사시 깊숙히 주사한다. ③ 해독제로서 투여할 경우에는 가급적 중독후 10 시간 이내에 투여하도록 한다. ◆ 상호작용 : N-아세틸시스테인의 반응기 때문에 N-아세틸시스테인이 특정물질과 직접 접촉을 하는 경우 (예를 들면 에어로졸 혼합, 주입등등) 물리화학적 상반의 특성이 나타날 수 있다.	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Nabota inj	
성분/함량	Clostridium botulinum A Toxin 100unit/V	Toxin 류
효능·효과	◆ 20 세 이상 65 세 이하의 성인에 있어서 눈썹주름근(Corrugator muscle) 그리고/또는 눈살근(procerus muscle) 활동과 관련된 중등도 내지 중증의 심한 미간주름의 일시적 개선 ◆ 근육강직 : 18 세 이상 성인의 뇌졸중과 관련된 상지 경직	
용법·용량	◆ 각 적응증에 따라 용량 다양 (의사의 지시에 따름)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 기타 근육이완제, 말초에 작용, Cholinergic nerve 말단에 존재하는 high-affinity recognition sites 에 presynaptically 결합하여 acetylcholine 의 방출을 감소시킴으로써 신경근육차단 효과를 나타냄. ◆ 부작용 : 호흡곤란, 삼킴곤란, 폐렴 그리고/또는 심각한 무기력, 아나필락시스, 피부발진, 가려움증, 알러지 반응, 주사부위 통증/당김/종창/열감, 드물게 심혈관계 유해반응(부정맥, 심근경색), 눈꺼풀경련 등 ◆ 금기 : 이 약에 과민증, 전신성 신경근접합부 장애 환자(중증근육무력증, Lambert-Eaton 증후군, 근위축성측색경화증 등-근이완작요으로 질환 악화 가능), 임신 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 등 ◆ 상호작용 ① Aminoglycoside 계 항생제 또는 근육, 신경전달을 방해하는 약물(투보쿠라린계 근이완제)와 병용시 Botulinum toxin 약효 증가 - Aminoglycoside 계 항생제 또는 spectinomycin 과의 계속적인 병용 금기 polymyxin, tetracycline, lincomycin 사용은 신중할 것 ② 다른 Botulinum toxin 을 동시 또는 수개월 내에 투여한 경우의 효과는 알려지지 않음. 이전에 투여한 보툴리눔독소의 효과가 사라지기 전에 다른 보툴리눔독소를 투여한 경우 근신경쇠약 악화 가능 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 냉장(2~8℃) 보관 ② 용해 시킨 경우 24 시간 동안 냉장(2~8℃) 보관 가능	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Nacain inj	
성분/함량	Ropivacaine HCl 150mf/20ml/A	국소마취제
효능·효과	수술시 마취: 제왕절개를 포함한 수술시의 경막외 마취, 전달마취, 침윤마취 급성통증 조절: 수술후 통증, 출산 통증시 연속적인 경막외 점적주사 또는 간헐투여, 전달마취, 침윤마취	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

용법·용량

◆ 수술시 마취

	농도 (%)	용량 (mL)	주성분함량 (mg)	작용발현(분)	작용지속(시간)
요추경막외 주사(수술)	0.75	15~25	113~188	10~20	3~5
요추경막외 주사 (제왕절개)	0.75	15~20	113~150	10~20	3~5
흉추경막외 주사 (수술후 통증조절을 위한 전처치)	0.75	5~15 (주사높이에 따라 다름)	38~113	10~20	
전달마취, 침윤마취	0.75	1~30	7.5~225	1~15	2~6

◆ 급성통증의 조절

	농도 (%)	용량 (mL)	주성분함량 (mg)	작용발현 (분)	작용지속(시간)
요추경막외 주사 단발주사 간헐주사 (출산통증조절 등)	0.2 0.2	10~20 10~15 (최소 30 분 간격)	20~40 20~30	10~15	0.5~1.5
요추경막외 주사 연속점적주사(수술 후 통증 및 출산통증조절 등)	0.2	16~14 mL/hr	12~28 mg/hr		
흉추경막외 주사 연속점적주사(수술 후 통증 및 출산통증조절 등)	0.2	6~14 mL/hr	12~28 mg/hr		
전달마취, 침윤마취	0.2	1~100	2~200	1~5	2~6
관절내 주사	0.75	20	150		2~6
말초신경마취(대퇴부 또는 사각근간 마취) 수술후 통증조절을 위해 연속적인 점적주사 또는 간헐적 정맥주사	0.2	5~10 mL/hr	10~20 mg/hr		

- 수술후 통증조절 : 수술 전에는 1%나 0.75%, 수술 후에는 0.75%를 단발로 주사, 진통효과의 유지를 위해 0.2%를 경막외 IV infusion
- 경막외 마취시: 시험용량으로 아드레날린이 포함된 싸이로카인 주사액 3~5mL 먼저 투여해 아드레날린에 의한 일시적 심박동율의 증가 및 척수 차단의 징후가 나타나는지 관찰하여 약물의 혈관 및 경막내로의 주사 여부를 확인하는 것이 바람직하다.
- 환자와 계속 이야기하면서 주용량을 천천히 또는 점차 속도를 증가시켜 25~50 mg/min의 속도로 주사하고 약물을 다 투여할 때까지 흡인을 반복한다. 독성에 의한 징후가 보이면 즉시 약물투여를 중지한다.
- 연속적인 점적주사나 반복되는 단발투여의 경우에는 약물의 높은 혈장농도로 인하여 독성반응이나 국소 신경장애를 유발할 위험성이 있다. 성인에 대한 임상 사용례에서는 24시간동안 약 800 mg까지 투여했을 때 좋은 내약성을 보였다.

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Na 이온의 신경막 투과성을 감소시켜 신경자극의 발생 및 전도를 모두 억제하여 그 결과 탈분극 억제, 전도가 차단됨 ◆ 금기 : Ropivacaine 또는 다른 Amide 계 국소마취제에 대한 과민증의 기왕력이 있는 환자 ② 대량출혈이나 쇼크 상태인 환자(과도한 혈압저하 발생가능) ③ 주사부위 또는 그 주변에 염증이 있는 환자(화농성 수막염 발생가능) ④ 패혈증 ⑤ 정맥내 부분마취 (Bier 차단마취) ⑥ 산모의 자궁목곁 조직마취, 뒤눈마취, 척수마취(지주막하 차단마취), 정맥 국소마취(정맥주사 차단 마취) ◆ 주의 ① 고령자 ② 부분 또는 완전한 심전도 차단, 진행된 간질환, 심각한 신장애 ③ 중추신경계 질환 ④ 혈전장애, 항혈전요법 받는 환자 ⑤ 척수결함 가진 환자 ⑥ 임산부 ⑦ 복부 비만환자 ⑧ 심각한 고혈압, 심혈관계 기능부전 환자 ⑨ 신경병리증상의 병력이 있는 환자 ⑩전신상태가 좋지 않은 환자 ⑪전도장애 환자 ⑫급성 포르피린증 환자 ◆ 상호작용 ① 다른 국소마취제, Amide 계와 구조적으로 유사한 제제(Tocainide, Mexiletine 등): 독성 부가됨 ② CYP1A 억제제(Verapamil, Fluvoxamine 등) : Ropivacaine 의 혈중농도 증가 ③ 선택적, 강력 CYP3A4 억제제(Ketoconazole) : Ropivacaine 의 혈중 농도 증가(혈중 소실율 15% 감소) ④ 일반 마취제 또는 모르핀계 마취제 : 약물 이상반응 증강 ⑤ 진정제 : 중추신경억제작용 증강 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 : pH 6.0 이상의 알칼리 용액과 배합금기: 침전 생성

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Naloxone inj	
성분/함량	Naloxone HCl 0.4mg/1ml/A, 2mg/2ml/A	해독제
효능·효과	① 마약 및 마약길항 진통제(Nalbuphine 등)의 아편류에 의한 호흡억제를 포함하는 마약억제의 전체적 또는 부분적 역전 ② 마약 과량 투여시 진단 ③ 뇌졸증, 뇌출혈에 의한 허혈성 뇌신경 장애	
용법·용량	*** IV, SC, IM 가능** ◆ 아편류에 의한 호흡억제 등 마약억제의 역전, 과량투여 진단 ① 성인 - 마약의 과량투여 또는 과량투여가 예상될 때 : 초기량은 0.4-2mg → 2-3 분 간격으로 IV(최대: 10mg) - 수술후 마약성 억제시: 0.1-0.2mg 씩 2-3 분 간격으로 IV ② 소아 - 마약의 과량투여 또는 과량투여가 예상될 때 : 초기량은 0.01mg/kg → 0.1mg/kg 로 재투여가능 - 수술후 마약성 억제시 : 0.005-0.01mg 을 2-3 분 간격으로 증량하여 IV ③ 신생아 (마약유도 억제시) : 0.01mg/kg ◆ 뇌졸증, 뇌출혈로 인한 허혈성 뇌신경장애, 뇌척수좌상 안면신경 및 사지마비의 급성기 : 초기량 0.4-4mg IV→ 4-8mg/일을 D5W 생리식염 주사액 1,000 mL 에 혼합하여 IV infusion	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 ① 마약의 해독제(Morphine 과 길항)로 환자의 금단증상을 감소 또는 소멸시킴 ② 투여 2 분이내에 작용이 발현되며, 1-4 시간 동안 지속됨 ◆ 부작용 : 오심, 구토, 발한, 빈맥, 혈압상승, 전율, 진전, 발작, 심정지, 심실성빈맥, 세동 및 폐부종, 경련, 진통효과의 역전 ◆ 배합금기 : Bisulfite, 장쇄 또는 고분자량의 음이온 및 alkali 용액 ◆금기: 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자, 바르비탈계 약물 등의 비마약성 중추신경억제제 또는 병적 원인에 의한 호흡 억제가 있는 환자 ◆ 주의 : 고혈압 및 심질환자(혈압상승, 빈맥 등이 나타날 수 있음)은 신중투여 , 신부전환자, 간질환 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 차광 ② 희석용매: N/S, D5W ③ 희석후 안정성: 24 시간	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Nasea inj	
성분/함량	Ramosetron 0.3mg/2ml/A	항구토제
효능·효과	◆ 항암제(Cisplatin 등) 투여로 인한 구역 및 구토의 방지 ◆ 수술 후 구역 및 구토의 방지	
용법·용량	◆ 성인 : 1일 1회 0.3mg을 정맥주사 효과가 불충분할 경우에는 동일한 용량을 추가 투여할 수 있음. (단, 1일 0.6mg을 초과하지 않음) 증상에 따라 적절히 증감	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 5-HT3 antagonist ◆ 부작용 : 간수치 증가(AST, ALT 등), 과민반응(가려움증, 발적, 피진 등), 설사, 변비, 두통, BUN상승, 혈중 크레아티닌상승, 딸국질, 두부열감, 체열감 등 ◆ 금기 : 이 성분에 과민증이 있는 환자 ◆ 상호작용 ① 이 약은 주로 간효소 CYP1A2, CYP2D6에 의해 대사되므로 fluvoxamine 과 병용투여시 fluvoxamine의 CYP1A2 저해작용에 의해 이 약의 혈중농도 상승으로 인한 이상반응 증가 위험이 있으므로 주의 ② 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI)와 세로토닌 노르아드레날린 재흡수 억제제(SNRI) 등의 다른 세로토닌성 약물과 동일 계열약물(5-HT3 수용체 길항제)의 병용투여 이후 세로토닌 증후군(정신상태 변화, 자율신경기능장애, 신경근육 이상을 포함)에 대한 보고가 있었다. ◆ 비고 ① 차광 보관 ◆ 과량투여시의 처치 ① 과량 투여 시, 설사, 신장의 수산결석을 초래할 수 있음 ② 1일 600mg 이상의 용량은 이뇨작용을 일으킬 수 있음 ③ 과량 독성 증상이 발현된 경우 투여 중단하고 대증요법 실시 ◆ 적용상의 주의 ① 이 약과 배합변화를 일으키는 약제는 다음과 같으며, 혼합하지 말 것 : D-mannitol 주사액, bumetanide 주사액, furosemide 주사액 (단, furosemide 주사액의 경우 20mg의 furosemide에 NS 200ml를 첨가하여 이 약(ramosetron) 1앰플(0.3mg)과 혼합하는 경우에는 지장 없음)	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

<table>
<tr><td>약품명</td><td colspan="2">Neocaf inj</td></tr>
<tr><td>성분/함량</td><td>Caffeine citrate 20mg/1ml/V</td><td>호흡촉진제</td></tr>
<tr><td>효능·효과</td><td colspan="2">◆ 미숙아의 무호흡증에 대한 치료</td></tr>
<tr><td>용법·용량</td><td colspan="2">Theophylline 을 투여한 적이 있는 신생아 또는 카페인을 섭취한 산모에게서 태어난 신생아는 이 약을 투여하기 전에 카페인 농도를 측정할 것.(50mg/L를 넘지 않도록 한다.)
<table>
<tr><td></td><td>Caffeine citrate 용량</td><td>투여경로</td><td>투여 횟수</td></tr>
<tr><td>초기용량</td><td>1ml/kg
(Caffeine citrate 20mg/kg)</td><td>정맥내투여(30분이상)</td><td>1회</td></tr>
<tr><td>유지용량</td><td>0.25ml/kg
(Caffeine citrate 5mg/kg)</td><td>정맥내투여(10분이상) 또는 경구투여</td><td>초기용량 투여 후 24시간마다</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>사용상의 주의사항</td><td colspan="2">◆ 약리작용 : 카페인의 adenosine 수용체(A1, A2 subtype) 길항작용에 따라 기관지 평활근 이완, 중추신경 촉진, 심근 촉진, 이뇨의 작용을 가짐.
◆ 부작용
: 중추신경계 흥분, 빈맥, 좌심실 박출량 증가, 심박출량 증가, 위 흡인증가, 위장관 불내성, 저혈당, 고혈당, 뇨속(urine flow rate)증가, 크레아티닌클리어런스 증가, 나트륨과 칼슘의 배설증가 등
◆ 금기
① 이 약의 성분에 과민증인 환자
② 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍증 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 등의 유전적인 문제가 있는 환자
◆ 신중투여 : 발작성장애환자, 심혈관계 질환환자, 간장애환자, 신장애환자
◆ 상호작용
① 카페인은 CYP 1A2에 의해 주로 대사되므로 이 효소와 관련된 약물의 영향을 받을 수 있다.
② Theophylline : 카페인과 상호전환을 일으킴.
◆ 비고 : 밀봉용기, 15~30℃ 보관
◆ 적용상의 주의
① 이 약을 투여하는 모든 신생아는 괴사성 장결장염의 발현을 모니터링해야 한다.
② 미숙아의 무호흡증이 지속되거나 위장관 불내성, 기면증상이 보이면 즉시 의사와 상담하여야 한다.
③ 이 약은 보존제 함유되지 않았으므로 1회용으로 개봉 후 즉시 사용하고, 남은액은 버리도록 한다.</td></tr>
</table>

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Nesp inj	
성분/함량	Darbepoetin-α 120mcg/Syr	빈혈 치료제
효능·효과	만성신부전 환자의 빈혈, 고형암의 화학요법에 의한 빈혈	
용법·용량	① 혈액투석환자 ㄱ. 초기용량: 1 회 20mcg 주 1 회 IV ㄴ. 유지투여기 용량: 주 1 회 15-60mcg IV, 1 회 투여로 개선 유지되면 1 회 투여량의 2 배를 2 주 1 회 투여로 변경 가능 (max. 1 회 180mcg, 헤모글로빈 목표치 11g/dL 전후) ② 복막투석환자 및 투석전 만성 신장병 환자 ㄱ. 초기용량: 1 회 30mcg, 2 주 1 회 SC, IV ㄴ. 유지투여기 용량: 2 주 1 회 30-120mcg SC, IV. 2 주 1 회 투여로 개선 유지되면 1 회 투여량의 2 배를 4 주 1 회 투여로 변경 가능(max. 1 회 180mcg, 헤모글로빈 목표치 12g/dL 전후) ③ 고형암의 화학요법에 의한 빈혈: 3 주 1 회 6.75mcg/kg SC 또는 주 1 회 2.25mcg/kg SC (헤모글로빈농도가 12.0g/dL 를 넘지 않도록 함)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 내인성 Erythropoietin 과 같은 적혈구 생성 촉진 단백질로서 hypoxia 의 발현에 따라 신장에서 생성후 혈중으로 분비되어 조혈모세포 자극, 적혈구계로의 분화 촉진, 적혈구의 생성 증가 ◆ 부작용 : 혈압변화, 혈전색전증, 부정맥, 울혈성 심부전, 심근경색, 뇌혈관장애, 두통, 현기증, 경련, 설사, 구토, 가려움, 복통, 관절통, 근육통, 사지통, 요통, 말초부종, 피로 ◆ 금기 : 조절이 불가능한 고혈압 환자 ◆ 주의 : 심근경색, 폐경색, 뇌경색환자, 간 장애자, 간 질환자, 겸상적혈구 빈혈환자, 고혈압환자, 알러지 소인이 있는 환자 ◆ 비고 : 차광, 냉장보관(2~8℃). 흔들지 말 것(장시간 흔들시 단백변성)	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Neulapeg PFS inj	
성분/함량	Pegteograstim 6mg/0.6ml/Syringe	G-CSF(Granulocyte Colony-stimulating factor)
효능·효과	◆ 고형암 및 악성 림프종에 대한 세포독성 화학요법을 투여 받는 환자의 중증 호중구감소증 기간 감소	
용법·용량	◆ 6mg을 세포독성 화학요법 완료 후 약 24hr 후에 SC	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Colony Stimulating Factor ◆ 부작용 : 백혈구증가증, 흐려보임, 어지러움, 두통, 주사부위 통증, 오심, 변비, 근육통, 요통, 사지통, 비장비대 또는 비장파열, 혈소판감소증, 빈혈 ◆ 금기 : 대장균으로부터 유래된 단백질, Pegfilgrastim, Filgrasim 등에 과민증 ◆ 주의 ① 약물 과민증의 병력, 알레르기 소인이 있는 환자 ② 간, 심장, 심폐기능에 심각한 장애가 있는 환자 ◆ 비고 : 냉장보관(2~8℃)	

약품명	Neutrogin inj	
성분/함량	Lenograstim 250mcg/V	G-CSF(Granulocyte Colony-stimulating factor)
효능·효과	◆ 고형암 및 혈액종양에 대해 항암화학요법을 받고 있는 환자의 호중구감소증 ◆ 조혈모세포이식시의 호중구수 증가촉진 ◆ 골수이형성증후군에 따른 호중구감소증 ◆ 재생불량성빈혈에 따른 호중구감소증 ◆ 선천성・특발성 호중구감소증 ◆ 사람면역결핍바이러스(HIV) 감염증 치료에 지장을 초래하는 호중구감소증 ◆ 면역억제요법(신이식)에 따른 호중구감소증 ◆ 조혈모세포의 말초혈중으로의 동원	
용법·용량	◆ 고형암에 대해 항암화학요법을 받고 있는 환자의 호중구감소증 ① 악성림프종, 소세포폐암, 배세포종양, 신경아세포종, 소아암 : 보통 성인·소아 모두, 항암화학요법제 투여종료 후(다음날 이후)부터 2 μg/kg 을 1 일 1 회 SC 출혈경향 등으로 피하주사가 곤란한 경우에는 5 μg/kg 을 1 일 1 회 IV(IVF 포함) ② 기타의 암 (호중구수<1,000/mm3 에서 발열 또는<500/mm3) : 2 μg/kg 을 1 일 1 회 SC 또는 5 μg/kg 을 1 일 1 회 IV(IVF 포함) ◆ 각 적응증 별, 호중구수치에 따라 투여량을 결정 ◆ 각 적응증 별로 피하, 정맥, 점적정맥주사 중 선택하여 투여	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (rHuG-CSF) ◆ 부작용 : 쇽, 피부발진, 발열, 두통, 권태감, 골통, 오심, 구역, 구토, 식욕부진, 간질성폐렴, Acute Respiratory Distress Syndrome, 비장파열, 요통, 흉부통, 혈소판 감소, ALT AST LDH ALP 상승 ◆ 금기 ① 이 약 또는 다른 과립구콜로니형성자극인자 제제에 과민반응 환자 ② 골수중의 아구가 충분히 감소하지 않은 골수성백혈병 환자 및 말초혈액중에 골수아구가 보이는 골수성백혈병 환자 ◆ 주의 ① 약물 과민반응의 병력이 있는 환자 ② 알레르기 소인이 있는 환자 ③ 간, 신장, 심폐기능에 중증 장애가 있는 환자 ◆ 비고 : 밀봉용기, 실온(25℃이하)보관	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

	◆ 적용상의 주의 : 점적 정맥주사시 N/S, 5% DW에 혼합하고, 다른 약물과는 혼합하지 말 것

약품명	**Newfactan**	
성분/함량	**Lung surfactant 120mg/V**	**폐포 표면 활성물질**
효능·효과	신생아의 호흡곤란 증후군	
용법·용량	① N/S 120mg/4ml 로 잘 현탁하여 120mg/kg 를 기관내 주입 ② 폐에 골고루 분포되도록 4-5 회 나누어, 매회 주입시 마다 체위를 변화시킴 ③ 매회 주입시마다 100% 산소로 주입하면서 경피산소분압 모니터하여 80mmHg 또는 그 이상인 것을 확인함 ④ 최초 투여시기는 8 시간 이내가 바람직하며 추가투여는 환자의 상태에 따라 결정함. 용량은 60-120mg/kg	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 폐포 표면 활성물질인 폐 계면활성제를 보충하여 미성숙 폐의 작용을 도움 ◆ 부작용 : 일시적 빈맥, 산소탈포화, 혈관수축, 저혈압, 내호흡관차단, 고혈압, 무호흡, 탄산과잉증, 탄산부족 ◆ 금기 : 알레르기 증상의 기왕력이 있는 환자 ◆ 주의 ① 투여전에 20 분 동안 실온에 방치하거나 손으로 8 분간 감싸줌으로서 가온 (인공적으로 가온하는 방법 금지) ② 26G 주사침을 부착한 주사기로 흡입하여 3-4Fr 의 멸균세관에 연결하고 기관내 삽입튜브를 연결하여 기관에 주입 ③ 혈관내 투여금지 ◆ 비고 : 차광, 냉장보관(2~8℃)	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Nexium inj	
성분/함량	Esomeprazole Na 40mg/V	소화성궤양용제
효능·효과	◆ 성인: 1. 경구 요법이 적절치 않을 때 경구 요법에 대한 대체요법으로서 식도염이 있고/혹은 위식도역류에 따른 증상이 심한 위식도역류질환(GERD) 2. 급성 출혈성 위궤양 또는 십이지장궤양의 내시경치료 후 재출혈의 예방 ◆ 1~18 세의 소아청소년: 경구 요법이 적절치 않을 때 경구 요법에 대한 대체요법으로서 미란성 역류식도염이 있고/혹은 위식도 역류에 따른 증상이 심한 위식도역류질환(GERD)	
용법·용량	1. 경구 요법이 적절치 않을 때 대체요법 - 1일 1회 20~40mg IV (식도역류 증상치료: 1일 1회 20mg/ 역류성 식도염: 1일 1회 40mg 투여) - 일반적으로 IV투여 후(임상적으로 최대 7일) 가능한 한 신속히 경구 투여로 전환 2. 급성 출혈성 위궤양 또는 십이지장궤양의 내시경치료 후 재출혈 예방 - 30분간 80mg IV 후 8mg/h의 속도로 71.5시간 동안 IVF, 비경구 치료 후 경구 투여로 전환하여 위산 억제치료 실시	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : proton pump inhibitor로 gastric parietal cell 내 K(+)/H(+)-ATPase를 선택적으로 억제하여 위산 생성의 마지막 단계를 차단 ◆ 부작용 : 호흡기계 감염, 부비동염, 췌장염, 복통, 변비, 설사, 고창, 구역/구토, 두통, 소화불량, 투여부위반응(국소홍반 및 가려움 등) 등 ◆ 금기 1) 이 약, 이 약의 구성성분 또는 벤즈이미다졸류에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자 2) 아타자나비르 및 넬피나비르를 투여중인 환자(상호작용항 참조) 3) 수유부 4) 릴피비린 함유제제를 투여중인 환자 (상호작용항 참조) ◆ 태아위험도: C ◆ 비고: 밀봉용기, 차광하여 30℃이하 보관 ◆ 적용상의 주의: 조제한 용액은 pH에 매우 의존적으로 분해되므로 반드시 생리식염주사액으로만 조제 - 정맥주사: 생리식염 주사액 5 mL를 바이알에 주입하여 조제 (적어도 3분에 걸쳐 정맥 주사) - 점적 정맥주사: 1바이알의 내용물(40 mg)을 100 mL 이내의 생리식염 주사액에 용해시켜 점적 주사액을 조제 (조제한 용액을 10~30분에 걸쳐 점적 주사) - 조제한 용액의 25 ℃에서 12시간 동안 물리, 화학적으로 안정함이 증명되었으나, 미생물학적 견지에서 오염의 위험을 줄이기 위해서는 조제후 즉시 사용

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Nimodipine inj	
성분/함량	Nimodipine 10mg/50ml/A	뇌순환 개선제
효능·효과	동맥류성 지주막하출혈후의 뇌혈관경련에 의한 허혈성 신경장애의 예방 및 치료	
용법·용량	◆ 점적 정맥주사 : 1mg/시간 으로 시작하여 2 시간 이상 투여, 내성이 좋고 현저한 혈압강하가 일어나지 않는 한 2 시간 이후부터 2mg/시간(30 ㎕/kg/시간) 로 증량 ◆ 지주막하투여: 이 약 1ml+19ml 의 Ringer 액에 희석하여 수술시 점적투여 ◆ 투여기간 ① 예방 : 출혈 후 4 일이내 시작 10-14 일간 IV → 7 일간 PO ② 치료 : 가능한 빨리 5-14 일간 IV → 7 일간 PO (총 투여기간: 21 일 초과금지)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Ca channel blocker ◆ 부작용 : 구역, 두통, 위장장애, 오심, 현훈, 무력증, 열감, 약간의 혈압강하, 흉통, 서맥, 빈맥, ALP, γ-GTP 상승, 졸음, 흥분, 발한, 안면홍조, 혈소판감소 ◆ 금기 : 임부 ◆ 상호작용 ① CCB 나 Methyldopa 병용하지 말 것 ② 신독성이 있는 약물(AG, Cepha, Furosemide)과 병용시 신기능 악화 ③ β-blocker: 강압작용 증가 ④ Cimetidine, Valproate: 이 약 혈중농도 상승 ⑤ 항전간제(Pb, Phenytoin, CBZ), Rifampicin: 이 약의 작용 감약 ⑥ Fluoxetin 의 농도 감소 ◆ 주의 : 뇌부종, 두개내압이 현저히 높은 환자는 신중 투여, 기계조작(어지러움으로 인한) 주의, 저혈압 환자(수축기 혈압 100mmHg 이하), 간·신기능장애 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 차광(경구, 주사), 정맥주사 시에도 차광 투여 바람직 ② 빛에 노출 후 10 시간까지 안정 ③ PVC 에 흡착되므로 polyethylene tube 사용 ◆ 과량투여시의 처치 - 급성과량투여시 즉시 투여를 중단, 응급처치는 증상에 따라 행함 - 혈압이 현저하게 떨어졌다면 도파민 또는 노르아드레날린을 정맥투여할 수 있음 - 특정 해독제가 알려져 있지 않으므로 다른 이상반응의 치료는 가장 현저한 증상에 따라 하여야 한다. ◆ 적용상의 주의사항 ① 5%포도당, 0.9%NaCl, 유산화링거액, 마그네슘을 함유하는 유산화링거액, 덱스트란 40 액 또는 6% poly(O-2-hydroxyethyl) 전분을 약 1:4(이 약 : 병용투여액)의 비율로 쓰리웨이 콕마개(three-way stopcock)를 이용하여 함께 투여가 가능하다. 만니톨, 사람알부민 5% 또는 혈액과도 병용투여가 가능하다. ② 이 약은 다른 주사용플라스틱용기나 병에 혼합해서는 안되며 다른 약물과 혼합해서도 안된다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Nitroglycerin tab	
성분/함량	NTG(Nitroglycerin diluted) 0.6mg/T	협심증 치료제
효능·효과	협심증	
용법·용량	◆ 급성협심증 발작이 일어나는경우 : 1 회 0.3mg 또는 0.6mg 을 설하 또는 구강내에 녹여 복용 증상이 완화될 때까지 5 분마다 반복 투여가능 ◆ 급성협심증 발작이 야기될 수 있는 작업을 하기 5-10 분전에 예방목적으로 미리 복용할 수 있다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 평활근을 이완(특히 관상순환계에 있는 세동맥과 모세 혈관 및 정맥확장), preload afterload 감소, 심근의 산소소모량 감소 ◆ 부작용 : 빈번한 두통, 심박급속, 오심, 구토, 현훈, 복통, 서맥, 빈혈, 혈압강하, 열감, 홍조, 심계항진, 기립성 저혈압, 허약, 실신, 요실금, 변실금, 발한, 박리성피부염, methemoglobinemia, PaO_2 저하, 외용(가려움, 접촉성 피부염, 발적) ◆ 금기 : 중증의 저혈압, 난치의 혈액감소증, 중증의 빈혈환자, 두부외상 또는 뇌출혈환자, 녹내장 및 폐쇄우각형 녹내장, 제한성 심근증, 협심증 심근증, 심막압전환자 ◆ 상호작용 ① 다른질산염제제, 혈압강하제, β-blocker, Phenothiazine 계약물 및 알코올 : 강압효과 증강 ② Sildenafil : 이 약 작용강화 ③ Aspirin 및 NSAIDs: 이 약 작용감소 ④ Pancronium 의 신경근 차단효과 연장 ◆ 배합금기 : Hydralazine, Phenytoin ◆ 주의 ① 저혈압, 급성 심근경색, CHF, 기립성 조절장애는 신중투여 ② 투여중지시 4-6 주에 걸쳐 용량 및 투여횟수 감소 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 경구: 차광 ② 주사 : PVC 수액용기 및 수액세트에 흡착(20-60% 흡착됨), pH 10 이상의 용액에 희석하면 이 약의 함량 저하 개봉시 24 시간동안 안정 ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 심한 두통, 구토, 불안, 저혈압, 청색증 및 메트헤모글로빈혈증 등 심한 경우에는 서맥, 호흡억제, 정신병 등이 나타날 수 있음 ② 상태가 안정될 때까지 머리를 낮추고 다리를 높인 후 위세척을 하고 산소공급 등 일반적인 처치를 한다. ◆ 임상검사치에의 영향 : 질산염제제는 Zlatkis-Zak 색상반응을 방해하여 혈청중의 콜레스테롤이 감소된 것과 같은 위양성반응을 나타낼 수 있다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Nitropress inj	
성분/함량	Sodium nitroprusside 50mg/2ml/V	혈관확장제
효능·효과	응급성고혈압(고혈압성 발증), 외과수술시 출혈감소를 위한 마취중 혈압강하(주사제)	
용법·용량	◆ 용액조제 : 이 약 1 바이알(50mg)을 원하는 농도에 따라 5% 포도당주사액 250-1000ml 에 희석시키고 빛에 의해 쉽게 변화될 수 있으므로 첨부된 차광봉지나 알루미늄호일 등 적절한 차광용지로 차광한다. 제조된 점적 정맥주사액은 엷은 갈색이며 사용하고 남은 액은 버린다. ◆ 다른 혈압강하제를 투여받고 있지 않는 성인 및 소아 ① 투여개시용량 : 0.3mcgkg/분 ② 평균투여용량 : 3mcg/kg/분을 미세주입 조절기를 사용 IV infusion (최대 권장주입속도: 10 μg/kg/분) ③ 투여용량범위 : 0.5-10mcg/kg/분	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : direct acting vasodilator cardiac output, peripheral resistance, cardiac index, stroke index 감소 ◆ 임상응용 : 응급성고혈압(고혈압성 발증), 외과수술시 출혈감소를 위한 마취중 혈압강하 ◆ 부작용 : 구토, 현훈, 발한, 빈맥, 근위축, 흉골압박감, CN 독성(과량투여시), 장폐색증, 두개내압상승, 서맥, 심전도변화, 발적, methemoglobinemia, 혈소판응집감소, 급성정맥염, 갑상선기능저하증 ◆ 금기 : 대상성 고혈압(동정맥류 대동맥협착), 빈사상태환자의 응급수술, 뇌순환장애, 중증의 간기능장애, 유전성 시신경 위축증을 앓고 있는 Vit B_{12} 결핍증, 니코틴으로 인한 약시, 대사성 산증, 저혈량증, 급성 CHF, 갑상선기능저하증 ◆ 상호작용 : 휘발성 액체마취제(Enfluran 등), 신경절차단제, 진정제, 순환억제제, 혈압강하제: 강압작용 증강 ◆ 주 의 ① 반드시 사용직전에 조제하고 24 시간 경과된 것과 잔량은 폐기할 것 (변색된 것은 사용하지 말것) ② 다른 약제와 혼합하지 말 것 ③ 간·신장애, 허혈성 심질환, 두개내압상승, 폐기능장애, 노인은 신중투여 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 차광(사용시에도 차광) ② 1 바이알 중 Na 양 6mg(0.26mEq)함유 ③ 희석용매 : D5W ◆ 적용상의 주의 : 수용액은 극소량의 유기 또는 무기물과 반응하여 색체반응을 나타내는 물질(청색, 녹색, 어두운 붉은색 등)을 형성할 수 있는 니트로프루시드이온을 생성하므로 일단 제조된 용액은 보관하지 말고 24시간 이내에 사용한다. ◆ 과량투여시의 처치 : 대량투여하여 시안독성이 발생한 징후가 나타나면 다음과 같은 방법으로 처치한다. ① 즉시 이 약의 투여를 중지한다. ② 정맥주사용 3% 질산나트륨용액이 준비될 때까지 매분당 15-30초 동안 아질산아밀을 흡입시킨다. ③ 정맥주사용 3% 질산나트륨용액을 주입속도 2.5-5.0ml/분을 초과하지 않는 속도로 총량이 10-15ml정도 될 때까지 정맥주사한다. ④ 그 다음 5% 포도당 용액 50ml에 치오황산나트륨 12.5g을 용해시킨 용액을 10분 이상에 걸쳐 정맥주사한다. ⑤ 과량투여 증상이 다시 나타날 수 있으므로 환자를 수시간 동안 관찰하고 과량투여 증상이 다시 나타나면 위의 두가지 용액을 위의 용량의 절반으로 하여 재투여한다. ⑥ 질산염을 투여하는 동안 또는 치오시안산이 생성된 후 혈압이 저하될 수 있으나 이는 혈관수축제로 조절	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Norpin inj	
성분/함량	Norepinephrine bitartrate 4mg/4ml/A, 20mg/20ml/A	혈관수축제
효능·효과	◆ 각종 질환에 따르는 급성 저혈압 또는 쇽의 보조치료(심근경색에 의한 쇽, 패혈증으로 인한 쇽, 아나필락시성 쇽, 순환혈액량 저하에 따르는 급성 저혈압 또는 쇽, 전신마취시의 급성 저혈압 등) ◆ 심정지의 보조치료	
용법·용량	◆ 급성 저혈압 쇽크시: 4mg 을 D5W, N/S 1L 에 희석하여 2-3ml/분의 속도로 IV infusion, 유지량은 0.5-1.0ml/분 ◆ 심장정지시: 심폐소생술 후 유효한 심박동과 환기를 확보한 후 위의 방법과 동일하게 IV	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 교감신경흥분제로 α수용체에 작용하여 말초혈관 수축시킴, β_1 수용체에 작용하여 심근수축력 증가 ◆ 임상응용 : 각종 질환에 따르는 급성 저혈압 또는 쇽의 보조치료(심근경색에 의한 쇽, 패혈증에 의한 쇽, 아나필락시스성 쇽, 순환혈액량 저하에 따르는 급성 저혈압 또는 쇽, 전신마취시의 급성저혈압 등), 심정지의 보조치료 ◆ 부작용 : 두통, 현기증, 불안, 심계항진, 서맥, 호흡곤란, 혈압상승(과량투여) 심박출량 감소, 뇌출혈, 경련, 부정맥, 구역, 구토, 주사부위 괴사, 혈장량 고갈 ◆ 금기 : 혈액량 부족으로 인한 저혈압, 고혈압, 갑상선기능항진증, 크롬친화성 세포종, 중증신기능장애, 폐성심환자, 중증부정맥, 임부 ◆ 상호작용 ① Cyclopropane, halogen 함유 흡입마취제, Catecholamine 은 병용금기 ② MAOI, TCA, 분만촉진제(Oxytocin, Ergotamine), 항히스타민제 : 이 약 작용증가 ① 갑상선 제제: 관부전 발작 유발 ④ Insulin 등 혈당강하제의 작용감소 ② Spironolactone: 이 약의 혈관반응성 저하 ⑥ 이소프레날린 등의 카테콜아민계 약물, 프로테레놀 등의 에피네프린 효능약: 심부정맥이나 심정지 (소생 등의위급 상황 이외의 경우에는 병용투여하지 않는다) ⑦ 구아네티딘: 동맥압의 상승 ◆ 배합금기 : 알칼리제, 산화제, Barbiturate 계, Chlorpheniramine, Phenytoin $NaHCO_3$, 요오드화나트륨, SM ◆ 태아위험도 : C ◆ 주의 ① Cocaine, 심실성 빈맥, 동맥경화증, 심질환, 서맥, 관상동맥, 장간막, 말초혈관혈전증, 심근경색으로 인한 저혈압, Prinzmetal 협심증은 신중투여 ② Extravasation 시 국소허혈성괴사가 일어남(Phentolamine 투여) ③ DW 사용(∵ 포도당은 산화로 인한 이 약의 역가감소를 억제함) ◆ 비고 ① Norepinephrine bitartrate 8mg = Norepinephrine 4mg ② 차광 ◆ 과량투여시의 처치 : 중증의 고혈압, 심박출량 감소, 말초저항 상승, 반사성 서맥, 눈부심, 흉골 후방 동통, 창백, 심한 발한, 구토, 뇌출혈, 두통, 폐부종 등의 증상이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 환자가 안정화될 때까지 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Onseran inj	
성분/함량	Ondansteron HCl dehydrate 4mg/2ml/A, 8mg/4ml/A	진토제
효능·효과	세포독성을 유발하는 화학요법 또는 방사선요법에 의한 구역과 구토, 수술 후 구역과 구토의 예방 및 치료	
용법·용량	◆ 화학요법, 방사선 요법에 의한 구역, 구토 ① 비교적 약한 구토 유발성 화학요법제(CTX, Doxorubicin, Carboplatin) 투여시 및 방사선 직전 : 8mg IV, IM 또는 치료 1-2 시간전에 경구 투여 하고 12 시간 후에 8mg 을 경구투여 ② 지연형 구토 예방 : 치료후 1 회 8mg 을 2 회/일로 5 일간 경구투여 ◆ 심한 구토 유발성 화학요법제 투여시(고용량의 Cisplatin) ① 화학요법 실시 직전 8mg 을 서서히 IV, IM→ 2-4 시간 간격으로 8mg 을 2 회 추가로 IV 또는 1mg/시간 속도로 IV infusion (최대 24 시간), 또는 16mg 을 N/S 50-100ml 에 희석하여 화학요법 실시 직전 15 분 이상에 걸쳐 IV infusion ② 화학요법 실시전 Dexa 20mg IV: 이 약 효과 증강 ◆ 수술 후 구역 구토 ① 예방 : 마취 1 시간 전 16mg 을 경구 투여하고, 마취 유도시 4mg IV, IM ② 치료 : 4mg 을 IV, IM ◆ 소아용량(≥2 세) 예방: 마취 유도 전,시,후 1 회 0.1mg/kg (최대 4mg 까지) 치료: 1 회 0.1mg/kg 에서 최대 4mg 천천히 정맥주사	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Selective 5-HT_3 수용체 길항작용 ◆ 부작용 : 설사, 변비, 두통, 발열, 조흥, 혈압상승, 졸음, 구갈, 발진, 가려움, 두중감, 복부온감, 심계항진, 혈압상승, 흉통, 부정맥 간기능 저하 ◆ 상호작용 ① Barbiturate, Carbamazepine, Rifampin, Phenytoin: 이 약의 효과감소 ② Tramadol 의 진통효과 감소 ◆ 주의 ① 간장애시 최대 8mg/일 ② 음식물의 대장통과 시간을 지연시킴 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 ① 차광 ② 희석용매: N/S, D5W, DS ③ 희석 후 안정성 : 냉장-24 시간	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Orfil inj	
성분/함량	Sodium valproate 150mg/1.5ml/A, 300mg/3ml/A	항전간제
효능·효과	◆ 간질[결신발작(소발작), 부분발작(초점발작), 정신운동성발작 및 혼합발작)]과 간질에 뒤따르는 성격, 행동장애의 예방과 치료 ◆ 수술후 및 외상후의 발작	
용법·용량	[OLTRIL inj 조제법] 첨부된 용제 4ml 를 바이알에 주입한 후 용해하여, 적정 용량을 사용한다. 조제된 용액의 발프로산나트륨 농도는 95mg/ml 이다. 이 약은 천천히 정맥 주사하거나 생리식염 주사액, 5% 포도당 주사액 또는 포도당 생리식염 주사액을 별도의 정맥관을 사용 하여 함께 투여한다. 이 약은 천천히 정맥주사 하거나 생리식염 주사액, 5%포도당 주사액 또는 포도당 생리식염주사액을 별도의 정맥관을 사용하여 함께 투여한다. ◆ 성인 : 400-800mg 서서히 IV(최대용량: 2,500mg/일) 또는 D5W, DS 에 희석하여 IV infusion ◆ 소아 : 20-30mg/kg/일(최대용량: 40mg/kg/일)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : GABA 의 분해효소를 억제하여 뇌속의 GABA 농도를 상승시키는 동시에 c-GMP 의 농도를 감소시키는 작용으로 항전간작용을 나타냄 ◆ 임상응용 ① 간질과 간질에 뒤따르는 성격, 행동장애의 예방과 치료 ② 수술후 및 외상후의 발작 ◆ 부작용 : 위장장애, 식욕항진, 췌염, 구내염, 권태감, 야뇨, 탈모, 부종, 백혈구, 혈소판 감소, 빈혈, 두통, 간장애 ◆ 금기 : 간염, 중증의 간장애, Carbapenem 과의 병용, Porphyria ◆ 상호작용 ①Carbapenem 계 항균제, 효소유도 항간질약(phenytoin, Pb, DPH, Carbamazepine): 이 약의 혈중농도 저하 ②TCA 계: 경련 유발 ③Pb, Primidone, Zidovudine 의 혈중농도 증가 ④DPH 의 혈중농도 저하로 발작 악화 ⑤Aspirin, EM, Cimetidine, 펠바메이트: 이 약의 농도 증가 ⑥Lamotrigine, Clozapine 의 대사 저하 ⑦Ethosuximide 의 혈중농도 변화 ⑧알콜, Benzodiazepine, Warfarin 의 작용강화 ◆ 주의 ①기계조작 ②췌장 장애, 선천적 효소결핍, 골수손상, 간기능장애, 신부전, 혈액응고장애 환자는 신중투여 ③정기적인 간기능 검사 ④3 세 미만 소아에게는 단독요법 실시 ◆ 태아위험도 : D ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 착란, 진정, 심하면 혼수, 근무력증, 반사저하 또는 무반사, 저혈압, 동공수축, 심혈관계와 호흡기계 질환, 뇌부종, 대사성 산증, 저칼륨혈증, 고나트륨혈증, 과도하게 과량투여시 사망한 경우도 있으나 대부분은 회복 ③ 처치 : 삼투성 이뇨, 심장 및 호흡기 기능 모니터링, 중증의 경우에는 투석 또는 치환수혈을 한다. 과량투여시 단백과 결합하지 않는 약물의 분획은 높으며, 혈액 투석 또는 혈액관류를 더한 직렬식 혈액투석은 약물을 현저히 제거할 수 있다. 적절한 요배설 유지를 위한 특별한 주의와 일반적 보조 방법을 병행하여 실시한다. 날록손이 효과적인 경우도 있다. 이론적으로는 간질 환자에게 날록손이 이 약의 항간질 효과를 반전시킬 수 있으므로 신중히 투여한다. 과량투여시 사망할 경우도 있으나 대부분은 회복된다. 사망예가 보고되었으나, 발프로산 농도 최고 2,120mcg/ml 부터 회복되었다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Oxciton inj	
성분/함량	Oxytocin 5IU/1ml/A	자궁수축제
효능·효과	다음 경우의 자궁수축의 유발, 촉진 및 자궁출혈의 치료 : 분만유도, 진통미약, 분만후 출혈, 이완성 자궁출혈, 자궁퇴축부전, 제왕절개술(태아만출 후), 유산, 인공임신중절	
용법·용량	◆ 분만유도 및 진통미약 : 5-10IU 를 D5W 500ml 에 희석하여 0.001-0.002IU/분의 속도로 IV infusion (최대: 0.02IU/분) ◆ 분만후 출혈, 이완성 자궁출혈, 자궁퇴축 부전, 유산, 인공임신중절, 제왕절개술(태아 만출 후) ①5-10IU 을 D5W 500ml 에 희석하여 IV infusion ② IM, IV(분만후 출혈, 이완성 자궁출혈): 5-10 IU ③자궁근층내 주사: 5-10IU(제왕절개술)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Urine myometrial tissue 의 Ca^{2+}농도 증가시켜 자궁수축 촉진, breast alveoli 와 lactiferous ducts 의 smooth muscle fiber 의 수축을 유도하여 산후 유즙분비 작용 ◆ 부작용 : 자궁의 과도한 진통, 강직, 경련성 수축, 자궁파열, 양수 색전증, 이완성출혈, 태아가사, 태아의 서맥, 부정맥, 빈맥, 혈압상승, 구역, 구토, 신생아 황달, 수분배출의 감소, 항이뇨효과, 경련 ◆ 금기 : 임신중독증 및 다태 임부, 심□신□혈관장애환자, 분만유도□진통미약의 치료목적으로 PG 투여중인 환자, 아두골반불균형, 자궁의 과도한 진통, 자궁절박파열 또는 태아가사상태의 환자, 상위태반 조기박리상태의 환자, 자궁패혈증, 연산도 강인증, 자궁경부의 개구부전, 골반협착, 아두전 분만유도, 양수색전증 및 양수과다증, 중증전자간 중독증, 질분만 금기인 환자 ◆ 상호작용 ① PG 제제(PGE_2, $PGF_{2\alpha}$): 상승효과로 과도한 진통유발 ② Cyclophosphamide: 이 약 작용증강 ③ 혈압강하제: 혈압강하 효과 증가 ④ 혈관수축성 교감신경 효능약: 지속성 동맥고혈압 ⑤ 흡입마취제: 이 약의 혈압강하작용 증가, 자궁수축작용 감소 ◆ 태아위험도 : X ◆ 비고 : 냉장 보관(10℃이하) ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 이 약의 과량투여시 자궁근수축에 대한 감수성이 높게 나타날 수 있다. 자궁의 지나치게 강한 수축에 의해 과도한 진통, 자궁파열, 경관열상, 태아가사, 양수색전증이 나타날 수 있다. 대량을 점적주사시 수분중독에 의한 혼수, 경련 등이 나타날 수 있다. ② 처치 : 자궁의 지나치게 강한 수축이 나타나는 경우 즉시 투여를 중지한다. 지나치게 강한 수축이 지속되어 자궁파열, 태아가사 등의 위험성이 나타나는 경우에는 긴급하게 제왕절개술의 적용을 고려한다. - 수분중독 : 투여중단, 수분섭취 제한, 이뇨, 고장액 투여, 전해질평형의 보정 등 을 한다. - 경련 : 항전간제를 투여한다. ◆ 적용상의 주의 ① 투여속도 : 정맥주사(특히 마취제, 혈압상승제 등을 병용하는 경우)시 혈압 등에 주의 하면서 천천히 한다. ② 투여시 : 이 약에 대한 자궁근의 감수성이 높은 경우에는 과도한 진통, 태아가사가 나 타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지 또는 감량한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Ozurdex implant inj	
성분/함량	Dexamethasone 0.7mg/EA	안과용제
효능·효과	◆ 망막분지정맥 폐쇄(branch retinal vein occlusion) 또는 망막 중심정맥폐쇄(central retinal vein occlusion) 후 나타나는 황반부종의 치료 ◆ 후안부 염증을 동반한 비감염성 포도막염의 치료 ◆ 당뇨병성 황반부종의 치료	
용법·용량	◆ 이식제 1개를 한쪽 안구의 유리체내 주사로만 투여(무균조건하 수행)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 다형핵 백혈구의 유주를 억제하고, 증가된 모세혈관 투과성을 감소시켜 염증 반응을 감소, 정상적인 면역반응을 억제 ◆ 부작용 : 두통, 안압상승, 결막 출혈, 고안압, 유리체 박리, 백내장, 유리체 출혈, 시각장애, 유리체 혼탁, 안통, 광시증, 결막 부종, 전방세포, 결막 충혈, 망막 열공, 전방 발적 ◆ 금기 ① 안구감염 또는 안구주위 감염 ② 유두함몰비(Cup/Disc ratio) 가 0.8 보다 큰 녹내장환자 ③ 수정체후낭 파열이 있는 무수정체증 환자 ④ 앞방인공수정체와 홍채 또는 경공막 고정안내렌즈 및 수정체후낭 파열이 있는 환자 ◆ 주의 ① 안구 단순포진 병력, 무수정체 환자 ② 망막허혈이 있는 망막정맥폐쇄에 의한 이차성 황반부종 ③ 항응고제 또는 항혈소판 제제 복용 환자 ④ 90일 이내에 내안부 수술 또는 레이저 치료를 받은자 ⑤ 양쪽 눈에 중심성 장액성 맥락망막병증 ⑥ 유리체 절제술 병력 ⑦ 공막의 박리화 또는 확장이 있는 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 실온(1-30℃) 보관 ◆ 적용상의 주의 ① 양쪽 눈 동시 투여의 경험은 없으므로 추천되지 않음 ② 투여 전 및 투여 당일 적절한 광범위 항균제 사용을 권장	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Papaverine inj	
성분/함량	Papaverine HCl 30mg/1ml/A	진경제
효능·효과	다음 질환에서의 내장평활근의 경련 : 위염, 담석증 말초순환장애, 급성 동맥색전, 급성 폐색전	
용법·용량	◆ 혈관, 요관, 담관, 소화관 등 평활근 진경 : 1 회 30-50mg SC(100-200mg/일) ◆ 급성 동맥 색전 : 1 회 50mg 동맥내 주사(IA) ◆ 급성 폐색전 : 1 회 50mg IV	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Vasodilating agent 로 arterior dilation, smooth muscle relaxation 평활근에 직접 작용하여 평활근의 이상 긴장 및 경련 억제 ◆ 임상응용 ① 내장 평활근의 경련 증상: 위염, 담석증 ② 말초 순환장애, 급성 동맥 색전, 급성 폐색전 ◆ 부작용 : 황달, 호산구증다증, 간기능 검사 변화, 두통, 현기, 졸음, 과도한 진정, 식욕부진, 구역, 변비, 설사, 복부불쾌감, 호흡 깊이의 증가, 호흡억제, 혈압상승, 박동수 증가, 발진, 안면홍조, 권태, 발한, 전신불쾌감, 음경 지속발기 ◆ 금기: 완전 심방실 블록환자(전도가 억제될 때 심실근원의 일과성 전위리듬, 조기박동, 발작성 서맥을 일으킴) ◆ 상호작용 ① Levodopa 의 작용 저하 ② Ginkgo: 이 약의 부작용 증가 ◆ 주의 ① 녹내장 환자 ② 발기불능 사용금지 : 약물 또는 외과수술 중재가 필요한 음경 지속발기가 보고됨 [태아위험도] C ◆ 비고 ① IV 투여시 심부정맥 및 호흡 억제를 일으킬 수 있으므로 주입 속도를 아주 천천히 할 것 ② 젖산 Ringer 주사액과 혼합시 침전 생성 ③ 차광보관 ◆ 적용상의 주의 ① 정맥주사하는 경우에는 급속한 투여로 인한 호흡정지를 방지하기 위해 될 수 있는 한 천천히 투여한다. ② 앰플을 절단할 때는 유리의 미소편이 혼입되는 것을 피하기 위하여 앰플에 줄칼로 금을 넣은 후 알콜솜으로 씻어내고 절단한다. ③ 이 약은 침전을 생성하므로 젖산링겔주사액에 첨가하지 않는다. ④ X 선조영제인 이옥사글린산(Ioxaglic acid)과 혼합하면 침전이 생성될 수 있으므로 병용하는 경우에는 따로따로 사용하거나 또는 카테터 내를 생리식염액으로 씻어내는 등 직접 혼합하지 않도록 주의한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Peniramin inj	
성분/함량	Chlorpheniramine maleate 4mg/2ml/A	항히스타민제
효능·효과	고초열, 두드러기, 소앙성 피부질환(습진 피부염, 피부소양증, 약진, 곤충자상), 알레르기성비염, 혈관 운동성 비염	
용법·용량	◆ 성인 (>12 세) : 1 회 1/2-1 앰플을 1-2 회/일, IM 또는 서서히 IV (1ml/min) 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다. ◆ 소아용량 ① 6-12 세: 1 회 22.75-34.125mg(0.5-0.75ml) IM ② 4-5 세: 18.2-29.575mg(0.4-0.65ml) IM ③ 2-3 세: 11.375-15.925mg(0.25-0.35ml) IM ④ 6 개월-1 세: 4.55-9.1mg(0.1-0.2ml)을 IM(최대: 3mg/kg/일)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : H_1-antagonist 로서 모세혈관 확장□혈관투과성 항진□기관지수축 억제작용 ◆ 부작용 : 쇽, 발진, 광과민증, 박리성피부염, 두드러기, 졸음, 일과성 자극통, 구갈, 오심, 구토, 불안, 발한이상, 진정, 신경과민, 두통, 초조감, 빈뇨, 변비,배뇨곤란, 혈압강하, 재생불량성 빈혈, 무과립구증, 안압상승, 천명, 구강건조, 위장관장애, 심계항진, 요저류, 월경이상, 용혈성빈혈, 청색증, 호흡곤란, 흉부 불쾌감, 경련, 착란, 코□기도의 건조, 코막힘 ◆ 금기 : 폐쇄각 녹내장, 전립선 비대, 미숙아, 신생아, MAOI 투여환자 ◆ 상호작용 ①Phenytoin 의 대사 억제 ②알콜, 중추신경억제제: 졸음 유발 ◆ 주의 : 운전·기계조작시 주의 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 차광보관 ◆ 과량투여시의 처치 (클로르페니라민의 치사량은 체중 kg 당 25-5Omg 이다) ① 증상 : 진정, 중추신경계 비정상적 자극, 중독성 정신병, 경련, 무호흡, 정신착란, 항콜린 효과, 실조증, 부정맥을 비롯한 심혈관계 허탈증 등이 나타날 수있다. 유아 및 소아의 경우 환각, 흥분, 경련, 사망 등을 일으킬 수 있음. ② 처치 : 심장 ·호흡기 ·신장 ·간장 기능 및 수액전해질 균형에 특별한 주의를 기울이는 등 대중적 지지적인 처치, 중추신경계 경련은 디아제팜 또는 페니토인을 정맥주사하거나 심한 경우에는 혈액관류	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Pentaxim inj	
성분/함량	**diphtheria toxoid(1514-N-3S strain) 30이상I.U, filament hemagglutinin(1591 strain) 25μg, pertussis toxoid(1591 strain) 25μg, inactivaed poliomyelitis virus type 1(Mahoney) 40D항원, inactivated poliomyelitis virus types 2(MEF-1) 8D항원, inactivated poliomyelitis virus types 3(Saukett) 32D항원, polysaccharide of H. influenzae type B conjugated to tetanus protein 10μg, tetanus toxoid(1472-c strain) 40이상I.U**	**DTaP-IPV/Hib 백신**
효능·효과	◆ 디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오(소아마비) 및 헤모필루스 인플루엔자 비형균에 의한 침습성 감염증의 예방	
용법·용량	◆ 기초접종: 1회 용량 0.5mL씩 생후 2, 4, 6개월에 3회 접종한다. ◆ 프리필드시린지에 충진된 현탁액을 동결건조 분말 바이알에 넣어 용해(재구성) 후 근육주사 영아의 경우 대퇴부 전외측에 주사.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오(소아마비) 및 헤모필루스 인플루엔자 비형균에 의한 침습성 감염증을 동시에 예방하는 사백신 ◆ 부작용 : 주사부위 국소반응, 비정상적인 울음, 자극과민성, 발열 등 ◆ 금기 ① 이 백신의 성분에 알러지 반응이 있는 자 ② 글루타알데히드, 네오마이신, 스트렙토마이신, 폴리믹신B에 알러지 반응이 있는 자 ③ 백일해 백신에 알러지 반응이 있는 자 ④ 이 백신 또는 이 백신과 동일한 성분의 백신 접종 후 생명을 위협하는 반응이 있었던 자 ⑤ 진행성 뇌병증(뇌병변)을 앓고 있는 자 ⑥ 이전에 백일해 백신 접종 후 7일 이내 뇌병증(뇌병변)이 있던 자 ⑦ 발열 또는 급성질환을 앓고 있는 자 (이 백신의 접종을 연기해야 함.) ◆ 상호작용 : ① 홍역-유행성이하선염-풍진 백신 또는 B형간염 백신과 서로 다른 부위에 동시에 접종할 수 있음 ② 헤모필루스 인플루엔자 b형 항원은 소변으로 방출되기 때문에 이 백신 접종 1~2주 내 소변검사 시 양성 판정을 받을 수 있음. 이 기간 동안 Hib 감염을 확인하기 위해서는 다른 검사를 수행하여야 함. ◆주의 ① 면역억제 치료를 받거나 면역결핍증을 앓고 있는 환자 (그럼에도 불구하고 HIV 감염과 같은 만성 면역결핍 환자의 경우 항체반응이 제한적일 수 있지만, 백신 접종이 권고됨) ② 이전에 파상풍 톡소이드를 포함한 백신 접종 후 길랑-바레 증후군 또는 상완신경염이 나타난 환자 ③ 이전에 백일해 백신 접종 후 40℃ 이상 발열, 저긴장성-저반응성의 허탈 또는 쇽, 3시간 이상 비정상적인 울음, 경련 등이 발생한 경우 추가 접종 고려 ④ 열성·비열성 경련의 기왕력이 있는 환자 ⑤ 헤모필루스 인플루엔자b형 항원을 포함한 백신 접종 후 하지에 부종이 발생한 환자 (디프테리아-파상풍-백일해-소아마비 백신과 헤모필루스 인플루엔자 b형 백신은 반드시 다른 날, 다른 부위에 접종) ⑥미숙아(재태주수 28주 이하), 특히 이전에 호흡 부전의 병력이 있는 미숙아 ⑦혈소판감소증 또는 혈액응고장애가 있는 환장 경우 근육주사 시 출혈의 위험이 있으므로 주의해 주사. ◆ 태아위험도 C ◆ 비고 ① 차광하여 냉장보관(2-8℃) ② 용해(재구성) 후 즉시 사용	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	**Peramiflu inj**	
성분/함량	**Peramivir hydrate 150mg/15ml/V**	**항바이러스제**
효능·효과	◆ 성인 A 형 또는 B 형 인플루엔자 바이러스 감염증의 치료 (인플루엔자 감염의 초기증상 발현 48 시간 이내에 투여를 시작해야 한다.)	
용법·용량	◆ 성인 : 페라미비르로서 300 mg를 15분 이상 단회 점적정주 이 약의 투여는 증상 발현 후, 가능한 한 신속하게 투여를 시작하는 것이 바람직함. ◆ 신장기능장애 환자 : 높은 혈중 농도가 지속될 우려가 있으므로, 신장 기능의 저하 정도에 따라 아래 표를 기준으로 투여량을 조절한다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : cyclopentane 유사체로서 influenza virus neuraminidase enzyme을 선택적으로 저해하여 감염된 세포로부터 바이러스 입자의 방출을 막음. ◆ 부작용 : 설사, 호중구 감소, 단백뇨, 백혈구 감소, 오심, AST(GOT)상승 , ALT(GPT)상승, 단백뇨 , 뇨중 β2 마이크로글로불린 상승 , NAG상승, 임프구 증가, 혈중 포도당 증가 ◆ 금기 : 이 약의 성분에 대해 과민증의 과거 병력이 있는 환자 ◆ 상호작용 : ① 다른 약물과의 약물 상호작용에 대해 연구는 수행되지 않음. ② 신장에서 일차적으로 배설되므로 신장에서 배설되는 다른 약물을 사용할 때는 주의를 기울여 사용하고 환자의 신기능을 적절히 모니터링 ◆ 주의: 다음 환자에는 신중히 투여할 것 ① 신장기능 장애 환자 (이 약 투여시 용량조절이 필요) ② 고령자 (사용한 경험이 매우 드물다.) ③ 첨가물(염화 나트륨 , 주사용수에 관한 주의) - 심장, 순환기능 장애가 있는 환자(나트륨의 부하 및 순환 혈액량을 늘리는 것에서부터 심장에 부담을 끼쳐 증상이 악화될 염려가 있다.) - 신장기능 장애가 있는 환자(수분, 염화나트륨이 과잉투여되기 쉬우며, 증상이 악화될 염려가 있다.)	

Creatinine Clearance (mL/min)	페라미비르로서 1 회 투여량
50 ≤ Ccr	300 mg
30 ≤ Ccr < 50	100 mg (1 회 투여량의 1/3 용량)
10 ≤ Ccr < 30	50 mg (1 회 투여량의 1/6 용량)

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	PERidol inj	
성분/함량	Haloperidol 5mg/1ml/A	Butyrophenone계 Antipsychotics
효능·효과	정신분열증, 조증, 정신병적 장애의 증상, 투렛증후군(Gilles de la Tourette's syndrome), 구토, 딸꾹질	
용법·용량	◆ 1 일 6~15mg 을 분할하여 근육주사 ◆ 가능한 빨리 경구 투여로 변경 ◆ 연령, 증상에 따라 적절히 증감	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Butyrophenoene 계 antipsychotic 로, Dopamine receptor(D_1, D_2, D_2>D_1)에 결합하여 중추신경계의 dopamine 작용 억제 ◆ 부작용: 정좌불능증(Akathisa), 추체외로효과(Extrapyramidal effect), 파킨슨병(parkinsonism), 체중증가, 심전도이상(QT 간격 연장, T wave 의 변화 등), 혈압상승/저하, 부정맥, torsades de pointes 등 ◆ 금기 : 혼수상태, 알코올중독, Barbiturate 나 마취제 등의 중추신경억제제의 강한 영향 하에 있는 환자, 중증의 심부전, 파킨슨병 환자(추체외로증상이 악화될 수 있음), 기관지폐렴, 뇌저신경절손상, Epinephrine 투여중인 환자, 소아, 임부 및 수유부, 이 약 또는 Butyrophenone 계 약물에 과민증 환자 등 ◆ 상호작용 (상호작용 일으키는 약물이 많으므로 주의가 필요) ① 중추신경억제제(Barbiturate, 마취제), 수면제, 진통제, 항히스타민제, 진정제, 혈압강하제, 항콜린제, 유기인 살충제, 알코올 섭취에 의해 상호작용이 증가될 수 있으므로 용량 감량이 필요할 수 있음 ② Levodopa 의 항파킨슨 효과 저하 ③ Lithium: 심전도변화, EPS 작용, 지발성운동장애, NMS, 비가역적 뇌장애 ④ Carbamazepine, Phenobarbital : haloperiol 의 혈중농도 감소 ⑤ TCA 의 대사 저해 및 당뇨병 조절저해 ⑥ 제산제, Caffeine: haloperiol 의 흡수 저하 ⑦ Epinephrine, 교감신경흥분제: 혈압강하효과 ⑧ Methyldopa: 중추신경계효과 증강 ◆ 태아위험도 : C (국내 임부금기 2 등급) ◆ 비고 : 실온, 차광보관 ◆ 소아에 대한 투여 : 추체외로증상 특히 운동장애가 나타나기 쉬움 ◆ 고령자에 대한 투여 : 기립성 저혈압, 추체외로증상, 운동실조, 배설장애 등이 나타나기 쉬우므로 감량 투여하는 등 신중히 투여할 것 ◆ 주의 ① 이 약 투여 중 QT 연장이 발생할 가능성 있으므로 QT 연장의 소인(QT 증후군, 저칼륨혈증, QT 연장시키는 약물 등)이 있는 환자는 주의가 필요 ② 이 약에 의해 발작이 야기될 수 있으므로 간질, 경련의 소인이 있는 환자에 주의 ③ 장기 연용시 환자를 주의하여 관찰하고 간, 신기능, 혈액 검사 등을 실시	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Perlinganit inj 0.1%	
성분/함량	Nitroglycerin 10mg/10ml/A, 50mg/50ml/V	혈관확장제
효능·효과	◆ 수술전 후의 혈압조절 : 심장 수술증의 고혈압조절 및 수술증의 저혈압유지, 심혈관계 수술중과 수술 후 심근허혈의 치료 ◆ 급성심근경색에 수반되는 울혈성심부전(만성심부전의 급성악화기 포함) ◆ 협심증 : 불안정형협심증 또는 절산염 설하정 및 β-차단제로 치료되지 않는 협심증	
용법·용량	이 약은 적정 투여량은 개인에 따라 다르므로 혈류동력학적인 면을 모니터하면서 환자의 상태에 따라 조절한다. 보통 권장량은 니트로글리세린으로서 10-200mcg/분이며 필요에 따라 400mcg/분 까지 투여할 수 있다. ◆ 수술전후의 혈압조절 : 초회 25mcg/분 → 5 분 간격으로 25mcg/분 반복투여 ◆ 심근허혈 : 초회 15-20mcg/분 → 10-15mcg/분 반복투여 ◆ CH F: 초회 20-25mcg/분 → 10mcg/분 또는 20-25mcg/분을 15-30 분간 반복투여 ◆ 협심증 : 초회 10mcg/분 → 30 분 간격으로 10mcg/분 반복투여	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 평활근을 이완(특히 관상순환계에 있는 세동맥과 모세 혈관 및 정맥확장), preload afterload 감소, 심근의 산소소모량 감소 ◆ 부작용 : 빈번한 두통, 심박급속, 오심, 구토, 현훈, 복통, 서맥, 빈혈, 혈압강하, 열감, 홍조, 심계항진, 기립성 저혈압, 허약, 실신, 요실금, 변실금, 발한, 박리성피부염, methemoglobinemia, PaO_2 저하, 외용(가려움, 접촉성 피부염, 발적) ◆ 금기 : 중증의 저혈압, 난치의 혈액감소증, 중증의 빈혈환자, 두부외상 또는 뇌출혈환자, 녹내장 및 폐쇄우각형 녹내장, 제한성 심근증, 협심증 심근증, 심막압전환자 ◆ 상호작용 ① 다른질산염제제, 혈압강하제, β-blocker, Phenothiazine 계약물 및 알코올 : 강압효과 증강 ② Sildenafil: 이 약 작용강화 ③ Aspirin 및 NSAIDs: 이 약 작용감소 ④ Pancronium 의 신경근 차단효과 연장 ◆ 배합금기 : Hydralazine, Phenytoin ◆ 주의 ① 저혈압, 급성 심근경색, CHF, 기립성 조절장애는 신중투여 ② 투여중지시 4-6 주에 걸쳐 용량 및 투여횟수 감소 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① PVC 수액용기 및 수액세트에 흡착(20-60% 흡착됨) ② pH 10 이상의 용액에 희석하면 이 약의 함량 저하 ③ 개봉시 24 시간동안 안정 ◆ 과량투여시의 처치 과량투여시 중증의 저혈압, 반사성 심박증가 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 환자의 상태가 안정될 때까지 다리를 높게 하고 감량 투여하거나 천천히 투여를 중지하면 완화된다. 이 약 투여로 인한 혈관계 반응 지속시간은 매우 짧으므로 별도로 치료할 필요는 없으나 필요한 경우에는 혈압상승제인 a-효능약(메톡사민 또는 페닐레프린)을 정맥주사한다. ◆ 취급상의 주의 : 피부에 묻으면 심계항진, 두통 등이 나타나는 경우가 있으므로 즉시 물로 씻어낸다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	PhenylEPHRINE inj	
성분/함량	Phenylephrine HCl 10mg/V	혈관수축제
효능·효과	마취중의 혈압조절과 척수마취, 흡입마위중의 적정 수준의 혈압유지와 쇼크, 쇼크양 상태, 약물원성 저혈압 또는 과민반응시의 혈관실조 치료를 위해 사용되며, 발작성 상심실성 빈맥의 치료, 척수마취 시간의 연장을 위해 부분마취시의 혈관수축제로 사용한다.	
용법·용량	◆ 중등도의 저혈압 ① SC, IM : 초기량 5mg 이하, 상용량 2-5mg(1-10mg 범위내에서 주사) ② IV - 초기량 : 5mg 이하 - 상용량 : 0.2mg (0.1-0.5mg 범위내에서 주사) → 0.5mg IV 시 15 분간 혈압상승시킴 → 5mg IV 시 1-2 시간동안 혈압상승시킴 ※ 10-15 분 이내 재투약 금지 ◆ 심각한 저혈압과 쇽(약물원성 저혈압 포함) : 10mg 을 500ml(DW, N/S)에 희석 후 IV infusion ① 초기량: 100-180mcg/분 ② 유지량: 40-60mcg/분 ◆ 척수마취시 저혈압 ① 척수마취 주사 3-4 분전에 SC, IM (고위 마취시 : 3mg, 저위 마취시 : 2mg) ② 척수 마취 중 저혈압 응급시 : IV -초기량: 0.2mg -추가용량: 그 전 투여용량에서 0.1-0.2mg 를 초과하지 말 것 (최대 1 회 투여량: 0.5mg) ◆ 척수마취의 연장: 마취용액에 2-5mg 첨가 ◆ 국소마취시 혈관수축 : 혈관수축제로 사용될 때 적용되는 Epinephrine 의 농도의 약 10 배 농도가 추천됨. 최적농도는 1:20,000(매 20ml 의 마취용액에 이 약 1mg 을 가하여 만듬). 2mg 이상 주사시에는 승압반응이 일어남 ◆ 발작성 상심실성 빈맥 : 신속한 IV 로 최초 용량 0.5mg 를 넘지 않게 하며, 추가용량은 이전량 보다 0.1-0.2mg 을 넘지않게 하며 1mg 을 초과하지 말 것 ◆ 소아용량 (척수마취시 저혈압) 0.5-1mg/25 파운드(11.34kg)를 SC, IM	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : postsynaptic α-receptor stimulant, 심장에서 β-receptor 효과가 약간 있음 ◆ 부작용 : 두통, 반사성 서맥, 흥분, 불안, 부정맥 ◆ 상호작용 : 혈압상승제, MAOI, TCA: 승압반응 증강 ◆ 금기 : 심각한 고혈압, 심실성빈맥환자 ◆ 주의 : 노인, 갑상선기능항진자, 서맥, 부분적 심차단환자, 심근성질환, 심각한 죽상 동맥경화증 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ①차광보관 ②Phenylephrine=neosynephrine ◆ 과량투여시의 처치 : 과량투여는 심실성 기외수축 및 일과성 심실빈맥, 두중감, 수족동통을 유도할 수 있다. 과도한 혈압상승이 일어나는 경우에는 펜톨라민과 같은 아드레날린 억제제를 즉시 투여하여야 한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	PLACENTEX inj	
성분/함량	Polydeoxyribonucleotide sodium 5.625mg/3ml/A	기타의 조직세포의 기능용 의약품
효능·효과	◆ 피부이식으로 인한 상처의 치료 및 조직 수복	
용법·용량	◆ 1일 1바이알을 근육 또는 피하주사로 투여한다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : VEGF(vascular endothelial growth factor) 분비를 촉진하여 상처 부위의 모세혈관 생성을 통하여 혈류를 개선, 피부이식으로 인한 상처치료 및 조직 재생작용 ◆ 부작용 : 과민반응 ◆ 금기 이 약의 주성분 및 이 약에 함유된 성분에 과민증이 있는 환자 ◆ 일반적 주의 - 이 약의 투여로 과민반응이 나타날 경우 투여를 중단하고 적절한 처치를 한다. ◆ 태아위험도 : 자료없음 ◆ 비고 : 밀봉용기. 실온(1~30℃) 보관	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Pneumo-23 inj 성인용	
성분/함량	Pneumococcal vaccine s. pneumoniae 25mcg/0.5ml/V	폐렴구균 백신
효능·효과	◆ 백신 함유 폐렴구균 협막형(23 개의 폐렴구균 협막 다당류 type)에 의한 폐렴구균 질병의 예방 ◆ 1 차 접종 - 다음과 같은 특정그룹의 사람들에게 접종이 권장 ① 면역력이 양호한 사람 - 50 세 이상 (단, 국내 예방접종지침에 따른 접종 권고연령은 65 세 이상임) - 만성심혈관계질환, 만성폐질환, 당뇨, 알코올중독증, 만성간질환, 뇌척수액 유출이 있는 경우, 기능적 또는 해부학적 비장결손 있는 2 세 이상 ② 면역력이 손상된 사람 - HIV 감염, 백혈병, 림프종, Hodgkin 병, 다발성골수종, 전신암, 만성신부전, 신증후군이 있는 2 세 이상 - 면역억제요법 중인 자, 장기 또는 골수이식 환자 ◆ 재접종 - 본 백신을 이전에 접종 받은 사람 중 면역력이 정상인 경우 재접종이 일반적으로 권장되지 않음 - 단, 일부의 경우 재접종 하기도 함 . (폐구균 감염의 특정 고위험군의 경우 10 세 이상 환자는 5 년 이후, 10 세 이하 환자는 3 년 이후에 1 회 실시) -특정고위험군: 65 세 이상 노인, 기능적 또는 해부학적 무비증, 겸상적혈구증, 간경변, 신증후군, 만성 신장기능이상, HIV 감염자, 질환 및 치료로 인해 면역기능이 억제된 환자 -특정접종시기: 비장적출수술 예정이 있는 경우 적어도 2 주전, 암 치료를 위한 화학요법이나 다른 면역억제요법(예.호지킨병이 있거나 장기 또는 골수이식을 받는 경우) 최소 2 주전, HIV 감염환자 확진 후	
용법·용량	◆ 통상 1회 0.5ml 를 피하주사 또는 근육주사 (삼각근 또는 대퇴측부에 주사하는 것이 바람직)	
사용상의 주의사항	◆ 부작용 : 동통, 홍반/발적, 열감, 부종, 경결 등의 주사부위 국소반응, 발열 등 ◆ 금기 - 이 백신의 성분에 과민증상이 있는 사람 - 이 백신의 성분에 의한 급성 아나필락시스 반응이 발생할 경우 즉시 에피네프린 (1 : 1000) 주사를 투여 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 냉장(2~8℃) 보관	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Praxbind inj	
성분/함량	Idarucizumab 2.5g/50ml/V	지혈제
효능·효과	이 약은 프라닥사캡슐(다비가트란에텍실레이트메실산염) 특이적 역전제로서 프라닥사캡슐 투여 환자에서 다음과 같은 항응고효과의 긴급 역전이 필요한 경우에 사용 ① 응급 수술/긴급 처치 시 ② 생명을 위협하거나 조절되지 않는 출혈 발생 시	
용법·용량	◆ 1회 5g, 5-10분간 연속적으로 IVF 또는 IV ◆ 항혈전제 치료의 재개 시점 ① 환자가 임상적으로 안정되고 적절한 지혈이 이루어지면, 이 약 투여 24시간 후에 프라닥사캡슐(다비가트란에텍실레이트메실산염) 치료를 재개할 수 있다. ② 환자가 임상적으로 안정하고 적절한 지혈이 이루어지면, 이 약의 투여 후 다른 항혈전치료(예: 저분자 헤파린)를 언제든 시작할 수 있다. ③ 항혈전제를 사용하지 않으면 환자가 기저질환 또는 기저상태의 혈전성 위험에 노출될 수 있다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Dabigatran에 대한 특이적 역전제(reversal agent), Humanized monoclonal antibody fragment (Fab)로서 Dabigatran과 Dabigatran의 acylglucuronide 대사체에 특이적으로 결합하여 수 분 이내 항응고효과 중화 ◆ 주의 ① 유전성 과당불내성 환자 투여시 모니터링 필요(∵첨가제로 Sorbitol 함유) ② 혈전색전증 발생 위험 있으므로 적절한 항응고요법 재개 고려 ③ 일시적인 단백뇨를 야기할 수 있으므로 단백뇨 검사 고려 ④ 나트륨 함량 조절 식이 중인 환자(∵나트륨 포함) ◆ 비고 ① 밀봉, 냉장(2~8℃) 보관 ② 첨가제로 Sorbitol 함유: 2g/바이알 ③ Na 함유: 1.1 mmoL(또는 25 mg)/바이알 ④ 보관방법 ㄱ. 사용전 미개봉 바이알: 차광상태 48시간/ 빛에 노출된 상태의 경우 6시간 동안 상온(25 ℃) 보관 가능 ㄴ. 바이알에서 약액 빼낸 이후 안정성: 상온(25 ℃) 1시간 ⑤ 다른 약과 혼합하면 안되며, 기존 사용 중인 정맥투여 라인 사용시 이 약 투여 전후에 생리식염주사액으로 라인을 세척해야 함	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Precedex premix inj	
성분/함량	Dexmedetomidine HCl 200mcg/50ml/Btl, 400mcg/100ml/Btl	최면진정제
효능·효과	◆ 집중치료 관리하의 진정 : 집중치료 관리 하에 초기 삽관되어 인공호흡을 실시하는 환자의 진정 ◆ 수술 및 시술 시 비삽관 환자의 의식하 진정 1) 감시 하 마취 관리(Monitored Anesthesia Care, MAC) 2) 의식 하 광섬유 삽관(Awake Fiberoptic Intubation, AFI)	
용법·용량		
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 상대적으로 선택적인 alpha-2 adrenergic agonist로 진정작용을 가짐. 마취 효과의 정확한 기전은 알려져 있지 않으나 아마 central postsynaptic alpha-2 수용체의 자극과 관련 있는 것으로 추정 ◆ 부작용 : 서맥, 심방세동, 저산소증, 저혈압, 구역 등 ◆ 금기 : 이 성분에 과민증이 있는 환자 ◆ 상호작용 ① 마취제, 진정제, 수면제, 마약류 : 이 약과 병용 시 효과 증강 ◆ 태아위험도 : C ◆ 적용상의 주의 ① 이 약은 항상 엄격한 무균상태에서 취급한다. ② 이 약은 정맥으로만 투여한다. ③ 이 약의 지속 투여시 투여속도의 조절 가능한 주입기구(시린지펌프 등)를 사용한다.	

적응증	용법.용량
집중치료 관리하의 진정 개시	- 성인: 10~20 분간 1mcg/kg 의 부하용량으로 주입
집중치료 관리하의 진정 유지	- 성인: 유지용량으로 0.2-0.7mcg/kg/시간으로 주입 유지용량의 정맥주입 속도는 원하는 진정 수준을 달성하기 위하여 조절
의식 하 진정 개시	- 성인: 10 분간 1mcg/kg 의 부하용량으로 주입 안과수술과 같은 침습성이 적은 수술에서는 10 분 동안 0.5mcg/kg 의 부하용량 주입 - 의식 하 광섬유 삽관 환자 : 10 분간 1mcg/kg 의 부하용량 주입
의식 하 진정 유지	- 성인: 유지용량으로 0.6mcg/kg/시간으로 개시하고 원하는 임상 효과를 얻기 위해 0.2~1mcg/kg/시간으로 적정 유지용량 정맥주입의 속도는 목표한 진정 수준을 달성하기 위하여 조정 - 의식하 광섬유 삽관 환자 : 기관내 튜브가 안전하게 될 때까지 0.7mcg/kg/시간의 유지용량 주입

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	**Predisol inj**	
성분/함량	**Methylprednisolone sodium succinate 125mg/V**	**부신호르몬제**
효능·효과	내분비 장애, 류마티스성 장애, 교원성 질환, 피부 질환, 알레르기성 질환, 안과 질환, 위장관 질환, 호흡기계질환, 혈액 질환, 종양성 질환, 부종성 질환, 신경계 질환, 결핵성 수막염(지주막하의 차단상태 또는 차단이 우려되는 경우로서, 적절한 항결핵 화학요법제와 병용투여), 선모충증(신경성 또는 심근성 합병증이 수반된 경우) 장기이식, 암치료의 보조요법으로 증상완화	
용법·용량	◆ 쇽 상태의 보조요법 : 30mg/kg 을 30 분간 IV 4-6 시간마다 48 시간까지 ◆ 급성척수 손상 : 30mg/kg 을 15 분간 IV, 45 분후 23 시간동안 5.4mg/kg/hr 로 IV infusion ◆ 다발성경화증 : 급성악화시 Prednisolone 200mg/일을 7 일간 → Prednisolone 80mg/일을 격일로, 30 일간 ◆ 기타 : 10-40mg 을 개시용량으로 함	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 부신 피질 호르몬 제제로 Prednisolone 에 비해 더 강한 glucocorticoid 작용(소염작용)이 있고 Na·H_2O 저류작용이 적음 ◆ 부작용 : Cushing's syndrome, 여드름, 외상, 과당뇨, 과혈당, 위장장애, 골조송증, ALT·AST·ALP 증가, 소화성궤양, 창상치유지연, 우울증, 발작, 안압항진, 백내장, 녹내장 ◆ 금기 : 감염증, 전신진균감염, 생백신, 약독생백신, 단순포진, 대상포진, 수두, 신생아, 미숙아(∵ Benzyl alcohol) 수막공간내 투여, 경막외 투여 금기 ◆ 주의 : 소화성 궤양 환자, 정신병 환자, 중증 골다공증 환자, 녹내장 환자, 게실염, 결핵성 질환 환자, 후낭하 백내장 , 고혈압 환자, 전해질 이상 환자, 혈전증 환자, 최근 장문합술을 받은 환자, 급성 심근경색의 병력이 있는 환자, 안과 투여시 바이러스성 결막·각막 질환, 결핵성·진균성·급성 화농성 안질환 환자, 감염증 환자, 당뇨병 환자, 골다공증 환자, 신부전, 울혈성 심부전 환자, 갑상선기능저하증, 경변증 환자, 지방간, 지방색전증 환자, 중증 근무력증 환자, 비특이성 궤양성 대장염 환자, 혈전성 정맥염 소인이 있는 환자, 골다공증, 고혈압, 울혈성 심부전, 심각한 감정이상, 당뇨병, 결핵, 녹내장, 간장애, 간질, 소화성 궤양, 코르티코이드로 인한 근병증의 병력이 있는 환자, 소아 및 고령자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 희석 용해시는 첨부된 용제에 녹이고 48 시간 이내 사용할 것 ② Methylprednisolone 4mg = Prednisolone 5mg ③ 이 약 1g 중 Na: 2.01mEg 함유	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Prevenar inj	
성분/함량	**Purified polysaccharide from S.pneumoniae Conjugated to Diphtheria CRM197 vaccine (pneumococcal 13-valent diphtheria conjugate vaccine)** **0.5ml/Syringe (성인/소아)**	**폐렴구균 백신**
효능·효과	◆ 생후 6 주 이상 ~ 만 17 세까지의 영아, 어린이 및 청소년에서 폐렴구균으로 인하여 생기는 침습성 질환, 급성 중이염, 폐렴의 예방 ◆ 18 세 이상 성인 ① 50 세 이상의 성인에서 폐렴구균으로 인하여 생기는 폐렴의 예방 ② 18 세 이상의 성인에서 폐렴구균으로 인하여 생기는 침습성질환의 예방	
용법·용량	◆ 1회 0.5ml 근육주사 ◆ 6개월 이하의 영아 ① 기초접종 : 1회 0.5ml씩 생후 2, 4, 6개월에 총 3회 주사 ② 추가접종 : 12~15개월에 0.5ml 추가 주사 ◆ 기초접종을 하지 않은 7개월 이상의 영아 및 어린이 ① 7~11개월 : 1회 0.5ml 씩 3회 주사 (처음 2회는 적어도 1개월 간격을 두고, 세 번째는 생후 12개월 이후 두 번째 접종과 2개월 간격 두고 주사) ② 12~23개월 : 1회 0.5ml 씩 2개월 간격으로 총 2회 주사 ③ 24개월~만17세 : 0.5ml 씩 1회 주사 ◆ 기존에 프리베나 접종받은 영아 및 어린이에서 이 약으로의 전환 접종 : 프리베나 마지막 투여 후 적어도 2개월 간격 ◆ 18세 이상의 성인 : 1회 0.5ml 주사	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 백신은 B cell의 성숙을 신호하는 T-cell 의존적 면역 반응을 일으킴으로써 항체를 생산하고 pneumococcal polysaccharide에 대한 기억 세포를 생산하여 작용 ◆ 부작용 : 발열, 과민, 접종부위 반응(홍반, 경화/종창, 통증/압통), 졸음, 불안정한 수면, 식욕감퇴, 설사, 구토, 발진 등 ◆ 금기 : 이 약의 활성성분, 부형제 또는 Diphtheria toxoid 에 대해 과민성이 있는 자, 급성 중증의 열성질환을 앓고 있는 환자 ◆ 태아위험도 : 임신 또는 수유 중인 사람에 대한 자료 및 동물에서의 생식독성시험이 없으므로, 임신 중에 사용을 피할 것 ◆ 비고 : 냉장(2~8℃) 보관 ◆ 적용상의 주의 ① 투여 전 흔들어 균일한 백색 현탁액으로 만들어야 하며, 균일하게 현탁 되지 않는 경우에는 사용하지 말 것	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Primacor inj	
성분/함량	Milrinone 10mg/10ml/A	강심제
효능·효과	타약제 (경구용 디기탈리스류 강심제, 이뇨제, 혈관이완제)에 반응하지 않는 중증 울혈성 심부전의 단기 치료 심장수술후 저심박출량을 포함한 급성 심부전 *소아의 경우 35 시간까지 가능	
용법·용량	◆ 초기량 : 50 μg/kg 을 10 분이상 IV (소아: 30-60 분간 서서히 정맥투여) ◆ 유지량 : 0.375-0.75 μg/kg/분을 IV infusion ◆ 최대량 : 1.13mg/kg/일	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Bipyridine 유도체로, 심근 및 혈관조직에서 Phosphodiesterase III 를 선택적으로 억제하고, (+) Inotropic action 과 vasodilation 작용 ◆ 부작용 : 심실성 부정맥, 저혈압, 협심증, 흉통, 심실성 빈맥, 두통, 저 K 혈증, 진전, 혈소판감소증, 기관지경련 ◆ 금기 : 급성 심근경색, 중증의 폐쇄성 심질환 및 판막질환 ◆ 배합금기 : $NaHCO_3$, Furosemide, Bumetanide, Diazepam, Cefotiam, Piperacillin Na ◆ 주의 ① 심실성 부정맥 및 심근경색 악화, 혈압, 심박출량 관찰할 것 ② 신기능저하환자, 중증의 빈맥성부정맥, 혈청 K^+저하가 있는 환자는 신중투여 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 차광보관 ◆ 과량투여시의 처치 : 이 약은 혈관 확장 작용으로 인한 저혈압 또는 심부정맥이 유발될 수 있다. 만일 저혈압이 발생했을 경우에는, 환자의 상태가 안정될 때까지 이 약의 투여를 중단하여야 한다. 특별한 해독제는 알려져 있지 않으므로 순환계에 대한 일반적인 처치를 실시하여야 한다. ◆ 적용상의 주의 ① 병용에 관한 자료가 보고될 때까지는 이 약과 다른 약물을 혼합해서 사용해서는 안된다. [환자의 상태에 따라서 이 약의 점적 정주 투여량을 조절할 필요가 있다.] ② 중탄산나트륨 점적주사액을 희석용액으로 사용해서는 안된다. 적절한 희석액으로는 0.9% 생리식염수, 0.45% 생리식염수, 멸균 5% 포도당 용액 등이 있다. ③ 염산세포티엄(cefotiam)과 배합 후 신속하게 사용하고 어쩔 수 없이 사용하는 경우에는 6 시간 이내에 사용한다. ④ 희석된 약액은 24 시간 이내에 사용한다. ① 정맥주사액은 반드시 육안으로 관찰하고 이물질이 있거나 변색된 경우는 사용해선 안된다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Prodiax 23 inj	
성분/함량	Pneumococcal vaccine s. pneumoniae 25mcg/0.5ml/V	폐렴구균 백신
효능·효과	◆ 백신 함유 폐렴구균 협막형(23 개의 폐렴구균 협막 다당류 type)에 의한 폐렴구균 질병의 예방 ◆ 1 차 접종 - 다음과 같은 특정그룹의 사람들에게 접종이 권장 ① 면역력이 양호한 사람 - 50 세 이상 (단, 국내 예방접종지침에 따른 접종 권고연령은 65 세 이상임) - 만성심혈관계질환, 만성폐질환, 당뇨, 알코올중독증, 만성간질환, 뇌척수액 유출이 있는 경우, 기능적 또는 해부학적 비장결손 있는 2 세 이상 ② 면역력이 손상된 사람 - HIV 감염, 백혈병, 림프종, Hodgkin 병, 다발성골수종, 전신암, 만성신부전, 신증후군이 있는 2 세 이상 - 면역억제요법 중인 자, 장기 또는 골수이식 환자 ◆ 재접종 - 본 백신을 이전에 접종 받은 사람 중 면역력이 정상인 경우 재접종이 일반적으로 권장되지 않음 - 단, 일부의 경우 재접종 하기도 함	
용법·용량	◆ 통상 1회 0.5ml 를 피하주사 또는 근육주사 (삼각근 또는 대퇴측부에 주사하는 것이 바람직)	
사용상의 주의사항	◆ 부작용 : 동통, 홍반/발적, 열감, 부종, 경결 등의 주사부위 국소반응, 발열 등 ◆ 금기 - 이 백신의 성분에 과민증상이 있는 사람 - 이 백신의 성분에 의한 급성 아나필락시스 반응이 발생할 경우 즉시 에피네프린 (1 : 1000) 주사를 투여 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 냉장(2~8℃) 보관	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Profa infusion inj	
성분/함량	Acetaminophen 1g/100ml/Bag	비마약성진통제
효능·효과	◆ 통증이나 고열로 인하여 신속하게 정맥 투여할 필요가 있거나 다른 경로로 투여할 수 없는 경우 ① 중등도의 통증(특히 수술 후)의 단기간 치료 ② 발열의 단기간 치료	
용법·용량	◆ 정맥으로 15분간 투여하며, 성인 및 체중 33kg(약 11세) 이상인 소아에 한함. ① 50kg이상인 성인: 1회 1g, 1일 4회, 투여간격은 최소 4시간 (1일 최대 4g) ② 33kg(약 11세) 이상 소아, 50kg 미만인 성인: 1회 약 15mg/kg(이 약 1.5ml/kg), 투여간격은 최소 4시간 (1일 최대 60mg/kg 또는 4g) ③ 중증 신장애 환자(Clcr ≤ 30ml/min): 투여간격 최소 6시간	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Prostaglandin의 합성을 저해하고 통증의 역치를 높여서 통증을 경감시키는 것으로 추정, CNS에서 Prostaglandin의 생성과 분비를 억제하고 시상하부의 thermoregulator에서의 endogenous pyrogen을 억제함으로써 해열 작용 나타냄. ◆ 부작용 : 권태감, 저혈압, 간 transaminase 농도 증가, 무과립구증, 호중구 감소증, 반점발진, 주사부위 반응(통증, 작열감), 구역, 구토, 두통, 과민반응 등 ◆ 금기 : 아세트아미노펜이나 프로파세타몰염산염 또는 이 약에 대해 과민증이 있는 환자, 소화성 궤양 환자, 중증의 혈액 이상/간장애/신장 장애/심장기능저하 환자, 아스피린 천식 또는 그 병력 환자(NSAIDs에 의한 천식발작 유발), 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 복용 환자, 알코올 복용 환자 ◆ 상호작용 : ①Isoniazid, Phenytoin: 간 독성 증가 ②Probenecid, Salicylamide: 이 약의 작용 증가 ③Carbamazepine, Phenobarbital, Primidone, Rifampicin, Phenytoin: 이 약의 작용 감소 ④경구 항응고제: INR 값 변화->병용투여기간 및 Acetaminophen 중단 후 1주 동안은 INR 값의 모니터링이 수행 ◆ 주의 ① mg과 ml의 혼동으로 인한 투약 오류 위험 주의 ②경구 투여 가능 시 바로 적절한 진통제 사용 ③과량 투여의 위험성을 피하기 위해, 기 투여한 다른 약에 Acetaminophen 함유 확인 ①간독성 주의: 권장용량 이상 용량은 매우 심각한 간 손상 수반 ⑤Acetaminophen 복용 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스 - 존슨증후군(SJS), 독성 표피 괴사용해(TEN)와 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 반응은 치명적일 수 있음. ⑥신중투여: 간장애 또는 그 병력이 있는 환자, 신장장애 또는 그 병력이 있는 환자, 소화성 궤양의 병력이 있는 환자, 혈액 이상 또는 그 병력이 있는 환자, 출혈경향이 있는 환자, 심장기능이상이 있는환자, 과민증의 병력이 있는 환자, 기관지 천식 환자, 고령자(노인), 소아, 임부 또는 수유부, 와파린 장기 복용 환자, 리튬/치아짓계 이뇨제 복용 환자, 만성 알코올중독 환자, 만성 영양실조(간글루타치온의 낮은 보유량) 환자, 탈수/저혈량증 환자	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Protamine inj	
성분/함량	Protamine sulfate 50mg/5ml/A	해독제
효능·효과	◆ 헤파린 과량투여시의 중화 ◆ 혈액투석, 인공심폐, 선택적 뇌관류 냉각법 등 혈액 체외순환후 헤파린 작용의 중화	
용법·용량	◆ Heparin 1000 IU 당 10-15mg 투여 ◆ 1 회 50mg 이하의 양을 N/S 또는 D5W 100-200ml 에 희석하여 10 분간 서서히 IV	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 강염기성 단백질로서, 생체내에서 산성 heparin 을 중화 ◆ 부작용 : (급속투여) 혈압강하, 서맥, 호흡곤란, 일과성 피부홍조, 오심, 구토, 쇽 ◆ 금기 : 이 약의 성분에 과민반응 병력이 있는 환자 ◆ 상호작용 : Cepha 및 PC 계와 병용하지 말 것 ◆ 주의 ① 동물시험에서 과량투여로 적혈구응집, 호산구증다, 혈소판감소, 폐동맥 내막 병변, 간혈관 폐색 등이 보고됨 ② 이전에 프로타민의 사용을 포함하는 관상혈관성형술 또는 심폐 바이패스와 같은 처치를 거쳤던 환자 ③프로타민 인슐린으로 치료받았던 당뇨병 환자 ② 물고기에 알레르기가 있는 환자 ③ 정관절제술을 받았거나 불임인 남성환자 ④ 프로타민에 항체를 가지고 있는 환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 과량투여시의 증상은 급속투여시의 증상과 같다. ② 처치 : 응고검사의 모니터링, 호흡환기, 대증요법을 포함한다. 출혈이 문제가 되면 신선 동결혈장 또는 신선 전혈액을 투여해야 한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Proternol-L GI TAI inj, Proternol-L KOWA inj	
성분/함량	Isoproterenol HCl 200mcg/1ml/A	β-1, β-2 adrenergic receptor agonist
효능·효과	◆ Adams-Stokes 증후군의 발작 시(고도의 서맥, 심박동정지 포함) 또는 발작 반복 시 ◆ 심근경색이나 세균 내 독소 등에 의한 급성 심부전, 수술 후의 저심박출량 증후군	
용법·용량	◆ 일반적으로 점적 정맥 또는 bolus 정맥주사하며 심박동수, 혈압 등에 따라 근육 또는 피하주사할 수 있다. 긴급시에는 심장내 주사한다. ① IV infusion : 1-2mg 을 D5W 500ml 에 희석하여 0.5-5 μg/분으로 투여 ② IV bolus : 초기량은 0.2mg 을 D5W 또는 N/S 10ml 에 희석후 서서히 IV ③ IM, SC : 0.2mg(1ml) ④ IC : 0.02mg 를 심장내 주사 ◆ 소아용량 초기량 : 0.1mcg/kg/min (최대: 0.08-1.7mcg/kg/min)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : β_1, β_2 receptor agonist 로서 기관지, GI, 자궁평활근 이완시키고 심장에서 심박동수·수축력 증가, 말초에서 혈관수축 ◆ 부작용 : 빈맥, 부정맥, 저혈압, 심계항진, 협심증, 현훈, 오심, 진전, 흥분, 구토, 두통, 안면홍조, 창백, 신경과민, 발한, 빈맥 ◆ 금기 : Digitalis 중독, 갑상선기능 항진증, 중증 신질환, 중증 고혈압환자, 빈맥성부정맥, 비후성심근병증, 협심증 ◆ 상호작용 ① Epinephrine 과 병용시 부정맥 또는 심정지 유발 ② MAOI 나 TCA 병용시 이 약의 약효 증강 ◆ 주의 ① K^+저하 가능: Xanthine 계, Steroid 계, 이뇨제와 병용시 심화 가능 ② $NaHCO_3$(알카리성약들)과 혼합시 홍색-갈색으로 변색 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 차광, ~25 ℃ 보관 ◆ 과량투여시의 처치 ① 과량투여 시 과도한 심박수의 증가를 초래하여 심계항진, 흉부불쾌감, 안면홍조, 발한, 어지러움, 구토, 두통 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량하거나 점적주입 속도를 느리게 한다. ② 처치 : 보통 이 약의 투여를 중지하면 소실, 적당한 해독제는 심장선택성 β-차단제이나 이를 기관지경련의 병력이 있는 환자에 투여 시에는 특히 주의한다. ◆ 적용상의 주의 탄산수소나트륨과 같은 알칼리성 약들과 혼합하면 홍색-갈색으로 변색되고 역가가 감소되므로 혼합하지 않는다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Pulmicort respule	
성분/함량	Budesonide 0.5mg/2ml/A (0.25mg/ml)	부신호르몬제
효능·효과	◆ 기관지 천식(특히 스테로이드 요법의 다른 치료가 불충분하거나 적절치 않은 경우 ◆ 유아와 소아의 급성 후두 기관 기관지염(크룹)의 치료	
용법·용량	◆ 적당한 분무기를 사용하여 투여해야 하며 대부분의 분무기에 적당한 충진용량은 2~4ml 임. ◆ 기관지 천식 1. 흡입 투여시작시 또는 심한 천식기간의 치료요법시 또는 경구 코티코스테로이드를 감량하거나 중단시 ① 성인 : 1회 1~2mg을 1일 2회 ② 소아 : 1회 0.5~1mg을 1일 2회 2. 유지용량 ① 성인 : 1회 0.5~1mg을 1일 2회 ② 소아 : 1회 0.25~0.5mg을 1일 2회 ◆ 급성 후두 기관 기관지염(크룹) : 유소아에서 1회 2mg을 1일 1회	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 국소 부신피질 호르몬제로서 각종 염증반응 과정을 억제 ◆ 부작용 : 인후통, 구강염, 설염, 구갈, 기침, 구강 칸디다염, 쉰목소리, 불안, 초조, 우울, 드물게 기관지 협착 ◆ 금기 : 이 성분에 과민증이 있는 환자 ◆ 주의 ① 폐결핵 환자, 진균 및 바이러스에 의한 기도감염 환자, 스테로이드 의존성 환자에 신중투여 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 ① 실온 보관 ② 알루미늄 호일을 개봉한 상태에서는 3개월 동안 유효 ◆ 과량투여시의 처치 ① 이 약을 과량 일시 투여하더라도 일반적으로 뚜렷한 임상적 증상이 유발되지 않지만 혈중 코티졸 농도가 감소되고 순환 호중구수가 증가되며 백혈구 및 호산구수는 감소하였다. ② 습관적으로 과용량을 복용하게 되면 부신피질 기능항진과 HPA-axis의 억제가 유발될 수 있다. ③ 이 때 이 약의 복용을 중단하거나 용량을 감소시킴으로서 HPA-axis의 정상화는 느린 속도로 진행되지만 이와 같은 증상을 없앨 수 있다. ◆ 적용상의 주의 ① 이 약과 같은 흡입스테로이드제의 사용시 구강과 인두에서 칸디다증에 감염될 가능성이 있으므로 매 흡입한 후 물로 입과 얼굴을 세척해야 한다. ② 이 약의 보관 중에 침전물이 생성된 경우, 흔들어서 재현탁되지 않으면 폐기한다. ③ 이 약을 삼키거나 주사해서는 안되며, 분무기를 통해 흡입용으로만 사용해야 한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	**Rocumeron inj**	
성분/함량	Rocuronium Br	**골격근이완제**
효능·효과	◆ 기관 내 삽관을 촉진하고 수술하는 동안 골격근이완을 유도하기 위한 전신마취시의 보조제 ◆ 중환자실(ICU)에서 기관삽관과 기계적 환기를 돕기 위한 보조제	
용법·용량	◆ 기관내 삽관: 0.6mg/kg, 유지량: 0.15mg/kg(흡입마취제를 장시간 사용할 경우: 0.075-0.1mg/kg) ◆ IV Infusion: 개시용량: 0.6mg/kg, 유지량: 정맥주사, 마취하에서 5-10 μg/kg/분,흡입마취하에서 5-6 μg/kg/분 ◆ 노인, 간/담도/신부전 환자의 용량, 기관 삽관 용량: 0.6mg/kg, 유지용량(마취법에 상관없음): 0.07-0.1mg/kg, 주입속도: 5-6 μg/kg/분.	
약리작용	신경 차단에 의한 비탈분극성 근이완 작용	
사용상의 주의사항	◆ 부작용 부정맥, 심전도, 빈맥, 구역, 구토, 천식, 딸국질, 발진, 가려움증, 혈압변동 ◆ 금기 1) 이 약 및 이 약의 구성성분 또는 다른 신경근 차단제에 과민반응 환자 2) 임상의사의 판단에 환자가 성공적으로 기계적 환기를 할 수 없는 경우 3) 중증근무력증, 근무력증후군 환자 ◆ 주의 사항 1) 사용하기 전에 이 약에 알레르기가 있거나 그 밖에 다른 알레르기가 있을 경우. 2) 간/담도 질환과 신부전, 악성고열, 순환시간 연장, 신경근 질환, 저체온증, 비만, 화상, 중증의 전해질 부전 등의 경우 3) 호흡근을 마비시키므로 자발호흡이 회복될 때까지 호흡보조기를 사용해야 함 4) 임부, 수유부 안전성 자료 없음 ◆ 상호 작용 1) 흡입마취제: 이약의 근신경 차단제 활성증가 AG, Vancomycin, TC, Bacitracin, Colistin, 이뇨제, β-blocker,Thiamine, MAOI, Qunidine, α-blocker, Mg 염 2) 항경련제: 근신경차단 지속감소 Neostigmin, Pyridostigmin, Corticosteroid 만성투여, Azathiopurine, Theophylline, CaCl2 ◆ 비고 : 냉장(2-8℃) 보관	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Rotarix prefilled oral vaccine	
성분/함량	Rotavirus, live attenuated 100만 CCID50 1.5ml/Syringe	로타바이러스 감염질환 예방 백신
효능·효과	◆ 생후 6 주 이상의 영아에서 로타바이러스(G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8], G9P[8] 혈청형)에 의한 위장관염의 예방	
용법·용량	◆ 1차: 생후 6주 이후 경구 투여 ◆ 2차: 1차와 최소 4주 간격 두고 생후 16주 이전 경구투여 (최대 생후 24주 이내)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 로타바이러스 혈청형(유아에게 설사감염)에 반응하는 중화항체 유도 ◆ 부작용 : 설사, 고창, 복통, 피부염, 보챔, 장충첩증, 혈변, 위장관염 ◆ 금기 ① 이전에 로타바이러스 백신 접종 후 과민반응을 나타낸 자. ② 장중첩증의 병력이 있는 자. ③ 장중첩증이 일어나기 쉬운 교정되지 않은 선천성 위장관 이상(예. 메켈게실)이 있는 자. ④ 급성 중증 열성 질환자는 이 백신의 투여를 연기함. (경미한 감염(예. 감기)은 투여금기 아님) ⑤ 설사 또는 구토를 하는 경우 이 백신의 투여를 연기하여야 한다. ⑥ 중증혼합면역결핍증(SCID)이 있는 자. ◆ 상호작용 ① 디프테리아, 파상풍 및 백일해 백신(DTPa), 헤모필루스 인플루엔자 b형 백신(Hib), 불활화 폴리오 백신(IPV), B형 간염 백신(HBV) 및 폐렴구균 단백결합 백신, 수막구균 혈청형 C 접합체 백신과 동시 접종 가능 ② 투여 전 후 영아의 식이에 있어 특별한 제한 없음 ◆ 주의 ① 위장관 질환 또는 성장지연이 있는 영아 ② 면역이 결핍된 자와 접촉하는 경우 ③ 면역이 억제된 영아 ◆ 비고 ① 냉장(2~8℃) 및 차광 보관 ② 경구투여용으로만 사용하고 주사용으로 사용하지 말 것 ③ 이 백신으로 1차 투여받은 영아들은 이 백신으로 2차 투여까지 완료할 것을 권장(다른 로타바이러스 백신과 교차투여에 대한 안전성, 면역원성 또는 유효성 자료 없음) ④ 이 백신 투여받은 영아의 분변에서 백신 바이러스 배출되므로(7일경 최고, 평균 10일 동안 지속됨) 접촉하는 사람은 기저귀를 갈 때 위생에 신경쓰도록 함 ⑤ 이 백신은 조산아에게 투여될 수 있으나, 더 낮은 면역반응이 관찰될 수 있으며 임상적 방어 수준이 알려져 있지 않음 ⑥ 영아가 백신 용량 대부분을 뱉거나 토하였을 경우, 동일 방문시점에 1회 대체용량을 추가로 투여 가능 ⑦ 로타바이러스에 노출된 후 예방용으로 이 백신을 투여한 자료는 없음 ⑧ 이 백신을 다른 의약품과 혼합하면 안됨(적합성 시험 자료 없음)	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Rotateq	
성분/함량	Rotavirus vaccine(Live attenuated) 2ml/Tube	로타바이러스 감염질환 예방 백신
효능·효과	◆ 영아에서 G1, G2, G3, G4, G9P1A[8] 혈청형 로타바이러스에 의한 위장관염 예방	
용법·용량	◆ 매 회차에 1튜우브(2ml)를 복용, 총 3차 투여 ◆ 1차 투여는 생후 6-12주, 이후 각 투여간 4-10주의 간격을 두고 추가 투여 ◆ 3차 투여는 생후 32주 초과 금지	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : rotavirus 생백신의 기전은 명확하지는 않으나, 이 백신은 약독화된 생 rotavirus를 함유하고 있으며 소장에서 복제되고 위장관염에 대한 면역력을 증가시켜줌 ◆ 부작용 : 설사, 구토, 중이염, 비인두염, 기관지경련, 장중첩증, 혈변배설, 발작 ◆ 금기 ① 이 약 투여 후 과민반응이 의심되는 영아에게는 추가적인 투여를 실시해서는 안됨. ② 선천성 복부 질환, 복부 수술, 장중첩증의 병력을 가진 영아 ③ 급성 위장관 질환, 만성 설사로 성장지연이 있는 영아 ④ 면역 결핍이 있거나, 의심되는 영아 ⑤ 중증혼합면역결핍증(SCID)이 있는 영아 ◆ 상호작용 ① 방사선 치료, 항대사체, 알킬화제, 세포독성약물 및 고용량의 Corticosteroid 제와 같은 면역억제치료 : 이 약에 대한 면역반응의 감약 가능성 있음 ② 디프테리아 파상풍 toxoid 및 백일해 백신(DTaP), 불활화 소아마비 백신(IPV), 헤모필루스 인플루엔자 b 형 접합백신(Hib), B 형간염백신, 폐렴구균 접합백신과 함께 접종가능 ③ 영아의 음식 또는 음료(모유 포함) 섭취에 있어 특별한 제한없음 ◆ 비고 ① 냉장(2~8℃) 및 차광 보관 ② 경구투여용으로만 사용하고 주사용으로 사용하지 말 것 ③ 열성질환의 경우 이 백신의 투여 연기 가능 ④ Rotavirus에 노출된 이후 이 백신의 예방효과에 대한 임상시험 결과는 없음 ⑤ 조산아에게 태어난 날로부터의 주수에 따라 이 백신을 투여할 수 있는 근거 자료 있음 ⑥ 조절이 가능한 위식도역류병(GERD: GastroEsophageal Reflux Disease)이 있는 영아에게 이 백신을 사용할 수 있음을 뒷받침하는 임상시험 자료 있음 ⑦ 냉장고에서 꺼낸 상태로 25℃ 이하 실온에서 48시간까지 보관 후 투여 가능	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	**Shingrix inj**	
성분/함량	**Recombinant varicella zoster virus glycoprotein E(host cell: CHO-K1, vector: pRIT14427) 50mcg/0.5ml/V**	**백신류**
효능·효과	◆ 대상포진 (HZ; herpes zoster)의 예방 ① 만 50세 이상의 성인 ② 만 18세 이상에서 질병 혹은 치료로 인한 면역저하 또는 면역억제로 인하여 대상포진의 위험이 높거나 높을 것으로 예상되는 사람 (예, 자가조혈모세포이식자, 고형암, 혈액암, 고형장기 이식 환자)	
용법·용량	1회 0.5 mL씩, 2개월 간격으로 총 2회 근육 주사	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용: Varicella-zoster virus 의 재활성화에 의해 유발되는 질환에 대한 능동면역을 자극함으로써 대상포진 및 관련 합병증(예: 대상포진후신경통 (postherpetic neuralgia [PHN]))을 예방 ◆ 임상응용: 대상포진 (HZ; herpes zoster)의 예방 ① 만 50세 이상의 성인 ② 만 18세 이상에서 질병 혹은 치료로 인한 면역저하 또는 면역억제로 인하여 대상포진의 위험이 높거나 높을 것으로 예상되는 사람 (예, 자가조혈모세포이식자, 고형암, 혈액암, 고형장기 이식 환자) ◆ 부작용: 통증, 발적, 종창, 근육통, 피로, 두통, 떨림, 열, 위장관 증상 등 ◆ 금기: 이 백신의 구성 성분에 과민반응이 있는 자 ◆ 상호작용: 다른 백신과 병용 투여 시, 서로 다른 주사부위에 투여 ◆ 신중투여: ① 급성 중증 열성 질환을 앓고 있는 자 ② 혈소판 감소증이나 다른 혈액응고장애가 있는 환자(근육주사 시 출혈이 일어날 수 있으므로 주의) ◆ 비고: ① 냉장(2-8°C), 차광보관 ② 재구성한 백신은 신속하게 사용. 만약 신속히 사용하는 것이 불가능하다면 냉장 (2-8°C) 보관하고, 재구성 후 6시간 이내에 사용되지 않은 백신은 폐기	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Sigmart inj	
성분/함량	Nicorandil 48mg/V	협심증 치료제
효능·효과	불안정형 협심증 치료제	
용법·용량	◆ 개시용량 : 2mg/hr IV infusion (최대용량 : 6mg/hr) ◆ NS, D5W 에 용해하여 0.01-0.03% 용액이 되도록 함	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 관상혈관을 선택적으로 확장시키면서 심박수, 심근수축력에 대해 영향이 거의 없음 ◆ 부작용 : 간기능 장애, 황달, 혈소판 감소, 혈압저하, 심박수 증가, 두통, 현기증, 손발저림, 구역, 구토, 상복부 불쾌감, AST/ALT 상승, 빈혈, 혈소판 감소증, 혀의 마비 ◆ 금기 ① 중증의 간기능, 신기능 장애 환자 ② 중증의 뇌기능 장애 환자 ③ 중증의 저혈압 또는 심인성 쇽이 있는 환자 ④ Eisenmenger 증후군 또는 원발성 폐고혈압증 환자 ⑤ 우심실경색 환자 ⑥ 신경 순환 무력증 환자 ⑦ 협우각 녹내장 환자 ⑧ 이 약 또는 질산·아질산 에스테르계 약물에 대한 과민증의 병력이 있는 환자 ⑨ 포스포디에스테라제-5(PDE-5) 저해작용이 있는 약물을 투여중인 환자 ◆ 상호작용 ① 다른 혈관 확장제, 삼환계 항우울제 및 알코올의 혈압강하작용을 증강시킬 수 있음 ② 포스포디에스테라제-5(PDE-5) 저해작용이 있는 약물과 함께 투여할 수 없음 ◆ 주의 : 저혈압, 간신기능장애, 급성 폐부종에는 신중투여 ◆ 비고 : 밀봉용기, 10℃ 이하보관	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Sky Varicella inj	
성분/함량	Attenuated live Varicella virus 2,400PFU/0.5ml/V	수두 예방 백신
효능·효과	◆ 생후 12 개월~만 12 세 소아에서 수두의 예방	
용법·용량	◆ 첨부된 용제에 용해하여 0.5ml를 1회 SC	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 약독화 된 Oka 균주인 수두대상포진바이러스(Varicella-Zoster Virus, Oka/SK strain)로 만들어진 약독화 수두 생바이러스 백신 ◆ 부작용 : 고열(>38℃), 발열, 주사부위 후유증, 피부발진, 복통, 구토, 기침, 인후통, 설사, 오심, 메스꺼움, 코 울혈, 관절통 등 ◆ 금기 ① IV, IM 불가 ② 임부, 임신 가능성이 있는 여성 ③ 네오마이신에 의해 아나필락시스(유사반응)의 병력이 있는 자 ④ 급성 및 만성 백혈병, 림프종 또는 골수/림프계에 영향을 미치는 기타 상황, HIV/AIDS에 의한 면역억제, 세포성 면역결핍 ⑤ 면역억제요법을 받고 있는 환자 ⑥ 치료되지 않은 활동성 결핵 환자 ⑦ 열성 호흡기 질환 또는 다른 열성 감염증 환자 ◆ 비고 ① [임부금기] 1 등급(보건복지부 고시) ② 차광, 냉장보관(2-8℃) ③ 조제 후 즉시 투여, 용해 후 30분이내 사용하지 않은 약은 폐기	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	**Sodium bicarbonate inj**	
성분/함량	**Sodium bicarbonate 20mEq/20ml/A**	**전해질제**
효능·효과	산증(아시도시스), 급성두드러기	
용법·용량	◆ 성인 ① acidosis 시 : 1 회 1-5g(12-60mEq)씩 IV ※ 필요량(mEq) = 부족 염기량(Base deficit mEq(L) × 0.2 × 체중(kg) ② 심정지 - 초기 1mEq/kg/dose → 0.5mEq/kg/kg/dose 매 10 분당 반복 - 충분한 alveolar ventilation 과 cardiac compression 이 이뤄져야 함	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Sodium bicarbonate 1g 은 1/10N HCl 120ml 를 중화하여(산반동 있음) 혈액과 뇨의 pH 를 상승시킴 ◆ 임상응용 ① 경구: 위 십이지장궤양, 위염, 위산과다, 산증의 개선 ② 주사: 산증, 급성 두드러기 ③ 투석액: 급 만성 신부전환자 및 유독물 해독을 위한 혈액투석액 조제 ◆ 부작용 : 지각이상, 발열, 빈혈, 서맥, 대사성 Alkalosis, Na^+ 정체에 의한 부종, 저 K^+혈증, 혈액응고시간 연장, 경련, 강직, 저혈압, 쇽 ◆ 금기 ① 신장병, 방광결석, 위장출혈, 고혈압, 전해질 불균형, 탈수, 저 Cl 혈증, Alkalosis 야기성 이뇨제 투여중, 울혈성 심부전, 저칼슘혈증, 호흡저하상태 ② Na^+섭취 제한자: 고 Na^+혈증, 부종, 임신중독증, 방광결석, 고혈압, ◆ 배합금기 : Ca^{2+} 함유제제와 침전생성 ◆ 상호작용 ① 우유, Ca^{2+}제제: 우유 alkali 증후군 (고 Ca^{2+}혈증, 고질소혈증, alkalosis) ② TC, Salicylate, Lithium, Chlorpropamide 의 clearance 증가 ③ Quinidine, Amphetamine, Ephedrine, Pseudoephedrine 의 clearance 감소 ◆ 주의 ① 임신중독증, 저칼슘혈증, 저칼륨혈증, 신생아, CHF, 부종 또는 Na 정체, 감뇨증, 무뇨증에는 신중투여 ② 투석액: 주사나 복막관류 사용 금지 ◆ 비고 ① Na^+ : 459.8mg(=20mEq)/앰플 ②HCO_3^- : 1,220.2mg(=20mEq)/앰플 ③ 1g = 11.9mEq ◆ 과량투여시의 처치 : 이 약의 투여를 중지하고, 알칼로시스의 정도에 따라 처치한다. 호기재호흡을 시키고 생리식염주사액을 정맥투여할 수 있다. 저칼륨증이 있으면 염화칼륨을 투여할 수도 있다. 특히 강직이나 과다흥분이 수반되는 중증 알칼리증에는 글루콘산칼슘으로 처치할 수 있다. 간질환자를 제외한 중증 알칼리증에는 산성화제(예 : 2.14%염화암모늄)가 주입될 수 있다.	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Stamaril inj	
성분/함량	Attenuated yellow fever live virus 17D(AB237주) 0.5ml/V	황열 예방 백신
효능·효과	9 개월 이상의 소아 및 성인에서 황열병의 예방 [백신 접종 권장 대상자] - 해당질환의 풍토병이 발생하는 지역을 통과하는 여행자 및 거주자 - 해당백신의 접종을 필요로 하는 국가로의 여행자(이전 여행지에 따라 달라질 수 있음) - 감염 가능성이 있는 물질을 취급하는자(예. 실험실 종사자	
용법·용량	◆ 9 개월 이상의 소아 및 성인 1 회용량인 0.5mL 을 SC, 필요시 IM. 근육주사시 6 개월~2 세 유아 및 소아의 경우 대퇴부 전외측면, 2 세 이상 소아 및 성인의 경우 삼각근에 접종한다. 안전한 보호면역을 획득하기 위해, 풍토병 지역에 들어가기 최소 10 일 전에 본 제품을 접종하여야 한다. ◆ 노인 접종량은 성인과 동일 ◆ 재접종 고위험군에 한하여, 10 년 간격으로 초회접종과 동일한 용량으로 접종이 가능	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 바이러스백신(Yellow fever vaccine) - 황열 감염에 대해 거의 100%의 효과적인 면역반응률로 능동면역을 가능하게 하는 생백신이다. ◆ 부작용 : 두통, 통증, 홍반증, 혈종, 경결, 팽윤, 메스꺼움, 설사, 구토, 근육통, 발열, 무력증 ◆ 금기 1) 달걀이나 이 약의 성분에 과민한 자 2) 다음의 원인에 의한 면역 억제 상태 선천성, 특발성, 전신적 스테로이드 처치, 방사선 치료 또는 세포독성 약물투여 3) 흉선 기능 장애 병력이 있는 자 4) 증상이 있는 HIV 감염자, 면역 기능의 손상이 확인된 무증상 HIV 감염자 5) 6 개월 미만의 영아 6) 심한 발열 상태 7) 희귀한 유전성 과당불내성 환자 ◆ 상호작용 1) 동시에 다른 백신을 접종해야 할 때에는, 각 백신을 다른 접종 부위에 주사한다 2) 공식 권고 사항이 있을 경우, 홍역 백신과 동시에 접종될 수 있다. 3) 이 약은 장티푸스 Vi 캡슐형 다당류를 함유한 백신 및/또는 불활화 A 형 간염 바이러스를 함유한 백신과 동시에 접종될 수 있다. 4) 면역 억제 치료를 받고 있는 자에게는 접종되어서는 안 된다 (ex, 세포독성 약물, 표준 함량보다 많은 국소 혹은 흡입 스테로이드 등 ◆ 주의 1) 매우 드물게 백신과 관련된 향신경질환이 보고된 바 있다. 2) 매우 드물게 백신과 관련된, 야생형 바이러스에 의한 전격성 감염과 비슷한, 향내장질환이보고된 바 있다. 3) 면역억제 상태가 일시적인 경우, 면역력이 회복될 때 까지 백신 접종을 연기한다. 14 일 또는 그 이상의 기간 동안 전신적 코르티코스테로이드를 처치 받은 환자는 처치 후 최소 한달 이후에 백신을 접종 받을 것을 권장한다. ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

	1) 2℃~8℃ 냉장 상태에서 보관한다. 2) 차광상태를 유지하기 위해 박스 내에 보관한다. ◆ 적용상의 주의 1) 바늘이 부착되어있지 않은 주사기의 경우, 주사기 끝부분 캡을 제거한 후, 바늘을 단단하게 주사기 끝에 고정하고, 90˚ 회전시켜 고정여부를 확인한다. 2) 동결건조 약물이 함유된 바이알에 주사기에 들어있는 희석액을 넣어 녹인다. 3) 바이알을 흔들어 완전히 용해한 후에 현탁액을 다시 주사기로 흡입한다. 4) 접종전 희석한 백신을 충분히 흔들고 즉시 사용한다. 5) 소독제는 바이러스를 불활성화시킬 수 있기 때문에 접촉을 피한다. 6) 미사용 제품 혹은 폐기물은 가열 또는 소각로를 이용하여 폐기한다.

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Steritalc powder	
성분/함량	4g/Btl	Scleriding agent
효능·효과	◆ 악성 흉막삼출의 재발방지	
용법·용량	◆ 본제 5g을 0.9% NaCl 주사액 50~100ml에 현탁하여 사용한다.	
사용상의 주의사항	◆ 다음 환자에는 투여하지 말 것. 전신 치료가 더 적합하며 치료 가능한 악성종양 환자 ◆ 이상반응 1) 드물게 농흉이 발생하였다. 2) 드물게 폐렴, 급성호흡곤란증후군, 호흡곤란, 기관지흉막루, 객혈 및 폐색전증이 보고되었다. 3) 드물게 빈맥, 심근경색, 저혈압, 저혈량증, 수술 및/또는 마취와 관련된 무수축 심장마비가 보고되었다. 4) 흉관삽관술 또는 흉강경검사 부위의 감염, 국소 출혈 및 피하 농흉이 발생하였다. ◆ 상호작용 탤크 흉막유착술 후에 탤크의 흡수성으로 인해 두 번째 경화제의 효과가 감소하는지 여부는 알려지지 않았다. ◆ 임부에 대한 투여 이 약에 대해 임부를 대상으로 실시한 임상 시험은 없다. 토끼에게 탤크 900mg/kg(사람에서 mg/m2을 기준으로 약 5배 높은 용량)을 경구 투여했을 때 최기형성 독성은 나타나지 않았다. 그러나 동물에서의 생식·발생독성시험 결과로부터 사람에서의 결과를 항상 예측할 수 없으므로 임부에게 이 약이 반드시 필요한 경우가 아니라면 투여해서는 안된다. ◆ 적용상의 주의 1) 현탁액 조제 - 적절한 기류식 무균 실험대에서 아래 순서에 따라 탤크 현탁액을 조제한다. - 단계 1: 16 게이지 바늘이 부착된 60mL 주사기를 사용하여 0.9% 염화나트륨 주사액 50mL를 취하고 탤크가 들어있는 병에 이를 천천히 주입한다. - 단계 2: 탤크 가루가 확산되도록 병을 잘 흔든다. - 단계 3: 병을 계속 흔들면서 16 게이지 바늘이 부착된 60mL 주사기 2개에 각각 현탁액 25mL씩 나누어 담는다. 각 주사기에 0.9% 염화나트륨 주사액을 넣어 전체 용량이 50mL가 되도록 한다. 그런 다음 각 주사기를 60mL 표시점까지 당겨 공기 10mL를 주입하여 투여 전에 혼합할 수 있는 공간을 마련한다. 각 주사기에는 0.9% 염화나트륨 주사액 50mL에 현탁된 탤크 2.5g과 공기 10mL로 형성된 공간을 포함한다. - 단계 4: 주사기에 탤크 농도 및 사용기한을 명시하고 환자용이라는 라벨과 함께 다음 문구를 부착한다. "투여 전에 현탁액이 잘 섞일 수 있도록 주사기를 잘 흔들어줄 것" "흉막유착술에만 사용하고 정맥주사로는 사용하지 않음" 2) 투여 탤크가 가라앉지 않고 고르게 재확산될 수 있도록 투여 전에 지속적으로 주사기를 흔든다. 투여 직전에 각 주사기의 공기 10mL를 배출한다. 표준 절차에 따라 흉관을 통해 탤크 현탁액을 투여한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	**Suduvax inj**	
성분/함량	**Attenuated live Varicella virus 0.5ml/V**	**수두 백신**
효능·효과	◆ 수두의 예방	
용법·용량	◆ 첨부된 용해액으로 용해하여 보통 0.5ml 를 1회 피하주사 (접종 부위 : 보통 상완외측)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 수두 바이러스 생백신은 수두 항체 및 수두 감염으로부터 능동면역을 형성하는 세포-매개 면역반응 유도 ◆ 부작용 : 발열, 발진, 접종 부위의 발적, 종창, 경결 등 ◆ 태아위험도 : 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 자에 투여하지 말 것 ◆ 비고 : 냉장(2~8℃) 및 차광 보관0617 ◆ 적용상의 주의 ① 접종 직전에 첨부된 용해액으로 용해하여 즉시 사용할 것	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Sugaone inj	
성분/함량	Sugammadex Na 200mg/V	자율신경제
효능·효과	◆ Rocuronium 또는 Vecuronium 에 의해 유도된 신경근 차단의 역전	
용법·용량	◆ 이 약은 정맥주사(Bolus)로 단회 투여 ◆ 성인 1) 일반적인 역전 - 신경근 차단 상태로부터 강직 후 연축반응수가 1~2회 나타날 때 : 1회 4mg/kg IV - 자발적 회복에 접어들었을 때 : 1회 2mg/kg IV 2) Rocuronium 투여 후 신속한 역전 : Rocuronium 투여 3분 후 이 약 16mg/kg 1회 IV 3) 이 약 투여 후 Rocuronium 또는 Vecuronium 재투여 : 이 약(최고 4mg/kg) 투여 후 재투여 대기 시간은 다음과 같음	

대기시간	투여 용량
5 분	Rocuronium 1.2 mg/kg
4 시간	Rocuronium 0.6 mg/kg 또는 Vecuronium 0.1 mg/kg

사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Rocuronium, Vecuronium 과 복합체를 형성하여 neuromuscular junction에 있는 nicotinic receptor에 결합할 수 있는 neuromuscular-blocking agent의 양을 감소시켜 rocuronium, vecuronium에 의해 유도된 neuromuscular blockade 역전 시킴 ◆ 부작용 : 과민반응(아나필락시스, 홍조, 두드러기, 홍반성 발진, 중증의 저혈압, 빈맥, 혀부종, 인두부종 등), 마취 합병증(마취처치 또는 수술 중 사지 또는 몸의 움직임, 기침, 찡그림 등), 마취 동안 원하지 않는 각성상태 등 ◆ 금기 : 이 성분에 과민증이 있는 환자 ◆ 상호작용 ① Toremifen : 신경근 차단 상태에서 회복의 지연 또는 신경근 차단의 재발 나타날 수 있음 ② 경구용 호르몬성 피임제 : 피임제의 유효성이 감소할 수 있음 ③ Fusidic acid: 수술 전 정맥 투여 시 신경근차단 회복되는 시간이 지연될 수 있다. ◆ 비고 ① 차광 보관 ② 2~30℃ 보관 ③ 희석 후 2~25℃ 안정성은 48시간동안 유지 ◆ 과량투여시의 처치 : 고유량(high-flux) 혈액 투석법으로 제거 가능 ◆ 적용상의 주의 ① 0.9% 염화나트륨용액, 5% 포도당용액, 0.45% 염화나트륨용액 및 2.5% 포도당용액, 유산화링거액 (Ringer's lactate solution), 링거액, 5% 포도당과 0.9% 염화나트륨 혼합 용액 이 주입되고 있는 라인을 통해 이 약을 투여할 수 있음 ② ① 의 약을 제외한 다른 약과 혼합되어서는 안됨 ③ Verapamil, Ondansetron, Ranitidine 과의 물리적 배합금기 보고됨

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Tagamet inj	
성분/함량	Cimetidine 200mg/2ml/A	소화성궤양치료제
효능·효과	위·십이지장궤양, 역류성식도염, 졸링거-엘리슨증후군), 재발성궤양, 상부소화관출혈(소화성궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성위염에 의한	
용법·용량	◆ 성인 : 1 회 200mg 을 4-6 시간마다 IV, IV infusion (2 시간동안 최대: 2g/일) ◆ 소아용량 : 20-40mg/kg/일을 분할 IV	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 위의 벽세포에서 H_2 수용체 길항작용 ◆ 부작용 : 과립구 감소증, 무과립구증, 혈소판 감소증, 재생불량성 빈혈, 황달, 감염, 발진,변비, 설사, 복부팽만감, 두통, 경련, 사지저림, 서맥, 발열, 배뇨곤란, Stevens-Johnson syndrome, 표피괴사, 다형홍반, 근육통, 췌장염, 탈모, 범혈구감소, AST□ALT↑, 간질성경련, 급성신부전, 여성형유방 ◆ 금기 ① 시메티딘 또는 이 약의 다른성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자 ② 도페틸라이드를 투여하고 있는 환자 : 심실성 부정맥(torsades de pointes 를 포함)의 위험을 증가시킴 ◆ 상호작용 : Coumadin 계 항응고제, Midazolam, Diazepam, Chlordiazepoxide, Propranolol, Theophylline, Phenytoin, Lidocaine, Nifedipine, Imipramine, Erythromycin, Procainamide, Metronidazole, 삼환계 항우울약 등의 대사□배설을 지연시켜 혈중농도를 높인다는 보고가 있으므로 병용시 신중히 투여 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 ① 최대주입속도 150mg/hr 또는 2mg/kg/hr ② 계속주입시 24 시간 동안의 평균 주입속도<75mg/hr ◆ 주의 ① 신장애 환자(혈중 농도가 지속되므로 투여량을 감소하거나 투여간격을 두고 사용한다) ② 간장애 환자 ③ 약물 과민증의 병력이 있는 환자 ④ 고령자 ◆ 과량투여시의 처치 : 1 회 10g 또는 20g 까지 과량투여한 보고가 있으나, 중대한 영향은 보이지 않았다. 이러한 경우에 있어서도 최토, 위세척 등과 동시에 적절한 요법을 실시한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Tambocor inj	
성분/함량	Flecainide acetate 150mg/15ml/A	부정맥용제
효능·효과	◆ 심방 급성부정맥(상심실성 빈맥)의 치료 및 재발 방지 ◆ 생명이 위험하거나 다른 형태의 치료에 반응하지 않는 경우, 심실 급성부정맥(심실 빈맥)의 치료 및 재발 방지	
용법·용량	◆ 정맥주사(Bolus): 1mg/kg 을 천천히 주사(최소 5 분이상) 필요시, 5%포도당용액에 희석하여 mini infusion 가능 ◆ 점적정맥주입: 2mg/kg(30 분 이상), 다음의 투여속도가 권장 ① 최초 1 시간: 시간당 1.5mg/kg → 이후: 시간당 0.1~0.25mg/kg(주입시간: 24 시간을 넘지않음) ② 최대 누적용량: 24 시간 이내 투여량 400mg ③ 신장애환자(CLcr 35 ml/min/1.73m2 미만): 50% 감량	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 Class I-C 항부정맥 약물로서 심근의 전도를 억제함으로써(His-Purkinje system 에 효과가 가장 큼) 항부정맥 효과 ◆ 부작용 : 시각장애, 시력장애, 가슴 통증, 두드러기, 심실빈맥, 황달, 구토 ◆ 금기 : 동기능부전증후군, 중증의 자극전도장애[방실블록(2, 3 도), 각블록, 말초블록, 동방블록], 현저한 서맥 환자, 심근경색후 무증후성 심실성기외수축, 비지속성 심실빈맥 환자, 임부, 장기지속성 심방세동 환자 ◆ 상호작용 ① Terfenadine, Astemizole: QT 연장, 심실성 부정맥 유발 ② Ritonavir,Lopinavir,Indinavir: 이 약의 혈장농도 상승 ③ Class I 부정맥제, 타 나트륨 채널 차단제(항부정맥제): 심장에 대한 부작용 위험 증가 ④ Digoxin 의 혈중 농도 상승 ⑤ Amiodarone: 이 약의 혈장 농도 상승→이 약 감량 ⑥ Cimetidine,Fluoxetine: 이 약의 혈장농도 상승 ⑦ 항전간제(Phenytoin,Phenobarbital,Carbamazepine): 이 약의 배설속도 30% 증가 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 주사 → 경구는 가능한 빠른 시일내 전환 ② 장기간 탬보코 주사치료가 필요한 경우: 1-2mg/kg, 8-12 시간 간격을 두고 천천히 주사 ◆ 주의 ① 전해질 균형의 이상이 있는 경우 ② 느린 심박수 또는 심한 저혈압이 있는 경우 ③ 심박출량의 현저한 저하가 있는 경우 ④ 간 기능 또는 신장 기능의 장애가 있는 경우 ⑤ 지속적으로 또는 일시적으로 심박 조율기를 착용한 경우	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Tamceton inj	
성분/함량	Triamcinolone acetonide	부신호르몬제
함량/단위	40mg/1ml/V	50mg/5ml/V
효능·효과	◆ 관절내 주사 (관절강내 또는 점액낭내 주사 및 건초내 주사) : 골관절염의 활막염, 류마티스양 관절염, 급성·아급성 점액낭염, 급성 통풍성 관절염, 상과염, 급성·비특이성 건초염, 외상 후 골관절염 ◆ 근육주사 : 내분비계 장애, 류마티스성 장애, 교원성 질환, 피부과 질환, 알레르기 질환,, 안과 질환, 위장관 질환, 혈액 질환 등 ◆ 피내주사 : 원형탈모증(악성에 한함), 편평태선(악성에 한함), 조기켈로이드	
용법·용량	◆ 성인 ① IM : 초기량은 40mg, 1-2 주 이상간격으로 20-80mg 내에서 조절 ② 관절강, 연조직, 활액낭 내 주사 : 1 회 2-40mg, 2 주이상 간격 증감ㄷ. 국소 피내주사: 1 회 0.2-1mg 씩 주 1 회 (최대 : 10mg) ◆ 소아용량 (6-12 세) : 초기량 40mg 투여 후 증상, 몸무게, 연령에 따라 조절	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 항염증 작용, 항알러지 작용 ◆ 부작용 : 체액 및 전해질 장애, 근골격장애, 위천공 및 출혈, 상처치유 장애, 다한, 자반병, 색소침착, 월경불순, Cushing's syndrome, 소아성장억제, 당뇨병, 녹내장, 안구돌출, 혈전색전증, 다모, 구강 칸디다증, 백혈구증가, 혈전증 ◆ 금기 : 전신진균감염환자, 혈소판 감소성 자반병 환자, 상처치유지연, 입주위 피부염 환자, 단순포진, 대상포진, 수두, 관절강내 점액낭내 건초내 감염증이 있는 환자, 관절강내가 불안정한 환자 ◆ 주의 : CHF, 당뇨, 만성 신부전, 감염성 질환, 갑상선기능저하, 중증근무력증, 간경변, 소화성궤양, 정신병, 결핵성질환, 단순포진성 각막염, 후낭 백내장, 녹내장, 고혈압, 전해질이상, 혈전증, 골다공증, 중증근무력증 환자, 급성 심근경색을 일으켰던 환자는 신중투여 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 차광보관 ◆ 적용상의 주의사항 : 이 약은 현탁액제이므로 정맥주사하지 않는다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	TD vaccine inj	
성분/함량	Tetanus toxoid, Diphtheria toxoid 0.5ml/Syringe	Td 백신
효능·효과	◆ 디프테리아, 파상풍의 예방	
용법·용량	◆ 근육주사 (단, 특별한 경우(예: 출혈체질) 피하주사도 가능) ◆ 첫 예방접종 (대상 : 영·유아시기의 기초접종에 대한 명확한 기억이 없거나, 면역 접종을 하지 않은 사람) - 총 3회 접종 : 1차 접종 (7세 이상부터), 1차 접종 후 4~6주 경과 후, 2차 접종 후 6~12개월 경과 후 각각 0.5ml 씩 - 본제는 영·유아에 대한 기조 접종에 해당되지 않으므로, 영·유아시기의 표준 접종은 소아용 DTaP로 할 것 ◆ 재접종 (대상 : 영·유아시절 기초접종을 일정대로 모두 접종한 사람) - 만 10~12세 사이 0.5ml → 이후 매 10년 마다 0.5ml ◆ 상처 발생 시 파상풍 예방접종 ① 파상풍에 대한 과거 면역접종을 다 실시하고, 최근 접종이 다음과 같이 경과했을 경우, - 접종 후 5년까지 : 즉시 접종할 필요 없음 - 5~10년 경과시 : 본제 0.5ml - 10년 이상 경과시 : 본제 0.5ml + 파상풍 면역글로불린 250IU ② 면역이 결핍되거나 면역억제제 치료중인 환자는 백신접종의 예방효과가 불확실할 수 있어서 이러한 환자에 상처가 생겼을 경우에는 파상풍 면역글로불린을 동시에 접종 ※접종방법: 혈관에 직접 투여하지 말 것, 사용 전에 흔들어서 사용할 것	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 ① Diphtheria toxoid : diphtheria의 발생 위험성 감소 및 diphtheria toxin에 대한 중화 항체 형성을 유도 ② Tetanus toxoid : tetanus toxin에 대한 중화 항체의 형성을 자극 ◆ 부작용 : 주사부위의 통증, 발적, 저린감, 발열 등 ◆ 금기 : 급성질환에 걸려 치료가 필요한 환자는 회복 후 최소 2주가 경과할 때까지(예외: 상처 발생시), 과거에 디프테리아나 파상풍 접종에 의해 일시적인 혈소판 감소증이나 신경학적 합병증이 일어났던 일이 있는 자, 접종 후 합병증이 일어난 자, 백신성분 중 심각한 알레르기의 병력이 있는 자, 과거에 디프테리아 백신이나, 파상풍 백신, 디프테리아-파상풍 혼합 백신에 의해 부작용이 발생한 자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 냉장 보관(2~8℃) ◆ 적용상의 주의 ① 이 약은 현탁액이므로 잘 흔들어 균등하게 한 후 사용할 것 ② 투여 전 냉장고에서 꺼내 실온으로 한 다음 잘 흔들어서 접종	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Tetraxim inj	
성분/함량	**Diphtheria toxoid 30IU,** **Tetanus toxoid 40IU,** **Pertussis toxoid 25㎍,** **Inactivated polio virus types Ⅰ, Ⅱ & Ⅲ(40IU, 8IU, 32IU), Filamentous hemagglutinin 25μg 0.5ml/Syringe**	**DPT + Polio 백신**
효능·효과	◆ 디프테리아, 파상풍, 백일해 및 폴리오(소아마비) 예방	
용법·용량	◆ 근육주사 (주사부위 : 2세 미만 - 대퇴부의 전외부, 5세 이상 – 삼각근) ◆ 기초접종 : 1회 용량 0.5ml 씩 생후 2, 4, 6 개월에 3회 접종 ◆ 추가접종 : 4~6세에 1회 0.5ml 을 접종	
사용상의 주의사항	◆ 부작용 : 주사부위의 딱딱해짐, 부종, 홍반, 발열, 설사, 구토, 졸음, 식욕감퇴, 수면장애, 신경과민 등 ◆ 금기 : 백신 성분이나 백일해 백신에 알러지 반응 있는 경우, 진행성 뇌병증 (뇌병변)을 앓고 있는 경우, 이전에 백일해 백신 접종 후 7일 이내 뇌병증 (뇌병변)이 있던 경우, 발열 또는 급성 질환을 앓고 있는 자 ◆ 태아위험도 : 본제는 성인에 접종하기 않기 때문에 임부 투여에 대한 적절한 연구결과가 없음 ◆ 비고 : 냉장(2~8℃) 및 차광 보관 ◆ 적용상의 주의 ① 이 약은 현탁액이므로 투여 전 잘 흔들어 균질한 상태로 만든 후 사용할 것	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Thrombin Reyon	
성분/함량	Thrombin 5000unit/V	지혈제
효능·효과	◆ 통상의 결찰에 의해 지혈이 곤란한 소혈관, 모세혈관 및 실질장기에서의 출혈(예를 들면 외상에 수반하는 출혈, 수술중의 출혈, 골성출혈, 방광출혈, 발치후의 출혈, 비출혈 및 상부소화관에서의 출혈 등)	
용법·용량	◆ 통상 국소 출혈 부위에 생리식염액으로 녹인 용액(Thrombin으로서 50~1000unit/ml)을 분무, 관주 또는 분말 그대로 산포 ◆ 상부소화관 출혈의 경우 적당한 완충제로 녹인 용액(Thrombin으로서 200~400unit/ml)을 경구 투여 출혈부위 및 정도에 따라 적절히 증감	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 직접적으로 혈액의 fibrinogen 을 즉시 응고시키는 protein substance 임 (fibrinogen을 fibrin으로 전환시키는 highly specific protease 임) ◆ 부작용 : 쇽(호흡곤란, 청색증, 혈압강하 등), 응고이상, 이상출혈, 과민반응(발진, 발열, 두드러기, 가려움증, 부종 등), 구역, 구토, 두통 등 ◆ 금기 : 이 약 또는 소에서 유래된 모든 부분이나 물질에 과민반응 병력이 있는 환자, 응고촉진제, 항플라스민제, 아프로티닌제제를 투여 중인 환자 ◆ 상호작용 ① 응고촉진제(장기추출제제, 사독제제), 항플라스민제(아미노카프론산, 트라넥사민산), 아프로티닌제제 : 이 약과 병용시 혈전형성경향이 나타날 수 있으므로 병용하지 않음 ② 산화제(요오드, 과산화수소 등), 단백변성제(알코올 등), 중금속 함유 물질(치메로살 등) : 이 약의 효능 감소 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 냉장(2~8℃) 보관 ◆ 적용상의 주의 ① 용액으로서 국소에 사용 시 혈관 내로 들어가지 않도록 주의할 것 ② 상부소화관 출혈에 사용하는 경우 사용 전 위내 PH를 완충제 등으로 조절 (예) 이 약을 경구투여하기 전 약 50ml의 우유를 투여하고, 5분 후에 Thrombin 10000~20000unit을 약 50ml 우유에 용해하여 경구투여, 우유 대신 인산완충액 등도 이용 가능) ③ 조제 후 가능한 신속히 사용	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Toburex inj	doBUTAmine premix inj
성분/함량	Dobutamine HCl 250mg/5ml/A	Dobutamine HCl 500mg. Dextrose 12.5g /250ml/Bag
효능·효과	심장질환이나 심장수술로 인해 수축력이 저하된 심부전증의 단기 치료시 심박출력 증가	
용법·용량	2.5-10mcg/kg/분의 속도로 IV infusion(최대용량: 40mcg/kg/분)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : β_1 효능작용에 의해 cAMP 증가로 세포내 Ca^{2+}유리의 증가 → 수축력 증가 ◆ 임상응용 : 수축력이 저하된 심부전증 환자의 단기 치료요법을 위한 심박출력 증가 목적으로 사용 ◆ 부작용 : 두통, 오심, 심계항진, 숨가쁨, 복부통, 구역, 심실부정맥, 부정빈맥, 느린맥, 고혈압, 협심증, 신경과민, 호흡곤란 ◆ 금기 : 특발성 비후성 대동맥판하 협착증을 가진 환자, 교착성 심낭염, 심막압전환자 ◆ 상호작용 ① NTG, Nitroprusside 병용시 심박출량이 높아짐 ② ACEI: 심박출량증가 ③ β-blocker : 이 약 작용 감소 ◆ 배합금기 : Sodium bicarbonate, Acyclovir, Aminophylline, Ca gluconate, Diazepam, Digoxin, Furosemide, Insulin, $MgSO_4$, Phenytoin, Doxapram, Vit. K_1, MAOI ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ①앰플 희석용액 : D5W, D10W, DS, A-fluid, H/S, N/S ②희석 및 개봉 후 24 시간내 사용 ③ Premix : Alkali 용액(Na_2SO_4, Ethanol 함유제)과 희석하지 말 것 ◆ 적용상의 주의 ① 점적 정맥주사로만 투여한다. ② 혈관외로 흐를 경우에는 주사부위를 중심으로 발적, 종창 또는 괴사를 일으킬 수 있으므로 신중히 투여한다. ③ 5% 탄산수소나트륨 및 다른 강알칼리액에 희석하여 사용하지 않으며 또한 황산나트륨 또는 에탄올을 포함하는 다른 약이나 희석액과 혼합하지 않는다. ④ 정맥주사용액은 24 시간 이내에 사용한다. 이 약을 포함하는 용액은 분홍색을 나타낼 수 있으며 시간에 따라 색의 농도가 진해질 수 있다. 이 색의 변화는 약물이 약간 산화되었기 때문이며 위 조제시간동안에는 역가의 손실이 없다. ◆ 과량투여시의 처치 과량투여시 혈압의 과도한 변화나 빈맥이 나타날 수 있으므로 환자의 상태가 안정될 때까지 감량하거나 일시적으로 투여를 중단한다. 이 약은 작용시간이 짧으므로 일반적으로 부가치료수단은 필요하지 않다	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	**Tranexamic acid inj**	
성분/함량	**Tranexamic acid 500mg/A**	**지혈제**
효능·효과	◆ 전신적 섬유소용해항진과 관련있다고 생각되는 출혈 경향 (백혈병, 재생불량성 빈혈, 자반병, 암 등 및 수술 중·수술 후의 이상 출혈) ◆ 국소적 섬유소용해항진과 관련있다고 생각되는 이상출혈 (폐출혈, 성기출혈, 신출혈, 전립선 수술 중·수술 후의 이상 출혈)	
용법·용량	◆ 경구: 1 회 1-2 캅셀을 3-4 회/일 ◆ 주사: ① 250-500mg/일을 1-2 회 분할투여 IV, IM ② 수술중이나 후의 출혈 등에 필요시 1 회 0.5-1g IV 또는 0.5-2.5g IV infusion (급속히 투여시 구역, 흉부불쾌감, 심계항진, 혈압저하, 어지러움 나타남)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Plasminogen 이 plasmin 으로 전환되는 것을 차단하여 fibrin 분해, 조직인자의 분해, 혈소판 변성 혈관의 취약화 방지, 섬유소용해현상 억제 ◆ 부작용 : 과민증, 졸음(급속주사 시), 발진, 색감각 이상, 쇽, 위장장애, 두통 ◆ 금기 : 트롬빈을 투여 중인 환자, 활동성 혈전색전증 환자 ◆ 상호작용 ① Thrombin: 병용시 혈전형성이 증가. 병용금기 ② 혈성장기제제, Hemocoagulase: 대량병용투여 시 혈전형성 가능 ③ Batroxobin: 혈전색전증 발생 가능 ④ Eptacog alfa :구강 등 선용계활성이 강한 부위에서 응고작용이 강화 ◆ 주의 ① 혈전이 있는 환자(뇌혈전 심근경색, 혈전정맥염 등) 및 혈전증을 일으킬 우려가 있는 환자(혈전을 안정화할 우려가 있다.) ② 소모성 응고장애가 있는 환자(헤파린등과 병용한다.)(혈전을 안정화할 우려가 있다.) ③ 수술 후 침대에 누워있는 환자 및 압박지혈 처치중인 환자 (정맥혈전이 생기기 쉬운 상태이므로, 이 약을 투여하면 혈전이 생길 가능성이 커진다. 침대를 옮기거나, 압박을 중지한 이후 폐색전증이 발생한 예가 보고되었다.) ① 신부전 환자 (혈중농도가 축적될 수 있다.) ⑤ 파종혈관내응고(DIC) 환자 (급성 중증 출혈로 인해 섬유소용해계가 주로 활성화된 환자들에게만 국한해서 투여해야 한다. 반대로 응고계가 주로 활성화된 DIC 환자들에게 투여해서는 안된다. 이 환자들에게 투여할 때는 충분한 시설과 전문가가 있는 곳에서만 사용해야 한다.) ◆배합변화: 레세르핀, 탄닌산페네타딘, 메칠테스토스테론과 에칠에스트라디올의 혼합, 리피드트롬보프라스틴, 조직트롬보프라스틴, 설파디메톡신 ◆ 태아위험도 : B ◆ 과량투여시의 처치 : 과량투여 사례가 보고된 바는 없으나 과량투여시 구역, 구토, 기립성 저혈압 등의 증상이 나타날 수 있다. 과량투여시 신배설을 촉진시키기 위해 다량의 수액섭취를 유지한다. ◆ 적용상의 주의 : 서서히 정맥주사 할 것(급속히 투여하면 드물게 구역, 흉부불쾌감, 심계항진, 혈압저하, 어지러움 등이 나타날 수 있다.)	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Tridol inj	
성분/함량	Tramadol HCl 50mg/1ml/A	중추성 진통제
효능·효과	중증 및 중등도의 급만성 동통(각종 암 등), 진단 및 수술후 동통	
용법·용량	◆ 성인 (≥ 14 세) : 1 회 50-100mg IV, IM 필요에 따라 4-5 시간마다 반복주사 (최대용량: 400mg/일) ◆ 신기능 장애/투석 환자 또는 간기능 장애 환자, 노인(≥ 75 세): 이 약의 배설이 지연될 수 있으므로 투여간격 조절	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 ① 중추적으로 작용하는 합성 비마약성 진통제로서 μ-opioid receptor 와 결합하나 opiates 와는 화학적으로 연관성 없음 (μ-opioid 수용체에 대한 약한 효현작용) ② Norepinephrine, Serotonin 의 재흡수 차단 → ascending pain pathway 를 억제시킴 ◆ 임상응용 : 중증 및 중등도의 급만성 통증 진단 및 치료적 수술시 통증 ◆ 부작용 : 발작, 과민증, 호흡억제, 심계항진, 부정맥, 혈압저하, 안면창백, 수면, 통, 진전, 이명, 어지러움, 불쾌감, 구역, 의존성, 발열, 열감, 오한, 고긴장증, 체중감소 ◆ 금기 ① 급성 알콜중독자, 수면제, 진통제, 아편, 향정신성 약물 등 중추신경계 작용 중독 환자 ② 심한 호흡억제 상태, 두부손상 및 뇌의 병변이 있는 경우로 의식 혼탁 위험이 있는자 ③ MAOI 투여 받는자 ④ 기계조작 금지 ⑤적절한 치료를 받지 않고 있는 간질 환자 ⑥ 이 약 또는 이 약의 구성성분 및 아편에 대해 과민증 및 그의 병력이 있는 환자 ⑦ 임부, 수유부 ⑧ 마약 금단 증상 치료 목적의 사용 ◆ 상호작용 ① 중추신경계 약물, Digoxin, Warfarin, Quinidine 의 작용 증가 ② Carbamazepine: 이 약 대사 증가 ③ TCA 계, SSRI 계 또는 식욕억제제, MAOI, 신경이완제, 기타 발작의 역치를 낮추는 약물: 발작 가능성 증가 ④ 50mg/ml, 100mg/2ml 주사제는 디클로페낙, 인도메타신, 페닐부타존, 디아제팜, 플루니트라제팜, 미다졸람, 니트로글리세린 주사제와 배합을 금기한다. (주사제에 한함) ◆ 주의 ① Morphine 병용 또는 반복투여자, 담도질환, 간장애, 음주, 신장애, 중추신경 억제약물 투여받는 자, 경련이 있는 환자는 신중투여 ② 기계조작 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 과량시(증상: 중추 및 호흡기계 저하, 위장관 경련, 변비) Naloxone 2mg(소아: 0.01mg/kg)을 투여하고 필요시 18mg 까지 투여 가능 ② 주사 : 건냉암소(15℃ 이하) 보관 ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 과량투여하는 경우에는 심각한 호흡억제와 발작이 나타날 수 있으며, 다른 중추성 진통제(아편류)의 중독 증상과 유사한 증상이 나타날 수 있다. ; 동공수축, 구토, 심혈관 허탈, 의식 소실에 따른 혼수, 경련, 호흡 억제에 따른 호흡곤란 ② 처치 : 일반적인 응급처치를 실시한다. 기도를 확보하고, 증상에 따라 호흡과 심혈관 기능을 유지한다. 호흡곤란에 대한 해독제는 날록손이다. 동물실험에서 바르비탈계 약물 또는 벤조디아제핀계 약물에 의한 이 약의 과량투여에 의한 경련이 억제되나 날록손에 의해서는 증가되었다. ③ 투석 4 시간동안 이 약의 7% 이하가 제거되므로 혈액투석은 바람직하지 않다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Tylenol-ER tab	
성분/함량	Acetaminophen 650mg/T	해열진통제
효능·효과	◆ 해열 및 감기에 의한 동통(통증)과 두통, 치통, 근육통, 허리동통(통증), 생리통, 관절통의 완화	
용법·용량	◆ 12세 이상의 소아 및 성인 : 매 8시간마다 2정씩 복용. ◆ 24시간 동안 6정을 초과하지 말 것.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 ① CNS의 체온조절중추에 작용하여 피부혈관을 확장시켜 체온을 발산 ② 시상과 대뇌피질에 작용하여 통각역치를 상승 ◆ 부작용 : 혈소판·과립구 감소증, 용혈성빈혈, methemoglobin혈증, 혈소판기능저하, 구역, 구토, 식욕부진, 발진, 피부점막안증후군, 중독성 표피괴사증, 신독성, 과량투여시 간장·신장·심근의 괴사 유발 보고, 장기투여시 만성간괴사, 급성췌장염, 만성간염, 위장출혈, 소화성 궤양·천공 ◆ 금기 ① 이 약에 과민증 환자 ②소화성 궤양 환자 ③ 심한 혈액 이상, 간장애, 신장장애, 심장기능저하 환자 ④ 아스피린 천식 병력 환자 ⑤ 바르비탈계약물, TCA, 알코올 복용 환자 ⑥ 12세 미만 소아 ◆ 상호작용 ① Rifampin: 이 약의 진통효과 감소 ② Barbiturates, TCA, 알콜: 다량의 이 약을 대사시키는 능력이 감소되어 이 약의 t½ 증가(알콜은 간독성 증가시킴) ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 ① 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)를 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안됨 ② [연령금기] 12세 미만	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Vabysmo inj	
성분/함량	Faricimab 28.8mg/0.24ml/V	항혈관신생제(Faricimab)
효능·효과	◆ 신생혈관성 (습성) 연령관련 황반변성의 치료 ◆ 당뇨병성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료	
용법·용량	이 약은 유리체내 주사로 투여되어야 한다. 하나의 바이알은 한쪽 눈의 치료에만 사용해야 한다. 1. 신생혈관성 (습성) 연령관련 황반변성의 치료 6 mg(0.05mL)을 첫 4회 투여시 4주마다(매월) 유리체 내 주사로 투여한다. 2. 당뇨병성 황반부종에 의한 시력 손상의 치료 6 mg(0.05mL)을 첫 4회 투여시 4주마다(매월) 유리체 내 주사로 투여한다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : angiopoietin-2 (Ang-2)를 억제하여 혈관 안정성을 촉진하고 혈관을 VEGF-A의 효과에 대해 둔감하게 만든다. ◆ 부작용 : 백내장, 뇌혈관사고, 동맥혈전증, 망막박리, 심근경색, 유리체출혈, 결막출혈, 눈자극, 눈통증, 안통, 망막 색소 상피 열상, 안구불쾌, 앞방 염증, 전방 염증, 유리체 부유물, 항체 발현, 각막 긁힌 상처 ◆ 금기 1) 안구 또는 안구 주변 감염 환자 2) 활동성 안구 내 염증이 있는 환자 3) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 과민성이 있는 환자. 과민성은 발진, 소양증, 두드러기, 홍반 또는 중증 안구 내 염증으로 나타날 수 있다. ◆ 비고 : 냉장(2~8℃) 및 차광 보관 ◆ 주의사항 -이 약은 2~8℃에서 냉장 보관한다. 얼리지 않는다. 흔들지 않는다. -투여 준비에 앞서, 이 약의 바이알이 실온(20-25℃)에 도달하도록 한다. 차광을 위하여 바이알을 원래의 상자에 보관한다. -사용하기 전에, 이 약의 개봉하지 않은 바이알은 20-25℃의 실온에서, 최대 24시간 동안 보관할 수 있다. -바이알에는 권장 용량인 6mg(0.05mL)보다 많은 양이 들어있다. 바이알의 충전량(0.24mL) 전체를 사용하지 않는다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Vaqta PFS inj	
성분/함량	Purified inactivated Hepatitis A antigen(IM) 50unit/1ml/Syringe(성인용), 25unit/0.5ml/Syringe(소아용)	**A형 간염 백신**
효능·효과	◆ A 형 간염의 예방	
용법·용량	◆ 기본 면역 : 삼각근(둔부는 제외)에 근육주사 ① 성인 (만 18세 이상) : 1회 1ml (1440 EL.U) ② 소아 (만 1세~18세 미만) : 1회 0.5ml (720 EL.U) ◆ 추가 면역 : 기본 면역일로부터 6~12개월 후에 기본 면역과 동일한 방법으로 접종 ◆ 최소한 1년 정도의 예방효과를 얻기 위해서는 기본 면역 접종을 실시하고, 장기간(최대한 10년)의 예방효과를 얻기 위해서는 추가 면역 접종을 실시 ◆ 다른 백신과의 교차 접종: 다른 불활화 A형 간염백신으로 1차 접종하고 6-12개월 후에 이 백신으로 2차 접종 가능 ◆ 면역글로불린과의 병용 투여: 이미 A형 간염 바이러스에 노출되었거나 노출이 의심되는 경우 또는 A형 간염 유행지역을 여행 하는 경우	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 불활성화 바이러스 백신(inactivated virus vaccine)으로, A형 간염 바이러스 감염에 대한 면역을 유도 ◆ 부작용 : 신경과민, 두통, 졸음, 설사, 구역, 발진, 주사부위의 통증 및 발적, 피로감 등 ◆ 금기 : Neomycin 등 이 약 성분에 의한 알레르기를 일으킬 우려가 명확하거나, A형 간염백신에 과민증 병력 있는 자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 : 냉장(2~8℃) 및 차광 보관 ◆ 적용상의 주의 ① 이 약은 현탁액이므로 투여 전 잘 흔들어 균질한 상태로 만든 후 사용할 것	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Vasopressin inj	
성분/함량	Vasopressin 20IU/1ml/A	뇌하수체호르몬제
효능·효과	뇌하수체성 요붕증, 뇌하수체성 또는 신성 요붕증의 감별진단, 장내가스제거(복부팽만감, 담낭 촬영의 전처리, 신우 촬영의 전처리), 식도정맥류출혈의 긴급 처치	
용법·용량	◆ 성인 ① 뇌하수체성 요붕증: 1 회 2-10 IU 를 2-3 회/일 SC, IM ② 뇌하수체성 또는 신성 요붕증의 감별 : 5-10 IU 를 SC, IM 또는 0.1 IU 를 IV→ 요량이 현저히 감소 또는 요의 비중이 1.01 이상이면 Vasopressin 반응성 요붕증 ③ 장내가스 제거(복부팽만감, 담낭 촬영□신우 촬영의 전처리) : 5-10 IU 를 SC, IM ④ 식도 정맥류 출혈 긴급처치 : 20 IU 를 D5W 100-200ml 에 희석하여 IV infusion (투여속도: 0.1-0.4 IU/분) ◆ 소아용량 ① 뇨붕증: - 1 회 2.5-10 IU 씩 2-4 회/일(필요시) IM, SC - 0.0005IU/kg/시간 IV infusion, 30 분마다 2 배 용량 투여 가능 (최대: 0.01IU/kg/시간) ② GI Hemorrhage : 0.002-0.005IU/kg/분, 12 시간내지혈되면동량을 투여 후 24-48 시간내 서서히 중단	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 ① 뇌하수체 후엽 호르몬(항이뇨, 혈관수축)으로 고용량에서 평활근 수축 → 위장관으로 혈류감소시켜 식도정맥류의 급성대량 출혈의 긴급 처치 ② 신세뇨관으로부터 수분을 재흡수하여 이뇨를 억제, 혈액량 증가 ◆ 부작용 : 쇽, 발진, 홍조, 심부전, 심근허혈, 심실성 기외수축, 관상동맥 연축, 흉통, 서맥, 두통, 어지러움, 부정맥, 체온강화, 혈압상승, 혼수, 구토, 설사, 수분저류, 자궁수축, 월경과다, 수분저류에 의한 저 Na 혈증, 기관지 수축, 호흡곤란, 중추성 신경장애, 근육통, CPK 상승, 수분중독 ◆ 금기 : 관동맥경화증, 신속한 세포의 수분증가 위험이 있는 병태(심부전, 천식, 임신 중독증, 편두통, 전간 등의 환자), 혈중 질소 저류가 있는 만성신염 환자 ◆ 상호작용 ① Clofibrate, Carbamazepine, Paracetamol: 항 이뇨작용 증가 ② CTX: 이 약 배설 촉진 ◆ 주의 ① 동맥경화성질환, 고혈압을 수반한 순환기질환, 동맥경화에 기인하지 않은 허혈성 심질환, 노인은 신중투여 ② 간혈류량 감소로 비가역적 간부전 기능 ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 : 냉소보관(15℃ 이하) ◆ 과량투여시의 처치 ① 증상 : 수분저류에 의한 저나트륨혈증을 일으킬 수 있으며 초기 증상으로 체중의 급속한 증가, 두통, 무력, 기면 등이 나타날 경우에는 투여를 중지한다. ② 처치 - 수분의 공급을 차단한다. 중증 수분중독의 경우 소량의 고장식염수를 투여할 수 있다. - 뇌부종의 경우 요소나 만니톨을 투여한다. - 협심증통이 나타나는 경우에는 아밀나이트레이트를 흡입 또는 니트로글리세린을 설하투여한다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Vaxneuvance PFS inj	
성분/함량	Pneumococcal polysaccaride conjugate 0.5ml/Syringe	폐구균백신
효능·효과	1. 생후 6 주 이상부터 만 17 세 까지의 영아, 어린이 및 청소년 ① 생후 6 주 이상부터 만 17 세 까지의 영아, 어린이 및 청소년에서 폐렴구균(혈청형 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F 및 33F)으로 인하여 생기는 침습성 질환 및 폐렴의 예방 ② 생후 6 주 이상부터 만 17 세 까지의 영아, 어린이 및 청소년에서 폐렴구균(혈청형 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F 및 33F)으로 인하여 생기는 급성 중이염의 예방. (단,혈청형 1, 3, 5, 6A, 7F, 19A, 22F 및 33F 에 대한 유효성 자료는 이용 가능하지 않다.) 2. 만 18 세 이상의 성인에서 폐렴 구균 혈청형(1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F 및 33F)에 의한 침습성 질환 및 폐렴의 예방	
용법·용량	* 1 회 0.5mL 을 근육주사(IM) * (1) 6 개월이하 영아 1)기초접종 : 1 회 0.5ml, 생후 2,4,6 개월에 3 회 2)추가접종: 12-15 개월 0.5ml 추가 (2)기초접종을 하지 않은 생후 7 개월 ~ 만 17 세 영아, 어린이 및 청소년 1) 7-11 개월: 1 회 0.5ml, 3 회(처음 2 회는 적어도 4 주 이상 간격을 둔다. 3 번째 접종은 생후 12 개월 이후에 2 번째 접종과 적어도 2 개월 이상 간격을 두고 주사) 2) 12-23 개월: 1 회 0.5ml, 2 회(접종간격은 2 개월로 한다.) 3) 만 2 ~ 17 세의 어린이 및 청소년 : 1 회 0.5ml, 1 회 주사 4) 이전에 폐렴구균 접합백신을 접종 받은 만 2 ~ 17 세 어린이 및 청소년 : 항원가가 적은 폐렴구균 백신 기본 접종을 완료하지 않은 경우 1 회 용량 0.5 mL 를 1 회 주사하되 마지막 투여 후 적어도 2 개월 후에 이 약을 투여한다 (3) 만 18 세 이상 성인 : 1 회 0.5ml, 단회 주사	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 Promotes active immunization against invasive disease caused by S. pneumoniae serotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, and 33F, each of which are individually conjugated to CRM197 protein. ◆ 부작용 : 주사부위 반응, 발열, 과민, 식욕감퇴, 수면 증가/감소, 운동장애가 있는 통증/압통, 설사, 안면부종 등 ◆ 금기 : 이 백신 또는 디프테리아 톡소이드-함유 백신의 성분에 중증 알레르기 반응(예, 아나필락시스)의 병력이 있는 자 ◆ 상호작용 1) 만 2 세 미만의 영아 : 임상시험에서 이 백신 또는 프리베나 13 주와 병용 투여 시 병용 백신에 포함된 항원에 대한 면역반응은 비열등성 기준을 충족하였다. 2) 만 2 ~ 17 세 어린이 및 청소년 이 백신과 다른 백신의 병용투여에 대한 자료가 없다. 3) 50 세 이상의 성인 : 불활화 계절성 4 가 인플루엔자 백신과 병용투여 가능 4) 면역억제요법과 사용 : 방사선요법, 항대사제, 알킬화제, 세포독성약물, 코르티코스테로이드, 단백질치료제 및 표적 면역조절제를 포함한 면역억제요법은 백신에 대한 면역반응을 감소시킬 수 있다. ◆ 태아위험도 : B ◆ 비고 : 냉장 차광 (2~8℃) ◆ 주의사항 1) 근육주사로만 투여해야 하며, 정맥투여해서는 안 된다. 2) 영아의 경우 대퇴부 전외측에, 어린이 및 성인의 경우 상완 삼각근 부위에 투여하는 것이 바람직하다. 둔부, 주요 신경줄기 및/ 또는 혈관이 지나갈 수 있는 부위에 투여해서는 안 된다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Vecaron inj	
성분/함량	Vecuronium bromide 4mg/V	신경근차단제
효능·효과	마취시 근이완, 기관내 삽관시 근이완 유지, 기계적 조절호흡 용이, 수술시 근이완	
용법·용량	◆ 성인 ①삽관용량: 0.08-0.1mg/kg 를 IV ②유지량: 0.02-0.03mg/kg 를 IV ③Suxamethonium 으로 삽관후 수술중 투여량: 0.03-0.05mg/kg ④연속주입시 - 초기량은 bolus dose 투여 - 신경근 차단이 시작되면 0.8-1.4 μg/kg/분의 속도로 주입 ◆ 소아용량 : 신생아, 유아(출생 후 4 개월까지) - 초기량: 0.01-0.02mg/kg (5 개월-1 세는 성인과 같으나 고용량 삽관용량은 안됨)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Acetylcholine 이 신경근 말단 수용체에 결합하는 것을 차단하는 비탈극성 근이완제 ◆ 부작용 : 근마비, 쇽, 발적, 서맥, 딸국질, 홍반, 기관지경축, 지속성 호흡억제, 근육통, 무력감 ◆ 배합금기 : Thiopenthal Na ◆ 상호작용 ① 이 약의 작용증강 : 마취제, Suxamethonium 전투여(1mg/kg), 항생물질 (AG, Polypeptide 계, 고용량의 Metronidazole), 이뇨제, Thiamine, MAOI, $MgSO_4$, Quinidine, Protamine ② 이 약의 작용 감소 : Neostigmine, Pyridostigmine, 부신피질 호르몬, 항전간제, Azathioprine, Theophylline, $CaCl_2$, KCl ◆ 주의 ① 호흡곤란 및 기도폐색, 기관지천식, 전해질 이상, 노인 신생아 및 간 담도질환, 신부전, 순환시간연장, 신경근질환, 저체온증 환자는 신중투여 ② 기계조작 ③ 비만환자는 마른사람에 비해 용량 감소시킴 ◆ 태아위험도 : C ◆ 과량투여시의 처치 - 기계적 조절호흡을 시키고 해독제로 적당한 양의 콜린에스테라제 저해제 투여 - 콜린에스테라제 저해제의 투여로 역전시키지 못했을 경우, 자발적 호흡이 회복될 때까지 기계적 조절호흡을 계속 한다. 콜린에스테라제 저해제의 반복투여는 위험할 수 있다. ◆ 적용상의 주의 ① 이 약을 주사용수로 혼화시킨 후의 용액은 다음의 주입액과 혼합하여 40mg/L 까지 희석할 수 있다. : 0.9% 염화나트륨주사액, 5% 포도당 주사액, Ringer's 주사액, Ringer's 포도당주사액 → 또한 이상의 혼화액은 다음 용액이 주입되는 과정중에 주사할 수 있다. : Lactated Ringer's 주사액, Lactated Ringer's 주사액 및 5% 포도당, 5% 포도당과 0.9% 염화나트륨주사액, Haemaccel, 0.9% 염화나트륨주사액중의 5% Dextran-40, 주사용수 ② 이 약을 치오펜탈이나 치오펜탈 함유 용액에 배합할 수 없다. ③ 다음 약물의 주입과정에 이 약을 주사할 수 있다 : 펜타닐, 드로페리돌, 염산니코모르핀 및 브롬화판크로늄 ◆ 저장상의 주의사항 : 용제로 혼화한 후 용액은 실온, 일광 하에서 24 시간동안 보관할 수 있다. 엄격한 무균상태에서 조제되지 않은 혼화액과 희석액은 실온에서 12 시간이하만 보관이 가능하다. 그러나 미생물의 오염을 방지하기 위하여 사용되지 않은 용액은 버린다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Ventolin evohaler	
성분/함량	Salbutamol sulfate 200 dose/Btl	기관지 확장제
효능·효과	기관지천식, 만성기관지염, 폐기종 등 기도폐쇄성 장애에 의한 호흡곤란 등의 증상완화	
용법·용량	◆ 성인 ① 기관지 경련의 급성발작시 : 1 회 1-2 번(0.1-0.2mg)씩 분무 ② 알러지원 유발성 또는 운동 유발성 천식예방 : 운동시작 10-15 분전 1 회 2 번씩 분무 ③ 만성적 작용 : 1 회 2 번씩, 4 회/일 (최대 8 번/일) ◆ 소아용량 ① 기관지경련의 급성발작시, 운동전 : 1 회 1-2 번 분무 ② 만성적 사용 : 1 회 2 번, 4 회/일 (최대: 8 번/일)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 직접적으로 작용하는 속효성 β_2-selective adrenergic agent c-AMP 증가로 평활근 이완 촉진 ◆ 부작용 : 두통, 수지진전, 신경과민, 심계항진, 졸음, 부정맥, 고혈압, 식욕부진, 구역, 구토, 중증의 혈청 K 감소, 혈관부종, 두드러기, 발진, 비충혈, 인두염, 역리성 기관지경련, 근육통, 배뇨장애 ◆ 금기 : 교감신경 흥분성 amine 류에 과민체질, 비후성 심근병증, IV 사용, 단순 조숙산통 또는 절박유산을 막기위한 사용 ◆ 상호작용 ① Catecholamine 류(Epinephrine, Isoproterenol): 부정맥, 심정지 유발 ② MAOI, TCA 계: 이 약의 혈관계 작용 증가(2 주간 주의) ③ 비선택적 β-blocker 와 병용금지: 기도저항 증가, 기관지경련 유발 ④ Thiazide: 심전도상 변화 ⑤ Digoxin 의 농도감소 ◆ 주의 ① 갑상선 기능 항진증 환자, 고혈압 환자, 심부전증, 부정맥 등 심질환자, 당뇨병환자 ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고 ① 차광보관 ② 별칭 : Albuterol ③ Nebule: 호일포장 제거 후 25-30℃ 차광보관, 3 개월 이내 사용 ◆ 과량투여시의 처치 ① 살부타몰 제제의 과량투여로 인한 가장 흔한 증상 및 징후는 일시적인 β-효능제에 의한 약리학적 매개 작용들이다. 이 약의 과량투여로 β-아드레날린성 작용의 증강, 빈맥 또는 근육진전 등의 위에 기술된 이상반응 증상이 발현 또는 악화될 수 있다. 다른 교감신경흥분성 흡입제와 마찬가지로 심정지 심지어 사망까지도 이 약의 남용과 관련 있을 수 있다. 이 약의 연속투여 중 볼 수 있는 과량투여에 의한 증상은 보통 이 약의 투여를 중지하면 소실된다. 이 약의 과량투여로 저칼륨혈증이 나타날 수 있으므로 혈중 칼륨치를 모니터링하여야 한다. 과량투여시 저산소혈증을 유발하는 무반응상태가 나타날 수 있다. ② 심장 관련 증상(예, 빈맥, 심계항진)을 나타내는 환자에서는 이 약 투여를 중단하고 심장선택성 β-차단제와 같은 적절한 대증치료를 할 것을 고려해야 한다. β-차단제는 기관지 경련의 병력이 있는 환자에게는 조심하여 투여해야 한다. ③ 이 약을 지속적으로 투여하고 있는 동안에 과량 투여의 증상이 나타나는 경우에는 일반적으로 약물 투여를 중단함으로써 회복된다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Vit-K1 inj	
성분/함량	Vitamin K1 10mg/1ml/A	비타민제제
효능·효과	◆ 신생아 출혈성질환의 예방과 치료 ◆ 급성 또는 경구투여가 어려운 경우의 비타민 K 결핍 또는 비타민 K 의 활성이상으로 인한 다음의 혈액응고질환 ① 쿠마린(coumarin) 유도체에 의한 항응고제 유도성 프로트롬빈 결핍증 ② 항생제, 살리실산 제제 등에 의하여 2 차적으로 발생되는 저프로트롬빈혈증 ◆ 비타민 K 의 합성 또는 흡수제한으로 인하여 2 차적으로 발생되는 저프로트롬빈혈증	
용법·용량	◆ 성인 : ①항응고제 유도성 프로트롬빈 결핍증: 초회 이 약으로서 2.5-10mg 또는 최대 25mg 까지 투여, 드물게 50mg 이 사용되는 경우도 있다. 필요 시, 6-8 시간 이후 반복 투여 가능 ② 다른 원인으로 인한 저프로트롬빈혈증: 2.5-25mg, 최대 50mg (응급시 IV: 주입속도 5mg/분 초과금지) ◆ 소아용량 ① 신생아 출혈성 질환의 예방 : 분만직후 1 시간 이내 피토나디온으로서 신생아에게 0.5-1mg/회를 IM ② 신생아 출혈성 질환의 치료 : 1mg/일을 IM 또는 서서히 IV ③항응고제 유도성 프로트롬빈 결핍증 : 초회 이 약으로서 2.5~10mg (영아 : 1~2mg)을 SC, IM, 필요 시, 6~8 시간 이후 반복 투여 가능 (응급시 IV: 5mg/min 의 속도 초과금지)	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : RNA 합성을 유도함으로써 간에서 Prothrombin 형성을 촉진시킴 ◆ 부작용:핵황달, 용혈성빈혈,혈색소뇨증,현기,서맥,발한,호흡곤란, 기관지경련, 청색증, 주사부위 결절, 동통, 발적 ◆ 금기 : 담즙분비정지환자, 과민증환자, 간세포 손상으로 인한 저프로트롬빈혈증 환자 ◆ 배합금기 : Dobutamine ◆ 주의 : Heparin 의 항응고 작용에 대해 길항하지 않음 ◆ 상호작용 ①쿠마린계 항응고제의 작용을 감소시킬 수 있다. ②광범위 항생제, 퀴니딘, 퀴닌, 고용량의 살리실산염은 이 약의 효과를 감소시킬 수 있다. ③콜레스티라민, 광유는 이 약의 흡수를 감소시킬 수 있으므로, 투여 1 시간 전 또는 4 시간 후에 투여한다. ◆ 태아위험도 : C ◆ 비고: 차광보관 , 희석용매: N/S, D5W, DS ◆ 과량투여 시의 처치 : 이 약을 과량투여 했을 경우에는 프로트롬빈을 억제하는 항응고제를 다소 과량 투여하거나 헤파린 같은 다른 기전으로 작용하는 항응고제를 투여하여 증상을 역전. ◆ 적용상의 주의 ① 용량은 가능한 한 최소한으로 유지해야하고 프로트롬빈수치는 정기적으로 검사해야 한다. ② 주사 속도가 빠를 경우에는 쇽 증상이 발생될 수 있으므로 천천히 점적정맥주사하도록 한다(주사제에 한함). ③ 점적정맥주사하는 경우에는 광분해를 방지하기 위하여 차광커버를 사용하는 등 적용 시 주의한다. ④ 사용 시 앰플내 주사액의 투명도를 확인해야 한다. 부적절하게 보관한 경우, 내용액이 혼탁되거나 층이 분리된 경우가 발생될 수 있다. 이런 경우에는 사용하면 안 된다(주사제에 한함). ⑤ 정맥주사시 0.9% 생리식염 주사액, 5% 포도당 주사액, 5% 포도당/생리식염 주사액으로만 희석해야 하며 혼합 후, 즉시 투여를 시작해야 한다(주사제에 한함). ⑥ 다른 주사제와 혼합 또는 희석하여 사용하지 않아야 하지만 관류장치의 하부에 주입할 수 있다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	VoluLYTE inj	
성분/함량	**Hydroxyethyl starch 30g,** **Magnesium chloride hexahydrate 150mg,** **Potassium chloride 150mg,** **Sodium acetate trihydrate 2315mg,** **Sodium chloride 3010mg / 500ml / Bag**	**혈액, 체액용약**
효능·효과	◆ 혈액량 감소의 치료 및 예방 ◆ 신속한 동량 혈액희석요법(Acute Normovolemic Hemodilution(ANH))에 사용	
용법·용량	◆ 점적 정맥주사 ◆ 초기 10~20ml 는 환자 관찰하면서 천천히 투여 ◆ 1일 최대용량 : 50ml/kg	
사용상의 주의사항	◆ 부작용 ① 아나필락시양 반응, 발진, 가려움, 심방세동, 대사성 산증, 구토, 오한, 발열, 두통 등 ② 대량 투여 시 : 혈액응고기전 이상, 혈장 단백 농도 감소 ◆ 금기 : 패혈증, 중증 간 질환, 폐부종을 포함한 체액 과부하(수분과다) 상태, 핍뇨나 무뇨를 수반한 신부전 또는 중증 신부전, 울혈성 심부전 또는 중증 심부전, 중증 혈액응고장애, 투석치료중인 경우, 두개내 출혈, 중증 고나트륨혈증, 고칼륨혈증, 고마그네슘혈증 또는 고염소혈증과 같은 중증 전해질 이상, 이 약 성분에 과민한 환자 ◆ 주의 ① 칼륨 또는 나트륨 저류를 일으킬 수 있는 약물을 동시 투여시 주의 필요 ② 과량 투여에 의한 순환과부하를 피해야 하며, 투여 동안 혈청 전해질 모니터링이 필요 ③ 히드록시에틸전분을 정맥투여받는 환자는 2차 아나필락시양 반응이 일어날 수 있으므로 엄격하게 모니터링해야 하며, 아나필락시양 반응이 나타날 경우, 즉시 주입을 중단하고 응급처치를 한다. 또한 초기 정맥 투여시 주입 속도를 느리게 해야 한다. ① 중증 탈수의 경우 정질액 우선적으로 투여해야 한다. ② 고령자, 간기능부전, 신기능부전의 경우 주의깊은 모니터링이 필요함. ◆과량투여시의 처치 -증상: 폐부종과 같은 순환과부하를 초래할 수 있음 -처치: 투여를 즉시 중단하고 이뇨제 또는 혈관확장제를 투여	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Voluven inj	
성분/함량	Hydroxyethyl starch 30g, Sodium chloride 4.5g /500ml/Bag	혈장증량제
효능·효과	◆ 혈액량 감소의 치료 및 예방 ◆ 신속한 동량 혈액희석요법(Acute Normovolemic Hemodilution (ANH))에 사용	
용법·용량	◆ 점적 정맥주사: 초기 10-20mL 는 환자를 세심히 관찰하면서 천천히 투여 ◆ 1 일 투여량과 투여속도는 환자의 혈액손실량, 혈액역학적 검사치의 유지 또는 복구, 혈액희석에 따라 결정하고, 환자의 상태에 따라 수일간 반복투여를 할 수 있으며, 투여기간은 혈액량 감소의 지속기간 및 정도, 혈액역학적 작용, 혈액희석에 따라 결정한다. 단, 1 일 최대용량은 체중 kg 당 50mL 이다.	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 혈장증량제: 혈장내 삼투압을 증가시켜 혈장 증량 효과 ◆ 부작용 : 발진, 소양감, 구토, 오한, 발열, 두통 ◆ 금기 : CHF, 핍뇨 등을 수반하는 신부전환자 및 탈수상태의 환자, 중증 간 질환 환자, 폐부종을 포함한 체액 과부하 상태 환자, 중증 혈액응고장애 환자, 투석환자, 중증 고나트륨혈증 또는 중증 고염소혈증 환자 ◆ 주의 ① 폐수종, 신부전환자, 섬유소원 감소증, 혈소판 감소증, 간질환은 신중 투여 ② 가소제로 Di-(2-Ethyl Hexyl) Phthalate 를 사용한 PVC 재질용기 ③ 대량투여시 혈액응고기전을 일으킬 수 있고 출혈시간 연장 및 혈침속도 감소, 혈장단백 희석 가능성 있음 ◆ 과량투여시의 처치 : 이 약의 과량투여로 폐부종과 같은 순환과부하를 초래할 수 있다. 이러한 경우 투여를 즉시 중단하고 필요하다면 이뇨제 또는 혈관확장제를 투여한다. ◆ 적용상의 주의 ① 다른 약물과의 혼합을 피한다. 예외적인 경우에 다른 약물과의 혼합이 필요하다면 혼탁이나 침전 등의 상충작용, 오염, 균질하게 혼합되었는지에 주의한다. ② 개봉후 즉시 사용하여야 하며, 사용후 남은 잔액은 사용하지 않는다. ③ 사용기한이 경과된 제품은 사용하지 않는다. ④ 용액이 투명하고 포장이 손상되지 않은 제품만 사용한다. ⑤ 사용하기 전에 프리플렉스백(freeflex bag)으로부터 오버랩(overwrap)을 제거한다. ◆ 보관 및 취급상의 주의사항 ① 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. ② 25℃ 이하에서 보관하며 얼리지 않는다.	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Xgeva inj	
성분/함량	Denosumab 120mg/1.7ml/V	근골격계용제
효능·효과	◆ 다발성 골수종 및 고형암의 골전이 환자에서 골격계 증상(skeletal-related events) 발생 위험 감소. ※ 골격계 증상: 병리학적 골절, 뼈에 대한 방사선 조사, 척수압박, 뼈 수술 ◆ 성인 및 골 성숙이 완료된 청소년에서 절제가 불가능하거나 수술적 절제가 중증의 이환을 일으킬 가능성이 있는 골거대세포종 치료	
용법·용량	◆ 다발성 골수종 및 고형암의 골전이 : 1회 120 mg 매 4주 간격으로 상완, 허벅지 위쪽 또는 복부 SC ◆ 골거대세포종 : 1회 120 mg 매 4주 간격으로 투여하되, 치료 첫 번째 달의 제8, 15일째 1회 120 mg 추가 투여. 상완, 허벅지 위쪽 또는 복부 SC ※ 필요 시, 저칼슘혈증 치료 및 예방 위해 칼슘과 비타민 D 함께 복용	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : mRANKL(Receptor activator of uclear factor kappa-B ligand) inhibitor 기전의 monoclonal antibody로, 파골세포 형성, 기능을 저해하여 골재흡수를 감소시켜 골부피와 골강도를 증가시킴 ◆ 부작용 : 피로/무력증, 저인산혈증 및 구역, 호흡곤란, 뼈 괴사, 저칼슘혈증 ◆ 금기 : 중증의 치료받지 않은 저칼슘혈증 환자 ◆ 태아위험도 : D ◆ 주의 ① PROLIA inj(동일 주성분, 용량 및 적응증 다름)과 병용 금지 ② 과민반응: 이나필락시스, 저혈압, 호흡곤란, 상기도 부종, 입술 부종, 발진 등 ③ 저칼슘혈증: 중증 증상성 저칼슘혈증 악화 가능 ④ 턱뼈 괴사: 정기적인 구강검사 실시(치료전, 치료중 지속 관리) ⑤ 비정형 전자하부 및 골간 대퇴골 골절 ⑥ 뼈 성장 환자의 치료 중단에 따른 고칼슘혈증 ⑦ 다발성 골수종 환자에게 골격계 증상 발생 위험 감소를 위한 사용은 제한됨 ◆ 비고 ① [임부금기] 1등급(보건복지부고시) ② 냉장(2-8℃) 보관 ◆ 적용상의 주의 ① 투여하기 전에 냉장고에서 꺼낸 후 원래 포장 상태에 두고 실온(25℃까지)에 도달하도록 한다. 이 과정은 15~30분 정도 걸린다. 이 약을 다른 방법으로 따뜻하게 하면 안 된다. ② 27 게이지 주사침을 사용하여 바이알의 약액을 모두 취하여 SC	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Zoladex depot inj	
성분/함량	Goserelin acetate 3.6mg/Syr	항악성 종양제
효능·효과	◆ 호르몬요법이 적합한 전립선암, 폐경기전 및 주폐경기 여성의 진행성 유방암, 조기유방암의 보조요법 ◆ 자궁내막증, 자궁내막조직의 퇴축, 자궁근종, 보조생식술	
용법·용량	◆ 1 depot를 28일 간격으로 전방복벽에 SC	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : 황체형성호르몬 자극호르몬 동족체(LHRH analogue)의 합성유도체로서, 뇌하수체의 LH 분비억제하여 남성에서는 혈중 testosterone 농도를, 여성에서는 estradiol 농도를 억제 ◆ 부작용 : 관절통, 혈압변화, 피부발적 ① 남성: 홍조, 성욕감퇴, 발한, 골통증, 뼈무기질 밀도감소 ② 여성: 홍조, 발한, 성욕감퇴, 두통, 우울, 유방크기 변화, 고Ca혈증, 질출혈 ◆ 금기 : LHRH analogue 과민성 환자, 임부, 수유부 ◆ 주의 ① 남성: 요관 폐쇄환자, 척수압박 발현 가능성 높은 환자 ② 여성: 뼈무기질 밀도의 손실 유발 ◆ 태아위험도 : X ◆ 비고 : [임부금기] 1등급 (자궁내막증, 자궁내막축소증환자) (보건복지부고시) [임부금기] 2등급 (폐경전유방암환자) (보건복지부고시)	

세브란스병원
SEVERANCE HOSPITAL

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보

약품명	Zometa ready inj	
성분/함량	Zoledronic acid 4mg/V	골대사제제
효능·효과	◆ 악성 종양으로 인한 고칼슘혈증 ◆ 다발골수종 및 고형암의 골전이 환자의 치료에 표준항암요법과 연계하여 사용	
용법·용량	◆ 악성종양으로 인한 과칼슘혈증 (Albumin-corrected Ca≥12mg/dl 또는 3mmol/L): 4mg을 15분 이상 IVF ◆ 다발성 골수종 및 고형암의 골전이 - 4mg을 15분 이상 IVF, 3-4주마다 - 치료기간: 전립선암-15개월, 유방암 다발성 골수종-12개월, 다른 고형암-9개월 - 칼슘제 500mg과 Vit. D 400 IU 함유제 함께 복용1회 0.65ml 피하주사	
사용상의 주의사항	◆ 약리작용 : Bisphosphonate 계열로 ① 파골세포의 전구체 또는 파골세포에 의한 bone resorption 차단 ② Tumor에 의한 Ca2+ 유리 및 파골세포의 활성 저해 ③ Ca, P의 농도감소 ◆ 부작용 : 아나필락시스 반응, 눈 이상반응, 턱뼈 괴사, 비정형 대퇴부 골절, 심방세동, 신기능 손상, 급성기 반응, 저칼슘혈증, 체온상승, influenza(+) 증상(발열, 오한, 골통증, 근육통), 구역, 구토, 혈소판 범혈구 감소증, 졸음, 감각이상, 미각장애, 감각과민, 호흡곤란, 수면장애, 소양감, 홍반성 발진, 발한, 서맥, 시야혼탁, 신부 전, 단백뇨, 혈뇨, 과민반응, 혈관 신경성 부종, 체중증가, 흉통 ◆ 금기 ① 다른 Bisphosphonate계 과민증 ② 임부 및 수유부 ◆ 상호작용 ① Aminoglycoside: 혈청 Ca치를 낮추는데 상가작용 있음 ② Loop계 이뇨제: Hypocalcemia ③ Thalidomide: 경증~중등도 신기능 장애 환자 이 약의 용량조절 필요 ◆ 태아위험도 : D ◆ 비고 : ① [임부금기] 2등급(보건복지부고시) ② 개봉 후 안정성: 2-8℃ 에서 24시간 ◆ 적용상의 주의 ① 단독 정맥 주입 투여 ② Ca 또는 2가 양이온 함유된 점적용액(Lactated Ringer Solution)과 혼합 금지	

제정일: 2014.4.
개정일: 2014.10/2016.3/2017.3/2019.3/
2021.3/2022.3/2023.3/2023.6./2024.3./
2025.2/2025.5.
기안부서: 약무국

비품약 정보